

دانشگاه علم و هنر یزد

دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش: بالینی

عنوان:

نقش میانجی خودانتقادی و شرمساری در رابطه بین حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی در زنان مراجعه کننده به کلینیک

استاد راهنما:

دکتر فرنگیس دمهری

دانشجو:

مهدیه قهار

تابستان ۱۴۰۵

تقدیم به

خانواده عزیزم؛

به پاس قدردانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت، امنیت، آرامش و آسایش برای من فراهم آورده اند و مرا در راه رسیدن به اهداف عالی یاری می رسانند؛

سپاسگزاری

با تقدیر و تشکر فراوان از استاد فرهیخته و فرزانه سرکار خانم **دکتر فرنگیس دهری** که با نکته‌های دلاویز و گفته‌های بلند صحیفه‌های سخن را علم پرور نمود و همواره راهنما و راهگشای اینجانب در اتمام و اکمال این پایان نامه بوده‌اند

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودانتقادی و شرمساری در رابطه بین حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد بود که از میان آنان ۲۲۰ نفر به روش در دسترس انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های سطوح خودانتقادی (LOSC؛ تامپسون و زوروف، ۲۰۰۴)، احساس شرم (ESS؛ اندروز و همکاران، ۲۰۰۲)، ویرایش دوم افسردگی بک (BDI-II)، حساسیت بین‌فردی (IPSM؛ بویس و پارکر، ۱۹۸۹) و پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه-فرم کوتاه (YSQ-S3؛ اسمیت و همکاران، ۱۹۹۵) جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل مسیر و مدل‌سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد مدل ساختاری پژوهش از برازش مطلوبی با داده‌ها برخوردار است (GFI =۰/۹۸؛AGF=۰/۹۶؛ CFI =۰/۹۹؛ RMSEA=۰/۰۴۶). نتایج نشان داد حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی به صورت مستقیم و مثبت شدت افسردگی را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین شرمساری نقش میانجی معناداری در رابطه بین حساسیت بین‌فردی و شدت افسردگی ایفا کرد، اما نقش میانجی خودانتقادی در این رابطه تأیید نشد. علاوه بر این، مسیرهای غیرمستقیم طرحواره رهاشدگی به افسردگی از طریق خودانتقادی و شرمساری معنادار نبودند. بر اساس یافته‌ها، افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی حاصل تعامل عوامل شناختی، هیجانی و بین‌فردی است و حساسیت نسبت به روابط اجتماعی و انتظار از دست دادن حمایت دیگران می‌تواند از طریق افزایش تجربه‌های هیجانی منفی، به‌ویژه شرمساری، با شدت بیشتر افسردگی همراه شود. این پژوهش بر اهمیت بررسی همزمان عوامل بین‌فردی، طرحواره‌ای و هیجانی در تبیین افسردگی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها: خودانتقادی، شرمساری، حساسیت بین‌فردی، طرحواره رهاشدگی، افسردگی، زنان

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مسئله ۵

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۱۰

۱-۴ اهداف پژوهش ۱۲

۱-۴-۱ هدف اصلی ۱۲

۱-۴-۲ اهداف فرعی ۱۲

۱-۵ فرضیات پژوهش ۱۳

۱-۵-۱ فرضیه اصلی ۱۳

۱-۵-۲ فرضیات فرعی ۱۳

۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۳

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی ۱۳

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱ افسردگی ۱۶

۲-۱-۱ همه‌گیرشناسی اختلال افسردگی ۱۶

۲-۱-۲ مدل‌ها و درمان‌های شناختی-رفتاری اختلال افسردگی ۱۷

۲-۱-۲-۱ مدل شناختی-رفتاری بک ۱۷

۲-۱-۲-۲ نظریه ناامیدیِ افسردگی ۱۹

۲-۱-۲-۳ نظریه سبک‌های پاسخ ۱۹

۲-۱-۳ عوامل خطر و پیش‌آگهی ۲۰

۲-۱-۳-۱ عوامل خُلق و خویی ۲۰

۲-۱-۳-۲ عوامل محیطی ۲۱

۲-۱-۳-۳ عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیک ۲۱
۲-۱-۳-۴ تعدیل‌کننده‌های سیر اختلال افسردگی ۲۱
۲-۲ حساسیت بین فردی ۲۲
۲-۲-۱ ابعاد حساسیت بین فردی ۲۴
۲-۲-۱-۱ آگاهی بین‌فردی ۲۴
۲-۲-۱-۲ اضطراب جدایی ۲۴
۲-۲-۱-۳ کم‌رویی ۲۴
۲-۲-۱-۴ عزت‌نفس شکننده ۲۴
۲-۲-۱-۵ نیاز به تأیید ۲۵
۲-۲-۲ نظریات پیرامون حساسیت بین فردی ۲۵
۲-۲-۲-۱ حساسیت بین‌فردی در دیدگاه بایس و پارکر ۲۵
۲-۲-۲-۲ حساسیت بین‌فردی در دیدگاه داویدسون ۲۵
۲-۲-۲-۳ دیدگاه برنیری درباره حساسیت بین‌فردی ۲۶
۲-۲-۳ حساسیت بین‌فردی و آسیب‌پذیری نسبت به اختلالات روان‌شناختی ۲۶
۲-۳ طرحواره رهاشدگی ۲۷
۲-۳-۱ ابعاد طرحواره رهاشدگی ۲۸
۲-۳-۱-۱ ناپایداری رابطه ۲۸
۲-۳-۱-۲ تنهایی و بی‌ثباتی ۲۹
۲-۳-۱-۳ عدم امنیت ۲۹
۲-۳-۱-۴ طرد شدن ۳۰
۲-۳-۲ نظریات پیرامون طرحواره رهاشدگی ۳۰
۲-۳-۲-۱ نظریه طرحواره‌های ناسازگار اولیه ۳۱
۲-۳-۲-۲ نظریه دلبستگی ۳۱
۲-۳-۳ عوامل موثر بر طرحواره رهاشدگی ۳۲
۲-۳-۳-۱ تجارب دوران کودکی ۳۲
۲-۳-۳-۲ الگوهای دلبستگی ناایمن ۳۲

۲-۳-۳-۳ مؤلفه‌های شخصیتی ۳۲
۲-۳-۳-۴ نگرش‌ها و باورهای منفی ۳۳
۲-۳-۳-۵ عوامل اجتماعی و فرهنگی ۳۳
۲-۳-۴ اهمیت طرحواره رهاشدگی ۳۳
۲-۴ شرم ۳۴
۲-۴-۱ انواع شرم ۳۵
۲-۴-۲ تفاوت شرم با گناه ۳۵
۲-۴-۳ نظریات پیرامون شرم ۳۶
۲-۴-۳-۱ دیدگاه روانکاوری ۳۶
۲-۴-۳-۲ نظریه طرحواره های هیجانی ۳۷
۲-۴-۳-۳ دیدگاه وجودی ۳۹
۲-۴-۴ عوامل خانوادگی موثر بر شکل گیری احساس شرمساری ۳۹
۲-۴-۵ کارکرد شرم در اجتماع ۴۰
۲-۵ خودانتقادی ۴۱
۲-۵-۱ انواع خودانتقادی ۴۲
۲-۵-۲ نظریات پیرامون خودانتقادی ۴۲
۲-۵-۲-۱ دیدگاه بلات ۴۲
۲-۵-۲-۲ دیدگاه عملکرد اجرایی خودتنظیمی ۴۳
۲-۵-۲-۳ دیدگاه طرحواره های هیجانی ۴۴
۲-۵-۳ پیامدهای خودانتقادی ۴۵
۲-۵-۳-۱ مشکلات روان‌شناختی ناشی از خودانتقادی ۴۵
۲-۵-۳-۲ مشکلات فردی ناشی از خودانتقادی ۴۵
۲-۵-۴ نقش خانواده در خودانتقادی ۴۶
۲-۶ پیشینه پژوهش ۴۶
۲-۶-۱ پیشینه داخلی پژوهش ۴۶
۲-۶-۲ پیشینه خارجی پژوهش ۵۲

۲-۷ جمع بندی ۵۸

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ طرح پژوهش ۶۱
۳-۲ جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری ۶۱
۳-۳ ابزار گردآوری داده ها ۶۲
۳-۳-۱ پرسشنامه سطوح خودانتقادی (LOSC) ۶۲
۳-۳-۲ پرسشنامه احساس شرم (ESS) ۶۳
۳-۳-۳ پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II) ۶۳
۳-۳-۴ پرسشنامه حساسیت بین فردی (IPSM) ۶۴
۳-۳-۵ پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه–فرم کوتاه (YSQ-S3) ۶۵
۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۶۶
۳-۵ ملاحظات اخلاقی ۶۶

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱ ویژگی‌های جمعیت شناختی ۶۸
۴-۲ توصیف متغیرهای پژوهش ۷۰
۴-۳ مفروضه‌های تحلیل ۷۱
۴-۳-۱- نرمال بودن تک متغیری ۷۱
۴-۳-۲- همخطی بودن ۷۳
۴-۳-۳- نرمال بودن توزیع چند متغیری و بررسی داده‌های پرت ۷۳
۴-۳-۴- همگنی واریانس‌ها ۷۴
۴-۴ آزمون فرضیه‌های پژوهش ۷۷
۴-۴-۱- مدل ساختاری ۷۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ بحث در نتایج ۸۳
۵-۱-۱- فرضیه اصلی ۸۳
۵-۱-۲- فرضیه فرعی اول ۸۵

۵-۱-۳- فرضیه فرعی دوم ۸۷
۵-۱-۴- فرضیه فرعی سوم ۸۹
۵-۱-۵- فرضیه فرعی چهارم ۹۰
۵-۱-۶- فرضیه فرعی پنجم ۹۲
۵-۱-۷- فرضیه فرعی ششم ۹۳
۵-۱-۸- فرضیه فرعی هفتم ۹۴
۵-۱-۹- فرضیه فرعی هشتم ۹۶
۵-۲ نتیجه گیری ۹۷
۵-۳ محدودیت‌های پژوهش ۹۸
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی ۹۹
۵-۵ پیشنهادهای پژوهشی ۱۰۰
منابع ۱۰۲
منابع فارسی ۱۰۳
منابع لاتین ۱۰۶
پیوست ها ۱۱۵
پرسشنامه پژوهش ۱۱۶

فهرست جدول‌ها

عنوان **صفحه**

جدول ۴-۱- توصیف وضعیت تاهل شرکت‌کنندگان پژوهش..... ۶۸
جدول ۴-۲- توصیف سطح تحصیلات شرکت‌کنندگان پژوهش ۶۸
جدول ۴-۳- توصیف وضعیت اشتغال شرکت‌کنندگان پژوهش ۶۹
جدول ۴-۴- توصیف مدت زمان رواندرمانی شرکت‌کنندگان پژوهش ۶۹
جدول ۴-۵- شاخص‌های توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش ۷۰
جدول ۴-۶- کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش ۷۲
جدول ۴-۷- عامل تورم واریانس و ضریب تحمل متغیرهای پیش‌بین ۷۳
جدول ۴-۸- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۷۵
جدول ۴-۹- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری ۷۸
جدول۴-۱۰- ضرایب مسیر کل و مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری ۷۸

فهرست شکل‌ها

عنوان **صفحه**

شکل ۲-۱: مدل شناختی بک از افسردگی (بک، ۱۹۹۱) ۱۸

شکل ۴-۱- نمودار هیستوگرام توزیع مقادیر فاصله مهلنوبایس ۷۴

شکل ۴-۲- نمودار پراکندگی واریانس استاندارد شده خطا ۷۴

شکل ۴-۳- پارامترهای استاندارد در مدل ساختاری پژوهش ۸۱

شکل ۴-۴- پارامترهای غیر استاندارد در مدل ساختاری پژوهش ۸۱

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه

در دهه‌های اخیر افسردگی[1] به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های سلامت روان در زنان شناخته شده است و در بسیاری از کشورها، الگوی بار بیماری‌ها نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری زنان در برابر اختلالات خلقی، به‌ویژه در سال‌های باروری و میانسالی، به‌طور معناداری بیش از مردان است (بوخان[2] و همکاران، ۲۰۲۴). پژوهش‌ها حاکی از آن‌اند که عوامل زیستی (نظیر تغییرات هورمونی)، اجتماعی (مانند نقش‌های چندگانه خانوادگی–شغلی، فشارهای جنسیتی و تبعیض) و روان‌شناختی (نظیر الگوهای اسنادی منفی، انتظارات خودآسیب‌گر و حساسیت زیاد به طرد اجتماعی) در تبیین این تفاوت جنسیتی در افسردگی نقش هم‌افزا دارند (کرمانی[3]، ۲۰۲۶؛ راجو[4]، ۲۰۲۵؛ عزیز[5]، ۲۰۲۳). داده‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهند که در زنان، تجربه و تداوم افسردگی غالباً با الگوهای پایدار روابط بین‌فردی، شیوه‌های خودارزیابی و طرحواره[6]های عمیق هیجانی–شناختی گره خورده است، به‌گونه‌ای که صرفاً توجه به علائم سطحی بدون درک ساختارهای زیرین شخصیت و روابط، به مداخلات کوتاه‌مدت و کم‌اثر منجر می‌شود (لیو[7] و همکاران، ۲۰۲۴؛ مکلافلین[8] و همکاران، ۲۰۲۰).

در این میان، حساسیت بین‌فردی[9] به‌عنوان یکی از ابعاد مهم آسیب‌پذیری روان‌شناختی، در سال‌های اخیر توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است. مطالعات تازه نشان داده‌اند افرادی که به‌طور افراطی نگران ارزیابی دیگران هستند، نشانه‌های طرد یا انتقاد را سریع‌تر و اغلب به‌صورت تهدید تفسیر می‌کنند و این الگوی پردازش اطلاعات اجتماعی، آنان را مستعد واکنش‌های هیجانی منفی و خلق افسرده می‌سازد (پولسکایا[10] و همکاران، ۲۰۲۵؛ ژانگ و سان[11]، ۲۰۲۳). در زنان، حساسیت بین‌فردی بالا معمولاً با سبک‌های وابستگی ناایمن، ترس از ارزیابی منفی و گرایش به اجتناب از تعارض در روابط نزدیک همراه است (کالوتی[12] و همکاران، ۲۰۲۲؛ ورنر[13] و همکاران، ۲۰۲۱). این افراد غالباً برای حفظ پذیرش اجتماعی، نیازها و هیجان‌های خود را سرکوب می‌کنند و در نتیجه، احساس مزمن نادیده‌گرفته‌شدن، ناکافی‌بودن و طردشدن را تجربه می‌نمایند؛ احساسی که می‌تواند به‌مرور به درماندگی، ناامیدی و نشانه‌های افسردگی منجر شود (گیووازولیاس[14]، ۲۰۲۳).

---

[1] Depression
[2] Bokhan
[3] Kirmani
[4] Raghu
[5] Azeez
[6] Schema
[7] Liu
[8] McLaughlin
[9] Interpersonal Sensitivity
[10] Polskaya
[11] Zhang & Sun
[12] Calvete
[13] Werner
[14] Giovazolias

در سطح عمیق‌تر شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه[1] به‌ویژه در حوزه بریدگی و طرد[2] نقش کلیدی در شکل‌دهی به تفسیرهای فرد از خود و دیگران دارند. نتایج پژوهش‌های جدید در حوزه طرحواره‌درمانی نشان می‌دهد که طرحواره رهاشـــدگی/بی‌ثباتی، یکی از پایدارترین و ناتوان‌کننده‌ترین طرحواره‌ها در زنان دارای اختلالات خلقی اســـت (نیر[3] و همکاران، ۲۰۲۲). این طرحواره با انتظاری فراگیر مبنی بر این‌که دیگران در لحظه نیاز، فرد را ترک خواهند کرد یا در حمایت عاطفی پایدار نخواهند بود، مشـــخص می‌شـــود. چنین انتظاری موجب می‌گردد فرد رویدادهای مبهم بین‌فردی را به‌صورت نشانه‌ای از رهاشدن تعبیر کند؛ در نتیجه کوچک‌ترین فاصله، تغییر خلق یا بی‌توجهی موقت از سوی دیگران، به فعال شدن شدید هیجان‌هایی مانند غم، اضطراب، خشم فروخورده و شرم منجر می‌شود (یانگ[4] و همکاران، ۲۰۱۹). مطالعات طولی نشان داده‌اند که طرحواره رهاشدگی نه تنها با بروز افسردگی، بلکه با مزمن‌شدن و عود دوره‌های افسردگی نیز ارتباط دارد، زیرا در هر بحران بین‌فردی مجدداً فعال شده و چرخه افکار و هیجان‌های منفی را تشدید می‌کند (کریستون[5] و همکاران، ۲۰۲۳).

یکی از سازه‌های هیجانی-شناختی که در سال‌های اخیر به‌طور برجسته در پیوند با طرحواره‌های طرد و حساسیت بین‌فردی مطرح شده، شرم[6] است. پژوهش‌های معاصر بین‌فرهنگی نشان می‌دهند که شرم چه به صورت شـرم درونی (احسـاس عمیق نقص، حقارت و نامطلوب‌بودن خود) و چه به صـورت شـرم بیرونی (باور به این‌که دیگران فرد را ناقص و تحقیرشدنی می‌بینند) با افزایش خطر افسردگی در زنان همراه است (دیویس[7] و همکاران، ۲۰۲۳). در بافت فرهنگ‌هایی که در آن‌ها تأکید زیادی بر آبرو، حفظ ظاهر و رعایت انتظارات اجتماعی وجود دارد، شرم می‌تواند شدیدتر و پایدارتر تجربه شود و به صورت احساس مداوم بدبودن خود در سطح هویتی درآید (کیم[8] و همکاران، ۲۰۲۲). شواهد حاکی از آن است که شرم، حلقه واسطی میان تجربه‌های اولیه طرد، طرحواره‌های نقص شـرم و رهاشـدگی و بروز افسـردگی اسـت؛ بدین معنا که افراد، رویدادهای بین‌فردی را در پرتو این طرحواره‌ها به‌گونه‌ای تفسیر می‌کنند که شـرم‌انگیز بودن خود را تأیید کند و همین فرآیندِ خودارزیابی منفی، به خلق افسـرده و کناره‌گیری اجتماعی دامن می‌زند (متوس[9] و همکاران، ۲۰۲۲).

در کنار شرم، خودانتقادی[10] به‌عنوان یک سبک پایدار خودارزیابی، در مدل‌های معاصر آسیب‌پذیری نسبت به افسردگی جایگاه ویژه‌ای یافته است. پژوهش‌های فراوان نشان داده‌اند که خودانتقادی به شکل معیارهای افراطی،

[1] Early maladaptive schemas
[2] The area of cut and exclusion
[3] Nair
[4] Young
[5] Kriston
[6] Shame
[7] Davis
[8] Kim
[9] Matos
[10] Self-criticism

سـرزنش شـدید خود در مواجهه با اشـتباه، و ناتوانی در پذیرش جنبه‌های مثبت خود با شـدت و تداوم افسـردگی ارتباطی قوی دارد (زروف[1] و همکاران، ۲۰۱۶؛ گیلبرت[2] و همکاران، ۲۰۱۹؛ وارنر-سـیدلر[3] و همکاران، ۲۰۲۰). در زنان، این ویژگی اغلب در پی ترکیب انتظارات چندگانه (نقش‌های خانوادگی، شغلی و اجتماعی) و فشار برای کامل بودن شکل می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که هر نقص یا ناکامی نسبی، به‌صورت شکست کلی و نشانه‌ای از بی‌ارزشی کلی خود تجربه می‌شود (لویتن[4] و همکاران، ۲۰۲۰). مطالعات جدید نشان می‌دهند که خودانتقادی نه فقط یک پیامد افسردگی، بلکه عاملی پیش‌برنده و حفظ‌کننده آن اسـت؛ زیرا افراد خودانتقادگر، هنگام مواجهه با رویدادهای اسـترس‌زای بین‌فردی، به‌جای استفاده از راهبردهای مقابله‌ای سازگارانه، خود را مقصر اصلی دانسته و از حمایت اجتماعی فاصله می‌گیرند، امری که به افزایش تنهایی، شرم و افکار خودآسیب‌گر منجر می‌شود (دانکلی[5] و همکاران، ۲۰۲۱؛ کاکس[6] و همکاران، ۲۰۲۲).

مطابق با ادبیات پژوهشـی اخیر، می‌توان چنین اسـتنباط کرد که افرادی که از همان سـال‌های اولیه زندگی با پیوندهای ناایمن، بی‌ثباتی عاطفی والدین، یا تجربه‌های طرد و بی‌اعتنایی مواجه بوده‌اند، به احتمال بیشـتری طرحواره رهاشـدگی و احسـاس نقص-شرم را در خود درونی می‌کنند. در بزرگسـالی، این طرحواره‌ها در بافت روابط صـمیمی و اجتماعی فعال شـده و حسـاسـیت بین‌فردی، ترس از ارزیابی منفی و تفسـیر تهدیدآمیز از رفتار دیگران را تقویت می‌کند. در چنین زمینه‌ای، فرد در مواجهه با کوچک‌ترین نشـانه‌های فاصـله یا انتقاد، نه تنها احسـاس شـرم شـدیدی را تجربه می‌کند، بلکه با خودگویی‌های خودانتقادگرانه، این تجربه را به عنوان شـاهدی بر بی‌ارزشـی بنیادین خود تعبیر می‌کند. این ترکیبِ شـرم و خودانتقادی، زمینه‌سـاز تداوم خلق افسـرده، خسـتگی عاطفی، کناره‌گیری از روابط حمایتی و نهایتاً، تشدید نشانه‌های افسردگی می‌شود (گیلبرت و آیرونز[7]، ۲۰۲۲، کامینگز[8] و همکاران، ۲۰۲۲). با توجه به این شـواهد، بررسـی نقش میانجی خودانتقادی و شـرمسـاری در رابطه بین حسـاسـیت بین‌فردی و طرحواره رهاشـدگی با شـدت افسـردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک، از دو منظر اهمیت دارد: نخسـت، از منظر نظری، می‌تواند به تبیین دقیق‌تر مسـیرهای شـناختی-هیجانی منتهی به افسـردگی در زنان و روشـن‌تر شـدن جایگاه فرایندهای شـرم‌محور و خودانتقادگرانه در چارچوب طرحواره‌های ناسـازگار اولیه کمک کند. دوم، از منظر بالینی، شـناسـایی این نقش میانجی می‌تواند راهنمای طراحی مداخلات هدفمندتری باشد که علاوه بر کاهش علائم افسردگی، به اصلاح خودانتقادی‌های مزمن، کاهش شـرم سـمی و تعدیل طرحواره‌های رهاشـدگی و حسـاسـیت بین‌فردی در زنان بپردازند؛ مداخلاتی که

[1] Zuroff
[2] Gilbert
[3] Werner-Seidler
[4] Luyten
[5] Dunkley
[6] Cox
[7] Gilbert & Irons
[8] Cummings

به‌ویژه در بافت درمان‌های مبتنی بر شفقت، طرحواره‌درمانی و رویکردهای یکپارچه‌نگر، جایگاه برجسته‌ای دارند. بر این اساس، پژوهش حاضر می‌کوشد با تمرکز بر زنان مراجعه‌کننده به کلینیک، آزمون تجربی این مدل میانجی‌گری را در بافت فرهنگی ایران فراهم آورد و به این سوال پاسخ دهد که آیا خودانتقادی و شرمساری در رابطه بین حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی در زنان مراجعه کننده به کلینیک نقش میانجی معناداری دارند؟

۱-۲ بیان مسئله

افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلال‌های روان‌شناختی است که تقریباً ۱۲۱ میلیون نفر در سراسر جهان به آن دچار هستند (هادسون[1]، ۲۰۱۹؛ تاپر[2] و همکاران، ۲۰۲۲). تا سال ۲۰۱۰، این اختلال دومین مشکل سلامت روانی در سطح جهانی محسوب می‌شد، در حالی که در سال ۱۹۹۰ در رتبه چهارم قرار داشت (کامپتون و بالر[3]، ۲۰۱۶). بر اساس داده‌های آماری موجود، شیوع این اختلال عمدتاً حدود ۷ درصد گزارش شده است که در زنان سه برابر مردان است (دبرک و گلوواکا[4]، ۲۰۲۳). افسردگی به‌ویژه در زنان بیشترین فراوانی را دارد و مطالعات نشان می‌دهند که زنان نسبت به مردان گرایش بیشتری به تجربه اضطراب، افسردگی و شکایت‌های جسمانی همراه با این وضعیت دارند (ویگو[5] و همکاران، ۲۰۱۶). افسردگی خفیف[6] نیز در زنان نسبت به مردان شایع‌تر است و خود را به شکل‌های متنوعی از جمله مراجعه‌های مکرر به پزشکان و روش‌های تربیتی ناکارآمد در مواجهه با فرزندان نشان می‌دهد (ارجتا[7] و همکاران، ۲۰۲۲). افسردگی به‌عنوان یکی از رایج‌ترین اختلال‌های روانی شناخته می‌شود (تاپر و همکاران، ۲۰۲۲) و طبق ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی[8] (۲۰۱۳)، این اختلال با شناخت، تغییرات آشکار در عاطفه و عملکردهای عصبی-زیستی که طی یک دوره دو هفته‌ای بروز می‌کند، مشخص می‌شود و دارای بیشترین شیوع طول عمر در میان اختلال‌های روان‌پزشکی (۱۷ درصد) است. افسردگی جنبه‌های گوناگون زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و علائم آن عملکرد در حوزه‌های انگیزشی، هیجانی، شناختی، رفتاری و زیستی را مختل می‌کند (گودفرین ون هرینگن[9]، ۲۰۱۰). از نظر پیامدهای هیجانی، اجتماعی و اقتصادی، این اختلال اثرات قابل توجهی بر بیماران، خانواده و جامعه دارد و شیوع سالانه آن بین ۹/۲ تا ۶/۱۲ درصد در جمعیت عمومی گزارش شده است (هسین[10] و همکاران، ۲۰۰۵). به همین دلیل، افسردگی یکی از موضوعات اصلی در حوزه سلامت روان

[1] Hudson
[2] Thapar
[3] Compton & Baler
[4] Dobrek & Głowacka
[5] Vigo
[6] Mild Depression
[7] Orgeta
[8] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-V)
[9] Godfrin & Van Heeringen
[10] Hasin

محسوب می‌شود. افسردگی همچنین به‌عنوان یکی از چهار عامل اصلی در بروز بیماری‌های جسمانی و دیگر اختلال‌های روانی شناخته شده است (نمرف[1]، ۲۰۰۷) و زمینه را برای ظهور اختلالات دیگر از جمله حساسیت های بین فردی[2] فراهم می‌آورد (ژو[3] و همکاران، ۲۰۲۲؛ ژانگ و سان، ۲۰۲۳؛ لیو و همکاران، ۲۰۲۴).

همانگونه که بیان شد، یکی از عوامل مؤثر بر سلامت روان زنان، حساسیت بین فردی است (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۹). بویس و پارکر[4] (۱۹۸۹) معتقدند حساسیت بین فردی، شامل هوشیاری غیرضروری بیش از حد و حساسیت نسبت به رفتار و احساسات دیگران است که می‌تواند به تعاملات اجتماعی، توجه مفرط به واکنش‌های دیگران، نگرانی بیش از اندازه درباره افکار و رفتار دیگران و ترس از انتقاد واقعی منجر شود (حمیدی و همکاران، ۲۰۲۰). حساسیت بین فردی به دقت در ادراکات، قضاوت‌ها و پاسخ‌هایی که افراد نسبت به یکدیگر نشان می‌دهند اشاره دارد و به عبارتی دیگر توانایی فرد در ارزیابی حالات هیجانی و ویژگی‌های دیگران از طریق محرک‌های غیرکلامی است. این ویژگی به عنوان یک صفت منفی نیز تلقی شده و به معنای آگاهی و حساسیت بیش از حد نسبت به رفتار و احساسات دیگران تعریف می‌شود. حساسیت بین فردی از طریق احساس ناتوانی و سوءتعبیر مکرر رفتارهای میان‌فردی در دیگران مشخص می‌شود (پولسکایا و همکاران، ۲۰۲۵). این ویژگی ممکن است با احساس ناراحتی، رفتارهای اجتنابی، عزت نفس پایین و ترس از مواجهه در روابط بین فردی همراه باشد. نتایج پژوهش‌ها نشان داده‌اند افرادی که حساسیت بین فردی بالایی دارند، نسبت به افراد با حساسیت پایین، بیشتر از راهبردهای ناکارآمد شناختی هیجان مانند فاجعه‌سازی، سرزنش خود و دیگران استفاده می‌کنند (هالاموا[5] و همکاران، ۲۰۱۹). همچنین احمدی و همکاران (۲۰۲۰) دریافتند حساسیت بین فردی بالا با روان‌رنجوری، عزت نفس پایین، ناهماهنگی اجتماعی و شروع یا عود افسردگی مرتبط است. احمدآبادی و همکاران (۱۴۰۳) نیز نشان دادند که ترس از ارزیابی منفی، اضطراب اجتماعی و خودانتقادگری در دانشجویان همبستگی معناداری با حساسیت بین فردی دارد. مطالعات صادقی و همکاران (۲۰۲۴) نشان دادند که خودکنترلی پایین و حساسیت بین فردی بالا با افزایش نوسانات خلقی همراه است. به طور کلی، حساسیت بین فردی نشان‌دهنده احساس عدم کفایت شخصی است که همراه با تفسیرهای نادرست و مکرر از رفتار دیگران بروز می‌کند و می‌تواند با احساس ناراحتی در حضور دیگران و به عنوان اجتناب بین فردی و رفتارهای غیرفعال دیده شود (کورکی و همکاران، ۱۴۰۲). افراد با حساسیت بین فردی بالا تمایل دارند رفتار خود را مطابق با انتظارات دیگران تغییر دهند تا خطر انتقاد را به حداقل برسانند (حیاتی و همکاران، ۱۴۰۲). همچنین حساسیت بین فردی با علائم افسردگی، اعتماد به نفس پایین اجتماعی و عملکرد تحصیلی ضعیف همراه

[1] Nemeroff
[2] Interpersonal Sensitivity
[3] Xu
[4] Boyce and Parker
[5] Halamová

است (ارشدی، ۱۴۰۱). مطالعات همچنین نشان‌دادند که بین اختلالات اجتماعی و طرحواره ناسازگار اولیه[1]، مانند طرحواره‌های حوزه بریدگی و طرد[2]، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این طرحواره می‌تواند اختلالات اجتماعی را پیش‌بینی کند (پاک‌مهر و متولی‌زاده، ۲۰۲۴).

طرحواره‌های ناسازگار اولیه، شامل الگوهای هیجانی، شناختی و عاطفی فرد هستند که در مراحل ابتدایی زندگی شکل می‌گیرند، در ذهن تثبیت می‌شوند و در مسیر زندگی مکرراً ظاهر می‌گردند (رایان[3] و همکاران، ۲۰۲۰). این طرحواره‌ها ساختارهایی هستند که بر اساس تجربیات و واقعیت‌های فرد شکل می‌گیرند و به عنوان واسطه‌ای رفتارهای شخص را تحت تأثیر قرار می‌دهند (ویرا[4] و همکاران، ۲۰۲۳). این الگوها به دلیل عدم تأمین نیازهای هیجانی و اولیه در دوران کودکی ایجاد می‌شوند. نیازهای اساسی شامل داشتن دلبستگی ایمن به دیگران، خودتنظیمی، آزادی در ارضای نیازها و هیجانات سالم، خودانگیختگی و محدودیت‌های سنجیده هستند (بار[5] و همکاران، ۲۰۲۳). زمانی که این طرحواره‌ها شکل می‌گیرند، می‌توانند بر قدرت درک واقعیت و پردازش شناختی فرد اثرگذار باشند (بهاری و همکاران، ۲۰۲۳). طرحواره‌ها از ساختارهایی تشکیل شده‌اند که بر اساس تجربه واقعی فرد شکل می‌گیرند و پاسخ‌های رفتاری او را تحت تأثیر قرار می‌دهند. همچنین باورهایی درباره خود، دیگران و محیط ایجاد می‌کنند (فاسبندر و آرنتز[6]، ۲۰۲۱). این طرحواره‌ها بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی افراد را شکل می‌دهند، به ویژه آنهایی که در نتیجه تجارب منفی دوران کودکی شکل گرفته‌اند و می‌توانند هسته اصلی مشکلات شناختی و شخصیتی را ایجاد کنند (باشر[7] و همکاران، ۲۰۲۲). همانطو که بیان شد، یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری طرحواره‌های ناسازگار اولیه، برآورده نشدن نیازهای هیجانی و عاطفی اساسی دوران کودکی است؛ از جمله دلبستگی ایمن به دیگران، خودگردانی/کفایت و هویت، آزادی در بیان نیازها و هیجانات سالم، خودانگیختگی و تجربه محدودیت‌های واقعی، که فرد در زندگی بعدی مجبور به تحمل آن‌ها می‌شود (اکسی[8] و همکاران، ۲۰۲۰؛ جلیلین و همکاران، ۲۰۲۳).

یکی از حوزه‌های طرحواره‌های ناسازگار اولیه، طرد و بریدگی است که شامل پنج طرحواره محرومیت هیجانی[9]، نقص و شرم[10]، انزوا اجتماعی[11] (بیگانگی)، رهاشدگی/بی‌ثباتی[12] و بی‌اعتمادی/بدرفتاری[13] می‌باشد

[1] Early Maladaptive Schemas
[2] Disconnection and Rejection
[3] Ryan
[4] Vieira
[5] Bär
[6] Fassbinder & Arntz
[7] Baser
[8] Eksi
[9] Emotional Deprivation
[10] Defectiveness / Shame
[11] Social Isolation / Alienation
[12] Abandonment / Instability
[13] Mistrust / Abuse

(کیدو[1] و همکاران، ۲۰۲۲). افرادی که طرحواره‌های آنان در این حوزه قرار دارد، نمی‌توانند دلبستگی ایمن و رضایت‌بخش با دیگران تجربه کنند. این افراد معتقدند که نیاز آن‌ها به ثبات، امنیت، محبت، عشق و تعلق برآورده نشده است و در بزرگسالی تمایل دارند از روابط آسیب‌رسان فاصله بگیرند یا از برقراری روابط نزدیک اجتناب کنند (بهاری و همکاران، ۲۰۲۳). پژوهش‌ها نشان دادند که طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک دلبستگی با مهارت‌های بین فردی و اجتماعی در دانشجویان رابطه معناداری دارد (مقدم نیا و برکت، ۱۴۰۲). همچنین اعظمی (۱۴۰۱) در مطالعه‌ای مشخص کرد که روابط بین فردی با تعدیل طرحواره ناسازگار اولیه و آموزش مهارت جرأت‌ورزی افزایش می‌یابد. جانوفسکی[2] و همکاران (۲۰۲۳) گزارش دادند افرادی که طرحواره‌های ناسازگار دارند، در موقعیت‌هایی که احساس طرد شدن می‌کنند، ناراحتی و افکار منفی بیشتری تجربه می‌کنند.

یکی از متغیرهایی که می‌تولند در رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و بروز افسردگی نقش ایفا کند، احساس شرم[3] است (تیم و چانگ[4]، ۲۰۲۲). شرم را می‌توان به عنوان یک حس خودارزیابی تعریف کرد که از طریق ارزیابی‌های منفی یا آشکار شدن کاستی‌ها و نواقص فرد درک می‌شود (سولینز[5] و همکاران، ۲۰۲۳). این پدیده به دو شکل بروز می‌یابد: درونی، که شامل تمرکز بر قضاوت منفی نسبت به خود، احساس ناتوانی و حقارت است (شرم درونی)؛ و بیرونی، که به ادراک ارزیابی‌های منفی دیگران نسبت به فرد اشاره دارد (شرم بیرونی) (امت[6] و همکاران، ۲۰۲۳). گاهی در مطالعات به جای شرم از واژه احساس گناه[7] استفاده می‌شود. با این حال، شرم یک حس منفی، پایدار و کلی در ارتباط با خود است، در حالی که گناه بر رفتار خاصی که فرد انجام داده، متمرکز می‌شود (بوچنر[8] و همکاران، ۲۰۲۲). هنگامی که افراد احساس گناه می‌کنند، تمایل دارند که خسارت یا آسیبی را که ایجاد شده جبران نمایند، اما تجربه شرم موجب می‌شود که فرد نسبت به خود احساس بسیار بدی داشته باشد و بخواهد پنهان یا ناپدید شود. اگرچه گناه حس ناخوشایندی است، شرم ممکن است توانمندی فرد را برای اقدام محدود کند. شرم یکی از مؤلفه‌های کلیدی در طیف مشکلات روانی است، به‌طوری که خودانتقادگری[9] بالا در تجربه شرم می‌تواند زمینه‌ساز عود اختلالات روانی همانند افسردگی باشد (بر[10]، ۲۰۲۲).

عوامل متعددی می‌توانند در شکل‌گیری اختلالات افسردگی نقش داشته باشند؛ به‌طوری‌که هم متغیرهای درون‌فردی و هم شرایط محیطی در بروز آن اثرگذار هستند. یکی از الگوهایی که پژوهشگران برای تبیین افسردگی

---

[1] Cudo
[2] Janowski
[3] Shame
[4] Thimm & Chang
[5] Sullins
[6] Ümmet
[7] Feelings of Guilt
[8] Buchner
[9] Self-Criticism
[10] Barr

مورد توجه قرار داده‌اند، مدل آسیب‌پذیری شخصیتی[1] است. مطابق این دیدگاه، سه ویژگی شخصیتی شامل وابستگی[2]، خودانتقادی و کارآمدی[3]، افراد را مستعد ابتلا به افسردگی می‌کند. در میان این مؤلفه‌ها، خودانتقادی بیش از سایر متغیرها نقش پیش‌بینی‌کننده‌ای در شدت افسردگی دارد (رز[4] و همکاران، ۲۰۱۸؛ مهدوی راد[5] و همکاران، ۲۰۲۳). خودانتقادی یکی از عناصر اساسی و تعیین‌کننده در شکل‌گیری مشکلات و چالش‌های زندگی افراد به شمار می‌رود. این ویژگی می‌تواند سبب شود فرد عملکرد خود را ناکافی ارزیابی کند و معیارهایی غیرقابل دستیابی برای خود تعیین نماید؛ فرایندی که در نهایت به کناره‌گیری اجتماعی و کاهش تعامل با دیگران منجر می‌شود (واکلین[6] و همکاران، ۲۰۲۲). خودانتقادی شامل خودسرزنشگری، احساس فاصله گرفتن از استانداردهای شخصی و اجتماعی و تمرکز افراطی بر پیشرفت است (شری و همکاران، ۲۰۱۶؛ ردی[7]، ۲۰۲۳). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که این سازه با بسیاری از شاخص‌های آسیب‌شناسی روانی همبستگی مثبت دارد. در هر دو رویکرد شناختی و تحلیلی، خودانتقادی به‌عنوان یک عامل آسیب‌پذیرکننده اولیه برای افسردگی در نظر گرفته می‌شود. افراد دارای خودانتقادی بالا، اغلب مشکلات برون‌سازی‌شده‌ای مانند قانون‌شکنی و رفتارهای پرخاشگرانه نشان می‌دهند که به‌وضوح برای اطرافیان قابل مشاهده است (گرهاردت[8] و همکاران، ۲۰۲۴).

افرادی که سطوح بالایی از خودانتقادی را تجربه می‌کنند، بیش از دیگران در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد میان خودانتقادی و نشانه‌های افسردگی رابطه معناداری وجود دارد. به باور تامسون و زاروف[9] (۲۰۰۴) دو نوع خودانتقادی در افراد دیده می‌شود: خودانتقادی مقایسه‌ای[10] که در اثر مقایسه خود با دیگرانی که برتر تلقی می‌شوند شکل می‌گیرد و خودانتقادی درونی[11] که ناشی از مقایسه خود با انتظارات درونی بسیار بالا و دست‌نیافتنی است. وجود هر یک از این دو نوع می‌تواند موجب ارزیابی نادرست فرد از عملکرد خویش شود (لانکوآ[12] و همکاران، ۲۰۱۵). در بررسی ارتباط میان خودانتقادی و افسردگی، توجه به ویژگی‌های افراد خودانتقادگر اهمیت دارد. این افراد به دلیل داشتن آرمان‌های درونی و بیرونی بسیار بالا، تلاش‌های خود را ناکافی و کم‌ارزش تلقی می‌کنند و در نتیجه وارد چرخه معیوب شکست-انتظار می‌شوند؛ چرخه‌ای که پیامد آن ناامیدی و بروز افسردگی است (تیبوباس[13] و همکاران، ۲۰۲۳). خودانتقادی بر متغیرهایی مانند حمایت اجتماعی، رویدادهای

[1] Personality Vulnerability Model
[2] Dependency
[3] Efficacy
[4] Rose
[5] Mahdavi Rad
[6] Wakelin
[7] Reddy
[8] Gerhardt
[9] Thompson & Zuroff
[10] Comparative Self-Criticism
[11] Internalized Self-Criticism
[12] Iancua
[13] Tibubos

مثبت و منفی زندگی و میزان رضـــایت از روابط نزدیک تأثیر می‌گذارد و به نوبه خود شـــرایطی را برای افزایش نشانه‌های افسردگی فراهم می‌سازد. افراد خودانتقادگر درگیر خودارزیابی نادرست هستند و نسبت به تجربه شکست و دریافت انتقاد، آســیب‌پذیری بالایی دارند (گائو[1] و همکاران، ۲۰۲۳). این افراد اقدامات خود را معادل شـــکســـت می‌دانند، تنها اسـتانداردهای بسـیار بالا و دسـت‌نیافتنی را می‌پذیرند و همین امر باعث کناره‌گیری آنان از شـبکه‌های اجتماعی و افزایش حســـاســـیت بین فردی می‌شـــود (اطهری[2] و همکاران، ۲۰۲۴). افزون بر این، افراد خودانتقادگر معمولاً قادر به پذیرش تحسین دیگران نیستند و از آن لذت نمی‌برند؛ در مقابل، دستاوردهای درمانی خود را ناچیز و کم‌اهمیت ارزیابی می‌کنند. به دلیل مقاومت این افراد در برابر درمان‌های رایج، تمرکز ویژه بر کاهش خودانتقادی در مداخلات درمانی ضروری به نظر می‌رسد (فارسی‌جانی و همکاران، ۱۴۰۰).

با توجه به مطالبی که بیان‌شـد، بنظر می‌رسـد خودانتقادگری و شـرمسـاری به‌عنوان عوامل زمینه‌سـاز در بروز اختلال افســـردگی، علاوه بر اثرات مســـتقیمی که بر این اختلال دارند، می‌توانند موجب افزایش احســـاســـات منفی تجربه‌شـده ناشـی از حسـاسـیت بین‌فردی و طرحواره رهاشـدگی در زنان شـده و رابطه بین حسـاسـیت بین‌فردی و طرحواره رهاشـدگی با افسـردگی را در زنان میانجی‌گری کنند. از این رو پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سـوال اساسی خواهدبود که آیا خودانتقادی و شرمساری در رابطه بین حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی در زنان مراجعه کننده به کلینیک نقش میانجی معناداری دارند؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

افسردگی یکی از شایع‌ترین و ناتوان‌کننده‌ترین اختلالات روانی در جهان معاصر است و در میان زنان، شیوع بالاتری نسـبت به مردان دارد (شـوری[3] و همکاران، ۲۰۲۲). شـواهد متعدد نشـان داده‌اند که عوامل میان‌فردی و شـناختی در شـــکل‌گیری و تداوم افســـردگی نقش کلیدی دارند (اینگرام[4] و همکاران، ۲۰۱۵). از جمله این عوامل می‌توان به حسـاسـیت بین‌فردی (ژو و همکاران، ۲۰۲۲)، طرحواره‌های ناسـازگار اولیه (وانگ و همکاران، ۲۰۲۳)، خودانتقادی (مهدوی راد و همکاران، ۱۴۰۲) و شـــرمســـاری (اعتمادی[5] و همکاران، ۲۰۲۴) اشـــاره کرد که هر یک در تبیین سازوکارهای روان‌شناختی افسردگی سهم قابل توجهی دارند و بررسی تعامل میان آن‌ها می‌تواند درک عمیق‌تری از پویایی‌های درونی این اختلال فراهم آورد. حسـاسـیت بین‌فردی که به عنوان تمایل افراطی فرد برای درک و واکنش نسبت به نشانه‌های طرد یا عدم پذیرش از سوی دیگران تعریف می‌شود (وانگ و همکاران، ۲۰۲۵)، عاملی مهم در بروز آسیب‌پذیری نسبت به افسردگی محسوب می‌شود. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که افراد دارای حساسیت بین‌فردی

[1] Gao
[2] Athari
[3] Shorey
[4] Ingram
[5] Etemadi

بالا، در روابط اجتماعی خود دچار اضطراب، احساس تهدید و ترس از طرد می‌شوند و همین امر می‌تولند به احساس ناکافی بودن و در نهایت افسردگی بینجامد (هارب[1] و همکاران، ۲۰۱۹). از سوی دیگر، طرحواره‌های ناسازگار اولیه، به‌ویژه طرحواره رهاشدگی/بی‌ثباتی، به‌عنوان ساختارهای شناختی پایدار، در شکل‌گیری الگوهای تفکر منفی نسبت به خود و دیگران مؤثر هستند (یانگ[2] و همکاران، ۲۰۰۳؛ دازیوس و بک[3]، ۲۰۲۳). طرحواره رهاشدگی زمانی فعال می‌شود که فرد تجربه‌هایی از فقدان حمایت عاطفی یا بی‌ثباتی در روابط نزدیک داشته باشد و در نتیجه، در موقعیت‌های بعدی نیز انتظار طرد شدن و تنها ماندن را درونی کند (رنر[4] و همکاران، ۲۰۱۲).

با این حال، مسیر ارتباطی بین حساسیت بین‌فردی، طرحواره رهاشدگی و افسردگی، خطی و مستقیم نیست، بلکه از طریق متغیرهای میانجی همچون خودانتقادی و شرمساری عمل می‌کند. خودانتقادی، به معنای ارزیابی منفی مداوم از خویشتن و احساس ناکافی بودن در مقایسه با استانداردهای درونی یا دیگران است (تامسون و زاروف، ۲۰۰۴). این ویژگی شخصیتی به‌ویژه در زنان، که در بافت‌های فرهنگی تمایل بیشتری به ارزیابی خود بر اساس تأیید اجتماعی دارند، می‌تواند آسیب‌پذیری نسبت به افسردگی را تشدید کند (بلات[5] و زاروف، ۱۹۹۲). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که خودانتقادی نه تنها پیش‌بینی‌کننده‌ی قوی افسردگی است، بلکه در تداوم و عود آن نیز نقش دارد (دانکلی[6] و همکاران، ۲۰۱۲). از سوی دیگر، شرمساری به‌عنوان هیجانی اجتماعی و خودآگاه، زمانی تجربه می‌شود که فرد خود را در برابر معیارهای درونی یا اجتماعی نامناسب یا بی‌ارزش ببیند (گیلبرت[7]، ۲۰۱۴). احساس شرم با کناره‌گیری اجتماعی، خودسرزنشی و خودتنبیهی همراه است و به‌طور گسترده‌ای با افسردگی همبستگی دارد (کیم[8] و همکاران، ۲۰۲۱). تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که حساسیت بین‌فردی و طرحواره‌های ناسازگار، از طریق افزایش احساس شرم و خودانتقادی، می‌توانند به بروز افسردگی منجر شوند (تنگنی[9] و همکاران، ۲۰۱۴؛ کاندی[10] و همکاران، ۲۰۲۲).

بنابراین، بررسی نقش میانجی خودانتقادی و شرمساری در ارتباط بین حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی، می‌تواند به روشن شدن مسیرهای شناختی-هیجانی مؤثر بر آسیب‌پذیری روانی در زنان کمک کند. این مطالعه از نظر نظری، گامی در جهت یکپارچه‌سازی مدل‌های شناختی (نظیر مدل طرحواره‌های یانگ) و مدل‌های هیجانی-میان‌فردی (مانند نظریه شرم و حساسیت بین‌فردی) است. از نظر کاربردی نیز، نتایج آن

[1] Harb
[2] Young
[3] Dozois & Beck
[4] Renner
[5] Blatt
[6] Dunkley
[7] Gilbert
[8] Kim
[9] Tangney
[10] Cândea

می‌تولند در طراحی مداخلات درمانی هدفمند برای کاهش افســـردگی زنان، به‌ویژه از طریق تقویت پذیرش خود، کاهش خودانتقادی، و بازسازی طرحواره‌های ناسازگار اولیه، مورد استفاده قرار گیرد (گیلبرت و آیرون[1]، ۲۰۰۵). در جامعه ایران، که ساختار فرهنگی آن مبتنی بر روابط جمع‌گرایانه و تأکید بر ارزش‌های اجتماعی و نقش‌های جنسیتی است، احساس شرم و خودانتقادی می‌تواند به‌طور مضاعفی بر زنان اثر بگذارد (قربانی و همکاران، ۱۴۰۰). بنابراین، پژوهش حاضر علاوه بر غنای نظری، از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا می‌تواند به درک بهتر از تعامل میان عوامل شـــناختی، هیجانی و فرهنگی در بروز افســـردگی زنان ایرانی بینجامد و مبنایی علمی برای برنامه‌های پیشگیری و درمان در بافت‌های بومی فراهم آورد.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

بررسی چگونگی برازش مدل‌ساختاری برای پیش‌بینی شدت افسردگی بر اساس حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با میانجی‌گری خودانتقادی و شرمساری در زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد.

۱-۴-۲ اهداف فرعی

تعیین رابطه مستقیم حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد.

تعیین رابطه مستقیم طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد.

تعیین رابطه مستقیم خودانتقادی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد.

تعیین رابطه مستقیم شرمساری با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد.

تعیین رابطه غیرمستقیم حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد.

تعیین رابطه غیرمستقیم حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد.

تعیین رابطه غیرمستقیم طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد.

تعیین رابطه غیرمستقیم طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد.

[1] Irons

۱-۵ فرضیات پژوهش

۱-۵-۱ فرضیه اصلی

برای پیش‌بینی شدت افسردگی بر اساس حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با میانجی‌گری خودانتقادی و شرمساری در زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد می‌توان مدل ساختاری برازش کرد.

۱-۵-۲ فرضیات فرعی

حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری دارد.

طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری دارد.

خودانتقادی با شدت‌افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهرمشهد رابطه مستقیم معناداری‌دارد.

شرمساری با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری‌دارد.

حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

۱-۶ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۶-۱ تعاریف مفهومی

خودانتقادی: خودانتقادی شامل خودسرزنشگری، احساس فاصله گرفتن از استانداردهای شخصی و اجتماعی و تمرکز افراطی بر پیشرفت است (شری و همکاران، ۲۰۱۶).

شرمساری: پاسخی است که افراد نسبت به دیدگاه منفی مردم در برابر انجام رفتار اشتباه از خود بروز می‌دهند و موجب احساس خجالت در فرد می‌شود (یی و بامگارتنر، ۲۰۱۱).

حساسیت بین فردی: حساسیت بین فردی، به‌عنوان حساسیت عمومی نسبت به بازخورد اجتماعی، نگرانی افزایش یافته در ارتباط با دیگران، ترس از بی‌کفایتی شخصی و مورد انتقاد قرار گرفتن و سوءتعبیر مکرر رفتار بین فردی دیگران توصیف شده است (بویس و همکاران، ۱۹۹۳).

طرحواره رهاشدگی: افرادی که دارای طرحواره رهاشدگی هستند، نمی‌توانند دلبستگی ایمن و رضایت‌بخش با دیگران تجربه کنند. این افراد معتقدند که نیاز آن‌ها به ثبات، امنیت، محبت، عشق و تعلق برآورده نشده است و در بزرگسالی تمایل دارند از روابط آسیب‌رسان فاصله بگیرند یا از برقراری روابط نزدیک اجتناب کنند (بهاری و همکاران، ۲۰۲۳).

افسردگی: این اختلال با شناخت، تغییرات آشکار در عاطفه و عملکردهای عصبی-زیستی که طی یک دوره دو هفته‌ای بروز می‌کند، مشخص می‌شود و دارای بیشترین شیوع طول عمر در میان اختلال‌های روان‌پزشکی (۱۷ درصد) است. افسردگی جنبه‌های گوناگون زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و علائم آن عملکرد در حوزه‌های انگیزشی، هیجانی، شناختی، رفتاری و زیستی را مختل می‌کند (گودفرین ون هرینگن ، ۲۰۱۰).

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی

خودانتقادی: در این پژوهش منظور از خودانتقادی، نمره‌ای است که فرد در پرسشنامه سطوح خودانتقادی[1] (LOSC) تامپسون و زوروف (۲۰۰۴) کسب خواهدکرد.

شرمساری: در این پژوهش منظور از شرم، نمره‌ای است که فرد در پرسشنامه احساس شرم[2] (ESS) اندروز[3] و همکاران (۲۰۰۲) کسب خواهدکرد.

حساسیت بین فردی: در این پژوهش منظور از حساسیت بین فردی، نمره‌ای است که فرد در پرسشنامه حساسیت بین‌فردی[4] (IPSM) بویس و پارکر (۱۹۸۹) کسب خواهدکرد.

طرحواره رهاشدگی: در این پژوهش منظور از طرحواره رهاشدگی، نمره‌ای است که فرد در خرده مقیاس طرحواره رهاشدگی پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه-فرم کوتاه[5] (YSQ-S3) اسمیت[6] و همکاران (۱۹۹۵) کسب خواهدکرد.

افسردگی: در این پژوهش منظور از افسردگی، نمره‌ای است که فرد در پرسشنامه افسردگی بک[7] (BDI-II) کسب خواهدکرد.

---

[1] Levels of Self-Criticism Scale (LOSC)
[2] Experience of Shame Scale (ESS)
[3] Andrews
[4] Interpersonal Sensitivity Measure (IPSM)
[5] Young Schema Questionnaire (YSQ)
[6] Schmidt
[7] Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II)

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مرور پیشینه پژوهشی معمولاً نوعی ارزیابی تحلیلی از دانسته‌ها و یافته‌های موجود درباره یک موضوع علمی به شمار می‌آید. انجام دقیق و نظام‌مند این فرایند می‌تواند به روشن‌تر شدن ابعاد مسئله تحقیق کمک کند و نتایج مطالعه حاضر را در پیوند با دستاوردهای پژوهش‌های پیشین قرار دهد. چنین بررسی‌ای موجب می‌شود خواننده با یافته‌های تحقیقات دیگری که با موضوع مورد بررسی ارتباط نزدیک دارند آشنا شود و درک بهتری از مسیر شکل‌گیری دانش در آن حوزه به دست آورد. افزون بر این، مرور مطالعات قبلی سبب می‌شود تحقیق کنونی در چارچوب مباحث مطرح‌شده در ادبیات علمی قرار گیرد، کاستی‌ها و خلأهای موجود در پژوهش‌های پیشین شناسایی شود و زمینه برای گسترش و تکمیل آن مطالعات فراهم آید.

۲-۱ افسردگی

افسردگی یکی از شایع‌ترین انواع اختلال‌های روان‌پزشکی در جمعیت بزرگسال به شمار می‌آید. طی بیست سال اخیر، آگاهی و شناخت علمی درباره افسردگی و عوامل ایجادکننده آن به‌طور چشمگیری گسترش یافته است (ریچاردز[1]، ۲۰۱۱). در نخستین نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، اختلال‌های خلقی در گروه اختلال‌های ارگانیک یا واکنشی قرار گرفتند (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، ۱۹۵۲). در DSM-II (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، ۱۹۶۸)، نوع دیگری از طبقه‌بندی افزوده شد که اختلال‌ها را به دو دسته «نوروتیک» و «سایکوتیک» تفکیک می‌کرد. در نتیجه، در ویرایش دوم این نظام طبقه‌بندی، اختلال‌های خلقی هم‌زمان در گروه بیماری‌های مغزی ارگانیک و همچنین در دسته بیماری‌های نوروتیک جای گرفتند (ریچاردز، ۲۰۱۱). در DSM-III (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، ۱۹۸۰)، معیارهای تشخیصی دقیق و روشنی برای رده‌بندی افرادی که به اختلال‌های خلقی مبتلا هستند تدوین شد.

۲-۱-۱ همه‌گیرشناسی اختلال افسردگی

بر اساس گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی (WHO) طی دهه گذشته، تعداد افراد مبتلا به افسردگی در سطح جهان حدود ۲۰ درصد افزایش نشان داده است، به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ افسردگی پس از ایدز به عنوان دومین عامل ناتوانی در سراسر دنیا مطرح باشد (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۱۸). در حال حاضر بیش از ۳۵۰ میلیون نفر در جهان با این اختلال دست‌به‌گریبان‌اند (وینبرگر[2] و همکاران، ۲۰۱۸). در «مؤسسه ملی بهداشت روانی آمریکا[3]»، شیوع طول‌عمر اختلال‌های روان‌شناختی بین ۱/۶ تا ۵/۹ درصد گزارش شده است که در میان این میزان، حدود ۷/۳ تا ۷/۶ درصد به افسردگی اختصاص دارد (مطری و همکاران، ۱۳۹۵). شیوع ۱۲ماهه اختلال افسردگی اساسی در ایالات متحده حدود ۷ درصد برآورد شده است. البته این میزان در گروه‌های سنی مختلف یکسان نیست؛ در بازه سنی

[1] Richards
[2] Weinberger
[3] National Institute of Mental Health

۱۸ تا ۲۹ سال، شیوع افسردگی تقریباً سه برابر بیشتر از افراد ۶۰ سال و بالاتر گزارش گردیده است. همچنین، در اوایل دوره نوجوانی، میزان شیوع اختلال افسردگی اساسی در میان دختران حدود ۵/۱ تا ۳ برابر بیشتر از پسران ذکر شده است (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، ۲۰۱۳).

در ایران، مطابق نتایج مطالعات انجام‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب «طرح ملی پیمایش سلامت روان» در سال ۱۳۹۰، میانگین شیوع افسردگی حدود ۱۲ درصد برآورد شده است. در همین طرح، شیوع این اختلال در زنان ۵/۳۰ درصد و در مردان ۷/۱۶ درصد گزارش شده است (کاویانی و همکاران، ۱۳۸۱). بررسی وضعیت افسردگی در میان دانشجویان نشان داده که حدود ۷۸ درصد از آن‌ها درجاتی از نشانه‌های افسردگی را تجربه می‌کنند و در ۴۶ درصد این افراد، شدت علائم به حدی است که نیاز به مداخله و حمایت متخصصان سلامت روان احساس می‌شود (امینی و فرهادی، ۱۳۸۰). مرور نظام‌مند ادبیات پژوهشی مرتبط با شیوع افسردگی در ایران نشان می‌دهد میزان بروز و شیوع این اختلال در جمعیت‌های متفاوت ایرانی بین ۶۹/۵ تا ۷۳ درصد متغیر است. علاوه بر این، آمارها حاکی از آن است که در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، درصد شیوع افسردگی بیش از شهرهای بزرگ گزارش شده است. در این بررسی‌ها، بالاترین میزان افسردگی در میان زنان بیوه مشاهده شده است و پس از آن، به ترتیب افراد مطلقه، متأهل و در نهایت مجرد کمترین درصد ابتلا را داشته‌اند (منتظری و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۱-۲ مدل‌ها و درمان‌های شناختی-رفتاری اختلال افسردگی

در این بخش، سه رویکرد شناختی-رفتاری مرتبط با تبیین و درمان افسردگی شامل مدل شناختی-رفتاری بک[1] (۱۹۶۷)، نظریه ناامیدیِ افسردگی[2] (آبرامسون[3] و همکاران، ۱۹۸۹) و نظریه سبک‌های پاسخ[4] (نولن-هوکسما[5]، ۱۹۸۷؛ ۱۹۹۱؛ ۲۰۰۴) به‌طور فشرده معرفی می‌گردند.

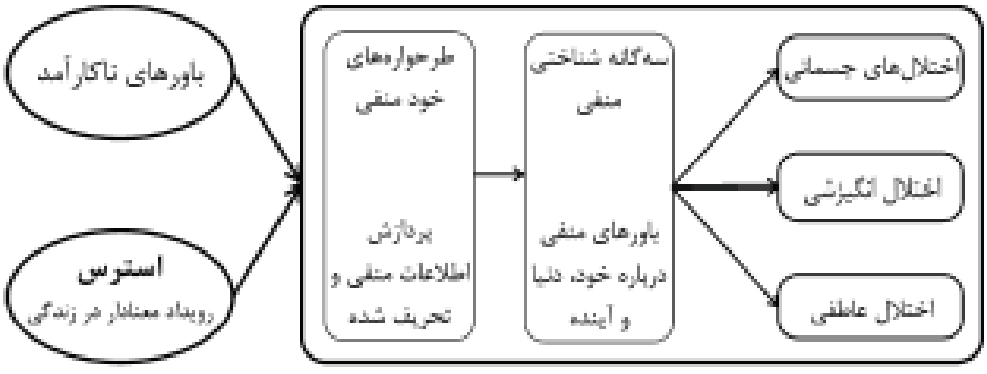
۲-۱-۲-۱ مدل شناختی-رفتاری بک

در سال ۱۹۶۷، بک نخستین چارچوب منظم شناختی درباره افسردگی را مطرح نمود. از دیدگاه او، الگوهای تفکر ناکارآمد از عوامل اصلی شکل‌گیری و تداوم این اختلال به شمار می‌روند. بک تأکید می‌کند که سه سطح متمایز شناخت در فرایند افسرده شدن نقش دارند. سطح نخست، «افکار خودآیند» است؛ این افکار به‌صورت جریان ذهنی سریع، تکرارشونده، مزاحم و با محتوای منفی ظاهر می‌شوند. سطح دوم، «قواعد مشروط» یا باورهای «اگر-پس» است که شامل افکار و عقاید غیرمنطقی بوده و زمینه و زیربنای همین افکار خودآیند را فراهم می‌کنند. برای مثال، یک باور شرطی با ماهیت افسرده‌ساز می‌تواند چنین باشد: «اگر این مقام را به دست نیاورم، آدم نادانی هستم». سطح سوم،

[1] Beck
[2] The hopelessness theory of depression
[3] Abramson
[4] The response styles theory
[5] Nolen-Hoeksema

«طرحواره‌های مرتبط با خودِ افسرده[1]» است که دربرگیرنده مجموعه‌ای از افکار منفی، باورهای بنیادین و شیوه‌های خاص پردازش اطلاعات درباره خود، دیگران و جهان هستند. افکار خودآیند به صورت خودبه‌خودی در ذهن پدیدار می‌شوند و باورهای غیرمنطقی حاصل فعال شدن همین طرحواره‌ها محسوب می‌گردند. بک بر وجود «مثلث شناختی» تأکید دارد؛ این مثلث از نگرش منفی نسبت به خود، نگاه منفی به دیگران و دید بدبینانه نسبت به آینده تشکیل شده است و در تمام انواع افسردگی نقش اساسی ایفا می‌کند (بک و همکاران، ۱۹۷۹).

در سال ۱۹۸۷، بک نظریه خود درباره افسردگی را مورد بازنگری قرار داد و به دو گونه محتوایی در طرحواره‌های ناکارآمد مرتبط با این اختلال اشاره نمود. نوع اول، ماهیتی میان‌فردی دارد و «طرحواره جامعه‌مداری/وابستگی[2]» نامیده می‌شود؛ این افراد برای تعامل، برقراری ارتباط و جلب توجه دیگران اهمیت ویژه‌ای قائل‌اند و به دنبال پذیرش، حمایت و راهنمایی از سوی اطرافیان هستند. نوع دوم، «طرحواره استقلال‌مداری/خودسرزنشی[3]» است که در افرادی دیده می‌شود که بر استقلال، تحرک، پیشرفت و کارآمدی شخصی تأکید زیادی دارند و تمایل بالایی به سرزنش خود در صورت ناکامی نشان می‌دهند. طبق مدل بازنگری‌شده بک، مواجهه با رویدادهای تنیدگی‌زا که با محتوای این طرحواره‌ها همخوانی دارند، این ساختارهای شناختی ناکارآمد را فعال کرده و در نتیجه به بروز افسردگی منجر می‌شود. برای نمونه، مشکلات جدی در روابط میان‌فردی برای فردی که دارای طرحواره جامعه‌مداری است می‌تواند محرک فعال شدن این طرحواره و تجربه افسردگی باشد. از سوی دیگر، دشواری در موقعیت‌های مرتبط با پیشرفت، موفقیت شغلی یا تحصیلی برای فرد دارای طرحواره استقلال‌مدار، زمینه‌ساز ایجاد مشکل و در نهایت تجربه افسردگی خواهد بود (اینگرام[4] و همکاران، ۲۰۰۶).



شکل ۲-۱: مدل شناختی بک از افسردگی (بک، ۱۹۹۱)

[1] depressive self-schema
[2] Sociotropy/dependency
[3] Autonomy/sef-criticism
[4] Ingram

بر اساس مدل شناختی–رفتاری بک، در «درمان شناختی–رفتاری» با هدف قرار دادن و اصلاح افکار، الگوهای رفتاری و طرحواره‌های مرتبط با هیجان‌های منفی، می‌توان به کاهش نشانه‌های افسردگی و بهبود وضعیت فرد کمک کرد. این رویکرد بر این اصل استوار است که افکار، احساسات و رفتارها با یکدیگر در ارتباطی متقابل قرار دارند؛ بنابراین، تغییر در هر یک از این سه حوزه (شناخت‌ها، رفتارها یا طرحواره‌ها) می‌تواند دگرگونی در هیجان‌ها را به دنبال داشته و شدت افسردگی را کاهش داده و همچنین احتمال بروز دوباره آن را در آینده کم کند (پرسونز[1]، ۲۰۰۸).

۲-۱-۲-۲ نظریه ناامیدیِ افسردگی

الگوی «ناامیدیِ افسردگی» (آبرامسون و همکاران، ۱۹۸۹) بر پایه چارچوب «درماندگی آموخته‌شده[2]» (سلیگمن[3]، ۱۹۸۵) شکل گرفته است. مطابق این دیدگاه، افرادی که سبک تفکر افسرده‌گرایانه دارند، رخدادهای نامطلوب زندگی را به علل پایدار (دائمی) و کلی (فراگیر) نسبت می‌دهند. چنین افرادی از دو جهت در معرض خطر بروز افسردگی قرار می‌گیرند: نخست آنکه بر این باورند هر اتفاق ناخوشایند پیامدهایی فاجعه‌آمیز و ویرانگر خواهد داشت؛ دوم آنکه رویدادهای منفی را نشانه‌ای از نقص، کاستی یا بی‌ارزشی شخصی خود تلقی می‌کنند. در نتیجه، طبق نظریه ناامیدی، نوعی آسیب‌پذیری اختصاصی شناختی در نحوه پردازش و ارزیابی رویدادهای زندگی فرد شکل می‌گیرد که به‌تدریج احتمال ابتلا به افسردگی را افزایش می‌دهد (به نقل از مک‌گین[4]، ۲۰۰۰).

۲-۱-۲-۳ نظریه سبک‌های پاسخ

بر اساس «نظریه سبک‌های پاسخ» (نولن–هوکسما، ۱۹۸۷؛ ۱۹۹۱؛ ۲۰۰۴)، گرایش به نشخوار فکری در مواجهه با احساس غمگینی و اندوه، به‌عنوان یک عامل خطر مهم برای افسردگی در نظر گرفته می‌شود. نشخوار فکری، الگویی از واکنش به پریشانی است که در آن فرد به‌طور منفعل و مکرّر درباره نشانه‌های ناراحتی، علل احتمالی و پیامدهای آن می‌اندیشد، در حالی که عملاً قادر نیست فرایند مؤثری برای حل مسئله آغاز کند که شاید بتواند این رنجش هیجانی را کاهش دهد (مورو و نولن–هوکسما، ۱۹۹۰). بر مبنای این نظریه، شیوه‌ای که افراد به خلق افسرده واکنش نشان می‌دهند، بر مدت‌زمان تداوم این خلق تأثیر مستقیم دارد. نشخوار فکری موجب طولانی‌تر شدن دوره‌های افسردگی و تشدید شدت آنها می‌شود؛ در مقابل، پاسخ‌های «بازگشتِ توجه» دوره‌های افسرده را کوتاه‌تر کرده و از میزان افسردگی می‌کاهند (مورو و نولن–هوکسما، ۱۹۹۰). به‌عنوان نمونه‌ای از پاسخ نشخوارگر، فردی را می‌توان در نظر گرفت که پس از بیان این‌که «چقدر حال بدی دارد»، عمدتاً ذهن خود را درگیر چرایی این احساس ناخوشایند و پیامدهای احتمالی آن می‌کند. در برابر، پاسخ‌های معکوسِ توجه شامل تلاش‌های فعال برای نادیده‌گرفتن نشانه‌های افسردگی و تمرکز بر فعالیت‌های خوشایند یا خنثی است؛ فعالیت‌هایی نظیر مشارکت در انواع

---

[1] Persons
[2] learned helplessness theory
[3] Seligman
[4] McGinn

ورزش‌ها، تعامل اجتماعی با دیگران، یا توجه به وظایف شـــغلی. ارتباط میان نشـــخوار فکری و افســـردگی، در پژوهش‌های گوناگون تأیید شده است (نولن-هوکسما و همکاران، ۱۹۹۴؛ نولن-هوکسما و همکاران، ۲۰۰۸).

به‌طور کلی، نشـخوار فکری نوعی شـیوه مقابله با حالت‌های خلقی منفی به شـمار می‌آید (ترینور[1] و همکاران، ۲۰۰۳) که در آن توجه به‌طور افراطی بر خود متمرکز می‌شود (لیوبومیرسکی[2] و نولن-هوکسما، ۱۹۹۳). در چارچوب نظریه سبک‌های پاسخ، این الگو با خود-تأملی مکرّر (مورو و نولن-هوکسما، ۱۹۹۰) و نیز اندیشیدن مداوم و منفعل درباره احساسات منفی همراه است (نولن-هوکسما، ۱۹۹۱). درمان شناختی-رفتاری کلاسیک، به‌طور مستقیم نشخوار فکری را در کانون مداخله قرار نمی‌دهد؛ با این حال برخی رویکردهای درمانی نســـل ســـوم، مانند «فعال‌ســـازی رفتاری»، «درمان شـناختی-رفتاری متمرکز بر نشـخوار فکری» (واتکینز[3] و همکاران، ۲۰۰۶) و نیز «درمان شـناختی-رفتاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی» (تیزدل و همکاران، ۱۹۹۵) به‌طور مشـخص به اصـلاح و کاهش نشـخوار فکری توجه نشان داده‌اند.

۲-۱-۳ عوامل خطر و پیش‌آگهی

اختلال افسردگی اساسی، وضعیت خوش‌خیم محسوب نمی‌شود؛ این بیماری غالباً سیر مزمن دارد و در بسیاری از مبتلایان، دوره‌ها به‌طور مکرر بازمی‌گردند. احتمال بهبودی بیمارانی که به دلیل نخسـتین اپیزود افسـردگی شـدید در بیمارستان بستری می‌شوند، طی یک سال حدود ۵۰ درصد برآورد شده است. بازگشت دوره‌های افسردگی اساسی بسیار شایع است؛ حدود بیست‌وپنج درصد بیماران در شش ماه ابتدایی، سی تا پنجاه درصد در دو سال نخست و پنجاه تا هفتاد و پنج درصـد آنان در پنج سـال اول پس از شـروع، حداقل یک عود را تجربه می‌کنند (سـادوک و سادوک[4]، ۱۳۸۷).

مهم‌ترین عواملی که احتمال آغاز و تداوم افسردگی را بالا می‌برند، عبارت‌اند از:

۲-۱-۳-۱ عوامل خُلق و خویی

ویژگی شخصیتی «روان‌رنـــجورخویی» به‌عنوان یک عامل خطر تأییدشده برای شروع افسردگی شناخته شده است. به نظر می‌رسد سطوح بالای این صفت، سبب می‌شود افراد در مواجهه با رویدادهای استرس‌زای زندگی، با احتمال بیشـتری وارد دوره‌های افسـردگی شـوند (انجمن روان‌پزشـکی آمریکا، ۱۳۹۳). کسـانی که نمره بالایی در روان‌رنـجورخویی دارند، استعداد ژنتیکی بیشتری برای ابتلا به اختلالات عاطفی، از جمله افسردگی، نشان می‌دهند و

[1] Treynor
[2] Lyubomirsky
[3] Watkins
[4] Sadock & Sadock

ممکن است در برابر حتی استرس‌های نسبتاً کوچک، واکنش‌های عصبی قابل‌توجهی بروز دهند (فیست و فیست، ۱۳۸۶).

۲-۱-۳-۲ عوامل محیطی

تجارب ناخوشایند در دوران کودکی، به‌خصوص هنگامی که مجموعه‌ای از تجارب متعدد با انواع مختلف آسیب و محرومیت وجود داشته باشد، از قوی‌ترین عوامل خطر برای بروز اختلال افسردگی اساسی به شمار می‌آیند. رویدادهای استرس‌زای زندگی به‌خوبی به‌عنوان محرک‌ها و تسریع‌کننده‌های دوره‌های افسردگی اساسی شناخته شده‌اند؛ با این حال، به نظر نمی‌رسد صرفِ حضور یا فقدان رویدادهای نامطلوب در فاصله زمانی نزدیک به شروع اپیزودها، راهنمای روشنی برای پیش‌آگهی یا انتخاب نوع درمان فراهم سازد (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، ۱۳۹۳). یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری افسردگی می‌تواند به حوادث ناگوار و تجربه انواع آسیب‌های شخصی مربوط باشد؛ برای نمونه از دست دادن شغل یا وقوع طلاق. اما صاحب‌نظران تأکید می‌کنند تمرکز اصلی نباید تنها بر معنای ظاهری این رخدادهای نامطلوب باشد، بلکه لازم است بافت وقوع حادثه و معنایی که آن رویداد برای فرد دارد مورد توجه قرار گیرد (بارلو و دوراند[1]، ۲۰۰۲).

۲-۱-۳-۳ عوامل ژنتیکی و فیزیولوژیک

خویشاوندان درجه‌اول افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، بین دو تا چهار برابر بیشتر از جمعیت عمومی در معرض ابتلا به همین اختلال قرار دارند. به‌نظر می‌رسد این خطر نسبی برای فرم‌های زودآغاز و همچنین نوع عودکننده، بالاتر باشد. میزان وراثت‌پذیری در حدود ۴۰ درصد برآورد شده است و صفت شخصیتی روان‌رنجورخویی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این آمادگی ژنتیکی را توضیح دهد (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، ۱۳۹۳). برخی مطالعات نشان داده‌اند که وراثت‌پذیری افسردگی اساسی در زنان بالاتر از مردان است (حدود ۴۰٪ در زنان و کمتر از ۴۰٪ در مردان) (بارلو و دوراند، ۲۰۰۲).

۲-۱-۳-۴ تعدیل‌کننده‌های سیر اختلال افسردگی

تقریباً تمام اختلالات عمده غیرخلقی، میزان خطر بروز افسردگی را در فرد افزایش می‌دهند. اپیزودهای افسردگی اساسی که بر زمینه یک اختلال دیگر رخ می‌دهند، عموماً با دوره‌های درمان طولانی‌تر همراه‌اند. در این میان، سوءمصرف مواد، اختلالات اضطرابی و اختلالات شخصیت مرزی از شایع‌ترین همبودها هستند و وجود نشانه‌های افسردگی ممکن است تشخیص این اختلالات را دشوار و به‌تعویق‌افتاده سازد. با این وجود، دستیابی به بهبود پایدار در علائم افسردگی، در بسیاری موارد به درمان مؤثر و کافی بیماری‌های زمینه‌ای وابسته است. بیماری‌های جسمی مزمن یا ناتوان‌کننده نیز خطر شکل‌گیری دوره‌های افسردگی اساسی را افزایش می‌دهند.

[1] Barlow & Durand

اختلالات جسمانی شایعی مانند دیابت، چاقی مرضی و بیماری‌های عروق قلبی، غالباً با دوره‌های افسردگی پیچیده‌تری همراه می‌شوند و احتمال مزمن شدن این اپیزودها در این گروه، بیشتر از افرادی است که از نظر بدنی وضعیت سالمی دارند (انجمن روان‌پزشکی آمریکا، ۱۳۹۳).

۲-۲ حساسیت بین فردی

حساسیت بین‌فردی به نوعی آسیب‌پذیری شخص نسبت به احساس بی‌کفایتی و حقارت در مقایسه با دیگران اشاره دارد. از جلوه‌های این ویژگی می‌توان به کوچک شمردن خود، تجربه ناآرامی و ناراحتی در موقعیت‌های ارتباطی و تعامل با دیگران اشاره کرد (فتحی‌آشتیانی، ۱۳۹۲). به بیان دیگر، حساسیت بین‌فردی با مؤلفه‌هایی مانند بی‌اعتمادی نسبت به دیگران، خودداری از انتقاد، ترس و حساسیت نسبت به طرد شدن، احساس مورد حمله قرار گرفتن، حسادت، اجتناب از روابط عاطفی نزدیک، دشواری در رها شدن از احساس فقدان پس از خاتمه روابط صمیمانه و همچنین ناتوانی در حفظ استقلال و فردیت در بستر تعاملات گروهی همراه است (نیک‌آمال و همکاران، ۱۳۹۲). حساسیت بین‌فردی تحت تأثیر سه عامل اصلی قرار می‌گیرد: ۱) فرصت فرد برای تجربه و تعامل با محیط، ۲) میزان توجه و ۳) هرگونه محدودیت در دستگاه ادراکی که توان پردازش طیف متنوعی از محرک‌ها را دارد. هر نوع فرایند پردازشی که این سه جنبه از احساس و ادراک بین‌فردی را تحت تأثیر قرار دهد، به همان نسبت بر سطح حساسیت بین‌فردی اثر می‌گذارد (هال و برنیری[1]، ۲۰۰۱).

روابط بین‌فردی فرایندی است که در آن افراد متقابلاً بر یکدیگر اثر می‌گذارند. شیوه درک افراد، تفسیر و ارزیابی آنان از رویدادها، موقعیت‌ها و دیگران در آغاز، تداوم و حفظ این روابط نقش اساسی دارد. روابط میان‌فردی در چارچوب معنایی‌ای شکل می‌گیرد که کنشگران از طریق تعامل متقابل برای همدیگر ایجاد می‌کنند. در متن این روابط، اشخاص با شناخت و پذیرش جنبه‌هایی از خود و با بهره‌گیری از بازخوردهایی که از دیگران دریافت می‌کنند، نقاط قوت و ضعف خویش را شناسایی می‌کنند. اگر فرد بیش از اندازه بر روابط بین‌فردی متمرکز شود، زمان اختصاص‌داده‌شده به خود را کاهش دهد و سایر روابط اجتماعی‌اش تضعیف گردد، در هنگام پایان یافتن آن روابط خاص، دچار ناراحتی و آشفتگی می‌شود (هیچدرمایز[2] و همکاران، ۲۰۱۶). حساسیت بین‌فردی متغیری تعاملی است که به صورت یک ویژگی نسبتاً پایدار شخصیتی به‌طور گسترده مطالعه شده است. این سازه به عنوان نوعی آگاهی و حساسیت افراطی و غیرضروری نسبت به احساسات و رفتار دیگران تعریف می‌شود. افرادی که چنین خصیصه‌ای دارند، غالباً در روابط بین‌فردی با تعارض مواجه می‌شوند، نسبت به خلق و رفتار دیگران حساس‌اند، به

[1] Hall & Bernieri
[2] Aydin & Híçdurmaz

انتقاد و طرد (ادراک‌شـــده یا واقعی) واکنش‌پذیری بالایی دارند و معمولاً رفتار خود را به‌گونه‌ای تنظیم و اصـــلاح می‌کنند که بتوانند انتظارات دیگران را برآورده سازند (اتانی[1] و همکاران، ۲۰۱۴).

این ویژگی از پنج مؤلفه اصلی تشکیل شده است:

۱- آگاهی بین‌فردی: نشان می‌دهد فرد تا چه حد از احساسات و رفتار دیگران آگاه است؛

۲- اضطراب جدایی: بیانگر میزان نگرانی درباره جدایی واقعی یا احتمالی از دیگران است؛

۳- کمرویی: ناتوانی در ابراز جسورانه خود در روابط برای جلوگیری از ناراحت شدن دیگران؛

۴- عزت‌نفس شکننده: دشواری در آشکار کردن احساسات درونی به علت ترس از طرد یا نقد؛

۵- نیاز به تأیید: تمایل شدید به این که از سوی دیگران پذیرفته و دوست داشته شود.

به نظر می‌رسـد منشـأ این ویژگی شـخصـیتی که در برخی منابع از آن با عنوان «حسـاسـیت به طرد» نیز یاد می‌شود تا حدی تحت کنترل عوامل ژنتیکی قرار دارد (ویلهلم[2] و همکاران، ۲۰۰۴).

حســاســیت بین‌فردی را می‌توان از دو بعد متمایز بررســی کرد. بعد نخســت به آگاهی نســبت به نیازها و احســاســات دیگران مربوط می‌شــود؛ افرادی که در این بعد نمره بالایی دارند، توان ارزیابی نســبتاً دقیق ویژگی‌های شـخصـیتی، افکار و هیجان‌های دیگران و درک صـحیح آنان را در موقعیت‌های ارتباطی دارا هسـتند. در این سـطح، حسـاسـیت بین‌فردی به صـورت دقت در تشـخیص علائم غیرکلامی، محتوای کلامی و وضـعیت جسـمانی دیگران تعریف می‌شود و می‌تواند کارکردی سازگارانه داشته باشد. بعد دوم زمانی مطرح است که شدت حساسیت بین‌فردی افزایش می‌یابد و در نتیجه، به شـکل‌گیری مشـکلات بین‌فردی و تجربه حالات عاطفی منفی منجر می‌شـود؛ در این حالت از آن با عنوان «ارزیابی اجتماعی منفی» یاد می‌شود. سطوح بالای حساسیت بین‌فردی پیامدهای نامطلوبی برای فرد به همراه دارد؛ از جمله می‌توان به ناامیدی، شـکنندگی هیجانی، بزرگ‌نمایی مشـکلات جزئی، تجربه اسـترس در روابط، کاهش آستانه تحمل و کیفیت پایین روابط اشاره کرد (آیدین و هیچدرمایز، ۲۰۱۶).

میان حسـاسـیت بین‌فردی و ویژگی‌های خلقی نیز پیوند معناداری وجود دارد. اشـخاصـی که از اسـتقلال روانی پایین‌تری برخوردارند و گرایش قوی‌تری به «اجتناب از آسـیب» دارند، معمولاً سـطح حسـاسـیت بین‌فردی بیشـتری نشـان می‌دهند. به نظر می‌رسـد این افراد درونـاً نابالغ و شـکننده‌اند و به‌جای تکیه بر اهداف و ارزش‌های شـخصـی، به محرک‌های بیرونی واکنش بیشـتری نشـان می‌دهند. در مقابل، کسـانی که دارای صـفت پرهیز از آسـیب هسـتند، اغلب بدبین، ترسـو، حسـاس به انتقاد و طرد، خجالتی و مردد توصـیف می‌شـوند. یافته‌های پژوهشـی حاکی از آن اسـت که حساسیت بین‌فردی با افزایش سن کاهش می‌یابد؛ از این رو، این ویژگی شخصیتی بیشتر در جمعیت جوان مشاهده

[1] Otani
[2] Wilhelm

می‌شـــود (اتانی و همکاران، ۲۰۰۸). در بخش بعد، چارچوب‌های نظری مرتبط با حســـاســـیت بین‌فردی با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۲-۱ ابعاد حساسیت بین فردی

ابعاد حساسیت بین‌فردی شامل چند مؤلفه اساسی است که هر یک جنبه‌ای از نحوه تجربه و تنظیم روابط با دیگران را توضیح می‌دهند:

۲-۲-۱-۱ آگاهی بین‌فردی

این بعد به حالتی اشـــاره دارد که در آن فرد توجه شـــدیدی به روابط انســـانی اطراف خود دارد و نســـبت به نشـــانه‌های رفتاری و هیجانی دیگران بســـیار حســـاس اســـت. چنین فردی حرکات، حالات چهره، لحن صـــحبت و تغییرات هیجانی اطرافیان را به‌طور مداوم رصد می‌کند و نسبت به آن‌ها واکنش درونی نشان می‌دهد.

۲-۲-۱-۲ اضطراب جدایی

این مؤلفه بیانگر تجربه تنش و نگرانی قابل‌توجه هنگام فاصـــله گرفتن یا جدا شـــدن از اشـــخاص مهم زندگی، به‌ویژه چهره‌های دلبستگی و تکیه‌گاه‌های عاطفی است. بر اساس نظریه دلبستگی بالبی (۱۹۷۷)، اگر در دوران کودکی فرصت تجربه یک پیوند ایمن فراهم نشود و الگوی دلبستگی مضطرب شکل بگیرد، فرد در بزرگسالی در برقراری روابط مؤثر با دیگران دچار مشکل می‌شود و در معرض افسردگی و احساس ناتوانی در ایجاد پیوندهای عاطفی سالم قرار می‌گیرد.

۲-۲-۱-۳ کم‌رویی

بعد کم‌رویی نشـــان‌دهنده ویژگی‌هایی مانند خجالتی بودن و ناتوانی در آغاز یا حفظ ارتباط مؤثر با اطرافیان اســـت. فرد خجول معمولاً در دریافت و پذیرش حمایت‌های محیطی، ابراز نیازها، نشـــان‌دادن خود واقعی و داشـــتن جرئت در تعاملات اجتماعی ضـــعف دارد. او تلاش می‌کند دیگران را خشـــنود نگه دارد، از ایجاد تعارض بپرهیزد و مراقب باشد کسی را ناراحت یا آزرده نکند؛ حتی اگر این کار به قیمت نادیده گرفتن نیازهای خودش تمام شود.

۲-۲-۱-۴ عزت‌نفس شکننده

در این بُعد، شـــخص به دلیل بیمِ طرد شـــدن و ترس از مواجهه با انتقاد، از ابراز احســـاســـات و هیجان‌های خودداری می‌کند. چنین فردی در ارزیابی ارزش شـخصـی خویش دچار تردید و ضـعف اسـت و احسـاس می‌کند به اندازه کافی شایسته، دوست‌داشتنی یا پذیرفتنی نیست. هر نشانه‌ای از نارضایتی یا نقد دیگران می‌تواند ضربه شدیدی به احساس ارزشمندی او وارد کند.

۲-۲-۱-۵ نیاز به تأیید

این مؤلفه نشان‌دهنده آن است که فرد بخش عمده‌ای از انرژی روانی خود را صرف راضی نگه داشتن دیگران می‌کند و به‌طور مداوم در پی کسب تأیید، تحسین و پذیرش از سوی آن‌هاست. ارزش‌گذاری او بر خود وابستگی زیادی به نظر اطرافیان دارد و برای اجتناب از رد شدن، به سازگار شدن افراطی با خواسته‌های دیگران گرایش پیدا می‌کند، حتی اگر این خواسته‌ها با نیازهای درونی و علایق شخصی‌اش همسو نباشد.

۲-۲-۲ نظریات پیرامون حساسیت بین فردی

۲-۲-۲-۱ حساسیت بین‌فردی در دیدگاه بایس و پارکر

بایس و پارکر[1] (۱۹۸۹)، حساسیت بین‌فردی را حالتی می‌دانند که در آن، فرد نسبت به بازخورد اجتماعی، واکنش‌پذیری کلی و شدیدی دارد؛ به این معنا که در تعامل با دیگران، دچار افزایش اضطراب می‌شود، از بی‌کفایتی می‌هراسد، نگران مورد انتقاد قرار گرفتن است و اغلب رفتارهای بین‌فردی دیگران را به طور مکرر و به شکلی نادرست تفسیر می‌کند. در تبیین آنها، پنج مقیاس برای سنجش حساسیت بین‌فردی مطرح شده است:

۱- حساسیت بین‌فردی: به معنای میزان آگاهی از پاسخ‌های انتقادی یا منفی است که از سوی دیگری دریافت می‌شود و نیز تاثیری که این دریافت‌ها بر درک فرد از تعاملات بین‌فردی می‌گذارد.

۲- نیاز به تأیید: یعنی تمایل قوی برای کسب رضایت و تأیید دیگران به منظور حفظ رابطه‌ای مسالمت‌آمیز و بدون تعارض.

۳- اضطراب جدایی: به احساس نگرانی و تنش در هنگام جدا شدن واقعی یا احتمالی از دیگران اشاره دارد.

۴- کم‌رویی: نشان‌دهنده فقدان جسارت است؛ بدین معنا که فرد به دلیل کم‌رویی قادر به تقویت و گسترش روابط میان‌فردی خود نیست.

۵- درون‌شکننده: حالتی که در آن شخص خود را دوست‌داشتنی نمی‌بیند و احساس می‌کند باید این جنبه از خویش را از دید دیگران پنهان نگه دارد.

۲-۲-۲-۲ حساسیت بین‌فردی در دیدگاه داویدسون

داویدسون[2] و همکاران (۱۹۸۹) معتقدند حساسیت بین‌فردی ساختاری است که به نوعی حساسیت افراطی نسبت به تجربه عزت‌نفس پایین در زمینه رابطه با دیگران اشاره دارد و دربرگیرنده حساسیت به طرد شدن و انتقاد از سوی اطرافیان است. این مفهوم همچنین بیانگر احساس ناکفایتی شخصی، سطح نازل عزت‌نفس و روحیه شکننده فرد محسوب می‌شود.

---

[1] Boyce & Parker
[2] Davidson

۲-۲-۲-۳ دیدگاه برنیری درباره حساسیت بین‌فردی

برنیری[1] (۲۰۰۱) بیان کرده است که حساسیت بین‌فردی، در معنای کلی، به‌صورت توانایی تجربه، درک دقیق و ارائه پاسخ متناسب به فرد و محیط اجتماعی تعریف می‌شود. از این منظر، حساسیت بین‌فردی تابع سه عامل اساسی است: ۱) فرصت شخص برای تجربه و تعامل با محیط؛ ۲) توجه؛ و ۳) هرگونه محدودیت در سیستم ادراکی در ارتباط با طیف گسترده محرک‌هایی که فرد قادر است آنها را شناسایی و پردازش کند. حضور سطح بالایی از حساسیت در روابط بین‌فردی می‌تواند به ایجاد مشغله ذهنی شدید درباره تعاملات اجتماعی، افزایش اضطراب، بروز افسردگی و در نهایت، آسیب به سلامت روان فرد منجر شود.

۲-۲-۳ حساسیت بین‌فردی و آسیب‌پذیری نسبت به اختلالات روان‌شناختی

در پژوهش‌های متعدد، پیوند معناداری میان سطح حساسیت بین‌فردی و بروز انواع اختلالات روان‌شناختی گزارش شده است. در افراد دچار افسردگی، معمولاً میزان حساسیت بین‌فردی بالاست؛ این ویژگی اغلب ریشه در تجربه‌های اولیه زندگی با مادرانی دارد که در مراقبت از فرزند، هم دلسوزی و حضور عاطفی کافی نداشته‌اند و هم کنترل‌گری افراطی نشان داده‌اند. حاصل چنین سبک فرزندپروری، شکل‌گیری عزت‌نفس ناپایدار و شکننده در فرد است که زمینه‌ساز حساسیت شدید در روابط با دیگران می‌شود. در اختلال فوبیای اجتماعی نیز، حساسیت بین‌فردی بالا به صورت آگاهی افراطی و وسواس‌گونه نسبت به جنبه‌های مختلف تعاملات انسانی بروز می‌کند. فرد دائم نگران ارزیابی منفی دیگران است و رفتارهای اطرافیان را اغلب به شکلی تحریف‌شده و نادرست تعبیر می‌کند؛ همین سوءبرداشت‌های مکرر، اضطراب اجتماعی او را تشدید می‌کند. در مورد پرخوری عصبی، ترکیبی از ویژگی‌های روانی مانند عزت‌نفس بسیار شکننده و ترس شدید از ارزشیابی شدن توسط دیگران که هر دو در حساسیت بین‌فردی بالا به چشم می‌خورند دیده می‌شود. این گروه از افراد برای حفظ تصویر ذهنی «باید همیشه ظاهر مطلوبی داشته باشم» نسبت به پیام‌های فرهنگی و اجتماعی درباره استانداردهای ایده‌آل زیبایی و جذابیت، آسیب‌پذیرترند و بیش از سایرین تحت تأثیر این پیام‌ها قرار می‌گیرند (هامان[2] و همکاران، ۲۰۰۹).

در جمع‌بندی می‌توان گفت ویژگی حساسیت بین‌فردی، احتمال آسیب‌دیدن فرد در برابر اختلالات اضطرابی را افزایش می‌دهد (ویلهلم و همکاران، ۲۰۰۴). افرادی که حساسیت بین‌فردی در آن‌ها بالاست، معمولاً از الگوهای تفکر ناسازگار و باورهای شناختی ناکارآمد رنج می‌برند (ویدی‌آندهی و سادهی[3]، ۲۰۰۰). در مواجهه با فشارهای روانی، آن‌ها اغلب از شیوه‌های مقابله‌ای نامناسب استفاده می‌کنند؛ مانند فاصله گرفتن و دوری گزیدن از فعالیت‌های اجتماعی، روی آوردن به خوددرمانی با مصرف مواد مخدر یا الکل، و بروز واکنش‌های هیجانی بسیار شدید

[1] Bernieri
[2] Hamann
[3] Vidyanidhi & Sudhir

(هیچدورماز و از، ۲۰۱۵). استمرار این چرخه ناکارآمد و آمیخته با پرخاشگری، وقتی فرد در شرایطی قرار می‌گیرد که آن را تهدیدآمیز یا ترس‌آور تجربه می‌کند، باعث وخیم‌تر شدن مشکلات میان‌فردی، کاهش بیشتر عزت‌نفس و رشد احساس بی‌ارزشی می‌شود و در نهایت، فرد را به سوی افسردگی سوق می‌دهد (پیک و رودریگز[1]، ۲۰۰۰).

در حوزه اختلالات شخصیت، تحقیقات نشان داده‌اند که حساسیت نسبت به طرد شدن در میان افرادی که دچار اختلال شخصیت مرزی یا اجتنابی هستند نیز به‌طور برجسته دیده می‌شود. در اختلال شخصیت مرزی، فرد غالباً در کودکی با عشق مشروط، غفلت عاطفی و رفتار سرد والدین مواجه بوده است؛ این تجربه‌ها با شکل‌گیری حساسیت شدید به طرد شدن ارتباط دارد. اشخاص مبتلا به این اختلال، هنگامی که امتیاز بالایی در مقیاس حساسیت بین‌فردی کسب می‌کنند، نسبت به هرگونه طرد چه واقعی و چه خیالی واکنش‌های بسیار شدید و افراطی نشان می‌دهند (استبلر[2] و همکاران، ۲۰۱۱). در مقابل، در اختلال شخصیت اجتنابی، راهبرد رایج فرد این است که برای پیشگیری از تجربه طرد شدن، از موقعیت‌های اجتماعی کناره می‌گیرد. کودکانی که در محیطی رشد کرده‌اند که والدینشان مکرراً آن‌ها را نقد، سرزنش یا طرد کرده‌اند، به تدریج این انتظار درونی را شکل می‌دهند که در آینده نیز احتمالاً از سوی دیگران پس زده خواهند شد. به همین علت، در بزرگسالی از راهبرد مقابله‌ای اجتناب و دوری از دیگران استفاده می‌کنند؛ رفتاری که به‌تدریج به هسته مرکزی اختلال شخصیت اجتنابی تبدیل می‌شود. همچنین باید در نظر داشت افرادی که در سیستم سمپاتیک و ناحیه لیمبیک مغز به دلیل تغییرات هورمونی، حساسیت زیستی بیشتری نسبت به نشانه‌های تهدید طرد شدن دارند، هنگام مواجهه با نشانه‌های طرد بالقوه، واکنش‌های شدیدتر، سریع‌تر و پررنگ‌تری نشان می‌دهند و به این ترتیب، احتمال اتخاذ الگوی اجتناب در آن‌ها بالاتر می‌رود (میر و کارور[3]، ۲۰۰۰).

۲-۳ طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی یکی از زیرمجموعه‌های مهم طرحواره‌های ناسازگار اولیه به‌شمار می‌آید که نخستین‌بار توسط روان‌شناس و درمانگرِ طرحواره‌محور، جفری یانگ معرفی گردید. در این الگوی شناختی-هیجانی، فرد چنین تجربه می‌کند که اداره و جهت‌دهی زندگی شخصی‌اش از اختیار او خارج شده، احساس خودمختاری نمی‌کند و آزادی عمل را در تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از دست داده است. شخصی که گرفتار طرحواره رهاشدگی است، باور دارد به‌تنهایی قادر نیست بر امور زندگی خویش تسلط داشته باشد و همواره خود را محتاج حمایت، راهنمایی و تکیه‌گاه دیگران می‌بیند (محمدنژاد، ۱۳۹۶). برخی از شاخص‌ها و ویژگی‌های بارز افرادی که این طرحواره را در ساختار

[1] Peake & Rodriguez
[2] Staebler
[3] Meyer & Carver

شـخصـیتی خود حمل می‌کنند عبارت‌اند از: وابسـتگی قابل‌توجه به دیگران در فرایند تصـمیم‌گیری و انجام کارهای روزمره، ناتوانی در پیشـبرد مسـتقل امور عادی زندگی و احسـاس نیاز مداوم به یاری اطرافیان، تجربه نابسـندگی و ناتوانی در مدیریت جنبه‌های مختلف زندگی شـخصـی، احسـاس بی‌کفایتی در پذیرش مسـئولیت‌ها و محدودیت در تحمل پذیرش پیامدهای تصـمیم‌ها، ضـعف در اعتماد داشـتن به توانایی‌ها و مهارت‌های خود، ترس شـدید از ترک شـدن یا جدا ماندن از افراد مهم زندگی و تجربه ناایمنی در مواقعی که دسترسی به مراقبت و پشـتوانه دیگران کاهش می‌یابد (شریعت، ۱۴۰۰).

این الگوی ناسـازگار می‌تواند از سال‌های اولیه رشـد و در دوران کودکی شـکل بگیرد؛ به‌ویژه زمانی که کودک با قطع ناگهانی مراقبت و حمایت والدین، تجربه فقدان یا جدایی از آن‌ها، یا بی‌ثباتی جدی در حضـور مراقبان اصـلی مواجه شده باشد. در چنین شرایطی، ذهن کودک به‌تدریج این باور بنیادین را درمی‌آمیزد که دنیا جای ناایمنی است و او بدون حضـور یک تکیه‌گاه دائمی، قادر به ادامه حیات عاطفی و روانی سـالم نخواهد بود. مداخله درمانی در مورد طرحواره رهاشـدگی مستلزم شـناسـایی دقیق و سـپس تعدیل و اصـلاح باورهای ناکارآمد، اسـکن خاطرات و تجارب اولیه مرتبط با ترس از تنهایی و احسـاس رها شـدن، کار متمرکز بر کاهش هراس از تنها ماندن، و تقویت تدریجی اعتماد به نفس، احسـاس کارآمدی شـخصـی و مسـئولیت‌پذیری فرد در حوزه‌های مختلف زندگی اسـت (خلعتبری و همکاران، ۱۴۰۰).

۲-۳-۱ ابعاد طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی متشکل از چهار مؤلفه محوری است که عبارت‌اند از:

۲-۳-۱-۱ ناپایداری رابطه

این بعد به نوع برداشت و اعتقاد فرد اشاره دارد؛ باوری که بر اساس آن، ارتباطاتش با دیگران موقتی، لرزان و آسیب‌پذیر تلقی می‌شود و احتمال زیادی می‌دهد که این پیوندها در آینده نزدیک به پایان برسند. در معنای ناپایداری ارتباط در چهارچوب طرحواره رهاشدگی، فرد پیوسته دل‌مشغول از دست دادن روابط خود است و مدام می‌ترسد که تماس‌ها و وابسـتگی‌های عاطفی‌اش گسـسـته شـوند. چنین نگرانی‌ای معمولاً ریشـه در خاطرات سـال‌های کودکی و نوجوانی دارد؛ دوره‌ای که شـخص تجربه کرده اسـت روابط مهم زندگی‌اش ثبات، استمرار و تداوم نداشته‌اند. افرادی که با این طرحواره زندگی می‌کنند، ممکن است بارها شاهد جدایی، قطع رابطه یا پایان گرفتن پیوندهای عاطفی خود باشند. آن‌ها می‌ترسند طرد شوند یا روابطشان دگرگون شده و از هم بپاشد. در نتیجه، احتمال دارد برای حفظ ارتباط، رفتارهای کنترل‌گرانه افراطی نشـان دهند یا به وابسـتگی شـدید نسـبت به دیگران روی آورند تا احسـاس بی‌ثباتی در روابط را مدیریت کنند و از اضطراب ناشی از آن بکاهند. برای عبور از این طرحواره، شخص لازم است توان اعتماد به خود را در خود پرورش دهد و در مسـیر ایجاد پیوندهای پایدار، سـالم و قابل اعتماد در زندگی گام بردارد. علاوه

بر این، آموزش مهارت‌های ارتباط مؤثر، حل تعارض و تنظیم هیجانی در تعاملات بین‌فردی می‌تولند نقش حمایتی مهمی در این زمینه ایفا کند. رویکردهای درمانی روان‌شـــناختی نیز قادرند به فرد کمک کنند تا میزان احســـاس ناپایداری در روابطش را کاهش دهد و الگوهای ارتباطی سازگارتر را جایگزین سازد (رحمانی، ۱۴۰۰).

۲-۳-۱-۲ تنهایی و بی‌ثباتی

این مؤلفه به تجربه درونی فرد از احســاس نااســتواری و تنها ماندن اشــاره می‌کند. شــخصــی که این بعد از طرحواره رهاشــدگی را دارد، اغلب با این تصــور زندگی می‌کند که در نهایت، تنها رها خواهد شــد و هیچ پشــتوانه عاطفی دائمی نخواهد داشــت. مقصــود از تنهایی و بی‌ثباتی در این چارچوب آن اســت که فرد جهان درونی خود را جایی می‌بیند که در آن، همیشــه در معرض از دســت دادن ارتباط و حمایت اســت و در ســطح عمیق، باور دارد که زندگی‌اش از منظر روابط انســـانی، فاقد ثبات و اتکای کافی اســـت. این تجربه معمولاً در گذشـــته فرد و در دوران کودکـــــی و نوجوانی ریشه دارد؛ زمانی که او احساس کرده است پیوند حمایتی مطمئن و ارتباط پایدار با دیگران را تجربه نکرده و اغلب در فضــای عاطفی ناهمگون و ناپایدار قرار داشــته اســت. اشــخاصــی با این طرحواره، معمولاً نگران‌اند که دوستان یا افراد مهم زندگی‌شان را از دست بدهند؛ ممکن است بارها جدایی، طرد شدن یا فروپاشی روابط را تجربه کرده باشند. این وضعیت سبب می‌شود احساس عمیق تنهایی، ناایمنی و بی‌پناهی در آن‌ها شکل بگیرد و دائماً با این باور زندگی کنند که هیچ‌کس واقعاً آن‌ها را نمی‌فهمد یا جایگاه محکمی در زندگی دیگران ندارند. برای کاهش اثرات این بعد، فرد باید در جهت ساختن روابط صمیمی، امن و ماندگار گام بردارد و پیوندهایی ایجاد کند که در آن‌ها نزدیکی عاطفی و اعتماد دوطرفه تجربه شـــود. همچنین تقویت خودباوری، افزایش اعتماد به توانایی‌های شخصی و احساس ارزشمندی می‌تواند در کم‌رنگ کردن احساس تنهایی و بی‌ثباتی بسیار مؤثر باشد. مداخلات درمانی مبتنی بر رویکردهای شـــناختی–رفتاری و طرحواره‌درمانی نیز در این حیطه می‌توانند بســـیار کمک‌کننده باشند (محمدی آشنانی، ۱۳۹۸).

۲-۳-۱-۳ عدم امنیت

این وجه از طرحواره به این باور مربوط می‌شود که دیگران قابل اتکا نیستند، نمی‌توان روی آن‌ها حساب کرد و احتمال از دست رفتن حمایتشان همیشه وجود دارد. فردی که این مؤلفه در او فعال است، به‌طور مداوم نگران قطع پشـــتیبانی عاطفی و رفتاری اطرافیان اســـت و احســـاس می‌کند در روابط و زندگی روزمره از ثبات و امنیت کافی برخوردار نیســـت. عدم امنیت، به‌عنوان یکی از ابعاد طرحواره رهاشـــدگی، یعنی فرد در لایه‌های عمیق روانی خود متقاعد شده است که در دنیای بین‌فردی‌اش، تداوم و اطمینان وجود ندارد. این حس ریشه در تجربه‌های اولیه زندگی دارد؛ به‌ویژه در سال‌های کودکی و نوجوانی که فرد دریافته است والدین یا مراقبان اصلی او نتوانسته‌اند بستر امن،

پایدار و قابل پیش‌بینی مورد نیاز را فراهم کنند و حضـــور و حمایت آن‌ها یا محدود، متناقض و ناپایدار بوده اســـت (ابراهیم‌نژادشهربابکی، ۱۳۹۷).

چنین فردی غالباً نگران فروپاشی روابط خود است، می‌ترسد نادیده گرفته شود، مورد بی‌توجهی یا حتی ترک و طرد قرار گیرد. احتمال دارد وابستگی شدیدی به دیگران پیدا کند و در عین حال، دائماً آن‌ها را زیر ذره‌بین بگذارد تا نشـانه‌ای از ترک شـدن را زودتر تشـخیص دهد؛ بنابراین، ممکن اسـت بی‌وقفه در حال ارزیابی، کنترل و بررسـی تعاملاتش باشـد تا شـاید به این وسـیله احسـاس ناایمنی را مهار کند. برای غلبه بر این الگو، فرد باید به تدریج توان تکیه بر منابع درونی خود را تقویت کرده، به مهارت‌ها و ظرفیت‌های شخصی‌اش اعتماد کند و احساس امنیت درونی و ثبات در خود را پرورش دهد؛ به‌گونه‌ای که منبع اصـــلی اتکا، تنها محیط بیرونی نباشـــد. ایجاد و حفظ روابط میان‌فردی پایدار، همراه با حمایت متقابل و قابل پیش‌بینی، نیز می‌تواند در کاهش این احســـاس ناامنی نقش بســـیار مؤثری ایفا کند (جعفریان، ۱۳۹۸).

۲-۳-۱-۴ *طرد شدن*

این بعد به تجربه ذهنی فرد از رد شدن و بی‌ارزش تلقی شدن از سوی دیگران مربوط است. شخص مبتلا به این مؤلفه طرحواره‌ای، دائماً نگران است که از جمع کنار گذاشته شود، پذیرفته نشود یا از سوی اطرافیان بی‌اهمیت شمرده گردد. منظور از طرد شدن در ساختار طرحواره رهاشدگی این است که فرد باور دارد مورد پذیرش، محبت و حمایت کافی قرار نمی‌گیرد و به‌طور ضمنی انتظار دارد در روابط نزدیک، رد یا کنار گذاشته شود. این باور می‌تواند بازتاب تجربه‌های گذشته در دوره‌های کودکی و نوجوانی باشد؛ زمان‌هایی که فرد احساس کرده است نادیده گرفته شده، به نیازهای عاطفی‌اش پاسخ داده نشده یا حتی به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم طرد شده است. در نتیجه، به این جمع‌بندی رسـیده که دیر یا زود دیگران او را پس خواهند زد و نیازهای هیجانی‌اش برآورده نخواهد شـد. در چنین الگویی، فرد ممکن است با نگاه بدبینانه به روابط خود بنگرد، همواره در انتظار طرد شدن بماند و کوچک‌ترین نشانه بی‌توجهی را به‌عنوان تأییدی بر این باور تفســـیر کند. برای رهایی از اثرات این بعد، لازم اســـت فرد به تقویت عزت‌نفس و باور به ارزشـمندی خود بپردازد و به این درک برسـد که شـایسـته توجه، محبت و پذیرش اسـت. کار درمانی بر محور ایجاد روابط صـــمیمی، امن و مبتنی بر اعتماد متقابل، و دریافت واقعی حمایت عاطفی، می‌تولند در بازسـازی این طرحواره نقش بسـیار مهمی داشـته باشـد و به تدریج انتظار مداوم طرد شـدن را کاهش دهد (طالب‌لو و محمدی، ۱۴۰۰).

۲-۳-۲ نظریات پیرامون طرحواره رهاشدگی

در حوزه طرحواره رهاشـــدگی، دیدگاه‌ها و الگوهای گوناگونی مطرح شـــده‌اند و در میان آنها دو نظریه از جامعیت بیشتری برخوردارند.

۲-۳-۲-۱ نظریه طرحواره‌های ناسازگار اولیه

بر اساس این نظریه، طرحواره رهاشدگی یکی از هجده الگوی ناسازگار اولیه به شمار می‌آید که شکل‌گیری آن به تجارب هیجانی و ارتباطی اوان کودکی بازمی‌گردد. حضور این طرحواره سبب می‌شود فرد همواره احتمال ترک شدن یا طرد شدن را در روابطش پیش‌بینی کند. الگوی طرحواره‌های ناسازگار اولیه که توسط جفری یانگ معرفی گردیده است، از مهم‌ترین رویکردها در توضیح چگونگی پدیدآمدن طرحواره رهاشدگی محسوب می‌شود. از دید این نظریه، طرحواره رهاشدگی به این باور بنیادین مربوط است که فرد پیش‌بینی می‌کند در روابط نزدیک خود یا رها خواهد شد یا نیازهای عاطفی‌اش پاسخ نخواهد گرفت. سرچشمه این طرحواره در سال‌های ابتدایی زندگی قرار دارد؛ زمانی که کودک احساس می‌کند خواسته‌های عاطفی‌اش نادیده گرفته شده، یا از سوی والدین و مراقبان اصلی طرد یا تنها گذاشته شده است (محمدی آشنانی، ۱۳۹۸).

یانگ این طرحواره را مشتمل بر مؤلفه‌هایی نظیر تجربه طردشدگی، احساس ناایمنی، تنهایی و بی‌ثباتی در روابط می‌داند؛ عناصری که به پیدایش باورهای ناکارآمد نسبت به خود و رابطه با دیگران منتهی می‌شوند. کسانی که گرفتار این طرحواره‌اند اغلب با نگرانی مداوم نسبت به طرد شدن دست به گریبان‌اند؛ نگرانی‌هایی که موجب دشواری در روابط و سازگاری بین‌فردی می‌گردد. از دیدگاه یانگ، اصلاح این طرحواره از مسیر بازسازی شناختی، ایجاد روابط سالم و فراهم‌کردن تجارب مثبت جایگزین امکان‌پذیر است. در مجموع، نظریه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ چارچوبی گسترده برای فهم و درمان طرحواره رهاشدگی ارائه می‌کند (شریعت، ۱۴۰۰).

۲-۳-۲-۲ نظریه دلبستگی

این نظریه تأکید می‌کند که الگوهای دلبستگی ناایمن در دوره کودکی زمینه‌ساز شکل‌گیری طرحواره رهاشدگی در بزرگ‌سالی هستند. کودکانی که از دلبستگی ناایمن برخوردار بوده‌اند، بیشتر در معرض ایجاد چنین طرحواره‌ای قرار می‌گیرند. نظریه پیوستگی از رویکردهای بنیادین در تبیین طرحواره رهاشدگی است. این نظریه که توسط پژوهشگرانی همچون جان بالبی و میری اینسورث مطرح شده، بیان می‌کند الگوهای دلبستگی‌ای که در سال‌های نخست زندگی شکل می‌گیرند، آثار پایداری بر روابط و طرحواره‌های فرد در بزرگ‌سالی بر جای می‌گذارند. یکی از این الگوها، دلبستگی ناایمن است (رحمانی، ۱۴۰۰). کسانی که در کودکی دلبستگی ناایمن را تجربه کرده‌اند، بیش از دیگران احتمال دارد با طرحواره رهاشدگی مواجه شوند. این افراد معمولاً انتظار دارند ترک شوند یا به روابط خود اعتماد کافی ندارند. اشخاصی که با این طرحواره زندگی می‌کنند ممکن است یکی از دو حالت را در واکنش به ترس از رها شدن نشان دهند: یا از روابط صمیمانه فاصله می‌گیرند، یا به شکل افراطی به دیگران وابسته می‌شوند تا از این طریق احساس امنیت کنند. در این دیدگاه، درمان طرحواره رهاشدگی مستلزم بازسازی الگوهای دلبستگی ناایمن و ایجاد روابط پایدار و امن است. به طور کلی، نظریه پیوستگی بر اهمیت تجربه‌های دلبستگی اولیه در پیدایش طرحواره رهاشدگی تأکید می‌نماید و شیوه‌های درمانی هماهنگ با این بنیان را پیشنهاد می‌کند (قادری و همکاران، ۱۳۹۹).

۲-۳-۳ عوامل موثر بر طرحواره رهاشدگی

۲-۳-۳-۱ تجارب دوران کودکی

رویدادهای منفی در سال‌های اولیه زندگی، از قبیل بی‌توجهی، طرد شدن یا نداشتن حمایت کافی از سوی والدین و مراقبان اصلی، از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری طرحواره رهاشدگی محسوب می‌شوند. کودکانی که درک می‌کنند والدین یا سرپرستان‌شان نسبت به نیازهای عاطفی و خواسته‌هایشان بی‌اعتنا بوده‌اند یا آنان را ترک کرده‌اند، بیشتر در معرض توسعه این طرحواره قرار دارند. نبود احساس امنیت و حمایت هیجانی مناسب در کودک سبب می‌شود این باور در او شکل گیرد که خواسته‌های درونی و نیازهای احساسی‌اش هرگز برآورده نمی‌شود. تجربه بی‌ثباتی و ناپایداری در رابطه با والدین یا مراقبان اصلی می‌تواند ذهن کودک را به این باور سوق دهد که روابط انسانی ذاتاً ناامن و ناپایدارند. حتی تجربه طلاق والدین نیز در سنین پایین مستقیماً بر ایجاد این سازه ذهنی اثرگذار است. علاوه بر این، آسیب‌های نظیر غفلت هیجانی، تجاوز یا سوءرفتار جسمی و عاطفی می‌توانند در سال‌های بعد زندگی بزرگ‌سالی به تقویت یا تداوم طرحواره رهاشدگی منجر شوند (ایمانی فرد، ۱۳۹۹).

۲-۳-۳-۲ الگوهای دلبستگی ناایمن

مطابق نظریه دلبستگی، روابط دلبستگی ناکارآمد در دوران کودکی نقش اساسی در پیدایش طرحواره رهاشدگی دارند. کودکانی که دلبستگی اجتنابی یا دوسوگرا تجربه می‌کنند، باور دارند روابط قابل اعتماد نیست و نیازهای عاطفی‌شان برطرف نخواهد شد. این طرز تلقی ذهنی، بستر شکل‌گیری احساس رهاشدگی در بزرگ‌سالی است. کودکانی با دلبستگی دوسوگرا عمدتاً بین احساس میل به نزدیکی و ترس از دوری در نوسان‌اند و این دوگانگی، سردرگمی و اضطراب رابطه‌ای آنان را افزایش می‌دهد. در نتیجه، رابطه‌شان پر از انتظار طرد شدن و احساس عدم امنیت می‌شود. چنین تجربیاتی در کودکی معمولاً در روابط بعدی تکرار می‌گردند و فرد بدون آگاهی، الگوهای مشابهی از وابستگی پرتنش یا اجتناب را دنبال می‌کند که به پایداری طرحواره رهاشدگی می‌انجامد. فقدان پیوندهای ایمن در دوران کودکی همچنین مانع استقرار روابط سالم در بزرگ‌سالی شده و به تثبیت این طرحواره می‌انجامد (جعفریان، ۱۳۹۸).

۲-۳-۳-۳ مؤلفه‌های شخصیتی

برخی خصوصیات شخصیتی، مانند اضطراب بالا، افسردگی، نگرانی مفرط و گرایش به افکار منفی، بستر مساعدی برای شکل‌گیری و استمرار طرحواره رهاشدگی فراهم می‌کنند. افرادی با ویژگی‌های هیجانی شکننده، معمولاً دچار ترس دائمی از دست دادن روابط یا طرد شدن از سوی دیگران‌اند و در نتیجه، بیش از دیگران مستعد درونی‌سازی این طرحواره هستند. صفات مرتبط با افسردگی نظیر ناامیدی، احساس بی‌ارزشی و دیدگاه منفی به خود نیز در این زمینه تأثیر دارند. حساسیت هیجانی بیش از اندازه، وابستگی افراطی به اطرافیان و نیاز شدید به تأیید اجتماعی، همگی با طرحواره رهاشدگی همپوشانی دارند و تعامل متقابل آن‌ها موجب تداوم چرخه اضطراب و وابستگی می‌شود. فردی که عزت‌نفس پایینی دارد، غالباً خود را شخصی ناکافی، طردشدنی و فاقد جذابیت یا ارزش برای دوست داشته شدن می‌پندارد، و همین باور ناکارآمد به تقویت طرحواره رهاشدگی می‌انجامد (ابراهیم‌نژاد شهربابکی، ۱۳۹۷).

۲-۳-۳-۴ نگرش‌ها و باورهای منفی

اعتقادات غیرمنطقی و دیدگاه‌های منفی درباره خود و روابط میان‌فردی، عامل مهمی در ایجاد یا تداوم طرحواره رهاشدگی هستند. کسانی که ارزش و استعداد خود را کم‌ارزش می‌دانند، بیشتر احتمال دارد احساس کنند غیرقابل محبت یا طردشدنی‌اند. وقتی فرد باور دارد قادر نیست روابط پایدار و مطمئن برقرار کند یا دیگران دائماً او را ترک خواهند کرد، ذهنش این تصور را به واقعیت تبدیل می‌کند. تمرکز بر تجارب گذشته‌ی طرد شدن یا ترک شدن و تعمیم آن‌ها به آینده، به تقویت احساس ناامنی و استمرار طرحواره رهاشدگی منجر می‌شود. ناتوانی در پذیرش نقص‌ها و خطاهای شخصی نیز از مؤلفه‌های کلیدی این فرآیند است؛ فردی که خود را ذلتاً ناقص و دوست‌نداشتنی می‌بیند، زمینه ذهنی پایداری برای این طرحواره ایجاد می‌کند (طالب‌لو و محمدی، ۱۴۰۰).

۲-۳-۳-۵ عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل محیطی و باورهای فرهنگی خانواده، از جمله هنجارهای اجتماعی، نقش‌های جنسیتی و ارزش‌های مرتبط با وابستگی، می‌توانند بر شدت و دوام طرحواره رهاشدگی اثرگذار باشند. در برخی فرهنگ‌ها، اهمیت افراطی روابط یا ترس از رد شدن توسط دیگران موجب تثبیت ذهنیت وابستگی و آسیب‌پذیری نسبت به طرد می‌شود. همچنین، در جوامعی که توقعات نقش‌محور برای زنان و مردان متفاوت است، احتمال شکل‌گیری این طرحواره در یکی از دو جنس افزایش می‌یابد. محیط‌هایی با حمایت اجتماعی یا عاطفی لندک—مانند خانواده‌های گسیخته، مدارس یا محل‌های کار فاقد همدلی—شرایط مساعدی برای گسترش احساس رهاشدگی فراهم می‌کنند. تعاملات ناسالم در خانواده و جامعه، که حاوی طرد یا واکنش‌های سرد هستند، می‌توانند این طرحواره را تثبیت کنند. در نواحی محروم یا فقیر که دسترسی به منابع حمایتی اجتماعی و عاطفی محدود است، خطر شکل‌گیری طرحواره رهاشدگی بیشتر مشاهده می‌شود (ایمانی فرد، ۱۳۹۹).

۲-۳-۴ اهمیت طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی می‌تواند تأثیر گسترده‌ای بر روابط بین‌فردی و کیفیت تعاملات اجتماعی فرد بر جای بگذارد. افرادی که درگیر این الگوی ذهنی هستند، معمولاً در ایجاد ارتباطات نزدیک، صمیمانه و پایدار با دیگران با دشواری روبه‌رو می‌شوند. این طرحواره با اختلال‌های هیجانی و روان‌شناختی مانند افسردگی، اضطراب و مشکلات تنظیم هیجان در ارتباط است و می‌تولند سلامت روان فرد را به طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. اگر این طرحواره در سال‌های اولیه زندگی شکل گرفته باشد، احتمال دارد به صورت پایدار و مزمن در بزرگ‌سالی باقی بماند و مشکلات شخصیتی و چالش‌های ارتباطی فرد را تشدید کند (محمدی آشنانی، ۱۳۹۸). همچنین، این الگوی ناسازگار می‌تواند با طرحواره‌های دیگری مانند بی‌کفایتی یا بی‌اعتمادی وارد تعامل شده و شدت آن‌ها را نیز افزایش دهد. این هم‌پوشانی طرحواره‌ها معمولاً به چرخه‌ای از نگرانی، ناامنی و وابستگی منتهی می‌شود که خروج از آن بدون مداخله درمانی دشوار است. ریشه‌های عمیق این طرحواره در دوران کودکی، همراه با پیوند آن با ابعاد مختلف شخصیت، معمولاً فرایند درمان را پیچیده و چالش‌برانگیز می‌سازد. با این حال، شناسایی این طرحواره به‌عنوان یک آسیب‌پذیری مهم روان‌شناختی، می‌تواند به درک بهتر مشکلات هیجانی و ارتباطی فرد کمک کند و مسیر درمان را روشن‌تر سازد.

توجه به این الگو و مداخله به‌موقع، نقش مهمی در ارتقای سلامت روان و بهبود کیفیت زندگی افرادی دارد که با طرحواره رهاشدگی درگیر هستند (قادری و همکاران، ۱۳۹۹).

۲-۴ شرم

شرم به‌عنوان هیجانی نیرومند شناخته می‌شود که با حس حقارت، برداشت بی‌ارزشی و تصویر ذهنی آسیب‌دیده از خویشتن در ارتباط قرار می‌گیرد (تانونگنی و دیرینگ، ۲۰۰۲، به نقل از ریو، ۱۳۹۵). در هر دیدگاه یا چهارچوب نظری که مطرح می‌شود، این احساس تأثیری فرساینده دارد و به‌نظر می‌رسد جزئی جدایی‌ناپذیر از تجربه زیستی انسان باشد. علاوه بر این، شدت و شکل بروز آن در زمان‌ها و موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کند و چنین تغییری طبیعی است؛ زیرا شرم بخشی از فرایند کنترل اجتماعی به‌شمار می‌آید که پس از نافرمانی نسبت به اصول اخلاقی یا واگذاری رفتار شایسته، ظاهر می‌گردد. افزون بر این، شرم نوعی هیجان مبتنی بر خودآگاهی و برآمده از بازتاب درونی است (خداپناهی، ۱۳۹۶). در حقیقت، این احساس نمود نوعی ارزیابی کلی و منفی از خویشتن است که معمولاً با درماندگی یا نوعی ناتوانی در اصلاح رفتار اشتباه همراه می‌شود. به‌طور کلی، تجربه شرم محوریت را بر خویشتن قرار می‌دهد؛ فرد پس از بروز خطا، برداشت منفی از خود پیداکرده و خود را انسانی نالایق یا بد تلقی می‌کند. این هیجان دردناک در نتیجه از دست رفتن حرمت و احترام شخص نزد دیگران و به‌علت رفتار نادرست یا فقدان شایستگی ایجاد می‌شود (حسین‌آبادی، ۱۳۹۰).

احساس شرم بیشتر ماهیتی درونی دارد و مجموعه‌ای از واکنش‌های روانی و بدنی را برمی‌انگیزد که مشابه حالتی است که انسان در هنگام مواجهه با ضربه تجربه می‌کند (ماتوس و پینو گوویا[1]، ۲۰۱۰). یعنی هنگامی که فرد شرم را تجربه می‌کند، مجموعه‌ای از پاسخ‌های فیزیولوژیک و رفتاری مانند سرخ شدن چهره، پایین گرفتن سر، اجتناب از نگاه مستقیم، جمع شدن بدن، سکوت ناگهانی، پوشاندن صورت، انجماد رفتاری، افزایش کورتیزول و بالا رفتن تپش قلب بروز می‌یابد (شور[2]، ۲۰۲۰). افرادی که این احساس را تجربه می‌کنند، معمولاً اسنادهای منفی درونی و پایدار بیشتری دارند، خود را سرزنش می‌کنند، دیگران را نیز به‌سبب اتفاقات ناخوشایند مؤاخذه می‌کنند و برداشت‌های منفی نسبت به رویدادهای ناگوار نشان می‌دهند (کاولیرا و پیپه[3]، ۲۰۱۴). افزون بر این، افراد هنگام مواجهه با موقعیتی آمیخته با شرم، اغلب تلاش می‌کنند آن را انکار کنند، پنهان سازند، از موقعیت دور شوند یا محیطی که باعث برانگیخته شدن این احساس می‌شود ترک کنند (تیگنور و کالوین[4]، ۲۰۱۹). شکست در انجام وظایفی که آسان تلقی می‌شوند نیز احتمالاً موجب برانگیخته‌شدن شرم خواهد شد. چنین ناکامی‌هایی در سطح اخلاقی یا عملکردی پیامدهایی دارند که به فرد هشدار می‌دهد نقصی در وجود او قرار دارد. این پیام سبب می‌شود

[1] Matos & Pinto-Gouveia
[2] Schore
[3] Cavalera & Pepe
[4] Tignor & Colvin

شرم به‌عنوان هیجانی «نامطلوب» تلقی گردد؛ احساسی که با رنج شدید، سردرگمی ذهنی، دشواری در بیان تجربه هیجانی، میل فراوان برای دوری از دیگران، نشخوار فکری و حمله هیجانی به خویشتن همراه است (ریو، ۱۳۹۵).

۲-۴-۱ انواع شرم

به‌طور کلی برای هیجان شرم دسته‌بندی‌های گوناگونی مطرح شده است؛ بااین‌حال یکی از رایج‌ترین شیوه‌های طبقه‌بندی، این احساس را به دو نوع «استعداد شرم یا شرم صفتی» و «شرم حالتی» تقسیم می‌کند (باخمن-وایلدبام[1] و همکاران، ۲۰۲۱). زمانی از استعداد شرم یا شرم صفت سخن گفته می‌شود که فرد در موقعیت‌های مختلف گرایش دارد شرم را به شکلی شدید و ناسازگار تجربه کند؛ به گونه‌ای که حتی در شرایطی که محرک آشکاری برای برانگیخته شدن این احساس وجود ندارد، باز هم آن را ادراک و تجربه می‌کند. این ویژگی دربرگیرنده دو جنبه است: نخست شرم درونی که به قضاوت و ارزیابی منفی فرد نسبت به محدودیت‌ها و کاستی‌های شخصی خود اشاره دارد، و دوم شرم بیرونی که به برداشت فرد از نگاه و داوری دیگران مربوط می‌شود؛ زمانی که فرد تصور می‌کند دیگران او را ضعیف یا ناقص ارزیابی می‌کنند (سینها[2]، ۲۰۱۷).

برخی پژوهشگران بر این باورند که استعداد شرم زمانی به مسئله‌ای مشکل‌آفرین تبدیل می‌شود که به پریشانی و آشفتگی روانی منجر گردد (شولنبر[3] و همکاران، ۲۰۲۱). در مقابل، شرم حالتی ماهیتی گذرا و موقتی دارد و تجربه آن به رویدادی وابسته است که در یک موقعیت مشخص رخ می‌دهد (مارتینس و همکاران، ۲۰۱۶). به بیان دیگر، در این نوع از شرم، فرد الزاماً دارای احساسی پایدار و درونی‌شده نیست که همواره بدون وجود محرک فعال شود؛ بلکه بسته به شرایط و رخدادهای محیطی ممکن است چنین احساسی را تجربه کند یا اصلاً دچار آن نشود. افزون بر این، تقسیم‌بندی دیگری نیز وجود دارد که شرم را به دو نوع آشکار و ضمنی تفکیک می‌کند (اونوکا و ویزین[4]، ۲۰۱۷). در این چارچوب، فرد نسبت به شرم آشکار آگاهی دارد و می‌تواند آن را از طریق پرسش‌های مستقیم، مانند ابزارهای خودگزارشی، ارزیابی و گزارش کند. در مقابل، شرم ضمنی حالتی است که فرد آگاهی مستقیمی نسبت به آن ندارد و این احساس به‌صورت خودکار در او فعال می‌شود؛ ازاین‌رو برای سنجش آن معمولاً لازم است از روش‌ها و ابزارهای غیرمستقیم استفاده شود (شونلبر و همکاران، ۲۰۲۱). برخی محققان نیز معتقدند اگر شرم ناهوشیار به‌درستی تنظیم نشود، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری آسیب‌های روان‌شناختی ایفا کند (شور، ۲۰۱۹).

۲-۴-۲ تفاوت شرم با گناه

این دو هیجان، به‌طور کلی در موارد متعددی با یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند. از مهم‌ترین این تمایزها می‌توان به این نکته اشاره کرد که احساس گناه به ارزیابی رفتار فرد مربوط می‌شود، در حالی که شرم با ارزیابی خودِ فرد ارتباط دارد (اسپرویت و همکاران، ۲۰۱۶). به بیان دیگر، شرم با کوچک شمردن خود، احساس ناتوانی، خواری و بی‌ارزشی همراه است و کل هویت و وجود فرد را درگیر می‌کند؛ اما گناه بر یک رفتار یا عمل خاص متمرکز است (ویلیامز و

[1] Buchman-Wildbaum
[2] Sinha
[3] Schoenleber
[4] Unoka & Vizin

بیبی[1]، ۱۹۹۴). تفاوت مهم دیگر میان این دو هیجان، به نوع اسنادهایی مربوط می‌شود که افراد در هر حالت به کار می‌برند. در این زمینه، تریسی و رابینز (۲۰۰۶) اظهار می‌کنند که شرم با اسنادهای درونی، پایدار و کنترل‌ناپذیر همراه است, در حالی که گناه با اسنادهای درونی، ناپایدار و کنترل‌پذیر درباره شکست ارتباط دارد. احساس گناه می‌تواند موجب افزایش همدلی شود، اما تجربه شرم، توانایی فرد در ایجاد و حفظ روابط همدلانه را تضعیف می‌کند (هاول[2] و همکاران، ۲۰۱۲). علاوه بر این، براساس دیدگاه ترونی و دئونا[3] (۲۰۰۸)، شرم مانعی برای برقراری روابط صمیمی به شمار می‌رود؛ در حالی که احساس گناه در جهت سازگاری اجتماعی و حفظ روابط نقش حمایتی ایفا می‌کند. همچنین می‌توان گفت شرم بیشتر با ایده‌آل‌ها و تصورات فرد از خود مرتبط است، اما گناه به نقض ممنوعیت‌ها و خطاهای رفتاری مربوط می‌شود. در نهایت نیز شرم فرد را به سمت خود هدایت می‌کند، در حالی که گناه توجه او را به دیگران و پیامدهای رفتار خود معطوف می‌سازد.

۲-۴-۳ نظریات پیرامون شرم

۲-۴-۳-۱ دیدگاه روانکاوری

فروید[4] نخستین بار مفهوم «ایگوی آرمانی» را مطرح می‌سازد؛ برداشتی که پایه‌ای برای شکل‌دهی «سوپراِگو» به شمار می‌آید. بر اساس دیدگاه فروید، ایگوی آرمانی تصویری از خویشتن است که فرد آن را مطلوب و شایسته می‌پندارد و تمایل دارد همان باشد. او همچنین بیان می‌کند هر بخش از رفتار انسان که با این تصویر آرمانی تعارض پیدا کند، می‌تولند احساس شرم یا گناه را برانگیزد (فروید، ۱۹۱۴). مطابق نظر وی، ساختار سوپراِگو نتیجه دگرگونی‌هایی در ایگوست که از طریق همانندسازی کودک با ویژگی‌های شخصیتی والدین به وجود می‌آید. فروید توضیح می‌دهد این دگرگونی‌ها چگونه موجب شکل‌گیری عاملی می‌شوند که جایگاه ویژه‌ای را در ذهن اشغال کرده و بخش تغییر یافته ایگو از این جایگاه، همانند یک ایگوی برتر یا سوپراِگو عمل کرده و سایر جنبه‌های شخصیت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. او با اشاره به خصلت سختگیرانه این بخش، آن را سرچشمه احساس گناه هشیار معرفی می‌کند که انسان آن را به صورت وجدان تجربه می‌نماید؛ اما هم‌زمان نوعی گناه ناخودآگاه نیز در فرد ایجاد می‌گردد. سوپراِگو دو نقش عمده بر عهده دارد: از یک‌سو معیارها و ایده‌آل‌هایی همچون «تو باید مانند این فرد باشی!» را تعیین می‌کند و از سوی دیگر انتخاب‌های انسان را با پیام‌هایی مانند «نباید شبیه او – پدر – باشی» محدود می‌سازد (فروید، ۱۹۲۳). در نگاهی کلی، وظایف نظام فراخود شامل نظارت بر ایگو، تعیین ارزش‌ها و معیارهای رفتاری، داوری و اعمال تنبیه یا سرزنش نسبت به خود و دیگران است (بارنت[5] و همکاران، ۲۰۱۸).

---

[1] Williams & Bybee
[2] Howell
[3] Teroni & Deonna
[4] Freud
[5] Barnett

از زاویه‌ای دیگر می‌توان فرآیند فراخود را این‌گونه توصیف کرد که گرایش برخی افراد به انتقادهای شدید، طاقت‌فرسا و افراطی از خویش، بخشی از کارکرد این ساختار در نظریه روان‌کاوی محسوب می‌شود. فراخود جنبه اخلاقی شخصیت انسان را تشکیل می‌دهد و دربرگیرنده هنجارها و باورهای ارزشی است؛ به عبارتی همان بخشی است که مردم آن را عالی‌ترین وجه اصول انسانی می‌دانند. طبق دیدگاه فروید، رشد و شکل‌گیری فراخود ارتباطی مستقیم با چگونگی رابطه و نقش والدین دارد. پیامد این نفوذ آن است که فراخود، فرد را برای رفتارهایی که در نگاه جامعه نادرست و ناپسند محسوب می‌شود سرزنش و مجازات کرده و برای اعمال مطلوب و پسندیده پاداش یا تایید فراهم می‌آورد. فراخودی که از حد معمول فعال‌تر باشد نوعی احساس گناه ناآگاهانه در فرد ایجاد خواهد کرد (مونگرین و لایتن[1]، ۲۰۰۶).

۲-۴-۳-۲ نظریه طرحواره های هیجانی

نظریه طرحواره‌های هیجانی، «مدل طرحواره هیجانی» را به‌عنوان یک چارچوب شناختی-اجتماعی برای تبیین شیوه ادراک، تفسیر، ارزیابی و پاسخ‌دهی افراد به احساسات خود و دیگران معرفی می‌کند. در این الگو، ایده‌ی «طرحواره» از دیدگاه پردازش اطلاعات اقتباس شده است و در حوزه باورهای مربوط به هیجان‌ها به کار می‌رود (لیهی[2]، ۲۰۱۹). به بیان دیگر، طرحواره‌های هیجانی نوعی ساختار ذهنی برای پردازش، سنجش و تفسیر تجربه‌های عاطفی هستند که فرد هنگام مواجهه با مسائل هیجانی بروز می‌دهد و این ساختارها بر شیوه برداشت او از رویدادهای هیجانی اثر می‌گذارند؛ بنابراین، پاسخ هر شخص بسته به معنایی که به تجربه‌های هیجانی خود نسبت می‌دهد و نیز تفسیر خاصی که از آن‌ها دارد، متفاوت خواهد بود (اصغری و میان‌آبادی، ۱۳۹۷). بر مبنای این دیدگاه، انسان‌ها فقط اتفاقات بیرونی را تفسیر نمی‌کنند، بلکه تجربه‌های درونی خود را هم مورد تعبیر و معناپردازی قرار می‌دهند (لیهی، ۲۰۱۹).

لیهی ۱۵ نوع طرحواره را مطرح کرده است که عبارت‌اند از:

۱- تأییدطلبی (دیگران متوجه می‌شوند فرد چه احساسی دارد)؛
۲- شرم (فرد بر این باور است که احساس گناه و شرمساری برایش معنا ندارد)؛
۳- قابل درک بودن (هیجان‌ها باید برای خود فرد مفهوم داشته باشند)؛
۴- دیدگاه ساده‌انگارانه درباره هیجان‌ها (شخص معتقد است نباید احساسات درهم‌آمیخته و پیچیده‌ای را تجربه کند)؛
۵- ارزش‌های والاتر (هیجانات بازتاب‌دهنده ارزش‌های متعالی فرد هستند)؛

[1] Mongrain & Leather
[2] Leahy

۶- کنترل (فرد نگران است احساساتش از اختیار او خارج شود)؛

۷- تلاش برای منطقی بودن (باید شخصی عقلانی و استدلال‌محور باشم، نه فردی تحت تأثیر هیجان)؛

۸- طول دوره (هیجان‌ها برای مدت طولانی تداوم خواهند یافت)؛

۹- توافق (سایر افراد همان احساساتی را دارند که شخص تجربه می‌کند)؛

۱۰- پذیرش احساسات (فرد نمی‌تواند هیجاناتی را که در خود دارد بپذیرد)؛

۱۱- نشخوار ذهنی یا اندیشناکی (گوشه‌ای می‌نشیند و مدام به این موضوع فکر می‌کند که چه احساسات ناخوشایندی را تجربه می‌کند)؛

۱۲- ابراز هیجان‌ها (نمی‌تواند به خودش اجازه گریه کردن بدهد)؛

۱۳- سرزنش (دیگران را عامل ایجاد این احساسات در خود می‌داند)؛

۱۴- کرختی (در تجربه کردن هیجان‌ها با دشواری روبه‌روست)؛

۱۵- بیان (به خود اجازه می‌دهد در حضور دیگران احساساتش را ابراز کند) (لیهی، ۲۰۰۱).

برخی از این طرحواره‌ها، به‌خصوص آن دسته که عمدتاً در نتیجه تجربه‌های ناخوشایند دوران کودکی شکل می‌گیرند، ممکن است هسته اصلی بسیاری از اختلال‌های شخصیت و مشکلات میان‌فردی را تشکیل دهند (لیهی، ۲۰۱۲). برای نمونه، اشخاصی که میزان زیادی هیجان منفی را تجربه می‌کنند، گرایش دارند در موقعیت‌های نسبتاً استرس‌زا یا نامطلوب واکنش‌های بسیار شدید نشان دهند؛ این افراد خودشان را سرزنش می‌کنند، با شدت زیادی نسبت به خود انتقاد دارند و نسبت به دیگران نیز حساسیت افراطی بروز می‌دهند (پیرساقی و همکاران، ۱۳۹۴).

وللدینی که شیوه طرد و کنار گذاشتن را در رابطه با فرزند به کار می‌گیرند، می‌توانند زمینه شکل‌گیری احساس شرم و گناه را در کودکان خود فراهم کنند. افرادی که دارای طرحواره نقص/شرم هستند، خود را موجوداتی ناقص، حقیر یا بی‌ارزش می‌دانند و باور دارند اگر در معرض دید و قضاوت دیگران قرار بگیرند، بی‌تردید طرد خواهند شد (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳). در نتیجه، یک الگوی ناسازگار در رابطه با احساس گناه و شرم در فرد شکل می‌گیرد که او را به این باور می‌رساند نباید احساسات شخصی داشته باشد یا این‌که دیگران نباید از هیجان‌های او باخبر شوند. چنین افرادی پیوسته خود را مورد ملامت و انتقاد قرار می‌دهند، احساسات خود را پنهان نگه می‌دارند و نسبت به هیجان‌هایشان اضطراب و اندوه زیادی تجربه می‌کنند. برای مثال، خشم را هیجانی نادرست تلقی می‌کنند و آن را به‌عنوان بخشی طبیعی از تجربه انسان بودن نمی‌پذیرند (لیهی، ۲۰۱۵).

۲-۴-۳-۳ دیدگاه وجودی

در رویکرد وجودی، احساس مسئولیت یکی از مؤلفه‌های اصلی نگرانی‌های وجودی به شمار می‌آید و به‌طور مستقیم از آزادی انسان ناشی می‌شود. از دیدگاه راچمن[1] (۱۹۹۷)، معمولاً تجربه احساس گناه و حس مسئولیت به‌صورت همزمان رخ می‌دهد. هنگامی که فرد نسبت به داشتن افکار منفی مشخص یا نسبت به پیشگیری نکردن از پیامدهای زیان‌بار مرتبط با این افکار خود را مسئول بداند، احتمال زیادی وجود دارد که به دلیل داشتن چنین افکاری دچار احساس گناه نیز شود. میچلی[2] (۱۹۹۲) نیز بر این باور است که انسان در برابر اموری که نسبت به آن‌ها احساس مسئولیت ندارد، احساس گناه نخواهد کرد. مسئولیت می‌تواند ناشی از وقوع یک رویداد یا ناشی از جلوگیری نکردن از آغاز برخی اتفاقات باشد. به اعتقاد او، برای آنکه فرد در روابط میان‌فردی احساس گناه را تجربه کند، لازم است نسبت به شرایط موجود نوعی احساس مسئولیت داشته باشد؛ به این معنا که باور داشته باشد عمل او یا حتی انجام ندادن یک اقدام از سوی او می‌تواند به دیگران آسیب وارد کند.

تانجنی و دیرینگ[3] (۲۰۰۲) نیز بیان می‌کنند افرادی که گرایش بیشتری به تجربه احساس گناه دارند، نسبت به نقش خود در موقعیت‌های میان‌فردی آگاهی بیشتری نشان می‌دهند و در قبال این موقعیت‌ها احساس تعهد و مسئولیت می‌کنند. همچنین راچمن (۱۹۹۷) اشاره می‌کند که اگر فرد برای داشتن افکار منفی خاص یا برای جلوگیری نکردن از آسیب‌های ناشی از آن افکار خود را مسئول بداند، به احتمال زیاد در پی آن افکار دچار احساس گناه نیز خواهد شد. در مواردی که شخص نسبت به رویدادهایی احساس مسئولیت می‌کند که در واقع خارج از کنترل او قرار دارند، ممکن است شکست را تجربه کند؛ شکستی که نمی‌تواند آن را به عوامل بیرونی نسبت دهد و در نتیجه به سرزنش خود روی می‌آورد. بنابراین منطقی به نظر می‌رسد هرچه میزان احساس مسئولیت در افراد بیشتر باشد، احتمال تجربه احساس گناه نیز در آن‌ها افزایش یابد.

۲-۴-۴ عوامل خانوادگی موثر بر شکل گیری احساس شرمساری

بر اساس مبانی نظری، احساس شرم و گناه همانند سایر هیجان‌های اجتماعی تحت تأثیر خانواده اصلی فرد قرار دارند (بسر و پریل[4]، ۲۰۰۶؛ هارپر، ۲۰۱۱) و ریشه آن‌ها را می‌توان در روابط اولیه والد–کودک جست‌وجو کرد (لیری[5]، ۲۰۱۵). در واقع تجربه‌های اولیه فرد در تعامل با والدین نقش مهمی در شکل‌گیری این هیجان‌ها دارد، به‌گونه‌ای که بدرفتاری یا سوءرفتار در دوران کودکی می‌تواند در شکل‌گیری و تقویت احساس شرم و گناه نقش داشته باشد (بسر و پریل، ۲۰۰۶؛ هارپر، ۲۰۱۱). همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد افرادی که از سبک دلبستگی ایمن

[1] Rachman
[2] Miceli
[3] Tangney & Dearing
[4] Bser & Prill
[5] Leary

برخوردارند، نسبت به دیگران کمتر در معرض تجربه احساس شرم و گناه قرار می‌گیرند (میکولینسر و اورباخ[1]، ۱۹۹۵). در مقابل، در افرادی که دارای سبک‌های دلبستگی ناایمن، به‌ویژه دلبستگی اضطرابی و اجتنابی هستند، احتمال تجربه این دو هیجان بیشتر مشاهده می‌شود (بارنت و همکاران، ۲۰۰۷).

بررسی‌ها همچنین نشان داده‌اند که الگوهای فرزندپروری والدین با احساس شرم رابطه دارند. به‌طور خاص، سبک‌های تربیتی گرم و حمایتگرانه با میزان کمتر احساس شرم در فرزندان همراه است، در حالی که حمایت افراطی و کنترل بیش از حد والدین رابطه مستقیمی با افزایش این هیجان دارد. به عبارت دیگر، هرچه میزان گرمی، صمیمیت و مراقبت والدین کاهش یابد و در مقابل کنترل و حمایت افراطی آنان افزایش پیدا کند، احتمال تجربه احساس شرم در فرزندان بیشتر می‌شود (نقل از انوشه‌ای و همکاران، ۱۳۸۷). علاوه بر این، والدینی که در شیوه تربیتی خود از الگوی رفتاری پرخاشگر–منفعل استفاده می‌کنند، حتی اگر از تنبیه بدنی بهره نگیرند، ممکن است از طریق القای احساس «بد بودن» به کودک و ابراز نارضایتی مداوم از او، زمینه تجربه احساس شرم و گناه را در فرزند فراهم کنند. در چنین شرایطی کودک با این احساس‌ها تنها گذاشته می‌شود و این هیجان‌ها تنها زمانی کاهش می‌یابند که فرد خود را سرزنش یا تنبیه کند (اینبار[2] و همکاران، ۲۰۱۳).

۲-۴-۵ کارکرد شرم در اجتماع

در زمینه سازوکار شرم در روابط فردی و اجتماعی، پژوهش‌ها نتایج متفاوتی ارائه کرده‌اند. برخی مطالعات، شرم را هیجانی سازنده و ضروری برای حفظ ارزش‌های اخلاقی و رعایت قوانین اجتماعی می‌دانند (گاولز[3] و همکاران، ۲۰۱۶). در مقابل، دیگر پژوهش‌ها نشان داده‌اند که شرم ممکن است باعث گسستن پیوندهای اجتماعی، کناره‌گیری از روابط و ترس از تعاملات بین‌فردی شود (دوراهی[4] و همکاران، ۲۰۱۷). الیسون (۲۰۱۹) از جمله نظریه‌پردازانی است که نقش عمده‌ای برای شرم در تنظیم روابط اجتماعی قائل است. او استدلال می‌کند که شرم را می‌توان دارای ریشه‌ای تکاملی دانست، به‌طوری‌که عملکردی مشابه درد جسمانی دارد: همان‌طور که درد جسمانی فرد را نسبت به آسیب بدنی آگاه می‌کند، شرم نیز به‌عنوان یک «درد اجتماعی» عمل می‌کند که فرد را از خطر طرد شدن توسط دیگران آگاه می‌سازد. به‌این‌ترتیب، تجربه شرم به فرد هشدار می‌دهد تا رفتارهای خود را با هنجارهای گروه و جامعه سازگار سازد و از رفتارهایی که موجب از دست دادن جایگاه اجتماعی یا احترام دیگران می‌شود، اجتناب کند. در این دیدگاه، شرم به انسان‌ها کمک می‌کند هنجارهای اجتماعی را بیاموزند، رعایت کنند و به آن‌ها احترام بگذارند؛

[1] Mikulincer & Orbach
[2] Inbar
[3] Gausel
[4] Dorahy

زیرا این امر موجب جلب پذیرش و احترام از جانب دیگران می‌شـــود و در نهایت از طرد شـــدن فرد در جمع جلوگیری می‌کند. در واقع، شرم به نوعی سازوکار حفظ انسجام اجتماعی است.

از ســـوی دیگر، احســـاس گناه ماهیتی فرهنگی دارد و در چارچوب ارزش‌های اخلاقی هر جامعه معنا پیدا می‌کند. در فرهنگ‌های شـــرقی، ارزش‌هایی مانند وفاداری، عشـــق ورزیدن، تعهد به خانواده و مســـئولیت‌پذیری، از اهمیت بالایی برخوردارند. زمانی که فرد از این ارزش‌ها عدول کند، دچار احساس گناه می‌شود. به تعبیر قاضی‌مرادی (۱۳۸۳)، وجدان و حتی «فرامین درونی» افراد بر پایه همین نظام ارزش‌ها شـــکل می‌گیرد و هنگامی که فرد از این چارچوب اخلاقی فاصله می‌گیرد، وجدان او را به خاطر سرپیچی از آن سرزنش کرده و موجب پیدایش احساس گناه می‌شود. در نتیجه، می‌توان گفت احساس گناه از حس مسئولیت فرد در برابر حفظ قوانین اخلاقی جامعه سرچشمه می‌گیرد (کریمیان و همکاران، ۱۳۹۰). این حس، ســـازوکاری درونی اســـت که رفتارهای فرد را با اصـــول اخلاقی جمع‌پذیر نگه می‌دارد و بدین‌گونه سبب استمرار هماهنگی اجتماعی و اخلاقی می‌شود.

۲-۵ خودانتقادی

خودانتقادی به‌مثابه یک سازه شخصیتی ناسازگار شناخته می‌شود که طی آن، افکار داورانه، محکوم‌کننده و پرخاشگر به‌سوی خویشتن جهت می‌گیرند، به‌ویژه هنگامی که فرد با اشتباهات، ناکامی‌ها یا ناتوانی در انطباق با معیارهای خود یا دیگران مواجه می‌گردد (گیلبرت و همکاران، ۲۰۰۴؛ کامپوس[1] و همکاران، ۲۰۱۳). این ویژگی را می‌توان نوعی فرایند درونی دانست که به برداشت غلط از عملکرد شخصی، گرایش به معیارهای بسیار دشوار و احساس بی‌امیدی منجر می‌شـــود (زِلکویتز و کولِه[2]، ۲۰۱۹). در واقع، تمایل فرد برای داشـــتن انتظارات افراطی و ســـنجش مداوم کارکردهای خود باعث می‌شود که دستاوردهای شخصی را ناکافی تلقی کرده و استانداردهایی غیرواقعی و غیرقابل دستیابی برای خویش تعریف نماید (یو[3] و همکاران، ۲۰۱۷). افراد درگیر این الگو زمانی که خود را مورد انتقاد قرار می‌دهند، تمرکز ذهنی‌شان روی خویشتن افزایش می‌یابد؛ در نتیجه، احساس ناکافی بودن، خودآزاری و تجربه نفرت یا بیزاری از خود در آنان بروز پیدا می‌کند (گیلبرت، ۲۰۰۴).

آنان معمولاً بر دستیابی به اهداف شخصی تأکید فراوان دارند اما در عین حال، از خشنودی حاصل از موفقیت‌های خود ناتوان‌اند و نگاهشان به دستاوردها با قضاوت‌های سخت‌گیرانه همراه است (بلات و همکاران، ۲۰۱۰). چنین اشخاصی غالباً احساس بی‌ارزشی، شکست و گناه را تجربه می‌کنند (یو و همکاران، ۲۰۱۷). این

[1] Campos
[2] Zelkowitz & Cole
[3] You

خصلت روان‌شناختی درواقع تجلی یک کشمکش دائمی و عمیق میان جنبه‌های متفاوت خود است؛ تقابلی ارزشی که با تعیین معیارهای بیش‌ازحد سخت در عملکرد و سپس شکل‌گیری نگرش تنبیهی نسبت به خویشتن شناخته می‌شود (شهر[1] و همکاران، ۲۰۱۱؛ شهر، ۲۰۱۵). هرچند خودانتقادی به‌عنوان ساختاری پایدار در شخصیت افراد مطرح است، نوساناتی بر پایه شرایط ویژه، عوامل زیستی و زمینه‌های اجتماعی از خود نشان می‌دهد. افزون بر این، ممکن است به‌صورت یک سازوکار دفاعی عمل کند؛ ابزاری برای جلوگیری از طرد شدن یا واکنش‌های رقابتی دیگران در روابط بین‌فردی (زوروف و همکاران، ۲۰۱۵).

۲-۵-۱ انواع خودانتقادی

تامپسون و زوروف (۲۰۰۳) بر این باورند که دو گونه از خودانتقادی ناکارآمد با جنبه منفی وجود دارد: نخست خودانتقادی مقایسه‌ای و دوم خودانتقادی درونی. نوع نخست به عنوان نگرشی منفی نسبت به تصویر فرد از خود در برابر دیگران شناخته می‌شود. در این حالت، تمرکز اصلی فرد بر سنجش نامطلوب خود با سایرین است؛ به گونه‌ای که دیگران را برتر می‌بیند و در نتیجه، دیدگاهی خصمانه یا انتقادآمیز نسبت به آنان پیدا می‌کند. حاصل چنین ارزیابی‌هایی، بروز احساس ناراحتی و نارضایتی در تعاملات اجتماعی است. سطح دوم خودانتقادی، ناظر بر ارزیابی منفی فرد از خودش در مقایسه با معیارها و استانداردهای شخصی و خصوصی است؛ در این وضعیت، تمرکز ذهنی فرد بر کمبودها و نقص‌های درونی خویش قرار دارد و بازتاب این کاستی‌ها را از منظر خود مشاهده می‌کند (رضایی و جهان، ۱۳۹۴). گیلبرت و همکاران (۲۰۰۴) در پژوهش‌های خود نشان داده‌اند که نوع مقایسه‌ای این ویژگی می‌تواند زمینه‌ساز احساس یأس، حقارت و بی‌کفایتی گردد، در حالی‌که خودانتقادی درونی بیشتر با بروز نفرت و تنفر نسبت به خویشتن همراه است.

۲-۵-۲ نظریات پیرامون خودانتقادی

۲-۵-۲-۱ دیدگاه بلات

در نظریه بلات، یکی از فرض‌های بنیادی آن است که آسیب‌پذیری نسبت به افسردگی از تعامل میان رویدادهای گوناگون زندگی و ویژگی‌های شخصیتی افراد ناشی می‌شود. در این چارچوب، دو بعد مهم شخصیتی یعنی خودانتقادی و وابستگی به عنوان عوامل کلیدی در شکل‌گیری افسردگی معرفی شده‌اند (قدیری، ۱۳۹۸). هومن و بلات (۱۹۹۲) معتقدند افرادی که در بعد وابستگی نمره بالایی دارند، با ایجاد روابط بین‌فردی صمیمانه و رضایت‌بخش احساس انسجام درونی و موفقیت بیشتری تجربه می‌کنند. این افراد برای احساس ارزشمندی و رضایت از خود، به روابط نزدیک و حمایت دیگران تکیه می‌کنند و تأیید و پذیرش اطرافیان برایشان اهمیت اساسی دارد.

[1] Shahar

در مقابل، خودانتقادی نوعی خودکاوی و خودارزیابی سخت‌گیرانه و مداوم است که اغلب با نگرانی از قضاوت دیگران و ترس از دست دادن تأیید افراد مهم زندگی همراه است (زوروف و همکاران، ۲۰۰۶). افرادی که سطح بالایی از خودانتقادی دارند، به‌طور دائمی درگیر افکاری درباره دریافت تأیید، تحسین و احترام از سوی دیگران هستند، اما در عین حال نگران‌اند که وابستگی به این تأییدها استقلال و خودمختاری آنان را تهدید کند. این افراد برای ایجاد احساس ارزشمندی در خود، معیارها و انتظارات دیگران را درونی کرده و آن‌ها را مبنای ارزیابی خویش قرار می‌دهند (پاورز و همکاران، ۲۰۰۴). در نتیجه، زمانی که به اهداف مورد نظرشان دست نمی‌یابند، تجربه‌هایی مانند احساس گناه، بی‌ارزشی و شکست را تجربه می‌کنند.

۲-۵-۲-۲ دیدگاه عملکرد اجرایی خودتنظیمی

از سوی دیگر، مدل عملکرد اجرایی خودتنظیمی در رویکرد فراشناختی تلاش می‌کند پدیده نشخوار فکری را در قالب یک ساختار سه‌سطحی توضیح دهد. بر اساس این دیدگاه، نشخوار فکری با فرایندهای خودتنظیمی و ناکارآمدی هیجانی در چارچوبی چندلایه مرتبط است. مطابق این مدل، باورهای فراشناختی که از نشخوار ذهنی حمایت می‌کنند، در آغاز و تداوم این سبک تفکر نقش مهمی دارند. ولز و متیوز در سال ۱۹۹۶ با ارائه این مدل، تعامل متقابل و پویایی را میان سطوح مختلف شناخت مطرح کردند؛ سطوحی که مؤلفه‌هایی همچون باورها، فراشناخت، کنترل توجه، پردازش مداوم اطلاعات و خودتنظیمی را در بر می‌گیرند. در این چارچوب، پایین‌ترین سطح شامل شبکه‌های پردازش اطلاعات است که با هیجانات منفی، باورها و طرحواره‌های ناسازگار فعال می‌شوند. این سطح به صورت خودکار و بلافاصله پس از مواجهه با محرک‌های بیرونی فعال می‌گردد. به عبارت دیگر، یک رویداد یا محرک خارجی می‌تولند افکار خاص مرتبط با آن را فعال کند. در این مرحله، محرک‌های بیرونی، افکار و واکنش‌های جسمانی مانند تعریق کف دست به صورت خودکار بازنمایی می‌شوند و این فرایند به‌طور پیوسته ادامه دارد. همچنین در این سطح، وقایع بیرونی افکار مرتبط با خود را تحریک می‌کنند.

با فعال شدن این افکار، سطح دوم که سطح اجرایی و نظارتی است، وارد عمل می‌شود. در این سطح، راهبردهای مقابله‌ای مختلف ــ از جمله نشخوار فکری ــ برای مواجهه با خلق افسرده شکل می‌گیرند. این فرایند از طریق ارتباط نزدیک میان سطوح مختلف شناختی انجام می‌شود. در این مرحله، محرک بیرونی و افکار درونی با توجه به اهداف فردی و محدودیت‌های اجتماعی ارزیابی می‌شوند و پس از آن فرد به جستجوی راهبرد مقابله‌ای مناسب می‌پردازد. سپس راهبرد انتخاب‌شده دوباره مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد تا میزان کارآمدی آن در مواجهه با موقعیت مشخص شود. بر اساس این مدل، دو دسته اصلی از راهبردهای مقابله‌ای مطرح می‌شوند: مقابله هیجان‌مدار و مقابله مسئله‌مدار. در نهایت، سطح سوم به دانش فرد درباره خود مربوط می‌شود؛ سطحی که باورهای

فراشناختی حامی نشخوار فکری در آن قرار دارند و در تداوم این فرایند نقش اساسی ایفا می‌کنند (وایتمر و گوتلیب، ۲۰۱۳).

۲-۵-۲-۳ دیدگاه طرحواره های هیجانی

در چارچوب دیدگاه طرحواره‌های هیجانی، طرحواره‌ها مجموعه‌ای از باورها درباره منشأ هیجان‌ها، تفاوت‌های فردی در تجربه آن‌ها، میزان جهان‌شمولی هیجانات، احساس گناه، فقدان کنترل، خطرناک بودن هیجان‌ها، قابلیت درک آن‌ها و ضرورت منطقی یا قانونمند بودن تجربه‌های هیجانی هستند (ثنایی‌ذاکر و همکاران، ۱۳۸۷). این باورها بر اساس تجربه‌های واقعی شکل می‌گیرند و به عنوان واسطه‌ای عمل می‌کنند که نحوه پاسخ‌دهی افراد به موقعیت‌های هیجانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طرحواره‌های ناسازگار معمولاً در بستر روابط بین‌فردی آشکار می‌شوند و می‌توانند کارکرد رابطه را تحت تأثیر قرار دهند (لیهی، ۲۰۱۲). به بیان دیگر، افرادی که در زمینه پذیرش، کنترل یا تحمل هیجانات خود دچار مشکل هستند، بیشتر از راهبردهای مقابله‌ای ناسازگارانه مانند نشخوار ذهنی، اختلالات خوردن، سوءمصرف مواد و نگرانی استفاده می‌کنند (ثنایی‌ذاکر و همکاران، ۱۳۸۷). در چنین شرایطی، وقتی فرد هیجان‌های خود را به صورت منفی ارزیابی می‌کند، آن‌ها را مسئله‌ساز تلقی کرده و به شکل مداوم درگیر نشخوار فکری می‌شود (لیهی، ۲۰۱۱).

نشخوار فکری یکی از شیوه‌های ناسازگارانه‌ای است که افراد در واکنش به طرحواره‌ها به کار می‌گیرند. در این حالت، فرد به طور مداوم درگیر یک هیجان خاص می‌شود که احساسات منفی را در او برمی‌انگیزد و به آن پایبند می‌ماند. چنین افرادی بارها و بارها توجه خود را بر تجربه‌های ناخوشایند گذشته متمرکز می‌کنند. از این رو، نشخوار ذهنی را می‌توان نوعی الگوی ناکارآمد در تنظیم هیجان دانست. افرادی که به این الگو گرفتار می‌شوند، قادر نیستند از هیجانات خود فاصله بگیرند و نمی‌پذیرند که این تجربه‌ها موقتی و گذرا هستند. بر اساس مدل طرحواره‌های هیجانی، نشخوار فکری راهبردی مسئله‌ساز برای مقابله با هیجان‌های ناخوشایند محسوب می‌شود؛ زیرا باعث می‌شود فرد در یک تجربه یا خاطره هیجانی گرفتار بماند، شدت هیجان‌های منفی افزایش یابد و کارکرد سازگارانه او مختل شود (لیهی، ۲۰۱۵؛ تیلور و همکاران، ۲۰۱۷). در چنین شرایطی فرد ممکن است باور داشته باشد که هیجاناتش خارج از کنترل هستند و برای مدت طولانی ادامه خواهند داشت. همچنین این هیجان‌ها را طبیعی تلقی نمی‌کند و آن‌ها را غیرقابل تحمل می‌داند. به همین دلیل، پیوسته می‌کوشد دلیل بروز این احساسات را کشف کند و ماهیت واقعی آن‌ها را بشناسد. با این حال، به دلیل تفسیرهای منفی از هیجانات خود، تلاش می‌کند با راهبردهای ناکارآمدی مانند نشخوار ذهنی و اجتناب آن‌ها را مهار کند. افزون بر این، ممکن است از تعامل با دیگران فاصله بگیرد و خود را فردی خسته‌کننده یا ملال‌آور تصور کند (لیهی، ۲۰۱۵).

۲-۵-۳ پیامدهای خودانتقادی

۲-۵-۳-۱ مشکلات روان‌شناختی ناشی از خودانتقادی

پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که خودانتقادی با طیف گسترده‌ای از مشکلات روان‌شناختی ارتباط دارد؛ از جمله افسردگی (بلات و همکاران، ۱۹۸۲)، اضطراب اجتماعی (کاکس و همکاران، ۲۰۰۴)، اختلال استرس پس از سانحه (هارمن و لی، ۲۰۱۰)، رفتارهای خودکشی‌گرایانه (کیم و همکاران، ۲۰۱۱)، اختلال شخصیت مرزی (پیترز و همکاران، ۲۰۱۳)، عزت‌نفس پایین (دانکلی و گریلو، ۲۰۰۷) و پرخوری (دانکلی و همکاران، ۲۰۱۰). به‌طور مشخص‌تر، نشخوار فکری می‌تواند فرایندهای آسیب‌شناختی را تشدید کند؛ به این معنا که با تقویت چرخه‌های معیوب و تکرارشونده میان خلق منفی و شناخت‌های منفی، حالات هیجانی ناخوشایند مانند غم و خشم را شدت می‌بخشد (سلبی و همکاران، ۲۰۰۸). افزون بر این، نشخوار ذهنی ممکن است در فرایند حل مسئله اختلال ایجاد کند و تولنایی فرد برای سازگاری با تغییرات را کاهش دهد (واتکینز و رابرتز، ۲۰۲۰). بر اساس پژوهش میلیا و همکاران (۲۰۲۱)، به نظر می‌رسد نشخوار فکری انتقادی، هنگامی که با انتظارات عملکردی بسیار بالا همراه می‌شود، می‌تواند پس از تجربه شکست موجب افزایش احساس شرم و استرس گردد. به بیان دیگر، زمانی که افراد در موقعیت‌های ارزیابی‌کننده قرار می‌گیرند و در آن شرایط احساس شرم و فشار روانی را تجربه می‌کنند، احتمال دارد در ادامه وارد چرخه نشخوار فکری خودانتقادی شوند.

۲-۵-۳-۲ مشکلات فردی ناشی از خودانتقادی

افرادی که سطح بالایی از خودانتقادی دارند، معمولاً در روابط بین‌فردی خود میزان لندکی از خودافشایی نشان می‌دهند. این افراد در روابط صمیمانه غالباً رفتاری سرد و فاصله‌گیرانه دارند و در تعامل با شریک عاطفی خود نیز مسئولیت کمتری می‌پذیرند. افزون بر این، در تعاملات روزمره با دیگران نیز با دشواری‌هایی مواجه می‌شوند و اغلب از سوی اطرافیان به‌عنوان افرادی کم‌تر دوست‌داشتنی ارزیابی می‌گردند. چنین افرادی برای آن‌که احساس مثبتی نسبت به خود داشته باشند، معمولاً هزینه‌های روانی و اجتماعی زیادی متحمل می‌شوند. فردی که با خودانتقادی شدید دست‌وپنجه نرم می‌کند، ممکن است برای دستیابی به جایگاهی مطلوب در اجتماع حتی روابط دوستانه خود را نیز قربانی کند. در حوزه انتخاب شریک عاطفی نیز الگوهای متفاوتی مشاهده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که زنان دارای ویژگی‌های وابستگی، معمولاً شریک عاطفی خود را بر اساس نیاز به صمیمیت و نزدیکی انتخاب می‌کنند، در حالی که زنان خودانتقادگر بیشتر تمایل دارند با افرادی وارد رابطه شوند که صمیمیت و ابراز محبت کمتری دارند و در عوض ویژگی‌هایی مانند استقلال، جسارت و قاطعیت در آن‌ها برجسته‌تر است (زوروف و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۵-۴ نقش خانواده در خودانتقادی

بر اساس دیدگاه بلات (۱۹۷۴، به نقل از قدیری، ۱۳۹۸)، ریشه‌های خودانتقادی را می‌توان در الگوهای تعامل والدین با فرزندان جست‌وجو کرد. در خانواده‌هایی که والدین با شیوه‌های کنترل‌گرانه سخت‌گیرانه، انتظارات بسیار بالا و انتقادهای مداوم با فرزندان خود رفتار می‌کنند، زمینه تضعیف استقلال کودک فراهم می‌شود. در چنین شرایطی کودک به تدریج این باور را درونی می‌کند که محبت و تأیید والدین به آسانی به دست نمی‌آید و تنها در صورتی قابل دستیابی است که عملکرد او مطابق معیارها و انتظارات آنان باشد. شکل‌گیری چنین باوری می‌تواند به بروز مشکلات درونی در کودکان منجر شود. والدینی که با رفتارهای کنترل‌کننده، محدودکننده و انتقادآمیز با فرزندان خود برخورد می‌کنند، ناخواسته زمینه شکل‌گیری شخصیت خودانتقادگر را در آنان فراهم می‌سازند. افرادی که گرایش بالایی به خودانتقادی دارند، معمولاً والدین خود را افرادی کنترل‌گر، محدودکننده، سرکوبگر، بی‌تفاوت، سرد و بیش از حد منتقد توصیف می‌کنند و گاه تجربه‌هایی از سوءاستفاده جسمانی را نیز گزارش می‌دهند (آیرونز، ۲۰۰۶). افزون بر این، چنین والدینی در دوران کودکی استانداردهای بسیار بالایی برای عملکرد فرزندان خود در نظر می‌گیرند و از آنان انتظار دارند که همواره این معیارها را رعایت کنند. در نتیجه، کودکان می‌آموزند که تنها در صورت برآورده ساختن این معیارها و دستیابی به سطح مشخصی از عملکرد، مورد محبت و پذیرش دیگران قرار خواهند گرفت (بلات، ۱۹۷۴، به نقل از قدیری، ۱۳۹۸). در همین راستا، بالبی (۱۹۸۰) نیز بر این باور است که رابطه اولیه دلبستگی میان وللدین و کودک، بنیان شکل‌گیری بازنمایی‌های درونی کودک و الگوهای ارتباطی او با دیگران را تشکیل می‌دهد. به بیان دیگر، کیفیت تعاملات اولیه با والدین نقشی اساسی در شکل‌گیری برداشت فرد از خود و دیگران و همچنین در نحوه برقراری روابط بین‌فردی در آینده ایفا می‌کند.

۲-۶ پیشینه پژوهش

۲-۶-۱ پیشینه داخلی پژوهش

فاریابی و اکرمی (۱۴۰۴) پژوهشی با عنوان «نقش میانجی حساسیت به طرد بین‌فردی در رابطه میان طرحواره‌های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و اختلال افسردگی با ویژگی‌های آتیپیک» انجام دادند. این پژوهش از نوع توصیفی–همبستگی بود و با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری اجرا شد. جامعه آماری شامل دانشجویان ۱۸ تا ۳۰ ساله ایرانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ بود که ۴۰۰ نفر از آنان به شیوه داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ (فرم کوتاه)، مقیاس حساسیت به طرد بین‌فردی و چک‌لیست نشانه‌های افسردگی استفاده شد. تحلیل داده‌ها با همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر انجام گرفت. نتایج نشان داد که حساسیت به طرد بین‌فردی به‌طور مستقیم شدت افسردگی با ویژگی‌های آتیپیک را پیش‌بینی می‌کند و

طرحواره‌های ناسازگار حوزه بریدگی و طرد نیز به‌صورت غیرمستقیم و از طریق افزایش حساسیت به طرد، با این نوع افسردگی مرتبط هستند. یافته‌ها بیانگر آن است که الگوهای شناختی ناسازگار اولیه و حساسیت هیجانی نسبت به طرد می‌توانند نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم افسردگی آتیپیک داشته باشند و توجه به این متغیرها در طراحی مداخلات درمانی هدفمند اهمیت دارد.

رئیسی و مقیمیان (۱۴۰۴) پژوهشی با عنوان «پیش‌بینی بی‌تلفن همراه هراسی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه با توجه به افسردگی، اضطراب و استرس در جوانان» انجام دادند. این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی و همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۳۸۴ جوان ۲۰ تا ۴۰ سال شهر اصفهان بود که به روش داوطلبانه از طریق شبکه‌های مجازی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، مقیاس نوموفوبیا ایلدریم، پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ و نسخه ۲۱ DASS بودند. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارهای AMOS و SPSS انجام شد و نتایج نشان داد که بی‌تلفن همراه هراسی با توجه به طرحواره‌های ناسازگار اولیه و شدت افسردگی، اضطراب و استرس قابل پیش‌بینی است و این طرحواره‌ها اثر مثبت و معنادار بر نوموفوبیا دارند. همچنین طرحواره‌های بریدگی/طرد و بازداری بیشترین تأثیر را بر نوموفوبیا داشتند. پژوهشگران توصیه کردند شناسایی این طرحواره‌ها و ارائه مداخلات سلامت روانی به جوانان می‌تواند در کاهش بی‌تلفن همراه هراسی مؤثر باشد.

میره‌ای و همکاران (۱۴۰۳) پژوهشی با عنوان «رابطه طرحواره‌های ناسازگار با افسردگی و اضطراب اجتماعی در سالمندان» انجام دادند. این مطالعه به‌صورت همبستگی-توصیفی طراحی شد و جامعه آماری شامل ۱۵۰ سالمند ۶۰ سال به بالا در شهر تهران بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه فرم ۷۵ آیتمی یانگ، مقیاس افسردگی سالمندان یاساویج و پرسش‌نامه هراس اجتماعی کانور بودند. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۸ تحلیل شد. نتایج نشان داد که طرحواره‌های رهاشدگی، محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و شکست بیشترین همبستگی را با افسردگی داشته و طرحواره‌های کمال‌گرایی، نقص/شرم، انزوای اجتماعی و آسیب‌پذیری نسبت به ضرر بیشترین ارتباط را با اضطراب اجتماعی داشتند. همچنین چهار طرحواره رهاشدگی، محرومیت هیجانی، نقص/شرم و بازداری هیجانی توان پیش‌بینی افسردگی و سه طرحواره انزوای اجتماعی، نقص/شرم و کمال‌گرایی توان پیش‌بینی اضطراب اجتماعی را داشتند. پژوهشگران پیشنهاد کردند آموزش و مداخلات پیشگیرانه در سنین کودکی و نوجوانی با تمرکز بر طرحواره‌ها می‌تواند به بهبود سلامت روان سالمندان کمک کند.

مالک‌پور و همکاران (۱۴۰۳) پژوهشی با عنوان «بررسی نقش واسطه‌ای شرم و خودانتقادگری در رابطه بین تجربیات اولیه زندگی و اندیشه‌پردازی پارانوئید در دانشجویان» انجام دادند. این پژوهش با رویکرد همبستگی و با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری اجرا شد. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

اهواز بود که ۲۷۲ نفر از آنان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه تجربیات اولیه زندگی، مقیاس اندیشه‌پردازی پارانوئید، مقیاس شرم درونی و بیرونی و مقیاس خودانتقادگری/خوداطمینان‌بخشی استفاده شد. تحلیل داده‌ها با روش همبستگی پیرسون، آزمون بوت‌استرپ و نرم‌افزارهای آماری انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین تجربیات اولیه زندگی، شرم، خودانتقادگری و افکار پارانوئید رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شرم نقش واسطه‌ای معناداری در ارتباط بین تجربیات اولیه زندگی و اندیشه‌پردازی پارانوئید ایفا می‌کند، اما نقش واسطه‌ای خودانتقادگری تأیید نشد. بر اساس یافته‌ها، توجه به مؤلفه‌هایی مانند شرم و خودانتقادگری می‌تواند در طراحی مداخلات درمانی برای کاهش افکار پارانوئید مؤثر باشد.

مغانلو و دادفر (۱۴۰۳) پژوهشی با عنوان «رابطه خودانتقادگری و احساس تنهایی با افسردگی در سالمندان: نقش میانجی نشخوار فکری» انجام دادند. این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود که با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری اجرا شد. جامعه آماری پژوهش را سالمندان بالای ۶۰ سال ساکن آسایشگاه‌های کرج، شهریار و شهر قدس تشکیل دادند که ۱۹۵ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های نشخوار فکری، خودانتقادگری، احساس تنهایی و افسردگی بود و داده‌ها با نرم‌افزارهای آماری SPSS و Smart-PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که خودانتقادگری درونی و مقایسه‌ای و همچنین نشخوار فکری، رابطه مثبت و معناداری با افسردگی سالمندان دارند، اما ارتباط مستقیم احساس تنهایی با افسردگی معنادار نبود. همچنین نشخوار فکری نقش واسطه‌ای مهمی در رابطه بین خودانتقادگری و احساس تنهایی با افسردگی ایفا کرد. بر اساس یافته‌ها، کنترل افکار نشخواری و کاهش خودانتقادگری می‌تولند به عنوان راهبردی مؤثر در پیشگیری و درمان افسردگی سالمندان مورد توجه متخصصان قرار گیرد.

نیک‌بخت و شفیعی‌تبار (۱۴۰۳) پژوهشی با عنوان «نقش خودشفقتی، حساسیت به طرد و باورهای غیرمنطقی در پیش‌بینی افسردگی و اضطراب زنان مطلقه» انجام دادند. این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۱۱۶ زن مطلقه ساکن شهر اراک بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی لاویبوند، مقیاس خودشفقتی ریس، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز و پرسشنامه حساسیت به طرد داونی و فلدمن بودند. تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه انجام شد و نشان داد که حساسیت به طرد و باورهای غیرمنطقی با افسردگی و اضطراب رابطه مستقیم دارند، در حالی که خودشفقتی با این متغیرها رابطه معکوس دارد. همچنین، تحلیل رگرسیون نشان داد که باورهای غیرمنطقی و حساسیت به طرد بخش قابل توجهی از تغییرات افسردگی و اضطراب را پیش‌بینی می‌کنند و حساسیت به طرد به‌عنوان مهم‌ترین سازه در تجربه اضطراب و افسردگی زنان مطلقه شناخته شد. این یافته‌ها بر اهمیت مداخلات روانشناختی برای کاهش حساسیت به طرد، اصلاح باورهای غیرمنطقی و تقویت خودشفقتی در این گروه تأکید دارد.

راحله و همکاران (۱۴۰۲) پژوهشی با عنوان «ارتباط ساختاری دلبستگی ناایمن و احساس شرم با افکار خودکشی در افراد دارای علائم افسردگی: نقش میانجی بدتنظیمی هیجانی» انجام دادند. این پژوهش از نوع همبستگی و با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری طراحی شد. جامعه آماری شامل افراد دارای علائم افسردگی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های شهر تهران بود که ۱۸۰ نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی بک (ویرایش دوم)، مقیاس افکار خودکشی بک، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی بزرگسالان، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و پرسشنامه احساس شرم بود. داده‌ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری و با نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. نتایج نشان داد بدتنظیمی هیجانی به‌طور مستقیم پیش‌بینی‌کننده معنادار افکار خودکشی است و دلبستگی ناایمن و احساس شرم نیز به‌صورت مستقیم با بدتنظیمی هیجانی ارتباط دارند. همچنین بدتنظیمی هیجانی نقش واسطه‌ای معناداری در رابطه بین دلبستگی ناایمن و احساس شرم با افکار خودکشی ایفا می‌کند. به‌طور کلی، متغیرهای پژوهش توانستند بخش قابل‌توجهی از واریانس افکار خودکشی را تبیین کنند و یافته‌ها بر اهمیت توجه به تنظیم هیجان در ارزیابی، پیشگیری و درمان افکار خودکشی در افراد افسرده تأکید دارد.

مهدوی‌راد و همکاران (۱۴۰۲) پژوهشی با عنوان «نقش واسطه‌ای شرم و خودانتقادگری در رابطه میان سبک‌های دلبستگی با شدت علائم افسردگی» انجام دادند. این پژوهش از نوع توصیفی–همبستگی بود که با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری اجرا شد. جامعه آماری شامل افراد ۱۸ تا ۴۷ سال ساکن شهر تهران در سال ۱۴۰۱ بود که ۲۱۲ نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه افسردگی بک، سبک‌های دلبستگی هازن و شیور، پرسشنامه احساس شرم و مقیاس خودانتقادگری استفاده شد و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد سبک‌های دلبستگی ناایمن (مضطرب–اجتنابی و مضطرب–دوسوگرا)، احساس شرم و خودانتقادگری با شدت علائم افسردگی رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین شرم و خودانتقادگری به‌طور معناداری نقش واسطه‌ای در ارتباط بین سبک‌های دلبستگی ناایمن و شدت علائم افسردگی ایفا کردند. یافته‌ها بیانگر آن است که سبک‌های دلبستگی ناایمن از طریق افزایش شرم و خودانتقادگری می‌توانند زمینه‌ساز تشدید افسردگی شوند و توجه به این متغیرها در پیشگیری و مداخلات درمانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

امیری مصور و همکاران (۱۴۰۲) پژوهشی با عنوان «ارتباط افکار خودکشی با خودانتقادی و افسردگی در دانشجویان کارشناسی پرستاری» انجام دادند. این مطالعه از نوع مقطعی–همبستگی بود و جامعه پژوهش را ۳۷۱ نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل دادند که به روش سرشماری وارد پژوهش شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس سطوح خودانتقادی و پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. داده‌ها با بهره‌گیری از آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و با نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین افسردگی و افکار خودکشی رابطه مثبت، قوی و معناداری وجود دارد و افسردگی به‌عنوان یک متغیر پیش‌بین معنادار افکار خودکشی عمل می‌کند. با این حال، ارتباط مستقیم و معناداری بین خودانتقادی و افکار خودکشی مشاهده نشد. یافته‌ها بر ضرورت پایش سلامت روان و اجرای مداخلات پیشگیرانه و حمایتی برای کاهش افسردگی و افکار خودکشی در دانشجویان پرستاری تأکید دارد.

سلمان‌نژاد و همکاران (۱۴۰۱) پژوهشی با عنوان «مدلی ساختاری برای مشکلات روانشناختی بر اساس حوزه طرد و بریدگی و افکار خودآیند منفی با نقش واسطه‌ای احساس تنهایی» انجام دادند. این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی و مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری بود و جامعه آماری شامل ۲۵۰ نفر از مراجعین با علائم روانشناختی به کلینیک‌های مرکز مشاوره قم در سال ۱۴۰۰ بود که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی (DASS)، پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ-L3)، پرسشنامه افکار خودآیند (ATQ-30) و پرسشنامه پذیرش و عمل (AAQ-II) بودند. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی برازش مناسبی دارد و احساس تنهایی نقش میانجی معنی‌داری در رابطه بین حوزه طرد و بریدگی و افکار خودآیند منفی با مشکلات روانشناختی دارد. پژوهشگران توصیه کردند که مشاوران و درمانگران می‌توانند با بررسی این متغیرها، برنامه‌های تشخیصی و درمانی مؤثرتر برای افراد مبتلا به مشکلات روانشناختی طراحی کنند.

آزادی و همکاران (۱۴۰۰) پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه تجارب بدرفتاری در دوران کودکی با شرم و گناه در اختلال افسردگی اساسی و اختلال شخصیت مرزی» انجام دادند. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و با رویکرد همبستگی و علی—مقایسه‌ای اجرا شد. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال شخصیت مرزی مراجعه‌کننده به روان‌پزشکان شهر یزد و نیز گروهی از افراد غیرمبتلا بود که در مجموع ۱۵۰ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه بدرفتاری در دوران کودکی، پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس تشخیصی شخصیت مرزی و پرسشنامه شرم و گناه بود و داده‌ها با آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که در افراد مبتلا به افسردگی، تجارب غفلت و آزار عاطفی در کودکی نقش مهمی در پیش‌بینی احساس شرم و گناه دارند. همچنین در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی، انواع مختلف بدرفتاری از جمله آزار جنسی، جسمی و عاطفی با سطوح بالاتر شرم و گناه مرتبط بودند. نتایج این مطالعه بر اهمیت توجه به تجارب آسیب‌زای کودکی در تبیین هیجان‌های منفی پایدار و طراحی مداخلات درمانی مناسب برای اختلالات روانی تأکید دارد.

یعقوبی و همکاران (۱۴۰۰) پژوهشی با عنوان «نقش میانجی شرم بیرونی و شفقت به خود در رابطه بین قربانی شدن توسط همسالان و نشانه‌های افسردگی در نوجوانان» انجام دادند. این مطالعه از نوع همبستگی مقطعی بود که جامعه آن نوجوانان دوره اول متوسطه شهر شاهین‌شهر اصفهان را شامل می‌شد. نمونه پژوهش ۳۰۰ نفر از

دانش‌آموزان دختر و پسر بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس قربانی‌شدن چندبعدی، مقیاس شرم بیرونی، فرم کوتاه شفقت به خود و پرسشنامه خلق و احساس استفاده شد. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل مسیر و با کمک نرم‌افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. نتایج نشان داد قربانی شدن توسط همسالان با افزایش شرم بیرونی و کاهش شفقت به خود همراه است و این متغیرها به‌طور معناداری با نشانه‌های افسردگی ارتباط دارند. همچنین شرم بیرونی و شفقت به خود نقش واسطه‌ای معناداری در رابطه بین قربانی شدن توسط همسالان و نشانه‌های افسردگی ایفا کردند. یافته‌ها بر اهمیت توجه به این سازوکارهای هیجانی در طراحی مداخلات پیشگیرانه و درمانی برای کاهش افسردگی نوجوانان قربانی قلدری تأکید دارد.

موسویان (۱۳۹۹) پژوهشی نظری با عنوان «مروری نظری بر نقش شرم نهادینه در سبب‌شناسی اختلال افسردگی اتکایی و درون‌فکنی‌شده» ارائه کرد. این مقاله از نوع مروری–نظری است و با تکیه بر شواهد بالینی و چارچوب‌های نظری مطرح در روان‌تحلیل‌گری، به‌ویژه دیدگاه سیدنی بلت و مدل رودن و همکاران، به تبیین ریشه‌های هیجانی افسردگی می‌پردازد. نویسنده افسردگی اتکایی را مرتبط با مشکلات بین‌فردی مانند ترس از رهاشدگی و تنهایی، و افسردگی درون‌فکنی‌شده را مرتبط با اختلال در تصور از خود، احساس ناکفایتی و کمال‌گرایی می‌داند. در این چارچوب، شرم نهادینه به‌عنوان هسته مشترک آسیب‌پذیری خودشیفتگی و عامل زمینه‌ساز هر دو نوع افسردگی معرفی می‌شود. مقاله نشان می‌دهد که افراد افسرده در هر یک از این دو الگو، با استفاده از مکانیسم‌های دفاعی متفاوتی از تجربه آگاهانه شرم اجتناب می‌کنند. نتیجه‌گیری مقاله بر ضرورت تمایز درمانی تأکید دارد؛ به‌طوری که در افسردگی اتکایی باید بر تقویت عاملیت و استقلال بین‌فردی و در افسردگی درون‌فکنی‌شده بر پرورش شفقت به خود تمرکز شود. این مرور نظری اهمیت توجه به شرم به‌عنوان مؤلفه‌ای کلیدی در آسیب‌شناسی و طراحی مداخلات درمانی افسردگی را برجسته می‌سازد.

متین و جهان (۱۳۹۸) پژوهشی با عنوان «مدل پیش‌بینی تنهایی اجتماعی بر اساس حساسیت بین‌فردی و هوش اجتماعی با میانجی‌گری خودانتقادی» انجام دادند. این مطالعه از نوع همبستگی بود و با بهره‌گیری از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران بود که ۶۳۲ نفر از آنان به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تنهایی اجتماعی، حساسیت بین‌فردی، هوش اجتماعی و خودانتقادی استفاده شد. نتایج نشان داد که خودانتقادی تأثیر مثبت و معناداری بر تنهایی اجتماعی دارد، در حالی که هوش اجتماعی اثر منفی و معناداری بر تنهایی اجتماعی و خودانتقادی نشان می‌دهد. همچنین حساسیت بین‌فردی هم به‌صورت مستقیم و هم به‌صورت غیرمستقیم از طریق خودانتقادی، تنهایی اجتماعی را افزایش می‌دهد. یافته‌ها بیانگر آن است که تقویت هوش اجتماعی و کاهش حساسیت‌های بین‌فردی و خودانتقادی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تنهایی اجتماعی دانشجویان ایفا کند.

۲-۶-۲ پیشینه خارجی پژوهش

استفان[1] و همکاران (۲۰۲۵) پژوهشی با عنوان «خودانتقادگری، اجتناب تجربی، اضطراب اجتماعی و افسردگی در چارچوب نمونه‌گیری تجربی» انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی نقش پیش‌بینی‌کننده خودانتقادگری و اجتناب تجربی بر اضطراب اجتماعی و افسردگی با استفاده از روش نمونه‌گیری تجربی (ESM) و چارچوب مدل درمان طرحواره‌ها بود. جامعه پژوهش شامل ۱۴۵ نفر بود و تحلیل‌ها در سه سطح انجام شد: اثر کوتاه‌مدت در هر بیپ بعدی (سطح ۱)، میانگین روزانه (سطح ۲) و میانگین کلی شرکت‌کننده (سطح ۳). علاوه بر این، تحلیل‌های مدل معادلات ساختاری پویا (RDSEM) به صورت پانل متقاطع انجام شد. نتایج نشان داد که در سطح روزانه و بین شرکت‌کنندگان، خودانتقادگری و اجتناب تجربی پیش‌بینی‌کننده اضطراب اجتماعی و افسردگی بودند. تحلیل پانل متقاطع نشان داد که افسردگی پیش‌بینی‌کننده ثابت سایر متغیرها در بیپ بعدی بود و اجتناب تجربی پیش‌بینی‌کننده اضطراب اجتماعی در همان زمان کوتاه‌مدت بود. همچنین خودانتقادگری و اجتناب تجربی نقش میانجی در رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و گزارش‌های میانگین اضطراب اجتماعی و افسردگی ایفا کردند. این پژوهش بر اهمیت نقش خودانتقادگری و اجتناب تجربی در تجربه لحظه‌ای اضطراب اجتماعی و افسردگی تأکید دارد و به محدودیت‌ها و مسیرهای پژوهشی آینده نیز پرداخته شد.

لیو[2] و همکاران (۲۰۲۴) پژوهشی با عنوان «تأثیر میانجی زنجیره‌ای طرحواره‌های منفی هسته‌ای و حساسیت بین‌فردی در رابطه بین دلبستگی بزرگسالان و علائم افسردگی در دانشجویان» انجام دادند. هدف پژوهش بررسی نقش میانجی طرحواره‌های منفی هسته‌ای و حساسیت بین‌فردی در ارتباط بین سبک‌های دلبستگی و علائم افسردگی بود. جامعه پژوهش شامل ۴۵۷ دانشجوی دانشگاه‌های مرکزی چین بود که پرسشنامه‌های تجارب دلبستگی نزدیک، مقیاس طرحواره‌های هسته‌ای کوتاه، مقیاس حساسیت بین‌فردی کوتاه و مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که دلبستگی اضطرابی و اجتنابی با علائم افسردگی رابطه مثبت معنادار دارد و اثر دلبستگی بر افسردگی از طریق سه مسیر رخ می‌دهد: میانجیگری طرحواره‌های منفی هسته‌ای، میانجیگری حساسیت بین‌فردی و میانجیگری زنجیره‌ای هر دو متغیر. این یافته‌ها بر اهمیت شناسایی زودهنگام دانشجویان دارای دلبستگی ناایمن و ارائه مداخلات به منظور کاهش طرحواره‌های منفی و حساسیت بین‌فردی برای پیشگیری از افسردگی تأکید دارد.

پیترز[3] و همکاران (۲۰۲۴) پژوهشی با عنوان «حساسیت بین‌فردی و پاسخ به مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین در بیماران مبتلا به افسردگی شدید حاد» انجام دادند. این مطالعه یک تحلیل تلفیقی از داده‌های ۱۷۰۹ بیمار در سه کارآزمایی بالینی تصادفی، دوسوکور و کنترل‌شده با دارونما برای بررسی اثر فلوکستین و پاروکستین بود.

---

[1] Stefan
[2] Liu
[3] Peters

علائم افسردگی با مقیاس رتبه‌بندی افسردگی همیلتون و حساسیت بین‌فردی با یک عامل از چک‌لیست علائم اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که هر دو دارو کاهش معناداری در حساسیت بین‌فردی نسبت به دارونما ایجاد کردند و این اثر حتی پس از کنترل بهبود افسردگی نیز باقی ماند، اگرچه بهبود افسردگی ۱۸.۵٪ از تغییرات حساسیت بین‌فردی را توضیح می‌دهد. حساسیت بین‌فردی پایه، اثر دارو بر علائم افسردگی را تعدیل نکرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین نه تنها افسردگی را کاهش می‌دهند، بلکه به طور ویژه حساسیت بین‌فردی را نیز درمان می‌کنند. مطالعه محدودیت‌هایی داشت، از جمله اندازه‌گیری حساسیت بین‌فردی تنها در هفته آخر و بررسی تنها دو دارو.

لیو و همکاران (۲۰۲۴) پژوهشی با عنوان «سرمایه روان‌شناختی و عوامل آن به‌عنوان میانجی بین حساسیت بین‌فردی و علائم افسردگی در دانشجویان چینی» انجام دادند. این مطالعه از نوع مقطعی و با نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌ای در شش دانشگاه چین بین نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ انجام شد. جامعه پژوهش شامل ۲۵۸۰ دانشجو با میانگین سنی ۱۹.۲۲ سال و ۶۹.۷۳٪ زن بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه حساسیت بین‌فردی، پرسشنامه سلامت روان، پرسشنامه سرمایه روان‌شناختی و پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی بودند. نتایج نشان داد حساسیت بین‌فردی تأثیر مستقیم معناداری بر علائم افسردگی دارد ($\beta = 0.416, P < 0.001$) و سرمایه روان‌شناختی و مؤلفه‌های آن شامل امید، خوش‌بینی و تاب‌آوری با افسردگی همبستگی منفی دارند. تحلیل میانجی‌گری نشان داد که امید، خوش‌بینی و تاب‌آوری نقش میانجی مهمی در رابطه بین حساسیت بین‌فردی و افسردگی دارند ($P < 0.001$). این یافته‌ها نشان می‌دهد که سرمایه روان‌شناختی می‌تواند اثرات منفی حساسیت بین‌فردی بر افسردگی در دانشجویان را کاهش دهد.

بای[1] (۲۰۲۳) پژوهشی با عنوان «تأثیر خودانتقادگری و وابستگی بر افسردگی نوجوانان، نتایج درمان و فرآیند درمانی در روان‌درمانی کوتاه‌مدت افسردگی» انجام داد. این مطالعه به بررسی نقش ابعاد شخصیتی خودانتقادگری و وابستگی در نوجوانان مبتلا به افسردگی بالینی و تعامل آن‌ها با فرآیند درمان پرداخته است. داده‌ها از یک کارآزمایی بالینی موجود شامل ۴۶۵ نوجوان مبتلا به افسردگی جمع‌آوری شد که تحت درمان‌های مختلف شامل رفتاردرمانی شناختی، روان‌درمانی تحلیلی کوتاه‌مدت و مداخلات روان‌اجتماعی کوتاه‌مدت قرار گرفتند. خودانتقادگری و وابستگی در شروع درمان اندازه‌گیری شد و اتحاد درمانی توسط نوجوانان و درمانگران در طول درمان ارزیابی شد؛ همچنین پس از پایان درمان مصاحبه‌هایی درباره تجربیات و انتظارات نوجولنان انجام گرفت. نتایج نشان داد که خودانتقادگری بالا با عملکرد پیش‌آزمون نامطلوب، دشواری در تعامل با درمان و اتحاد درمانی ضعیف همراه بود که در نهایت منجر به نتایج درمانی کمتر مطلوب شد. وابستگی نتایج پیچیده‌تری داشت؛ با اینکه با بهبود عملکرد کلی و

[1] Bai

اجتماعی در طول درمان مرتبط بود، اما خطر بازگشت علائم پس از درمان را افزایش می‌داد. همچنین شواهدی از تفاوت‌های جنسیتی مشاهده شد؛ خودانتقادگری در دختران و وابستگی در پسران با عملکرد ضعیف‌تر و اتحاد درمانی پایین‌تر همراه بود. این تحقیق بر اهمیت نقش خودانتقادگری و وابستگی در افسردگی نوجوانان و تعامل آن‌ها با فرآیند درمان تأکید دارد و محدودیت‌ها و پیامدهای بالینی آن نیز مورد بحث قرار گرفته است.

بیرمان[1] (۲۰۲۳) پژوهشی با عنوان «شرم، خودانتقادگری و ترس از شفقت در اختلال شخصیت مرزی» انجام داد. هدف این مطالعه بررسی پردازش اطلاعات خودمحور در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی (BPD) و نقش احساسات منفی خودآگاه مانند شرم، خودانتقادگری و ترس از دریافت یا ابراز شفقت بود که مانع ادغام اجتماعی این افراد می‌شود. پژوهش شامل سه مطالعه بود که ضمن بررسی این مفاهیم، ابزارهای لندازه‌گیری مربوط به خودانتقادگری و ترس از شفقت نیز برای اولین بار به زبان آلمانی ترجمه و اعتبارسنجی شدند. نتایج نشان داد که افراد BPD در بعد «خود منفور» خودانتقادگری بالاتر و در بعد «خود ناکافی» نیز نسبت به جمعیت عمومی و گروه کنترل سالم، نمرات بالاتری داشتند، در حالی که «خود مطمئن» در آن‌ها پایین‌تر بود. همچنین، این افراد در هر سه بعد ترس از شفقت (برای خود، برای دیگران، از سوی دیگران) نسبت به شرکت‌کنندگان غیر بالینی تفاوت معنی‌داری داشتند، که نشان‌دهنده مقاومت‌های خاص در فرآیندهای اجتماعی و روابط میان‌فردی است. در یک آزمایش تجربی نیز مواجهه با تصویر خود باعث افزایش شرم و تنفر از خود و مواجهه با تصویر دیگران باعث افزایش حس حسادت در BPD شد. یافته‌ها تأکید می‌کنند که مشکلات مربوط به خودانتقادگری و شرم نقش کلیدی در آسیب‌شناسی روانی BPD دارند و توسعه درمان‌های مبتنی بر شفقت می‌تواند رویکردی مؤثر برای این اختلال باشد.

ژو[2] و همکاران (۲۰۲۳) پژوهشی با عنوان «مسیر حساسیت بین‌فردی تا افسردگی در میان دانشجویان چینی در طول قرنطینه دانشگاهی ناشی از COVID-19» انجام دادند. این مطالعه با هدف بررسی نقش میانجی اضطراب و نقش تعدیل‌کننده سرمایه روانشناختی در رابطه بین حساسیت بین‌فردی و افسردگی طراحی شد. جامعه پژوهش شامل ۱۲۹۴۵ دانشجوی کارشناسی در چین بود که بین ۱۰ تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۲ با پرسشنامه‌های آنلاین حساسیت بین‌فردی، اضطراب، سرمایه روانشناختی و افسردگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مدل تحلیل میانجی تعدیل‌شده با استفاده از PROCESS در SPSS 25 بررسی شد، به‌طوری که اضطراب نقش میانجی و سرمایه روانشناختی نقش تعدیل‌کننده داشت. نتایج نشان داد حساسیت بین‌فردی با افسردگی رابطه مثبت دارد ($r = 0.47, P < 0.001$) و اضطراب ۷۰٪ از این اثر را به‌صورت میانجی منتقل می‌کند. همچنین سرمایه روانشناختی در رابطه بین حساسیت بین‌فردی و اضطراب و همچنین بین اضطراب و افسردگی نقش تعدیل‌کننده معنادار داشت. یافته‌ها نشان داد که

[1] Biermann
[2] Xu

کنترل اضطراب و تقویت سرمایه روانشناختی می‌تواند خطر افسردگی در دانشجویان چینی تحت قرنطینه دانشگاهی را کاهش دهد.

بیشاپ[1] و همکاران (۲۰۲۱) پژوهشی با عنوان «طرحواره‌های ناسازگار اولیه و افسردگی در بزرگسالی: یک مرور نظام‌مند و فراتحلیل» انجام دادند. هدف این مطالعه تلفیق یافته‌های پژوهش‌های پیشین درباره رابطه بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه (EMS) و افسردگی بود تا عوامل شناختی خطرساز برای افسردگی شناسایی شوند. در این پژوهش، ۵۱ مطالعه شامل ۱۷٫۸۳۰ شرکت‌کننده بزرگسال بررسی و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که همه ۱۸ طرحواره ناسازگار اولیه با افسردگی همبستگی مثبت دارند؛ اثر بزرگ برای طرحواره‌های «انزوای اجتماعی» و «نقص/شرم» و اثر کوچک برای طرحواره «حق‌به‌جانب بودن» گزارش شد. این یافته‌ها نشان می‌دهد افرادی که خود را ناقص، بد یا غیرقابل دوست داشتن می‌دانند، سطح افسردگی بالاتری تجربه می‌کنند. پژوهشگران تأکید کردند که برای تعیین جهت رابطه بین EMS و افسردگی نیاز به مطالعات طولی است و تمرکز درمان بر کاهش تأثیر طرحواره‌های انزوای اجتماعی و نقص/شرم می‌تواند به کاهش علائم افسردگی کمک کند.

استرویان[2] (۲۰۲۱) پژوهشی با عنوان «نیازهای هیجانی و عملکرد طرحواره‌ای در افسردگی: مروری روایتی» انجام داد. هدف این مطالعه مرور ادبیات موجود در رابطه با نقش نیازهای هیجانی اساسی به‌عنوان عوامل انگیزشی در افسردگی و ارتباط آن با عملکرد طرحواره‌ای بود. این پژوهش بر پایه نظریه شناختی و مدل درمان طرحواره‌ای استوار است که طرحواره‌های ناسازگار اولیه را محصول بی‌اعتنایی به نیازهای هیجانی معرفی می‌کند. مرور مطالعات نشان داد که شناخت و هدف‌گذاری بر نیازهای هیجانی در درمان روان‌درمانی افراد افسرده می‌تواند اثرگذار باشد، اما شواهد تجربی در مورد کاربرد عملی آن هنوز محدود است. نویسنده همچنین به ملاحظات نظری درباره نقش نیازهای هیجانی و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی در زمینه عملکرد طرحواره‌ای در افسردگی پرداخته است. این مطالعه بر اهمیت توجه به نیازهای هیجانی در طراحی مداخلات درمانی افسردگی تأکید دارد.

گیتینز[3] و همکاران (۲۰۲۰) پژوهشی با عنوان «خودانتقادی و عزت‌نفس در اوایل نوجوانی: آیا پیش‌بینی‌کننده افسردگی هستند؟» انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین دو نوع شناخت منفی از خود (خودانتقادی و عزت‌نفس) و علائم افسردگی در نوجوانان اوایل دوره نوجوانی بود. جامعه پژوهش شامل ۲۴۳ نوجوان استرالیایی با میانگین سنی ۱۲ سال (۵۲٪ دختر) بود که در سه زمان‌بندی مختلف (شروع مطالعه، ۱۲ ماه و ۲۴ ماه بعد) با پرسشنامه‌های مربوط به عزت‌نفس، خودانتقادی و علائم افسردگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که خودانتقادی و علائم افسردگی در طول زمان افزایش یافتند، در حالی که عزت‌نفس کاهش پیدا کرد و این تغییرات با یکدیگر مرتبط بودند. تحلیل‌های متقاطع نشان داد که عزت‌نفس می‌تواند از زمان دوم به سوم علائم افسردگی را

[1] Bishop
[2] Stroian
[3] Gittins

پیش‌بینی کند، و در عین حال علائم افسردگی از زمان اول به دوم عزت‌نفس را تحت تأثیر قرار می‌دهند، اما خودانتقادی تأثیر پیش‌بینی‌کننده‌ای بر افسردگی نداشت و افسردگی نیز خودانتقادی را پیش‌بینی نمی‌کرد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه بین عزت‌نفس و افسردگی در اوایل نوجوانی تا حدودی دوطرفه است، در حالی که خودانتقادی نقش پیش‌بینی‌کننده مستقیمی در توسعه افسردگی ندارد

کاروالهو[1] و همکاران (۲۰۱۹) پژوهشی با عنوان «نقش شرم، خودانتقادگری و خاطرات هیجانی اولیه در تفکر پارانوییدی نوجوانان» انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی اثر شرم، خودانتقادگری و تجربیات شرم در دوران کودکی بر بروز تفکرات پارانوییدی در نوجوانان بود. جامعه پژوهش شامل ۱۶۵۷ نوجوان ۱۴ تا ۱۸ ساله از مدارس دولتی و خصوصی جزیره سنت میگوئل در آزور، پرتغال بود که با پرسشنامه‌های خودگزارشی، پارانویا، تجربیات شرم و خودانتقادگری را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد که دختران نسبت به پسران در ابعاد شرم بیرونی، خودانتقادگری، ایده‌های آزاردهنده و احساس بی‌اعتمادی نمرات بالاتری داشتند، هرچند اندازه اثر کوچک بود. همچنین، مدل‌هایی که شامل شرم، خودانتقادگری و تجربیات شرم بودند، توانستند بین ۲۶ تا ۴۸ درصد از واریانس تفکر پارانوییدی، به ویژه تفکرات آزاردهنده، را تبیین کنند. پژوهشگران تأکید کردند که به دلیل مقطعی بودن مطالعه، نمی‌توان روابط علی را تعمیم داد، اما یافته‌ها اهمیت توسعه مداخلات پیشگیرانه بر پایه آموزش والدین، حمایت اجتماعی و پرورش مهارت‌های هیجانی–اجتماعی در نوجوانان را نشان می‌دهد.

ژانگ[2] و همکاران (۲۰۱۹) پژوهشی با عنوان «خودانتقادی و علائم افسردگی: نقش میانجی خودشفقتی» انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی نقش خودشفقتی در کاهش تأثیر خودانتقادی بر علائم افسردگی بود. جامعه پژوهش شامل ۱۴۷ نفر از بزرگسالان آفریقایی–آمریکایی شهری با درآمد پایین و سابقه اقدام به خودکشی بود. شرکت‌کنندگان با پرسشنامه‌هایی در زمینه خودانتقادی، علائم افسردگی و خودشفقتی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که خودانتقادی با افزایش علائم افسردگی و کاهش خودشفقتی مرتبط است، در حالی که خودشفقتی با کاهش علائم افسردگی رابطه منفی دارد. تحلیل‌های بوت‌استرپ نشان داد که خودشفقتی نقش میانجی بین خودانتقادی و افسردگی را ایفا می‌کند و می‌تواند اثر منفی خودانتقادی بر افسردگی را کاهش دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مداخلات روان‌شناختی متمرکز بر تقویت خودشفقتی می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و کاهش افسردگی در این جمعیت کمک کند.

پورتر[3] و همکاران (۲۰۱۸) پژوهشی با عنوان «ارتباط‌های منحصربه‌فرد خودانتقادی و گرایش به شرم با علائم اختلال خوردن و افسردگی» انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی نقش مستقل خودانتقادی و گرایش به شرم در پیش‌بینی علائم اختلال خوردن و افسردگی و همچنین بررسی اینکه آیا خودانتقادی و گرایش به شرم می‌توانند ارتباط بین این دو را توضیح دهند، بود. جامعه پژوهش شامل ۱۸۶ دانشجوی کارشناسی بود که با استفاده از

[1] Carvalho
[2] Zhang
[3] Porter

پرسشنامه‌های مربوط به خودانتقادی، شرم، علائم افسردگی و اختلال خوردن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو متغیر خودانتقادی و گرایش به شرم با علائم افسردگی و اختلال خوردن همبستگی داشتند، اما تنها خودانتقادی توانست اثر پیش‌بینی‌کننده مستقل و معناداری بر هر دو متغیر داشته باشد. همچنین خودانتقادی بخش قابل‌توجهی از همبستگی بین اختلال خوردن و افسردگی را توضیح داد و نشان داد که می‌تواند عامل مشترک و فراگیر شناختی این دو اختلال باشد. یافته‌ها بر اهمیت تمرکز درمانی بر خودانتقادی به‌عنوان هدف مداخله‌ای در کاهش همزمان اختلال خوردن و افسردگی تأکید دارند.

اتانی[1] و همکاران (۲۰۱۸) پژوهشی با عنوان «رابطه نزدیک حساسیت بین‌فردی با باورهای منفی بنیادین درباره خود به عنوان سازه مرکزی آسیب‌پذیری شناختی نسبت به افسردگی» انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی این بود که آیا حساسیت بین‌فردی به‌عنوان یک ویژگی شخصیتی می‌تواند آسیب‌پذیری شناختی نسبت به افسردگی را منعکس کند یا خیر. جامعه پژوهش شامل ۳۳۵ داوطلب ژاپنی بود که حساسیت بین‌فردی با استفاده از مقیاس IPSM و باورهای منفی بنیادین درباره خود با زیربخش خود منفی پرسشنامه Brief Core Schema Scale اندازه‌گیری شد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هر چهار مؤلفه حساسیت بین‌فردی (آگاهی بین‌فردی، اضطراب جدایی، خجالتی بودن و خود درونی آسیب‌پذیر) با نمرات باورهای منفی بنیادین درباره خود رابطه قوی و معناداری دارند. همچنین مدل‌یابی معادلات سلسله‌مراتبی نشان داد که این مؤلفه‌ها به‌طور قوی توسط باورهای بنیادین منفی درباره خود پیش‌بینی می‌شوند. یافته‌ها نشان می‌دهد که حساسیت بین‌فردی با باورهای منفی بنیادین درباره خود ارتباط نزدیکی دارد و می‌تواند به‌عنوان یک آسیب‌پذیری شناختی نسبت به افسردگی در نظر گرفته شود.

داوودی[2] و همکاران (۲۰۱۸) پژوهشی با عنوان «طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افسردگی و اختلال سوماتیزاسیون» انجام دادند. هدف مطالعه بررسی نقش طرحواره‌های ناسازگار اولیه (EMS) به عنوان عوامل آسیب‌پذیری شناختی مشترک یا متمایز در افسردگی و اختلال سوماتیزاسیون بود. جامعه پژوهش شامل ۳۰ بیمار مبتلا به افسردگی اساسی و ۳۰ بیمار مبتلا به اختلال سوماتیزاسیون از بیمارستان و کلینیک روان‌پزشکی بود. ابزارهای پژوهش شامل مصاحبه بالینی ساختاریافته DSM-IV، پرسشنامه افسردگی بک نسخه دوم و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ بود. نتایج نشان داد که بیماران مبتلا به افسردگی در همه پنج حوزه طرحواره و برخی طرحواره‌های خاص مانند محرومیت عاطفی، بی‌اعتمادی و سوءاستفاده، انزوای اجتماعی، نقص/شرم، شکست، سرسپردگی، بازداری هیجانی و کنترل ناکافی خود، سطوح بالاتری دارند. حتی پس از کنترل شدت علائم افسردگی، افسردگی با سطوح بالاتر انزوای اجتماعی، بازداری هیجانی و حوزه‌های نظارت و بازداری همراه بود. این یافته‌ها نشان می‌دهد

[1] Otani
[2] Davoodi

که برخی EMSها می‌توانند افسردگی و سوماتیزاسیون را از یکدیگر تمایز دهند و پیشنهاد شده است که پژوهش‌های آینده گروه کنترل غیرروان‌پزشکی را نیز شامل شوند تا نقش مطلق EMSها در اختلال سوماتیزاسیون مشخص شود.

دینگر[1] و همکاران (۲۰۱۵) پژوهشی با عنوان «مشکلات بین‌فردی، وابستگی و خودانتقادگری در اختلال افسردگی اساسی» انجام دادند. هدف این مطالعه بررسی همپوشانی بین دو رویکرد تحقیقاتی در خصوص ویژگی‌های شخصیتی بین‌فردی در افسردگی اساسی بود و فرض شد که ابعاد تجربیات افسردگی بلات شامل وابستگی (مرتبط با روابط) و خودانتقادگری (مرتبط با تعریف خود) با مشکلات بین‌فردی مشخص بر اساس مدل دایره‌ای بین‌فردی همبستگی دارد. روش پژوهش شامل تحلیل داده‌های ۲۸۳ بیمار مبتلا به افسردگی اساسی از دو نمونه متفاوت بود: ۱۵۱ بیمار در یک کارآزمایی بالینی تصادفی در ایالات متحده و ۱۳۲ بیمار در بخش بستری در آلمان. بیماران پرسشنامه‌های مربوط به اختلالات علائم، مشکلات بین‌فردی و تجربیات افسردگی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که وابستگی با مشکلات بین‌فردی مرتبط با سلطه پایین و وابستگی زیاد به دیگران همراه است، در حالی که خودانتقادگری با مشکلات بین‌فردی مرتبط با کمبود وابستگی و فاصله گرفتن از دیگران همبستگی دارد و این روابط مستقل از شدت افسردگی بود. همچنین خودانتقادگری با شدت علائم شناختی افسردگی همپوشانی بالایی داشت. پژوهشگران نتیجه گرفتند که ابعاد تجربیات افسردگی بلات ماهیت بین‌فردی دارند و خودانتقادگری با فاصله گرفتن یا سرد بودن نسبت به دیگران و شدت بیشتر افسردگی مرتبط است، اما با بعد سلطه همبستگی ندارد.

۲-۷ جمع بندی

با توجه به مجموعه پژوهش‌های داخلی و خارجی، می‌توان گفت که ادبیات موجود به‌طور هم‌گرا بر نقش طرحواره‌های ناسازگار اولیه، حساسیت بین‌فردی، شرم، خودانتقادگری و متغیرهای مرتبط با دلبستگی در تبیین افسردگی، اضطراب و سایر پیامدهای روان‌شناختی تأکید دارد. در سطح شناختی طرحواره‌ای، مطالعاتی مانند فاریابی و اکرمی (۱۴۰۴)، رئیسی و مقیمیان (۱۴۰۴)، میره‌ای و همکاران (۱۴۰۳) و بیشاپ و همکاران (۲۰۲۱) نشان داده‌اند که طرحواره‌های حوزه طرد و بریدگی (رهاشدگی، محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی، نقص/شرم و...) با شدت افسردگی، اضطراب اجتماعی و سایر شاخص‌های آسیب‌شناسی روانی رابطه مثبت معنادار دارند و در برخی موارد از طریق متغیرهای میانجی به پیامدهای بالینی پیوند می‌خورند. در همین راستا، مرورهای نظری استرویان (۲۰۲۱) و موسویان (۱۳۹۹) نیز طرحواره‌های ناسازگار اولیه و شرم نهادینه را به‌عنوان عناصر مرکزی در سبب‌شناسی افسردگی و تداوم آن معرفی کرده‌اند. از سوی دیگر، حساسیت بین‌فردی در پژوهش‌های متعددی به‌عنوان یک سازه کلیدی مرتبط با افسردگی و مشکلات عاطفی مورد تأکید قرار گرفته است. نتایج مطالعاتی نظیر متین و جهان (۱۳۹۸)، لیو و

[1] Dinger

همکاران (۲۰۲۴)، ژو و همکاران (۲۰۲۳) و پیترز و همکاران (۲۰۲۴) نشـــان می‌دهد که حســـاســـیت بین‌فردی هم به‌طور مستقیم علائم افسـردگی را پیش‌بینی می‌کند و هم از طریق سـازوکارهایی نظیر طرحواره‌های منفی هسـته‌ای، اضطراب، سرمایه روان‌شناختی و سایر عوامل شناختی ـــ هیجانی بر افسردگی اثر می‌گذارد. همسو با این یافته‌ها، پژوهش‌هایی مانند نیک‌بخت و شـفیعی‌تبار (۱۴۰۳) و لیو و همکاران (۲۰۲۴) حاکی از آن اسـت که متغیرهایی نظیر خودشـــفقتی، امید، خوش‌بینی و تاب‌آوری می‌توانند نقش حفاظتی در برابر اثرات منفی حســـاســـیت بین‌فردی و طرحواره‌های ناســازگار بر افســردگی و اضــطراب داشــته باشــند. در حوزه هیجانی و خودارتباطی، مجموعه‌ای از پژوهش‌ها نقش شـرم، خودانتقادگری و بدتنظیمی هیجانی را برجسـته سـاخته‌اند. نتایج مطالعات آزادی و همکاران (۱۴۰۰)، مهـدوی‌راد و همکـاران (۱۴۰۲)، راحلـه و همکـاران (۱۴۰۲)، یعقوبی و همکـاران (۱۴۰۰)، کـاروالهو و همکاران (۲۰۱۹)، بیرمان (۲۰۲۳) و پورتر و همکاران (۲۰۱۸) نشـان می‌دهد که شـرم و خودانتقادگری هم به‌صـورت مستقیم با افسردگی، افکار خودکشی، تفکر پارانویید و علائم اختلالات شخصیت مرتبط‌اند و هم به‌عنوان متغیرهای واســـطه‌ای مهم، اثر تجارب اولیه ناسازگار، سـبک‌های دلبســـتگی ناایمن و بدرفتاری در کودکی را به پیامدهای آسـیب‌شـناختی منتقل می‌کنند. افزون بر این، یافته‌های پژوهش‌هایی مانند مغانلو و دادفر (۱۴۰۳) و ژانگ و همکاران (۲۰۱۹) بیانگر آن اسـت که فرایندهایی نظیر نشـخوار فکری و کاهش خودشـفقتی می‌توانند مسیر تأثیر خودانتقادگری و احســـاس تنهایی بر افســـردگی را تبیین کنند. در مجموع، پیشـــینه موجود نشـــان می‌دهد که ترکیب تجارب اولیه نامطلوب، طرحواره‌های ناسـازگار اولیه به‌ویژه در حوزه طرد و بریدگی، حساسیت بین‌فردی، شـرم و خودانتقادگری، زمینه‌ساز بروز و تداوم افسردگی، اضطراب، افکار خودکشی و سایر پیامدهای روان‌شناختی است و این روابط اغلب از طریق متغیرهای میانجی مانند بدتنظیمی هیجانی، احســـاس تنهایی، نشـــخوار فکری، باورهای منفی بنیادین درباره خود و سـرمایه روان‌شـناختی تبیین می‌شـود. همچنین، بخشـی از پژوهش‌ها به نقش عوامل حفاظتی نظیر خودشـفقتی، عزت‌نفس، امید و تاب‌آوری در کاهش اثرات منفی این ســـازه‌ها اشـــاره کرده‌اند. با این حال، علی‌رغم غنای نســـبی ادبیات پژوهشی در تبیین نقش این متغیرها به‌صورت جداگانه یا در قالب مدل‌های جزئی، هنوز ترکیب هم‌زمان آن‌ها در چارچوب مدل‌های ساختاری جامع، به‌ویژه با تأکید بر مکانیزم‌های میانجی خاص (مانند شرم و خودانتقادگری) و در گروه‌های جمعیتی مشخص، به‌طور نظام‌مند و یکپارچه مورد بررسی قرار نگرفته است. این خلأ پژوهشی می‌تواند ضـرورت انجام پژوهش حاضـر را در جهت طراحی و آزمون مدلی تلفیقی که جایگاه این متغیرها و روابط علّی میان آن‌ها را در پیش‌بینی علائم افسردگی و پیامدهای مرتبط روشن‌تر سازد، توجیه نماید.

فصل سوم

روش پژوهش

پژوهش را می‌توان فرایندی سامان‌مند برای جست‌وجو و دستیابی به شناخت درباره موقعیتی دانست که هنوز به‌طور کامل روشن و مشخص نشده است. به بیان دیگر، تحقیق مسیری نظام‌یافته است که از طریق آن می‌توان به بررسی امور ناشناخته پرداخت و آگاهی لازم را نسبت به آن‌ها به دست آورد. یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های هر مطالعه علمی، شیوه و چارچوب روش‌شناختی آن است؛ زیرا در نبود یک روش‌شناسی دقیق و منسجم، نتایج حاصل از بررسی‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده از اعتبار علمی کافی برخوردار نخواهند بود و امکان تعمیم آن‌ها نیز با تردید مواجه می‌شود. در این فصل از پژوهش که به‌نوعی بنیان علمی تحقیق را شکل می‌دهد، تلاش شده است تا چارچوب روش‌شناختی مطالعه به‌صورت دقیق مورد تبیین قرار گیرد. در این راستا، ابتدا نوع و ماهیت پژوهش تعیین و معرفی شده و سپس طرحی کلی از مراحل اجرای تحقیق ارائه گردیده است. در ادامه، جامعه مورد مطالعه، شیوه انتخاب نمونه‌ها و ابزارهایی که برای گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته‌اند تشریح شده‌اند. در بخش پایانی فصل نیز نحوه پردازش و تحلیل داده‌ها توضیح داده شده و روش‌های آماری، فنون تحلیلی و نرم‌افزارهایی که برای انجام تحلیل‌ها به کار رفته‌اند معرفی شده‌اند.

۳-۱ طرح پژوهش

از نظر روش‌شناختی، این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی با رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری[1] (SEM) بود و در زمره پژوهش‌های بنیادی قرار دارد.

۳-۲ جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری

جامعه آماری شامل زنان ۱۸ تا ۵۵ ساله مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روانشناسی شهر مشهد بود. انتخاب جامعه زنان از آن جهت انجام شد که پژوهش‌های متعددی تفاوت‌های جنسیتی قابل‌توجهی را در تجربه شرم، خودانتقادی، حساسیت بین‌فردی و افسردگی در زنان گزارش کرده‌اند (کوینر، ۲۰۱۷؛ السی و همکاران، ۲۰۱۲). بازه سنی ۱۸ تا ۵۵ سال با هدف دستیابی به نمونه‌ای از زنان بزرگسال انتخاب شد؛ زیرا در این دوره، افراد از نظر رشدی، شناختی و هیجانی توانایی پاسخ‌گویی معتبر به ابزارهای خودگزارشی را دارند و همچنین شیوع و اهمیت بالینی نشانه‌های افسردگی، خودانتقادی و مشکلات مرتبط با روابط بین‌فردی در این گروه سنی قابل توجه است. از سوی دیگر، محدود کردن دامنه سنی به کمتر از ۵۵ سال با هدف کاهش اثر عوامل مرتبط با سالمندی، تغییرات زیستی دوره سالمندی و تفاوت‌های روان‌شناختی ناشی از این دوره انجام شد. نمونه‌گیری به روش در دسترس از میان مراجعان کلینیک‌های روان‌شناسی انجام شد. بر اساس نظر کلاین[2] و همکاران (۲۰۲۲) در مدل‌یابی معادلات ساختاری حداقل

[1] Structural equation modeling
[2] Klein

حجم نمونه ۲۰۰ نفر توصیه شده است. با در نظر گرفتن احتمال خطای پاسخ‌گویی، حذف پرسشنامه‌های ناقص و ریزش احتمالی آزمودنی‌ها، حجم نمونه پژوهش حاضر ۲۲۰ نفر تعیین شد.

ملاک‌های ورود: زن بودن، بازه سنی ۱۸ تا ۵۵ سال، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن جهت پاسخ به پرسشنامه‌ها، تمایل به شرکت در پژوهش، رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش، کسب حداقل نمره ۲۱ (خط برش) در پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II).

ملاک‌های خروج: تکمیل ناقص پرسشنامه‌ها، پاسخ تصادفی و شانسی به پرسشنامه‌ها، عدم کسب نمره برش (نمره ۲۱) در پرسشنامه افسردگی بک، انصراف از ادامه همکاری در پژوهش، وجود اختلالات روان‌پزشکی شدید مانند اختلالات سایکوتیک، اختلال دوقطبی در فاز مانیا یا شرایطی که بر توانایی پاسخ‌گویی معتبر به پرسشنامه‌ها تأثیر بگذارد، سوءمصرف فعال مواد مخدر یا محرک در زمان اجرای پژوهش، بستری روان‌پزشکی اخیر که ممکن بود بر وضعیت روان‌شناختی فعلی فرد اثر قابل توجهی داشته باشد به گزارش شرکت‌کننده.

۳-۳ ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش از: ۱. پرسشنامه سطوح خودانتقادی[1] (LOSC)، ساخته تامپسون و زوروف (۲۰۰۴)، برای سنجش دو بعد خودانتقادی درونی‌شده و مقایسه‌ای، ۲. پرسشنامه احساس شرم[2] (ESS) اندروز[3] و همکاران (۲۰۰۲)، که دو زیرمقیاس شرم درونی و شرم بیرونی را اندازه‌گیری می‌کند، ۳. پرسشنامه افسردگی بک[4] (BDI-II) به عنوان شاخص سنجش شدت افسردگی، ۴. پرسشنامه حساسیت بین‌فردی[5] (IPSM) بویس و پارکر (۱۹۸۹) که میزان حساسیت فرد نسبت به موقعیت‌های بین‌فردی تهدیدزا را می‌سنجد و ۵. پرسشنامه طرحواره‌های ناسازگار اولیه–فرم کوتاه[6] (YSQ-S3) اسمیت[7] و همکاران (۱۹۹۵) که زیرمقیاس طرحواره رهاشدگی برای این پژوهش به شرح زیر بصورت فرم آنلاین و غیرحضوری استفاده شد:

۳-۳-۱ پرسشنامه سطوح خودانتقادی (LOSC)

مقیاس سطوح خودانتقادی (LOSC) با هدف سنجش خودانتقادی به‌عنوان سازه‌ای دارای دو بُعد، توسط تامپسون و زوروف (۲۰۰۴) تدوین شده است و برای ارزیابی دو شکل متمایز این ویژگی یعنی خودانتقادی مقایسه‌ای (CSC) و خودانتقادی درونی‌شده (ISC) به کار می‌رود؛ این ابزار شامل ۲۲ گویه است که پاسخ‌دهی به آن‌ها بر مبنای یک

[1] Levels of Self-Criticism Scale (LOSC)
[2] Experience of Shame Scale (ESS)
[3] Andrews
[4] Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II)
[5] Interpersonal Sensitivity Measure (IPSM)
[6] Young Schema Questionnaire (YSQ)
[7] Schmidt

مقیاس لیکرت ۷ درجه‌ای از ۱ (به شدت مخالفم) تا ۷ (به شدت موافقم) انجام می‌شود و کسب نمرات بالاتر بیانگر شدت بیشتر خودانتقادی است؛ در این مقیاس، آیتم‌های معکوس شامل شماره‌های ۶، ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۲۰ و ۲۱ بوده و گویه‌های مربوط به خرده‌مقیاس خودانتقادی درونی‌شده شامل آیتم‌های ۱، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۷ و ۱۹ است، در حالی که خرده‌مقیاس خودانتقادی مقایسه‌ای از آیتم‌های ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تشکیل می‌شود؛ همچنین، یاماگوچی و کیم (۲۰۱۳) در بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی این ابزار، پایایی درونی مطلوبی را گزارش کرده‌اند به‌طوری‌که مقدار آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با ۰/۰۹۰ به دست آمده است، در مطالعات داخلی نیز بهادری و همکاران (۱۳۹۶) روایی این ابزار را تایید کرده و پایایی درونی این ابزار را برای مقیاس خودانتقادی درونی ۰/۷۸، خودانتقادی بیرونی ۰/۹۳ و برای مقیاس کلی برابر با ۰/۸۶ گزارش کردند.

۳-۳-۲ پرسشنامه احساس شرم (ESS)

پرسشنامه احساس شرم را اندرو و همکاران در سال ۲۰۰۲ طراحی کردند. این ابزار شامل ۷ گویه است که به‌منظور سنجش میزان احساس شرم در پژوهش‌های روان‌شناختی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ پاسخ‌دهی به گویه‌های این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج‌درجه‌ای انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که گزینه «کاملاً مخالفم» کمترین امتیاز یعنی ۱ و گزینه «کاملاً موافقم» بیشترین امتیاز یعنی ۵ را به خود اختصاص می‌دهد و سایر پاسخ‌ها به‌ترتیب امتیازات ۲، ۳ و ۴ را شامل می‌شوند؛ در پژوهش عمویی (۱۳۹۶)، روایی صوری و محتوایی این ابزار مورد بررسی قرار گرفته و نتایج، تأییدکننده کفایت آن برای سنجش احساس شرم بوده است، همچنین پایایی درونی پرسشنامه با بهره‌گیری از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شده که مقدار آن برابر با ۰٫۸۶ گزارش شده و نشان‌دهنده ثبات و انسجام مطلوب گویه‌های پرسشنامه است.

۳-۳-۳ پرسشنامه افسردگی بک (BDI-II)

این ابزار بر مبنای نظریات بک در سال ۱۹۹۹ گسترش یافت. این مقیاس شامل ۲۱ مجموعه عبارت است و از پاسخ‌دهنده خواسته می‌شود هر یک از این مجموعه‌ها را با دقت مطالعه کند و در هر گروه تنها یک جمله را که بیشترین انطباق را با وضعیت هیجانی او از دو هفته گذشته تا زمان پاسخ‌دهی دارد انتخاب نماید آزمون افسردگی بک ابزاری است که شدت نشانه‌های افسردگی را در دامنه گسترده‌ای از اختلالات روان‌پزشکی می‌سنجد و در ارزیابی اثربخشی مداخلات درمانی و روند روان‌درمانی کاربرد قابل توجهی دارد و این پرسشنامه ۲۱ مؤلفه را در بر می‌گیرد که شامل غمگینی، بدبینی، احساس شکست در گذشته، ناتوانی در لذت بردن، احساس گناه، احساس تنبیه، دوست نداشتن خود، خودانتقادی، افکار یا گرایش به خودکشی، گریه، بی‌قراری، کاهش علاقه، ناتوانی در تصمیم‌گیری، احساس بی‌ارزشی، کاهش انرژی، تغییر در الگوی خواب، تحریک‌پذیری، تغییر در اشتها، مشکل در تمرکز، خستگی یا کسالت و کاهش میل جنسی است؛ این مؤلفه‌ها در سه بعد اصلی طبقه‌بندی می‌شوند به‌طوری‌که

بعد شـــناختی شـــامل گویه‌های ۱۳، ۳، ۱۴، ۵، ۶، ۷ و ۸، بعد عاطفی مشـــتمل بر گویه‌های ۱، ۲، ۴، ۹ و ۱۲ و بعد جسمانی دربرگیرنده گویه‌های ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۱۰، ۱۱، ۱۶، ۱۸ و ۲۱ است؛ شیوه نمره‌دهی بر اساس طیف لیکرت چهاردرجه‌ای از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم انجام می‌شـود که به‌ترتیب امتیازهای ۳، ۲، ۱ و ۰ به آن‌ها اختصـاص می‌یابد و برای تفسـیر نتایج، امتیازهای حاصـل از ۲۱ عبارت با یکدیگر جمع می‌شـوند به‌گونه‌ای که کمترین نمره ممکن ۰ و بیشترین نمره ۶۳ خواهد بود، به‌طوری‌که نمره ۰ تا ۲۱ نشان‌دهنده افسردگی ضعیف، بازه ۲۱ تا ۳۱ بیانگر سطح متوسط و نمرات بالاتر از ۳۱ حاکی از شدت بالای افسردگی است؛ همچنین روایی این پرسشنامه با بهره‌گیری از نظر اساتید راهنما و مشاور مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است و پایایی آن نیز توسط تمنایی فر و همکاران (۱۳۸۷) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و نرم‌افزار SPSS محاسبه شده که مقدار آن برای متغیر افسردگی برابر با ۰/۹۱ گزارش شده است.

۳-۳-۴ پرسشنامه حساسیت بین فردی (IPSM)

این ابزار به‌منظور سنجش حساسیت فرد نسبت به طرد اجتماعی و تعاملات بین‌فردی، توسط بایس و پارکر در سال ۱۹۸۹ طراحی و معرفی شد و ابزاری است که میزان آسیب‌پذیری هیجانی افراد را در روابط اجتماعی ارزیابی می‌کند؛ این پرسشنامه از ۳۶ سؤال تشکیل شده و پنج خرده‌مقیاس آگاهی بین‌فردی، نیاز به تأیید، اضطراب جدایی، کمرویی و عزت‌نفس شـکننده را در بر می‌گیرد؛ در بررسـی ویژگی‌های روان‌سـنجی، بایس و پارکر (۱۹۸۹) ضـرایب پایایی آلفای کرونباخ را برای خرده‌مقیاس آگاهی بین‌فردی ۰/۷۶، نیاز به تأیید ۰/۵۵، اضـــطراب جدایی ۰/۶۷، کمرویی ۰/۶۳، عزت‌نفس شکننده ۰/۵۹ و برای نمره کل مقیاس ۰/۸۶ گزارش کردند و همچنین با برآورد همبستگی این ابزار با آزمون قضـاوت بالینی حسـاسـیت بین‌فردی، روایی همزمانی معادل ۰/۷۲ به دسـت آوردند که بیانگر اعتبار مناسـب این پرسـشـنامه اسـت؛ در ایران نیز در پژوهش وجودی و همکاران (۱۳۹۳) ضـریب آلفای کرونباخ کل ابزار برابر با ۰/۸۱ گزارش شـد و محمدیان و همکاران (۲۰۱۶) با بررسـی مجدد شـاخص‌های روان‌سـنجی، ضـرایب پایایی خرده‌مقیاس‌های آگاهی بین‌فردی ۰/۷۰، نیاز به تأیید ۰/۵۱، اضـــطراب جدایی ۰/۵۸، کمرویی ۰/۵۸، عزت‌نفس شـــکننده ۰/۷۰ و آلفای کرونباخ کل مقیاس ۰/۸۶ را به دســـت آوردند؛ این پرســـشـــنامه بر اســـاس طیف لیکرت چهاردرجه‌ای نمره‌گذاری می‌شـــود که در آن گزینه کاملاً موافقم امتیاز ۴، تا حدودی موافقم امتیاز ۳، تا حدودی مخالفم امتیاز ۲ و کاملاً مخالفم امتیاز ۱ را دریافت می‌کند و فاقد گویه‌های با نمره‌گذاری معکوس است؛ خرده‌مقیاس آگاهی بین‌فردی شـامل سـؤالات ۲، ۴، ۱۰، ۲۳، ۲۸، ۳۰ و ۳۶، نیاز به تأیید شـامل ۶، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۰ و ۳۴، اضـطراب جدایی شـامل ۱، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۵، ۲۶ و ۲۹، کمرویی مشـتمل بر ۳، ۷، ۹، ۱۴، ۲۱، ۲۲، ۳۲ و ۳۳ و عزت‌نفس شـکننده دربرگیرنده سـؤالات ۵، ۲۴، ۲۷، ۳۱ و ۳۵ اسـت؛ در نهایت با جمع امتیاز تمامی سـؤالات، نمره کلی حسـاسـیت بین‌فردی فرد محاسـبه می‌شـود که دامنه آن از صـفر تا ۱۴۴ متغیر اسـت، به‌طوری‌که نمرات بالاتر و

نزدیک به ۱۴۴ نشان‌دهنده سطح بالای حساسیت بین‌فردی و نمرات پایین و نزدیک به صفر بیانگر حساسیت بین‌فردی کمتر در فرد است.

۳-۳-۵ پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه-فرم کوتاه (YSQ-S3)

این ابزار که توسط اسمیت، جونز و یانگ در سال ۱۹۹۵ تدوین شده است (نقل از لطفی و همکاران، ۱۳۸۶)، شامل ۹۰ گویه بوده و پاسخ‌دهی به آن بر اساس طیف لیکرت شش‌درجه‌ای از «کاملاً درست» با امتیاز ۶ تا «کاملاً غلط» با امتیاز ۱ انجام می‌گیرد و برای سنجش طرح‌واره‌ها در پنج حوزه کلی و پانزده خرده‌مقیاس طراحی شده است؛ حوزه نخست با عنوان بریدگی و طرد، خرده‌مقیاس‌های رهاشدگی/بی‌ثباتی با سؤالات ۲، ۲۰، ۳۸، ۵۶ و ۷۴، بی‌اعتمادی/بدرفتاری با گویه‌های ۳، ۲۱، ۳۹، ۵۷ و ۷۵، محرومیت هیجانی با سؤالات ۱، ۱۹، ۳۷، ۵۵ و ۷۳، نقص/شرم با آیتم‌های ۵، ۲۳، ۴۱، ۵۹ و ۷۷ و انزوای اجتماعی/بیگانگی با سؤالات ۴، ۲۲، ۴۰، ۵۸ و ۷۶ را دربر می‌گیرد؛ حوزه دوم که خودگردانی و عملکرد مختل نام دارد، شامل وابستگی/بی‌کفایتی با گویه‌های ۷، ۲۵، ۳۸، ۴۳، ۶۱ و ۷۹، آسیب‌پذیری نسبت به ضرر و بیماری با آیتم‌های ۸، ۲۶، ۴۴، ۶۲ و ۸۰، خودتحول‌نیافته/گرفتار با سؤالات ۹، ۲۷، ۴۵، ۶۳ و ۸۱ و شکست با گویه‌های ۶، ۲۴، ۴۲، ۶۰ و ۷۸ است؛ در حوزه سوم با عنوان محدودیت‌های مختل، خرده‌مقیاس استحقاق/بزرگ‌منشی از طریق سؤالات ۱۴، ۳۲، ۵۰، ۶۸ و ۸۶ و خویشتن‌داری و خودانضباطی ناکافی با گویه‌های ۱۵، ۳۳، ۵۱، ۶۹ و ۸۷ ارزیابی می‌شود؛ حوزه چهارم دیگرجهت‌مندی را شامل می‌شود که در آن اطاعت با سؤالات ۱۰، ۲۸، ۴۶، ۶۴ و ۸۲، ایثار با گویه‌های ۱۱، ۲۹، ۴۷، ۶۵ و ۳۰ و پذیرش‌جویی/جلب توجه با آیتم‌های ۱۶، ۳۴، ۵۲ و ۷۰ سنجیده می‌گردد؛ حوزه پنجم با عنوان گوش‌به‌زنگی بیش از حد و بازداری، خرده‌مقیاس‌های منفی‌گرایی/بدبینی با سؤالات ۱۷، ۳۵، ۵۳، ۷۱ و ۸۹، بازداری هیجانی با آیتم‌های ۱۲، ۳۰، ۴۸، ۶۶ و ۸۴، معیارهای سرسختانه/عیب‌جویی افراطی با گویه‌های ۱۳، ۳۱، ۴۹، ۶۷ و ۸۵ و تنبیه با سؤالات ۱۸، ۳۶، ۵۴، ۷۲، ۸۸ و ۹۰ را دربر دارد؛ از نظر ویژگی‌های روان‌سنجی، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در نمونه‌های غیربالینی برای خرده‌مقیاس‌ها در دامنه ۰.۷۵ تا ۰.۸۲ گزارش شده است (لطفی و همکاران، ۱۳۸۶) و نسخه فارسی آن توسط آهی و همکاران (۱۳۸۶) ترجمه و هنجاریابی شده که همسانی درونی بر اساس آلفای کرونباخ در زنان ۰.۹۷ و در مردان ۰.۹۸ به دست آمده است، همچنین در پژوهش قدسی و همکاران (۱۳۹۳) پایایی کل پرسشنامه برابر با ۰.۹۴ گزارش شده است. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر صرفا نمرات حاصل از خرده‌مقیاس رهاشدگی/بی‌ثباتی با سؤالات ۲، ۲۰، ۳۸، ۵۶ و ۷۴ مدنظر خواهد بود.

۳-۴ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

داده‌های به‌دست‌آمده پس از گردآوری، با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه ۲۷ و AMOS نسخه ۲۶ مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل‌ها شامل آمار توصیفی، ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای آزمون اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاست. از شاخص‌های برازش مدل نظیر CFI، TLI، RMSEA و χ^2/df برای ارزیابی مطابقت مدل مفهومی با داده‌های تجربی استفاده شد (براین، ۲۰۱۶).

۳-۵ ملاحظات اخلاقی

از نظر اخلاقی، پژوهش حاضر با رعایت اصول محرمانگی داده‌ها، رضایت آگاهانه و اختیار شرکت در مطالعه انجام‌شد. کلیه شرکت‌کنندگان پس از توضیح اهداف پژوهش و تضمین حفظ حریم خصوصی، رضایت خود را جهت شرکت در پژوهش اعلام کردند.

فصل چهارم

یافته‌های پژوهش

در این فصل از پژوهش، داده‌های گردآوری‌شده تحت تحلیل‌های آماری قرار گرفته و نتایج حاصل از این بررسی‌ها ارائه شده‌اند. در ابتدای این فصل، داده‌های جمعیت‌شناختی مربوط به نمونه مورد بررسی و سپس شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیرهای مورد پژوهش گزارش شد. در ادامه، به منظور ارزیابی پیش‌نیازهای آزمون مدل پژوهش، روابط میان متغیرها در قالب یک ماتریس همبستگی نمایش داده شده است. پس از آن، آزمون مدل مورد بررسی قرار گرفت و شاخص‌های نیکویی برازش به همراه نتایج حاصل از تحلیل مدل‌سازی معادلات ساختاری، مطابق فرضیه‌های پژوهش ارائه شده‌اند.

۴-۱ ویژگی‌های جمعیت شناختی

در این بخش، ویژگی‌های جمعیت شناختی مرتبط با نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول ۴-۱- توصیف وضعیت تاهل شرکت‌کنندگان پژوهش

وضعیت تاهل	فراوانی	درصد فراوانی
مجرد	۱۱۶	۵۲/۷
متاهل	۸۶	۳۹/۱
جداشده/سایر	۱۸	۸/۲
کل	۲۲۰	۱۰۰/۰

مطابق با جدول ۴-۱ مشاهده می شود که از ۲۲۰ شرکت کننده در این پژوهش، ۱۱۶ نفر مجرد، ۸۶ نفر متاهل و ۱۸ نفر جداشده یا در سایر وضعیت‌های تاهل بودند.

جدول ۴-۲- توصیف سطح تحصیلات شرکت‌کنندگان پژوهش

سطح تحصیلات	فراوانی	درصد فراوانی
زیر دیپلم	۸	۳/۶
دیپلم	۱۸	۸/۲
لیسانس	۱۲۶	۵۷/۳
فوق لیسانس	۶۸	۳۰/۹
کل	۲۲۰	۱۰۰/۰

مطابق با جدول ۴-۲ مشاهده می‌شود که از ۲۲۰ شرکت‌کننده در این پژوهش، ۸ نفر دارای مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم، ۱۸ نفر دیپلم، ۱۲۶ نفر لیسانس و ۶۸ نفر فوق لیسانس بودند.

جدول ۴-۳- توصیف وضعیت اشتغال شرکت‌کنندگان پژوهش

وضعیت اشتغال	فراوانی	درصد فراوانی
خانه دار	۵۹	۲۶/۸
دانشجو	۴۸	۲۱/۸
کارمند	۶۲	۲۸/۲
شغل آزاد	۳۹	۱۷/۷
سایر	۱۲	۵/۵
کل	۲۲۰	۱۰۰/۰

مطابق با جدول ۴-۳ مشاهده می‌شود که از ۲۲۰ شرکت‌کننده در این پژوهش، ۵۹ نفر خانه دار، ۴۸ نفر دانشجو، ۶۲ نفر کارمند، ۳۹ نفر شغل آزاد و ۱۲ نفر سایر مشاغل را دارا بودند.

جدول ۴-۴- توصیف مدت زمان رواندرمانی شرکت‌کنندگان پژوهش

مدت زمان تحت رواندرمانی	فراوانی	درصد فراوانی
کمتر از ۶ ماه	۱۶۶	۷۵/۵
بین ۶ تا ۱۲ ماه	۱۷	۷/۷
بین ۱ تا ۲ سال	۱۹	۸/۶
بین ۲ تا ۳ سال	۸	۳/۶
بیش از ۳ سال	۱۰	۴/۵
کل	۲۲۰	۱۰۰/۰

مطابق با جدول ۴-۴ مشاهده می‌شود که از ۲۲۰ شرکت‌کننده در این پژوهش، ۱۶۶ نفر کمتر از ۶ ماه تحت رواندرمانی بودند، ۱۷ نفر بین ۶ تا ۱۲ ماه، ۱۹ نفر بین ۱ تا ۲ سال، ۸ نفر بین ۲ تا ۳ سال و ۱۰ نفر بیش از ۳ سال تحت رواندرمانی قرار داشتند.

۴-۲ توصیف متغیرهای پژوهش

جدول ۴-۵ شاخص‌های توصیفی و ضرایب آلفای کرونباخ مؤلفه‌های افسردگی (شناختی، عاطفی و جسمانی)، شرمساری، حساسیت بین‌فردی (آگاهی بین فردی، نیاز به تایید، اضطراب جدایی، کمرویی و عزت نفس شکننده)، خودانتقادی (خودانتقادی درونی و خودانتقادی مقایسه ای) و طرحواره رهاشدگی را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۵- شاخص‌های توصیفی و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

متغیر	مولفه	نقش در مدل	کمترین	بیشترین	میانگین	انحراف معیار	آلفای کرونباخ
سن	–	کنترل	۱۸	۵۵	۳۰/۷۷	۷/۹۹	–
افسردگی	شناختی	درون‌زا	۰	۲۰	۶/۴۹	۴/۵۲	۰/۷۶
	عاطفی		۰	۱۴	۴/۱۷	۳/۵۲	۰/۷۲
	جسمانی		۱	۲۰	۸/۶۳	۴/۹۲	۰/۶۸
	کل		۲۱	۵۳	۱۹/۲۹	۱۱/۵۸	۰/۷۴
شرمساری	–	میانجی	۷	۳۲	۱۸/۵۵	۱۱/۵۳	۰/۷۰
خودانتقادی	خودانتقادی درونی	میانجی	۱۳	۶۰	۳۷/۹۶	۱۱/۵۹	۰/۶۶
	خودانتقادی مقایسه‌ای		۱۳	۵۲	۳۲/۷۳	۹/۸۹	۰/۹۱
	کل		۲۸	۱۰۷	۷۰/۶۹	۱۸/۴۱	۰/۸۴
حساسیت بین‌فردی	آگاهی بین فردی	برون زا	۸	۲۷	۱۸/۴۵	۴/۱۹	۰/۸۵
	نیاز به تایید		۱۷	۲۹	۲۴/۲۵	۲/۳۲	۰/۷۸
	اضطراب جدایی		۱۱	۳۲	۱۹/۷۴	۴/۳۷	۰/۶۹
	کمرویی		۱۳	۳۰	۲۰/۵۳	۴/۰۸	۰/۷۴
	عزت نفس شکننده		۷	۱۷	۱۱/۹۶	۲/۹۳	۰/۶۷
	کل		۶۴	۱۳۱	۹۴/۹۴	۱۴/۸۷	۰/۸۴
طرحواره رهاشدگی	–	برون زا	۵	۲۸	۱۴/۷۹	۶/۵۹	۰/۸۷

پیش از آزمون فرضیه‌های پژوهش، شاخص‌های توصیفی متغیرها و میزان پایایی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. نتایج جدول ۴-۵ نشان می‌دهد که میانگین سن شرکت‌کنندگان برابر با ۳۰/۷۷ سال و انحراف معیار آن ۷/۹۹ سال است. دامنه سنی نمونه نیز بین ۱۸ تا ۵۵ سال قرار دارد. در متغیر افسردگی، میانگین نمره مؤلفه شناختی ۶/۴۹ (انحراف معیار = ۴/۵۲)، مؤلفه عاطفی ۴/۱۷ (انحراف معیار = ۳/۵۲) و مؤلفه جسمانی ۸/۶۳ (انحراف معیار = ۴/۹۲) به دست آمد. همچنین میانگین نمره کل افسردگی ۱۹/۲۹ و انحراف معیار آن ۱۱/۵۸ گزارش شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های شناختی، عاطفی، جسمانی و نمره کل افسردگی به ترتیب برابر با

۰/۷۶، ۰/۷۲ ، ۰/۶۸ و ۰/۷۴ است که بیانگر پایایی قابل قبول این مقیاس و مؤلفه‌های آن است. در متغیر شرمساری، میانگین نمره برابر با ۱۸/۵۵ و انحراف معیار ۱۱/۵۳ بود و نمرات افراد در دامنه ۷ تا ۳۲ قرار داشت. ضریب آلفای کرونباخ این متغیر نیز ۰/۷۰ به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی مناسب ابزار لندازه‌گیری است. برای متغیر خودانتقادی، میانگین مؤلفه خودانتقادی درونی شده ۳۷/۹۶ با انحراف معیار ۱۱/۵۹ و میانگین مؤلفه خودانتقادی مقایسه‌ای ۳۲/۷۳ با انحراف معیار ۹/۸۹ گزارش شد. میانگین نمره کل خودانتقادی نیز ۶۹/۷۰ و انحراف معیار آن ۱۸/۴۱ بود. ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفه خودانتقادی درونی، خودانتقادی مقایسه‌ای و نمره کل به ترتیب ۰/۶۶، ۰/۹۱ و ۰/۸۴ محاسبه شد که به‌ویژه برای نمره کل و مؤلفه خودانتقادی مقایسه‌ای، بیانگر همسانی درونی مطلوب است. در متغیر حساسیت بین‌فردی، میانگین مؤلفه آگاهی بین‌فردی ۱۸/۴۵ (انحراف معیار = ۴/۱۹)، نیاز به تأیید ۲۴/۲۵ (انحراف معیار = ۲/۳۲)، اضطراب جدایی ۱۹/۷۴ (انحراف معیار = ۴/۳۷)، کمرویی ۲۰/۵۳ (انحراف معیار = ۴/۰۸) و عزت‌نفس شکننده ۱۱/۹۶ (انحراف معیار = ۲/۹۳) به دست آمد. همچنین میانگین نمره کل حساسیت بین‌فردی برابر با ۹۴/۹۴ و انحراف معیار آن ۱۴/۸۷ بود. ضرایب آلفای کرونباخ برای مؤلفه‌های مختلف این متغیر بین ۰/۶۷ تا ۰/۸۵ و برای نمره کل ۰/۸۴ گزارش شد که نشان‌دهنده پایایی مناسب این مقیاس است. در نهایت، برای متغیر طرحواره رهاشدگی، میانگین نمره ۱۴/۷۹ و انحراف معیار ۶/۵۹ به دست آمد و دامنه نمرات بین ۵ تا ۲۸ بود. ضریب آلفای کرونباخ این متغیر نیز ۰/۸۷ محاسبه شد که بیانگر همسانی درونی مطلوب و قابلیت اعتماد بالای این ابزار اندازه‌گیری است. به طور کلی، نتایج شاخص‌های توصیفی نشان می‌دهد که متغیرهای پژوهش از پراکندگی مناسبی برخوردار هستند و ضرایب آلفای کرونباخ تمامی مقیاس‌ها در دامنه قابل قبول تا مطلوب (۰/۶۶ تا ۰/۹۱) قرار دارند؛ بنابراین، ابزارهای مورد استفاده از پایایی کافی برای انجام تحلیل‌های استنباطی و آزمون فرضیه‌های پژوهش برخوردار هستند.

۴-۳ مفروضه‌های تحلیل

۴-۳-۱- نرمال بودن تک متغیری

به منظور بررسی میزان نرمال بودن توزیع داده‌ها در سطح تک‌متغیری، شاخص‌های چولگی و کشیدگی برای هر یک از متغیرهای پژوهش به صورت جداگانه محاسبه و ارزیابی شدند. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۶ ارائه شده است.

جدول ۴-۶- کشیدگی و چولگی متغیرهای پژوهش

متغیر	کشیدگی	چولگی
افسردگی-شناختی	۰/۸۹۶	۰/۳۷۴
افسردگی-عاطفی	۰/۸۷۴	-۰/۰۴۷
افسردگی-جسمانی	۰/۵۴۲	-۰/۶۴۸
افسردگی	۰/۷۵۱	-۰/۱۰۲
شرمساری	۰/۰۷۲	-۰/۵۰۱
خودانتقادی درونی‌شده	-۰/۳۳۷	-۰/۴۴۳
خودانتقادی مقایسه‌ای	۰/۰۶۲	-۰/۶۷۴
خودانتقادی	-۰/۲۶۴	-۰/۴۵۱
حساسیت بین‌فردی-آگاهی بین فردی	-۰/۰۴۳	-۰/۶۴۰
حساسیت بین‌فردی-نیاز به تایید	-۰/۴۱۰	۰/۴۸۸
حساسیت بین‌فردی-اضطراب جدایی	۰/۴۲۵	-۰/۱۶۰
حساسیت بین‌فردی-کمرویی	۰/۰۷۶	-۰/۴۶۱
حساسیت بین‌فردی-عزت نفس شکننده	۰/۰۲۸	-۱/۰۴۷
حساسیت بین‌فردی	۰/۲۳۵	-۰/۵۵۱
طرحواره رهاشدگی	۰/۱۳۹	-۱/۰۶۹

مطابق بر یافته‌های جدول ۴-۶ مقادیر چولگی و کشـــیدگی تمامی مؤلفه‌ها در محدوده ۲± قرار دارد. این یافته بیانگر آن است که مفروضه نرمال بودن توزیع داده‌های تک متغیری در بین داده‌ها برقرار است (کلاین[1]، ۲۰۱۶). با توجه به حجم نمونه پژوهش (۲۲۰ نفر) و هدف استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری، بررسی نرمال بودن داده‌ها بر اساس شاخص‌های چولگی و کشیدگی انجام شد؛ زیرا آزمون‌های نرمالیتی مانند شاپیرو–ویلک و کولموگروف–اسمیرنوف در حجم نمونه‌های نسبتاً بزرگ نسبت به انحراف‌های جزئی از توزیع نرمال حساس بوده و ممکن است حتی در شرایطی که داده‌ها از نظر عملی نرمال تلقی می‌شوند، نتایج معنادار گزارش کنند. بنابراین، در پژوهش حاضر علاوه بر بررسی شاخص‌های توصیفی، معیار چولگی و کشیدگی به عنوان ملاک اصلی ارزیابی نرمال بودن توزیع داده‌ها در نظر گرفته شد.

[1] Kline

۴-۳-۲- همخطی بودن

در این پژوهش مفروضه همخطی بودن به کمک عامل تورم واریانس[1] (VIF) و ضریب تحمل[2] مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول ۴-۷ قابل ملاحظه است.

جدول ۴-۷- عامل تورم واریانس و ضریب تحمل متغیرهای پیش‌بین

متغیر	ضریب تحمل	عامل تورم واریانس
شرمساری	۰/۴۵۷	۲/۱۸۷
خودانتقادی درونی‌شده	۰/۳۳۱	۳/۰۲۵
خودانتقادی مقایسه‌ای	۰/۲۵۸	۳/۸۸۰
حساسیت بین‌فردی-آگاهی بین فردی	۰/۱۶۸	۵/۹۴۵
حساسیت بین‌فردی-نیاز به تایید	۰/۵۴۶	۱/۸۳۰
حساسیت بین‌فردی-اضطراب جدایی	۰/۱۶۱	۶/۲۰۵
حساسیت بین‌فردی-کمرویی	۰/۵۰۰	۱/۹۹۸
حساسیت بین‌فردی-عزت نفس شکننده	۰/۲۳۷	۴/۲۲۷
طرحواره رهاشدگی	۰/۴۶۱	۲/۱۶۷

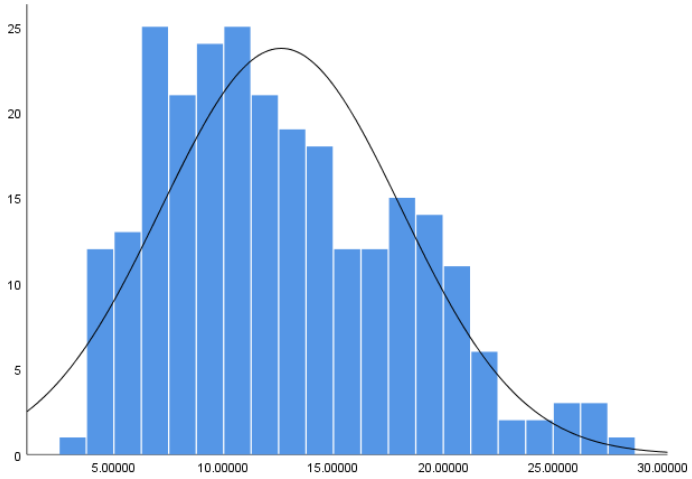
جدول ۴-۷ نشان می‌دهد که مفروضه همخطی بودن در بین داده‌های پژوهش حاضر برقرار است. چرا که مقادیر ضریب تحمل متغیرهای پیش بین بزرگتر از ۰/۱ و مقادیر عامل تورم واریانس هر یک از آنها کوچکتر از ۱۰ است. منطبق بر دیدگاه مایرز[3] و همکاران (۲۰۰۶) ضریب تحمل کوچکتر از ۰/۱ و ارزش عامل تورم واریانس بزرگتر از ۱۰ نشان دهنده عدم برقراری مفروضه همخطی بودن است.

۴-۳-۳- نرمال بودن توزیع چند متغیری و بررسی داده‌های پرت

به منظور بررسی مفروضه نرمال بودن توزیع چندمتغیری داده‌ها، از شاخص‌های مربوط به نرمالیت چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار چولگی چندمتغیری برابر با ۰/۵۱ و کشیدگی چندمتغیری برابر با ۰/۴۲ و در محدوده قابل قبول قرار دارند و بنابراین مفروضه نرمال بودن چندمتغیری داده‌ها برقرار است. همچنین، به منظور شناسایی داده‌های پرت چندمتغیری، از فاصله مهلنوبایس[4] استفاده شد. در این روش، مقادیر فاصله مهلنوبایس هر آزمودنی با مقدار بحرانی کای‌دو با درجات آزادی برابر با تعداد متغیرهای مورد بررسی مقایسه شد. نتایج بررسی

[1] variance inflation factor (VIF)
[2] tolerance
[3] Meyers
[4] Mahalanobis distance (D)

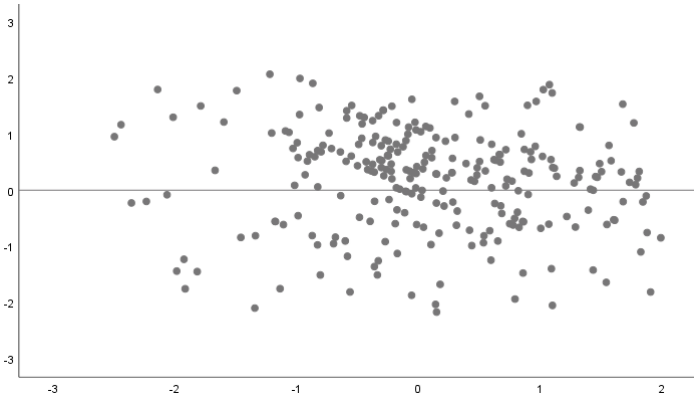
نشـــان داد که هیچ‌یک از موارد دارای فاصـــله مهلنوبایس بالاتر از مقدار بحرانی نبودند؛ بنابراین، هیچ داده پرت چندمتغیری از تحلیل حذف نشـــد و تمامی ۲۲۰ آزمودنی در تحلیل نهایی باقی ماندند. نمودار توزیع مقادیر فاصـــله مهلنوبایس در شکل ۴-۱ ارائه‌شد.



شکل ۴-۱- نمودار هیستوگرام توزیع مقادیر فاصله مهلنوبایس

۴-۳-۴- همگنی واریانس‌ها

به منظور بررسی مفروضـه همگنی واریانس‌ها، ابتدا آزمون لوین برای بررسی برابری واریانس‌ها انجام شـد. نتایج این آزمون نشـان داد که مقدار آزمون لوین برای متغیرهای پژوهش در سـطح معناداری بالاتر از ۰/۰۵ قرار دارد؛ بنابراین، فرض صـفر مبنی بر برابری واریانس‌ها رد نشـد و مفروضـه همگنی واریانس‌ها برقرار بود. همچنین، به منظور بررسـی بصـری این مفروضـه در چارچوب تحلیل‌های مبتنی بر مدل‌یابی معادلات سـاختاری، نمودار پراکندگی باقیمانده‌های اسـتانداردشـده نیز مورد بررسـی قرار گرفت. همان‌گونه که در شـکل ۴-۲ مشـاهده می‌شـود، پراکندگی باقیمانده‌ها در سـراسـر دامنه مقادیر پیش‌بینی‌شـده الگوی خاصـی نداشـته و توزیع آن‌ها نسـبتاً یکنواخت اسـت؛ بنابراین، شـواهد لازم برای تأیید برقرار بودن مفروضه همگنی واریانس‌ها فراهم شد.



شکل ۴-۲- نمودار پراکندگی واریانس استاندارد شده خطا

جدول ۴-۸- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵
۱.افسردگی-شناختی	۱														
۲.افسردگی-عاطفی	۰/۶۵**	۱													
۳.افسردگی-جسمانی	۰/۶۶**	۰/۷۶**	۱												
۴.افسردگی	۰/۸۷**	۰/۸۸**	۰/۹۱**	۱											
۵.شرمساری	۰/۶۲**	۰/۴۲**	۰/۵۶**	۰/۶۱**	۱										
۶.خودانتقادی درونی‌شده	۰/۴۷**	۰/۳۵**	۰/۴۴**	/۴۸**	۰/۴۹**	۱									
۷.خودانتقادی مقایسه‌ای	۰/۵۳**	۰/۵۴**	۰/۵۵**	۰/۶۱**	۰/۵۶**	۰/۴۷**	۱								
۸.خودانتقادی	۰/۵۸**	۰/۵۱**	۰/۵۷**	۰/۶۲**	۰/۶۱**	۰/۸۸**	۰/۸۳**	۱							
۹.آگاهی بین فردی	۰/۵۸**	۰/۴۷**	۰/۵۸**	۰/۶۲**	۰/۶۵**	۰/۷۱**	۰/۷۳**	۰/۸۴**	۱						
۱۰.نیاز به تایید	۰/۲۴**	۰/۲۱**	۰/۳۴**	۰/۳۰**	۰/۳۴**	۰/۳۹**	۰/۳۰**	۰/۴۱**	۰/۵۸**	۱					
۱۱.اضطراب جدایی	۰/۶۷**	۰/۵۸**	۰/۶۶**	/۷۲**	۰/۶۸**	۰/۷۸**	۰/۶۹**	۰/۸۶**	۰/۸۲**	۰/۳۹**	۱				
۱۲.کمرویی	۰/۶۵**	۰/۴۸**	۰/۵۷**	۰/۴۶**	۰/۴۹**	۰/۳۶**	۰/۵۰**	۰/۵۰**	۰/۵۶**	۰/۴۵**	۰/۵۵**	۱			
۱۳.عزت نفس شکننده	۰/۵۲**	۰/۵۱**	۰/۶۲**	۰/۶۲**	۰/۵۱**	۰/۶۳**	۰/۷۸**	۰/۸۲**	۰/۷۹**	۰/۴۲**	۰/۷۷**	۰/۴۴**	۱		
۱۴.حساسیت بین‌فردی	۰/۶۸**	۰/۵۷**	۰/۶۹**	۰/۷۴**	۰/۶۸**	۰/۷۲**	۰/۷۵**	۰/۸۵**	۰/۹۲**	۰/۶۵**	۰/۸۹**	۰/۷۵**	۰/۸۴**	۱	
۱۵.طرحواره رهاشدگی	۰/۶۱**	۰/۴۴**	۰/۴۸**	۰/۵۸**	۰/۴۵**	۰/۳۴**	۰/۶۱**	۰/۵۴**	۰/۵۸**	۰/۴۳**	۰/۴۵**	۰/۶۰**	۰/۴۹**	۰/۶۳**	۱

P^{**}< ۰/۰۱ و P^{*}< ۰/۰۵

جدول ۴-۸ ضـرایب همبسـتگی پیرسـون بین متغیرهای پژوهش را نشـان می‌دهد. نتایج بیانگر آن اسـت که تمامی روابط گزارش‌شـــده از نظر آماری در ســـطح P<۰/۰۱ معنادار هســـتند. به طور کلی، بین متغیرهای پژوهش همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد که بیانگر هم‌جهت بودن تغییرات آن‌ها است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، سـه مؤلفه افسـردگی با یکدیگر همبسـتگی مثبت و نسـبتاً بالایی دارند؛ به‌گونه‌ای که همبسـتگی بین مؤلفه شـناختی و عاطفی برابر با ۰/۶۵، بین مؤلفه شناختی و جسمانی برابر با ۰/۶۶ و بین مؤلفه عاطفی و جسمانی برابر با ۰/۷۶ است. همچنین هر سـه مؤلفه با نمره کل افسـردگی همبسـتگی بسـیار بالایی دارند که این ضـرایب برای مؤلفه‌های شـناختی، عاطفی و جسـمانی به ترتیب برابر با ۰/۸۷، ۰/۸۸ و ۰/۹۱ اسـت. متغیر شـرمسـاری نیز با افسـردگی و مؤلفه‌های آن همبسـتگی مثبت و معناداری نشـان داد؛ به طوری که ضـرایب همبسـتگی آن با مؤلفه‌های شـناختی، عاطفی و جسـمانی افسـردگی به ترتیب ۰/۶۲، ۰/۴۲ و ۰/۵۶ و با نمره کل افسـردگی ۰/۶۱ بود. علاوه بر این، شـرمسـاری با خودانتقادی درونی‌شـده، خودانتقادی مقایسـه‌ای، نمره کل خودانتقادی، آگاهی بین‌فردی، نیاز به تأیید، اضـطراب جدایی، کمرویی، عزت‌نفس شکننده، حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی نیز رابطه مثبت و معناداری داشت.

نتایج مربوط به متغیر خودانتقادی نشـان داد که دو مؤلفه خودانتقادی درونی‌شـده و خودانتقادی مقایسـه‌ای با یکدیگر همبسـتگی مثبت و معناداری (۰/۴۷) دارند و هر دو با نمره کل خودانتقادی همبسـتگی بسـیار بالایی نشـان می‌دهند؛ به‌طوری‌که ضریب همبستگی خودانتقادی درونی‌شده با نمره کل ۰/۸۸ و خودانتقادی مقایسه‌ای با نمره کل ۰/۸۳ است. همچنین نمره کل خودانتقادی با افسردگی، شرمساری، آگاهی بین‌فردی، نیاز به تأیید، اضطراب جدایی، کمرویی، عزت‌نفس شـکننده، حسـاسـیت بین‌فردی و طرحواره رهاشـدگی همبسـتگی مثبت و معناداری دارد. در میان مؤلفه‌های حساسیت بین‌فردی نیز همبستگی‌های مثبت و معناداری مشاهده شد. بیشترین همبستگی مربوط به رابطه آگاهی بین‌فردی و اضـطراب جدایی (۰/۸۲) و کمترین همبسـتگی مربوط به رابطه نیاز به تأیید و اضـطراب جدایی (۰/۳۹) بود. همچنین نمره کل حسـاسـیت بین‌فردی با آگاهی بین‌فردی، نیاز به تأیید، اضـطراب جدایی، کمرویی و عزت‌نفس شکننده همبستگی مثبت و معناداری نشان داد که بیانگر انسجام مناسب مؤلفه‌های این سازه است.

طرحواره رهاشدگی نیز با تمامی متغیرهای پژوهش رابطه مثبت و معنادار داشت. ضرایب همبستگی این متغیر با مؤلفه‌های شـناختی، عاطفی و جسـمانی افسـردگی به ترتیب برابر با ۰/۶۱، ۰/۴۴ و ۰/۴۸ و با نمره کل افسـردگی ۰/۵۸ بود. همچنین این متغیر با شـرمسـاری، خودانتقادی درونی‌شـده، خودانتقادی مقایسـه‌ای، نمره کل خودانتقادی و حساسیت بین‌فردی نیز همبستگی مثبت و معناداری داشت. به طور کلی، نتایج ماتریس همبستگی نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای اصـــلی پژوهش دارای روابط مثبت و معنادار با یکدیگر هســـتند. همچنین هیچ‌یک از ضـــرایب همبستگی بین متغیرهای اصلی از مقدار ۰/۹۰ فراتر نرفته است؛ بنابراین، با وجود وجود همبستگی‌های نسبتاً قوی، شواهدی مبنی بر هم‌خطی شدید میان سازه‌های اصلی پژوهش مشاهده نمی‌شود و ماتریس همبستگی از کفایت لازم برای ادامه تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری برخوردار است. همچنین مطابق با جدول ۴-۸ می‌توان گفت ضـرایب همبستگی بین متغیرها در جهت مورد انتظار و همسو با تئوری های حوزه پژوهش بود.

۴-۴ آزمون فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اصلی: برای پیش‌بینی شدت افسردگی بر اساس حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با میانجی‌گری خودانتقادی و شرمساری در زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد می‌توان مدل ساختاری برازش کرد.

فرضیه فرعی اول: حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری دارد.

فرضیه فرعی دوم: طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری دارد.

فرضیه فرعی سوم: خودانتقادی با شدت‌افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهرمشهد رابطه مستقیم معناداری‌دارد.

فرضیه فرعی چهارم: شرمساری با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری‌دارد.

فرضیه فرعی پنجم: حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

فرضیه فرعی ششم: حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

فرضیه فرعی هفتم: طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

فرضیه فرعی هشتم: طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

برای آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر از روش تحلیل مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. این روش در دو مرحله، ابتدا به ارزیابی چگونگی برازش مدل اندازه‌گیری با داده‌های گردآوری شده و در ادامه به ارزیابی چگونگی برازش مدل ساختاری با داده‌ها می‌پردازد. در این روش برای ارزیابی چگونگی برازش مدل ساختاری تحلیل مسیر به کار گرفته می‌شود.

۴-۴-۱- مدل ساختاری

در مدل اندازه‌گیری پژوهش (شکل ۴-۳) چنین فرض شده بود که متغیر مکنون افسردگی بعنوان متغیر درونزا، متغیر مکنون شرمساری و خودانتقادی بعنوان متغیرهای میانجی و متغیرهای مکنون حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی نیز بعنوان متغیرهای برونزا در نظر گرفته شد. چگونگی برازش مدل اندازه‌گیری با استفاده از تحلیل عاملی

تاییدی، نرم افزار AMOS 26.0 و برآورد بیشینه احتمال[1] (ML) ارزیابی شد. جدول ۴-۹ شاخص‌های برازندگی مدل اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.

جدول ۴-۹- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری

شاخص‌های برازندگی	مدل اندازه گیری	نقطه برش[2]
مجذور کای[3]	۱/۴۵۹	-
درجه آزادی مدل	۱	-
χ^2/df[4]	۱/۴۵۹	کمتر از ۳
GFI[5]	۰/۹۸	۰/۹۰ <
AGFI[6]	۰/۹۶	۰/۸۵۰ <
CFI[7]	۰/۹۹	۰/۹۰ <
RMSEA[8]	۰/۰۴۶	۰/۰۸ >

جدول ۴-۹ نشان می دهد که همه شاخص‌های برازندگی حاصل از تحلیل عاملی تاییدی از برازش قابل قبول مدل اندازه‌گیری با داده‌های گرآوری شده حمایت می‌کنند. در مدل ساختاری فرض شده بود که حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با میانجی‌گری خودانتقادی و شرمساری، شدت افسردگی را در زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد پیش‌بینی می‌کند. بدین ترتیب در آزمون فرضیه اول چنین نتیجه گیری شد که مدل ساختاری پژوهش با داده های گردآوری شده برازش دارد و فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار گرفت. جدول ۴-۱۰ ضرایب مسیر در مدل ساختاری را نشان می دهد.

جدول۴-۱۰- ضرایب مسیر کل و مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل ساختاری

اثر	مسیر	b	S.E	β	p
مستقیم	حساسیت بین‌فردی ← خودانتقادی	۱/۰۴۷	۰/۰۵۶	۰/۸۴۶	۰/۰۰۱
	حساسیت بین‌فردی ← افسردگی	۰/۳۹۴	۰/۰۷۵	۰/۵۰۶	۰/۰۰۱
	حساسیت بین‌فردی ← شرمساری	۰/۲۶۰	۰/۰۲۶	۰/۶۴۸	۰/۰۰۱
	طرحواره رهاشدگی ← خودانتقادی	۰/۰۳۲	۰/۱۲۷	۰/۰۱۲	۰/۸۰۰
	طرحواره رهاشدگی ← افسردگی	۰/۳۲۴	۰/۰۹۸	۰/۱۸۴	۰/۰۰۱
	طرحواره رهاشدگی ← شرمساری	۰/۰۴۱	۰/۰۵۸	۰/۰۴۵	۰/۴۸۱

[1] Maximum Likelihood

[2] نقاط برش براساس دیدگاه کلاین (۲۰۲۳)

[3] Chi-Squre
[4] normed chi-square
[5] Goodness Fit Index
[6] Adjusted Goodness Fit Index
[7] Comparative Fit Index
[8] Root Mean Square Error of Approximation

	خودانتقادی ← افسردگی	-۰/۰۱۶	۰/۰۵۳	-۰/۰۲۶	۰/۷۵۷
	شرمساری ← افسردگی	۰/۳۹۱	۰/۱۱۵	۰/۲۰۱	۰/۰۰۱
غیرمستقیم[1]	حساسیت بین فردی ← خودانتقادی ← افسردگی	۰/۰۸۵	۰/۰۷۱	۰/۱۰۹	۰/۰۰۱
	حساسیت بین فردی ← شرمساری ← افسردگی	۰/۱۳۰	۰/۰۹۲	۰/۲۶۲	۰/۰۰۱
	طرحواره رهاشدگی ← خودانتقادی ← افسردگی	۰/۰۱۵	۰/۱۱۷	۰/۰۰۹	۰/۸۰۰
	طرحواره رهاشدگی ← شرمساری ← افسردگی	۰/۰۰۹	۰/۱۱۲	۰/۰۱۸	۰/۴۸۱
کل	حساسیت بین فردی ← افسردگی	۰/۶۰۹	۰/۰۹۰	۰/۳۹۴	۰/۰۰۱
	طرحواره رهاشدگی ← افسردگی	۰/۳۳۹	۰/۱۱۸	۰/۱۹۳	۰/۰۰۱

فرضیه فرعی اول: حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری دارد.

جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که ضریب مسیر کل بین حساسیت بین‌فردی و افسردگی (β=۰/۳۹۴ ،P =۰/۰۰۱) مثبت و معنادار است. بر این اساس در آزمون فرضیه فرعی اول چنین نتیجه‌گیری شد که حساسیت بین فردی به صورت مثبت و معنادار شدت افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد پیش‌بینی می‌کند.

فرضیه فرعی دوم: طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری دارد.

جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که ضریب مسیر کل بین طرحواره رهاشدگی و افسردگی (β=۰/۱۹۳ ،P =۰/۰۰۱) مثبت و معنادار است. بر این اساس در آزمون فرضیه فرعی دوم چنین نتیجه‌گیری شد که طرحواره رهاشدگی به صورت مثبت و معنادار شدت افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد پیش‌بینی می‌کند.

فرضیه فرعی سوم: خودانتقادی با شدت‌افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهرمشهد رابطه مستقیم معناداری‌دارد.

جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که ضریب مسیر مستقیم بین خودانتقادی و افسردگی (β=-۰/۰۲۶ ،P =۰/۷۵۷) منفی و معنادار نیست. بر این اساس در آزمون فرضیه فرعی سوم چنین نتیجه‌گیری شد که خودانتقادی، شدت افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد پیش‌بینی نمی‌کند.

فرضیه فرعی چهارم: شرمساری با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری‌دارد.

[1] – در این پژوهش به منظور برآورد خطای استاندارد مسیرهای غیر مستقیم از روش برآورد بوت استراب با حجم نمونه ۲۰۰۰ استفاده شد.

جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که ضریب مسیر مستقیم بین شرمساری و افسردگی (P =۰/۰۰۱، β=۰/۲۰۱) مثبت و معنادار است. بر این اساس در آزمون فرضیه فرعی چهارم چنین نتیجه‌گیری شد که شرمساری به صورت مثبت و معنادار شدت افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد پیش‌بینی می‌کند.

فرضیه فرعی پنجم: حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین حساسیت بین فردی و افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی (P =۰/۰۰۱، β=۰/۱۰۹) مثبت و معنادار است. بر این اساس در آزمون فرضیه فرعی پنجم چنین نتیجه‌گیری شد که خودانتقادی به صورت مثبت و معناداری رابطه بین حساسیت بین فردی و شدت افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد پیش‌بینی می‌کند.

فرضیه فرعی ششم: حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین حساسیت بین فردی و افسردگی با میانجی‌گری شرمساری (P =۰/۰۰۱، β=۰/۲۶۲) مثبت و معنادار است. بر این اساس در آزمون فرضیه فرعی ششم چنین نتیجه‌گیری شد که شرمساری به صورت مثبت و معناداری رابطه بین حساسیت بین فردی و شدت افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد پیش‌بینی می‌کند.

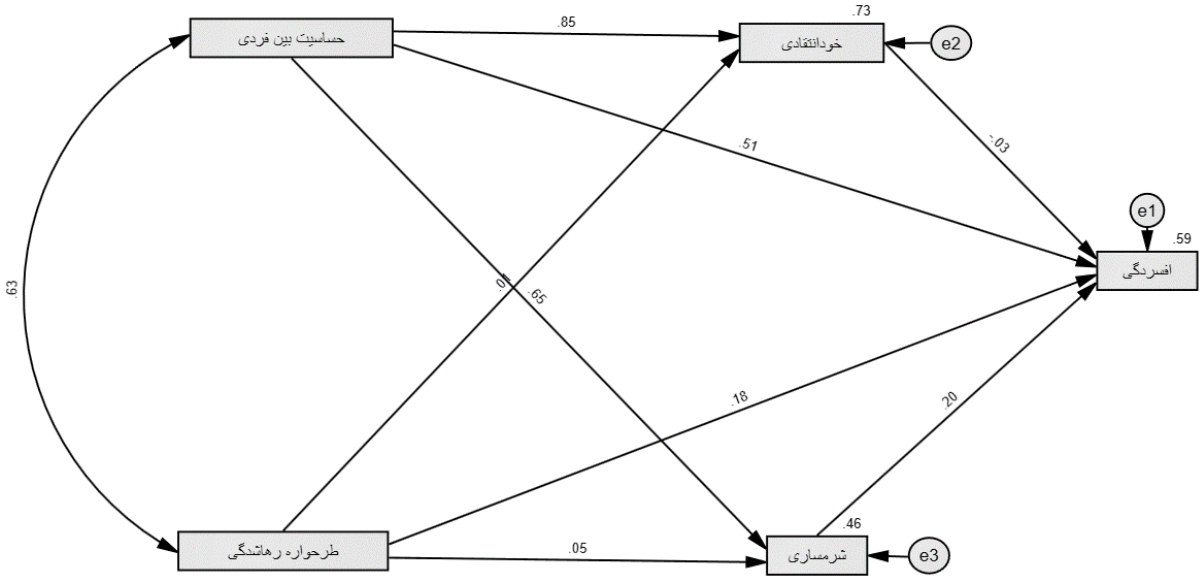
فرضیه فرعی هفتم: طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین طرحواره رهاشدگی و افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی (P =۰/۸۰۰، β=۰/۰۰۹) مثبت و معنادار نیست. بر این اساس در آزمون فرضیه فرعی هفتم چنین نتیجه‌گیری شد که خودانتقادی رابطه بین طرحواره رهاشدگی و شدت افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد پیش‌بینی نمی‌کند.

فرضیه فرعی هشتم: طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

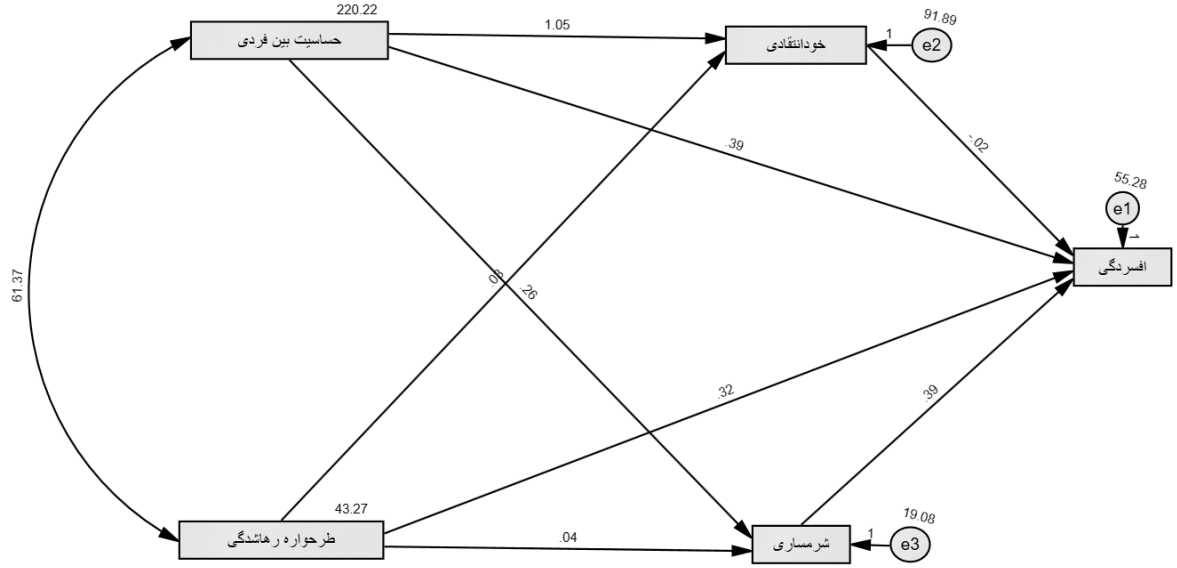
جدول ۴-۱۰ نشان می‌دهد که ضریب مسیر غیرمستقیم بین طرحواره رهاشدگی و افسردگی با میانجی‌گری شرمساری (P =۰/۴۸۱، β=۰/۰۱۸) مثبت و معنادار نیست. بر این اساس در آزمون فرضیه فرعی هشتم چنین نتیجه‌گیری شد که شرمساری رابطه بین طرحواره رهاشدگی و شدت افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد پیش‌بینی نمی‌کند.

شکل ۴-۴ مدل ساختاری پژوهش با استفاده از داده‌های استاندارد و شکل ۴-۵ مدل ساختاری پژوهش با استفاده از داده‌های غیر استاندارد را نشان می‌دهند.



شکل ۴-۳- پارامترهای استاندارد در مدل ساختاری پژوهش

شکل فوق نشان می‌دهد که مجموع مجذور همبستگی‌های چندگانه (R^2) برای متغیر افسردگی برابر با ۰/۵۹ به بدست آمده است، این موضوع بیانگر آن است که حساسیت بین فردی، طرحواره رهاشدگی، خودانتقادی و شرمساری در مجموع ۵۹ درصد از واریانس افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد تبیین می‌کند. همچنین ضریب تعیین شرمساری و خودانتقادی به ترتیب برابر با ۰/۴۶ و ۰/۷۳ محاسبه شد.



شکل ۴-۴- پارامترهای غیر استاندارد در مدل ساختاری پژوهش

فصل پنجم

بحث و نتیجه‌گیری

در فصل‌های پیشین، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش‌شناسی تحقیق و همچنین یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ارائه شد. در فصل حاضر، یافته‌های پژوهش با توجه به اهداف، فرضیه‌ها و چارچوب نظری مورد بحث و تفسیر قرار می‌گیرد. هدف اصلی این فصل، تبیین و تحلیل نتایج به‌دست‌آمده و مقایسه آن‌ها با یافته‌های پژوهش‌های پیشین است تا ابعاد مختلف روابط میان متغیرهای مورد بررسی روشن‌تر شود. در این فصل، ابتدا خلاصه‌ای از یافته‌های اصلی پژوهش ارائه می‌شود؛ سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در پرتو مبانی نظری و مطالعات پیشین مورد بررسی و تفسیر قرار می‌گیرد. در ادامه، پیامدهای نظری و کاربردی یافته‌ها، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده ارائه خواهد شد. این فصل درصدد است ضمن جمع‌بندی نتایج پژوهش، به درک بهتر نقش متغیرهای مورد مطالعه در تبیین پدیده مورد بررسی کمک کرده و زمینه‌های جدیدی را برای تحقیقات آتی فراهم سازد.

۵-۱ بحث در نتایج

۵-۱-۱- فرضیه اصلی

برای پیش‌بینی شدت افسردگی بر اساس حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با میانجی‌گری خودانتقادی و شرمساری در زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد می‌توان مدل ساختاری برازش کرد.

یافته‌های پژوهش حاضر در مورد این فرضیه نشان داد که مدل ساختاری پیشنهادی برای پیش‌بینی شدت افسردگی بر اساس حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی با میانجی‌گری خودانتقادی و شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد، با داده‌های گردآوری‌شده برازش قابل قبول داشته و فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر، نتایج نشان داد که مجموعه متغیرهای حساسیت بین‌فردی، طرحواره رهاشدگی، خودانتقادی و شرمساری در قالب یک مدل ساختاری توانایی تبیین شدت افسردگی را دارند و مسیرهای مفهومی پیش‌بینی‌شده در مدل پژوهش با الگوی مشاهده‌شده در نمونه مورد مطالعه همخوانی دارد. این یافته با یافته‌های پژوهش فاریابی و اکرمی (۱۴۰۴)، سلمان‌نژاد و همکاران (۱۴۰۱)، مهدوی‌راد و همکاران (۱۴۰۲)، لیو و همکاران (۲۰۲۴)، استفان و همکاران (۲۰۲۵) و پورتر و همکاران (۲۰۱۸) همسو بود.

در تبیین این یافته می‌توان گفت که برازش مدل ساختاری پژوهش حاضر نشان می‌دهد افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی، حاصل تعامل ساده و مستقیم یک عامل منفرد نیست، بلکه نتیجه فعال شدن زنجیره‌ای از فرایندهای شناختی، هیجانی و بین‌فردی است که در بستر ویژگی‌های شخصیتی و تجربیات رابطه‌ای فرد شکل می‌گیرند. بر اساس دیدگاه‌های شناختی و طرحواره‌ای، افراد در طول رشد خود، بر اساس تجربه‌های مکرر از پاسخ‌دهی محیط، روابط اولیه، میزان دریافت حمایت هیجانی و کیفیت دلبستگی، الگوهای پایدار شناختی و هیجانی را شکل می‌دهند که بعدها به‌عنوان چارچوب تفسیر رویدادهای زندگی عمل می‌کنند (یانگ و همکاران، ۲۰۱۹). در این میان، طرحواره رهاشدگی به‌عنوان یکی از طرحواره‌های حوزه بریدگی و طرد، موجب

می‌شود فرد انتظار داشته باشد افراد مهم زندگی او در زمان نیاز حضور نداشته باشند یا حمایت عاطفی مورد انتظار را ارائه نکنند. این انتظار پایدار، موجب می‌شود موقعیت‌های مبهم بین‌فردی مانند کاهش توجه دیگران، فاصله گرفتن موقت یا تغییر رفتار اطرافیان، به شکل تهدیدآمیز تفسیر شود و فرد آمادگی بیشتری برای تجربه هیجان‌های منفی مانند ترس، غم، ناامیدی و شرمساری پیدا کند. در چنین شرایطی، طرحواره رهاشدگی تنها به‌صورت یک باور شناختی باقی نمی‌ماند، بلکه از طریق ایجاد سبک خاصی از پردازش اطلاعات اجتماعی، روابط فرد با دیگران و برداشت او از ارزشمندی خویشتن را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ فرایندی که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری علائم افسردگی شود (نیر و همکاران، ۲۰۲۲).

همچنین می‌توان بیان کرد که حساسیت بین‌فردی در مدل حاضر به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم آسیب‌پذیری روان‌شناختی، نقش اساسی در انتقال تجربه‌های اجتماعی به تجربه‌های افسرده‌ساز ایفا می‌کند. افرادی که حساسیت بین‌فردی بالاتری دارند، معمولاً نسبت به نشانه‌های ارزیابی، انتقاد، عدم پذیرش یا طرد اجتماعی، توجه و واکنش هیجانی بیشتری نشان می‌دهند و تمایل دارند رفتار دیگران را از زاویه تهدید، بی‌ارزشی شخصی یا احتمال رد شدن تفسیر کنند. این سبک پردازش اجتماعی باعث می‌شود فرد در روابط خود دائماً در وضعیت پایش تهدید قرار گیرد و کوچک‌ترین نشانه‌های منفی را به عنوان تأییدی بر ناکافی بودن یا دوست‌داشتنی نبودن خود برداشت کند (بویس و پارکر، ۱۹۸۹). تداوم چنین فرایندی، تعاملات اجتماعی را برای فرد به منبعی از اضطراب و نگرانی تبدیل کرده و احتمال کناره‌گیری اجتماعی، کاهش دریافت حمایت اجتماعی و افزایش احساس تنهایی را بالا می‌برد. از آنجا که حمایت اجتماعی یکی از عوامل محافظت‌کننده مهم در برابر افسردگی محسوب می‌شود، کاهش تعاملات مثبت و افزایش برداشت‌های منفی از روابط می‌تواند مسیر شکل‌گیری و تداوم علائم افسردگی را تقویت کند. بنابراین، قرار گرفتن حساسیت بین‌فردی در کنار طرحواره رهاشدگی در مدل پژوهش حاضر نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری افسردگی در زنان می‌تواند از طریق تعامل میان انتظار طرد شدن و حساسیت شدید نسبت به ارزیابی دیگران شکل گیرد (پولسکایا و همکاران، ۲۰۲۵).

از سوی دیگر، نقش میانجی خودانتقادی و شرمساری در مدل حاضر را می‌توان بر اساس این دیدگاه تبیین کرد که عوامل شناختی و هیجانی، حلقه اتصال میان تجربه‌های بین‌فردی آسیب‌زا و بروز افسردگی هستند. حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی به‌تنهایی الزاماً به افسردگی منجر نمی‌شوند، بلکه زمانی اثرات آسیب‌زای بیشتری پیدا می‌کنند که فرد این تجربه‌ها را در سطح هویت شخصی خود پردازش کند. در این شرایط، فرد ممکن است به جای آنکه رفتار دیگران را ناشی از عوامل موقعیتی بداند، آن را نشانه‌ای از نقص، بی‌ارزشی یا ناتوانی خود تلقی کند (تامسون و زاروف، ۲۰۰۴). این نوع تفسیر، زمینه را برای فعال شدن خودانتقادی فراهم می‌کند؛ به گونه‌ای که فرد در مواجهه با ناکامی‌های اجتماعی، اشتباهات یا تجربه طرد، به جای حمایت از خود، به سرزنش، تحقیر و ارزیابی منفی خویشتن می‌پردازد. خودانتقادی مداوم سبب می‌شود فرد معیارهای سختگیرانه و دست‌نیافتنی برای خود ایجاد کند و هرگونه فاصله از این معیارها را به عنوان شکست شخصی تجربه نماید. در نتیجه، چرخه‌ای از ارزیابی منفی خود، احساس ناکارآمدی، ناامیدی و خلق افسرده شکل می‌گیرد که با تداوم علائم افسردگی همراه است (گیلبرت و همکاران، ۲۰۱۹).

شـرمسـاری نیز در این مدل به‌عنوان یک فرایند هیجانی عمیق، می‌تواند توضـیح‌دهنده این باشـد که چگونه تجربه‌های مربوط به طرد، رهاشـدگی و حسـاسـیت نسـبت به دیگران به احسـاس افسـردگی تبدیل می‌شـوند. شـرم برخلاف احساس گناه که بیشتر به یک رفتار مشخص مربوط است، ارزیابی منفی کلی از خود را دربر می‌گیرد؛ یعنی فرد نه صرفاً احساس می‌کند کاری اشتباه انجام داده، بلکه خود را فردی ناقص، نامطلوب یا فاقد ارزش تلقی می‌کند (گیلبرت، ۲۰۱۴). هنگامی که طرحواره رهاشـدگی یا حسـاسـیت بین‌فردی فعال می‌شـود، فرد ممکن اسـت تجربه‌های اجتماعی منفی را به ساختار هویتی خود مرتبط سازد و باور کند که علت عدم پذیرش یا فاصله دیگران، وجود نقصی اسـاسـی در شـخصـیت اوسـت (کیم و همکاران، ۲۰۲۱). این فرایند، تجربه شـرم را افزایش داده و با ایجاد احسـاس حقارت، کناره‌گیری اجتماعی، کاهش ارتباط با دیگران و افزایش افکار منفی درباره خود، زمینه را برای تشـــدید افسـردگی فراهم می‌کند. بنابراین، یافته مربوط به برازش مدل میانجی در پژوهش حاضـر را می‌توان نشـان‌دهنده نقش اساسی فرایندهای هیجانی مانند شرم و فرایندهای شـناختی مانند خودانتقادی در تبدیل آسیب‌پذیری‌های بین‌فردی و طرحواره‌ای به علائم افسردگی دانست (تنگنی و همکاران، ۲۰۱۴).

بر اساس این تبیین، تأیید مدل ساختاری پژوهش حاضر بیانگر آن است که رابطه میان حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشـدگی با شـدت افسـردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک، در یک شـبکه پیچیده از باورهای بنیادین، ارزیابی‌های خود، هیجان‌های خودآگاه و الگوهای تعامل اجتماعی قرار دارد. از منظر نظریه طرحواره‌های ناسـازگار اولیه، تجربه‌های اولیه برآورده نشدن نیازهای هیجانی، به شکل‌گیری ساختارهایی منجر می‌شوند که در بزرگسالی بر ادراک فرد از خود و دیگران اثر می‌گذارند (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳). زمانی که این ساختارها با حساسیت بالا نسبت به روابط اجتماعی همراه شـوند، فرد آمادگی بیشـتری برای تجربه طرد ادراک‌شـده، خودسـرزنشـی و شـرم پیدا می‌کند. این فرایندها به تدریج ظرفیت فرد برای تجربه روابط امن، پذیرش خود و تنظیم هیجان‌های منفی را کاهش داده و احتمال شـدت یافتن افسـردگی را افزایش می‌دهند (کاندی و همکاران، ۲۰۲۲). بنابراین، مدل تأییدشـده در پژوهش حاضر را می‌توان بازتابی از تعامل میان عوامل شناختی عمیق، تجربه‌های هیجانی و سازوکارهای بین‌فردی دانست که در کنار یکدیگر مسیر شکل‌گیری و تداوم افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی توضیح می‌دهند.

۵-۱-۲- فرضیه فرعی اول

حسـاسـیت بین‌فردی با شـدت افسـردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شـناختی شـهر مشـهد رابطه مستقیم معناداری دارد.

یافته‌های پژوهش حاضـر در مورد این فرضـیه نشـان داد که حسـاسـیت بین‌فردی با شـدت افسـردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم، مثبت و معناداری دارد؛ به‌طوری‌که ضریب مسیر کل بین حسـاسـیت بین‌فردی و افسـردگی برابر با ۰/۳۹۴ و در سـطح ۰/۰۰۱ معنادار بود. این یافته نشـان می‌دهد که افزایش حسـاسـیت بین‌فردی با افزایش شـدت نشـانه‌های افسـردگی همراه اسـت و زنان دارای حسـاسـیت بین‌فردی بالاتر، آمادگی بیشـتری برای تجربه علائم افسـردگی نشـان می‌دهند. این یافته با یافته‌های پژوهش فاریابی و اکرمی (۱۴۰۴)، سـلمان‌نژاد و همکاران (۱۴۰۱)، لیو و همکاران (۲۰۲۴)، پولسـکایا و همکاران (۲۰۲۵) و کیم و همکاران (۲۰۲۱) همسو بود.

در تبیین این یافته می‌توان گفت که حساسیت بین‌فردی یکی از سازه‌های مهم در تبیین آسیب‌پذیری روان‌شناختی افراد محسوب می‌شود؛ زیرا این ویژگی باعث می‌شود فرد در تعاملات اجتماعی، توجه بیشتری به نشانه‌های احتمالی ارزیابی منفی، انتقاد، عدم پذیرش و طرد شدن داشته باشد و رویدادهای بین‌فردی را با سوگیری منفی پردازش کند. بر اساس دیدگاه بویس و پارکر (۱۹۸۹)، حساسیت بین‌فردی شامل مؤلفه‌هایی مانند آگاهی شدید نسبت به واکنش دیگران، اضطراب در روابط اجتماعی، کم‌رویی، عزت‌نفس شکننده و نیاز زیاد به تأیید دیگران است. وجود این ویژگی‌ها موجب می‌شود فرد ارزشمندی خود را بیش از اندازه به بازخوردهای اجتماعی وابسته کند؛ به‌گونه‌ای که تغییرات کوچک در رفتار دیگران، فاصله گرفتن افراد مهم یا دریافت نکردن تأیید مورد انتظار، به‌عنوان تهدیدی برای ارزش شخصی تجربه شود. در نتیجه، فرد به جای آنکه روابط اجتماعی را منبع حمایت و امنیت تجربه کند، آن‌ها را به‌عنوان موقعیت‌هایی تهدیدکننده ادراک کرده و در معرض هیجان‌های منفی پایدار مانند اضطراب، غم، ناامیدی و احساس ناکارآمدی قرار می‌گیرد؛ هیجان‌هایی که از عوامل زمینه‌ساز شکل‌گیری و تشدید افسردگی هستند (دیویدسون، ۲۰۰۰).

بر اساس مدل شناختی افسردگی بک، نحوه تفسیر فرد از خود، دیگران و رویدادهای زندگی نقش مهمی در ایجاد و تداوم افسردگی دارد. افراد دارای حساسیت بین‌فردی بالا، به دلیل تمرکز افراطی بر نشانه‌های اجتماعی و نگرانی از ارزیابی دیگران، بیشتر در معرض فعال شدن افکار خودکار منفی قرار می‌گیرند (بک، ۱۹۷۶). این افراد ممکن است رفتارهای خنثی یا مبهم دیگران را به شکل منفی تعبیر کرده و آن را نشانه‌ای از دوست‌داشتنی نبودن، ناکافی بودن یا رد شدن خود بدانند. تکرار این شیوه پردازش شناختی باعث شکل‌گیری چرخه‌ای از افکار منفی، هیجان‌های ناخوشایند و رفتارهای اجتنابی می‌شود که در نهایت می‌تواند شدت افسردگی را افزایش دهد. از این منظر، حساسیت بین‌فردی نه به‌عنوان یک عامل منفرد، بلکه به‌عنوان یک سبک پردازش شناختی-هیجانی عمل می‌کند که فرد را در برابر تجربه‌های افسرده‌ساز آسیب‌پذیر می‌سازد (آبرامسون و همکاران، ۱۹۸۹).

همچنین می‌توان این یافته را بر اساس نظریه دلبستگی و رویکردهای بین‌فردی افسردگی تبیین کرد. افرادی که حساسیت بین‌فردی بالاتری دارند، معمولاً نگرانی بیشتری درباره از دست دادن روابط، عدم پذیرش شدن و کاهش حمایت عاطفی دیگران تجربه می‌کنند (میکولینسر و شاور، ۲۰۱۶). این نگرانی مداوم سبب افزایش هوشیاری نسبت به نشانه‌های تهدید در روابط شده و فرد را در وضعیت انتظار طرد یا شکست رابطه‌ای قرار می‌دهد. چنین شرایطی می‌تواند موجب کاهش احساس امنیت روانی، افزایش احساس تنهایی و کاهش کیفیت روابط اجتماعی شود. از آنجا که روابط حمایتی نقش مهمی در تنظیم هیجان و محافظت در برابر افسردگی دارند، اختلال در این روابط می‌تواند زمینه بروز یا تشدید علائم افسردگی را فراهم کند. بنابراین، زنانی که حساسیت بین‌فردی بیشتری دارند، ممکن است در مواجهه با تعارض‌های رابطه‌ای یا تغییرات اجتماعی، واکنش‌های هیجانی شدیدتری نشان دهند و سریع‌تر وارد چرخه افسردگی شوند (هورویتز و همکاران، ۲۰۰۳).

از سوی دیگر، ارتباط مستقیم حساسیت بین‌فردی با افسردگی را می‌توان از طریق نقش این متغیر در شکل‌گیری ارزیابی‌های منفی از خود و دیگران توضیح داد. حساسیت بیش از حد به تعاملات اجتماعی معمولاً با مقایسه اجتماعی منفی، ترس از قضاوت شدن و کاهش اعتمادبه‌نفس همراه است. فردی که دائماً رفتار دیگران را

برای یافتن نشـانه‌های عدم پذیرش بررسـی می‌کند، احتمال بیشـتری دارد که تجربیات اجتماعی خود را به صـورت شکست شخصی تفسیر کند (بک، ۱۹۷۶). این فرایند می‌تواند احساس درماندگی، بی‌ارزشی و نارضایتی از خود را افزایش دهد؛ احساساتی که در ساختار شناختی افسردگی جایگاه اساسی دارند. به عبارت دیگر، حساسیت بین‌فردی از طریق افزایش تمرکز بر تهدیدهای اجتماعی و کاهش تولنایی فرد برای تفسـیر واقع‌بینانه تعاملات، زمینه ایجاد نگرش‌های منفی نسبت به خود و زندگی را فراهم می‌کند (نولن–هوکسما، ۲۰۰۰).

همچنین در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شـناختی، این رابطه می‌تواند تحت تأثیر شـرایط بالینی و تجربه‌های هیجانی شدیدتر قرار داشته باشد؛ زیرا این افراد معمولاً با مشکلات روان‌شناختی همراه با کاهش احساس امنیت، افزایش نگرانی‌های بین‌فردی و تجربه‌های منفی درباره روابط نزدیک مواجه هستند (گیلبرت و آیرون، ۲۰۰۵). در چنین شرایطی، حساسیت بین‌فردی می‌تواند به عنوان عاملی تقویت‌کننده عمل کرده و موجب شود فرد نشانه‌های اجتماعی را به شکل تهدیدآمیزتری پردازش کند. این برداشت‌های منفی، احتمال تجربه هیجان‌های افسرده‌ساز مانند غم، ناامیدی، احسـاس تنهایی و بی‌ارزشـی را افزایش می‌دهد. یافته پژوهش حاضـر مبنی بر وجود رابطه مسـتقیم و معنادار بین حسـاسـیت بین‌فردی و شـدت افسـردگی، نشـان‌دهنده آن اسـت که ویژگی‌های مرتبط با ادراک روابط اجتماعی و حساسیت نسبت به واکنش دیگران، بخش مهمی از فرایند آسیب‌پذیری زنان در برابر افسردگی را تشکیل می‌دهد (تنگنی و همکاران، ۲۰۱۴).

۵-۱-۳- فرضیه فرعی دوم

طرحواره رهاشـدگی با شـدت افسـردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شـناختی شـهر مشـهد رابطه مستقیم معناداری دارد.

یافته‌های پژوهش حاضـر در مورد این فرضـیه نشـان داد که طرحواره رهاشـدگی با شـدت افسـردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم، مثبت و معناداری دارد؛ به‌طوری‌که ضریب مسیر کل بین طرحواره رهاشدگی و افسردگی برابر با ۰/۱۹۳ و در سطح ۰/۰۰۱ معنادار بود. بر این اساس مشخص شد که افزایش میزان فعال بودن طرحواره رهاشـدگی می‌تواند شدت علائم افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شـناختی پیش‌بینی کند. این یافته با یافته‌های پژوهش فاریابی و اکرمی (۱۴۰۴)، سـلمان‌نژاد و همکاران (۱۴۰۱)، استرویان (۲۰۲۱)، لیو و همکاران (۲۰۲۴) و یانگ و همکاران (۲۰۱۹) همسو بود.

در تبیین این یافته می‌توان گفت که طرحواره رهاشـدگی به‌عنوان یکی از طرحواره‌های ناسـازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد، بیانگر انتظار پایدار فرد از بی‌ثباتی روابط، از دسـت دادن افراد مهم زندگی، عدم دسـترسـی به حمایت هیجانی و احتمال تنها ماندن است. این طرحواره معمولاً در نتیجه تجربه‌های اولیه‌ای شکل می‌گیرد که در آن نیازهای اساسـی هیجانی فرد، به‌ویژه نیاز به امنیت، ثبات، حمایت و ارتباط عاطفی پایدار، به اندازه کافی برآورده نشـده اسـت (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳). بر اسـاس نظریه طرحواره‌درمانی یانگ، زمانی که فرد در دوران کودکی و نوجوانی با تجارب مکرر بی‌ثباتی، طرد، عدم حضـور عاطفی والدین یا فقدان احسـاس امنیت مواجه می‌شـود، این تجارب به صورت ساختارهای شناختی عمیق در ذهن او تثبیت می‌شوند و در بزرگسالی نیز بر نحوه تفسیر روابط و رویدادهای

اجتماعی اثر می‌گذارند. در نتیجه، فرد دارای طرحواره رهاشدگی ممکن است حتی در شرایطی که تهدید واقعی برای رابطه وجود ندارد، نشانه‌های کوچک فاصله، تغییر رفتار یا کاهش توجه دیگران را به عنوان نشانه‌ای از ترک شدن یا از دست دادن رابطه تفسیر کند. این شیوه ادراک، زمینه تجربه مداوم نگرانی، ناامنی هیجانی و هیجان‌های منفی را فراهم کرده و می‌تواند به افزایش آسیب‌پذیری در برابر افسردگی منجر شود (یانگ و همکاران، ۲۰۱۹).

بر اساس مدل شناختی افسردگی، باورهای بنیادین منفی یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری و تداوم افسردگی محسوب می‌شوند (بک، ۱۹۷۶). طرحواره رهاشدگی می‌تواند به عنوان یکی از این باورهای بنیادین منفی عمل کند؛ زیرا فردی که این طرحواره در او فعال است، ممکن است خود را فردی ناپایدار در روابط، آسیب‌پذیر در برابر از دست دادن دیگران و فاقد حمایت کافی ادراک کند. چنین باورهایی موجب شکل‌گیری نگرش منفی نسبت به خود، دیگران و آینده می‌شوند که سه مؤلفه اصلی در شناخت افسرده‌ساز بک را تشکیل می‌دهند. فرد ممکن است خود را شایسته دریافت محبت و حمایت نداند، دیگران را غیرقابل اعتماد و روابط را ناپایدار تصور کند و آینده را همراه با احتمال طرد و تنهایی پیش‌بینی نماید. تداوم این الگوهای شناختی می‌تواند احساس درماندگی، ناامیدی و غمگینی را افزایش داده و در نهایت به شدت یافتن علائم افسردگی منجر شود (بک و همکاران، ۱۹۸۷).

یکی از سازوکارهای مهمی که می‌تواند رابطه میان طرحواره رهاشدگی و افسردگی را توضیح دهد، تأثیر این طرحواره بر تنظیم هیجان و تجربه روابط بین‌فردی است. افراد دارای این طرحواره معمولاً نسبت به احتمال از دست دادن روابط مهم، حساسیت هیجانی بیشتری دارند و در مواجهه با تعارض یا فاصله گرفتن دیگران، واکنش‌های هیجانی شدیدتری نشان می‌دهند (میکولینسر و شاور، ۲۰۱۶). این افراد ممکن است به دلیل ترس از ترک شدن، دائماً به دنبال اطمینان گرفتن از دیگران باشند یا برعکس، به دلیل انتظار پایان یافتن روابط، از صمیمیت و ارتباط عمیق اجتناب کنند. هر دو الگوی رفتاری می‌تواند کیفیت روابط اجتماعی را کاهش داده و موجب افزایش احساس تنهایی و کاهش حمایت اجتماعی شود. از آنجا که حمایت اجتماعی یکی از عوامل مهم در محافظت از سلامت روان و کاهش احتمال افسردگی است، کاهش کیفیت روابط و افزایش احساس انزوا می‌تواند مسیر انتقال طرحواره رهاشدگی به علائم افسردگی را تقویت کند (استرویان، ۲۰۲۱).

همچنین، طرحواره رهاشدگی می‌تواند از طریق ایجاد سبک دلبستگی ناایمن، زمینه شکل‌گیری هیجان‌های منفی پایدار را فراهم کند. بر اساس نظریه دلبستگی، تجربه روابط اولیه و میزان دسترس‌پذیری و پاسخ‌دهی مراقبان، نقش مهمی در شکل‌گیری احساس امنیت روانی فرد دارد (میکولینسر و شاور، ۲۰۰۷). زمانی که فرد در روابط اولیه خود با بی‌ثباتی یا عدم اطمینان مواجه شود، ممکن است در بزرگسالی نیز انتظار داشته باشد که دیگران او را ترک کنند یا حمایت مورد نیازش را ارائه ندهند. این انتظار دائمی از فقدان رابطه، موجب افزایش اضطراب دلبستگی، اشتغال ذهنی درباره روابط و کاهش توانایی تجربه آرامش هیجانی می‌شود. چنین شرایطی فرد را در برابر تجربه هیجان‌های افسرده‌ساز مانند ناامیدی، بی‌ارزشی و احساس تنهایی آسیب‌پذیرتر می‌کند (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳).

از سوی دیگر، ارتباط مستقیم طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی را می‌توان با توجه به نقش این طرحواره در شکل‌گیری برداشت‌های منفی از خود و روابط اجتماعی تبیین کرد. فردی که انتظار دارد دیگران او را ترک کنند، ممکن است این باور را درونی کند که دوست‌داشتنی نیست، ارزش کافی برای حفظ رابطه ندارد یا

همواره در معرض از دست دادن افراد مهم زندگی قرار دارد (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳). این باورها به تدریج موجب کاهش عزت‌نفس، افزایش خودارزیابی منفی و تقویت احساس بی‌کفایتی می‌شوند. چنین فرآیندی با ویژگی‌های شناختی و هیجانی افسردگی مانند احساس گناه، ناامیدی، کاهش انگیزه و کناره‌گیری اجتماعی همخوانی دارد. بنابراین، طرحواره رهاشدگی از طریق تأثیر بر ساختارهای شناختی عمیق فرد، نحوه تفسیر روابط و تجربه هیجان‌های مرتبط با فقدان و طرد، می‌تواند به صورت مستقیم شدت افسردگی را افزایش دهد (استرویان، ۲۰۲۱).

در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی، این رابطه می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد؛ زیرا این گروه معمولاً با سطوح بالاتری از مشکلات هیجانی و تجربه‌های منفی بین‌فردی مواجه هستند. فعال بودن طرحواره رهاشدگی در چنین شرایطی می‌تواند موجب شود فرد نه‌تنها رویدادهای فعلی، بلکه تجربه‌های گذشته و آینده خود را نیز از منظر احتمال از دست دادن، عدم حمایت و طرد شدن ارزیابی کند (قربانی و همکاران، ۱۴۰۰). این تفسیر مداوم از روابط، فشار هیجانی قابل توجهی ایجاد کرده و ظرفیت فرد برای مقابله سازگارانه با مشکلات را کاهش می‌دهد. در نتیجه، یافته پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین طرحواره رهاشدگی و شدت افسردگی نشان می‌دهد که باورهای بنیادین مرتبط با فقدان امنیت عاطفی و انتظار ترک شدن، نقش مهمی در شکل‌گیری و تشدید نشانه‌های افسردگی در زنان ایفا می‌کنند (گیلبرت و آیرون، ۲۰۰۵).

۵-۱-۴- فرضیه فرعی سوم

خودانتقادی با شدت‌افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهرمشهد رابطه مستقیم معناداری‌دارد.

یافته‌های پژوهش حاضر در مورد این فرضیه نشان داد که خودانتقادی با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری ندارد. نتایج تحلیل مدل ساختاری نشان داد ضریب مسیر مستقیم بین خودانتقادی و افسردگی برابر با ۰/۰۲۶- و مقدار معناداری ۰/۷۵۷ است که بیانگر عدم توانایی خودانتقادی در پیش‌بینی مستقیم شدت افسردگی در این نمونه پژوهشی است. این یافته با نتایج برخی پژوهش‌ها که نقش مستقیم خودانتقادی را در افسردگی گزارش کرده‌اند، متفاوت بود؛ اما با توجه به یافته‌هایی که نقش پیچیده و وابسته به متغیرهای میانجی خودانتقادی را مطرح کرده‌اند، قابل تبیین است. یافته حاضر با پژوهش پورتر و همکاران (۲۰۱۸) که نشان داد خودانتقادی می‌تواند در ارتباط با افسردگی نقش داشته باشد اما اثر آن در حضور سایر متغیرهای روان‌شناختی تغییر می‌کند و پژوهش‌هایی که بر نقش عوامل واسطه‌ای در رابطه خودانتقادی و مشکلات روان‌شناختی تأکید کرده‌اند، همسو بود.

در تبیین این یافته می‌توان گفت که اگرچه خودانتقادی در بسیاری از مطالعات به عنوان یکی از عوامل مرتبط با افسردگی شناخته شده است، اما اثر آن همواره به صورت مستقیم و مستقل ظاهر نمی‌شود و ممکن است تحت تأثیر سایر فرآیندهای شناختی و هیجانی قرار گیرد (بک، ۱۹۷۶). خودانتقادی معمولاً زمانی با افسردگی ارتباط قوی‌تری پیدا می‌کند که همراه با احساس شکست، شرم، خودسرزنش‌گری شدید، احساس بی‌ارزشی یا طرحواره‌های منفی درباره خود باشد. بر اساس دیدگاه‌های شناختی، صرف وجود گرایش به ارزیابی انتقادی خود الزاماً به افسردگی

منجر نمی‌شود، بلکه نحوه تفسیر فرد از این ارزیابی‌ها و هیجان‌های همراه با آن تعیین‌کننده پیامدهای روان‌شناختی است (گیلبرت و آیرون، ۲۰۰۵).

همچنین می‌توان بیان کرد که در مدل پژوهش حاضر، خودانتقادی احتمالاً به عنوان یک سازوکار انتقالی عمل کرده است و اثر آن در ارتباط با سایر متغیرهای پژوهش مانند حساسیت بین‌فردی، طرحواره رهاشدگی و شرمساری بهتر قابل مشاهده است. افرادی که دارای طرحواره‌های منفی مانند رهاشدگی یا حساسیت بالا نسبت به ارزیابی دیگران هستند، ممکن است در شرایط خاص به خودانتقادی بیشتری روی آورند، اما خودانتقادی به تنهایی و بدون فعال شدن هیجان‌هایی مانند شرم یا باورهای منفی عمیق درباره خود، الزاماً شدت افسردگی را افزایش نمی‌دهد (شری و همکاران، ۲۰۱۶). این موضوع با دیدگاه‌های جدیدتر درباره خودانتقادی همخوان است که آن را بیشتر یک فرآیند شناختی-هیجانی چندبعدی می‌دانند که در تعامل با سایر عوامل آسیب‌پذیری روان‌شناختی بر سلامت روان اثر می‌گذارد (گیلبرت و همکاران، ۲۰۱۹).

از سوی دیگر، عدم معناداری رابطه مستقیم خودانتقادی و افسردگی در پژوهش حاضر می‌تواند نشان‌دهنده نقش برجسته‌تر متغیرهای هیجانی مانند شرمساری در تبیین افسردگی باشد. خودانتقادی ممکن است زمانی به تجربه افسردگی منجر شود که فرد ارزیابی منفی از خود را به سطح هویت شخصی تعمیم دهد و آن را همراه با احساس شرم تجربه کند (تنگنی و همکاران، ۲۰۱۴). در واقع، تفاوت میان یک ارزیابی انتقادی از عملکرد خود و یک باور کلی مبنی بر «بی‌ارزش بودن خود» می‌تواند تعیین‌کننده شدت پیامدهای روان‌شناختی باشد. بنابراین، در نمونه حاضر ممکن است خودانتقادی به تنهایی قدرت پیش‌بینی افسردگی را نداشته باشد و اثر آن از طریق متغیرهایی مانند شرمساری یا تعامل با طرحواره‌های ناسازگار اولیه آشکار شود (کیم و همکاران، ۲۰۲۱).

بر این اساس، یافته پژوهش حاضر نشان می‌دهد که رابطه میان خودانتقادی و افسردگی رابطه‌ای ساده و مستقیم نیست، بلکه به زمینه شناختی و هیجانی فرد وابسته است (پورتر و همکاران، ۲۰۱۸). در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی، ممکن است تجربه افسردگی بیشتر تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل مانند احساس طردشدگی، ناامنی در روابط، شرم و برداشت منفی از خود قرار داشته باشد و خودانتقادی تنها در تعامل با این عوامل بتواند نقش مهمی ایفا کند. بنابراین، عدم تأیید مسیر مستقیم خودانتقادی به افسردگی در مدل حاضر نشان می‌دهد که این سازه برای تبیین شدت افسردگی نیازمند در نظر گرفتن شبکه گسترده‌تری از فرآیندهای شناختی و هیجانی است (کاندی و همکاران، ۲۰۲۲).

۵-۱-۵- فرضیه فرعی چهارم

شرمساری با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم معناداری‌دارد.

یافته‌های پژوهش حاضر در مورد این فرضیه نشان داد که شرمساری با شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه مستقیم، مثبت و معناداری دارد؛ به‌طوری‌که ضریب مسیر مستقیم بین شرمساری و افسردگی برابر با ۰/۲۰۱ و در سطح ۰/۰۰۱ معنادار بود. بر این اساس مشخص شد که افزایش تجربه

شرمساری می‌تواند شدت علائم افسردگی را در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی پیش‌بینی کند. این یافته با پژوهش مهدوی‌راد و همکاران (۱۴۰۲)، پورتر و همکاران (۲۰۱۸)، تنگنی و همکاران (۲۰۱۴) و کیم و همکاران (۲۰۲۱) همسو بود.

در تبیین این یافته می‌توان گفت که شرمساری یکی از هیجان‌های خودآگاه مهمی است که به جای تمرکز صرف بر یک رفتار یا عملکرد خاص، کل وجود و ارزشمندی فرد را مورد ارزیابی منفی قرار می‌دهد (بک، ۱۹۷۶). زمانی که فرد احساس شرمساری را تجربه می‌کند، معمولاً نه فقط یک عمل اشتباه، بلکه خود را فردی ناکافی، نامطلوب یا فاقد ارزش تلقی می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود شرمساری ارتباط نزدیکی با ساختارهای شناختی افسردگی مانند احساس بی‌ارزشی، ناامیدی و نگرش منفی نسبت به خود داشته باشد. بر اساس دیدگاه شناختی بک، ارزیابی منفی از خود یکی از مؤلفه‌های اصلی افسردگی است و تجربه مداوم شرمساری می‌تواند این ارزیابی‌های منفی را تقویت کرده و زمینه افزایش شدت علائم افسردگی را فراهم کند (تنگنی و همکاران، ۲۰۱۴).

همچنین می‌توان بیان کرد که شرمساری از طریق ایجاد احساس نقص و ناتوانی شخصی، مسیر شکل‌گیری افکار افسرده‌ساز را تقویت می‌کند. افرادی که مستعد تجربه شرم هستند، معمولاً رویدادهای منفی را به ویژگی‌های ثابت و منفی شخصیت خود نسبت می‌دهند؛ برای مثال ممکن است شکست، طرد یا تعارض بین‌فردی را نشانه‌ای از بی‌ارزش بودن خود بدانند (گیلبرت و آیرون، ۲۰۰۵). این شیوه تفسیر باعث می‌شود تجربه‌های ناخوشایند اجتماعی به جای آنکه موقعیتی و قابل تغییر در نظر گرفته شوند، به تهدیدی برای هویت فرد تبدیل شوند. در نتیجه، احساس درماندگی، کناره‌گیری اجتماعی و کاهش ارتباط با دیگران افزایش یافته و احتمال تجربه افسردگی بیشتر می‌شود (گیلبرت و همکاران، ۲۰۱۹).

از سوی دیگر، رابطه شرمساری با افسردگی را می‌توان با توجه به نقش آن در روابط بین‌فردی تبیین کرد. شرمساری شدید معمولاً با ترس از قضاوت شدن، نگرانی از رد شدن و تمایل به پنهان کردن خود واقعی همراه است (گیلبرت، ۲۰۱۴). فردی که احساس شرمساری بالایی دارد، ممکن است برای جلوگیری از تجربه دوباره این هیجان، از موقعیت‌های اجتماعی فاصله بگیرد یا تعاملات خود را محدود کند. این کناره‌گیری می‌تولند دریافت حمایت اجتماعی را کاهش داده و احساس تنهایی را افزایش دهد؛ عواملی که از مسیر افزایش هیجان‌های منفی، شدت افسردگی را بیشتر می‌کنند. بنابراین، شرمساری نه‌تنها یک تجربه درونی منفی است، بلکه از طریق تأثیر بر کیفیت روابط اجتماعی نیز می‌تواند به تداوم علائم افسردگی کمک کند (کیم و همکاران، ۲۰۲۱).

همچنین در چارچوب طرحواره‌درمانی، شرمساری می‌تواند پیامد فعال شدن طرحواره‌های ناسازگار اولیه مرتبط با طرد، نقص و بی‌ارزشی باشد. هنگامی که فرد دارای باورهای عمیق درباره دوست‌داشتنی نبودن یا ناکافی بودن خود است، تجربه‌های منفی زندگی و روابط بین‌فردی می‌توانند این باورها را فعال کرده و احساس شرم را افزایش دهند (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳). تداوم این فرایند باعث می‌شود فرد به صورت مکرر خود را از منظر منفی ارزیابی کرده و آمادگی بیشتری برای تجربه افسردگی پیدا کند. بنابراین، یافته پژوهش حاضر نشان می‌دهد که شرمساری به عنوان یک فرآیند هیجانی مهم، می‌تواند نقش مستقیمی در افزایش شدت افسردگی زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی داشته باشد (گیلبرت و همکاران، ۲۰۱۹)

۵-۱-۶- فرضیه فرعی پنجم

حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

یافته‌های پژوهش حاضر در مورد این فرضیه نشان داد که حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم، مثبت و معناداری دارد؛ به‌طوری‌که ضریب مسیر غیرمستقیم حساسیت بین‌فردی و افسردگی از طریق خودانتقادی برابر با ۰/۱۰۹ و در سطح ۰/۰۰۱ معنادار بود. این یافته نشان داد که خودانتقادی به‌عنوان یک متغیر میانجی، نقش مهمی در انتقال اثر حساسیت بین‌فردی به شدت افسردگی ایفا می‌کند. این یافته با پژوهش پورتر و همکاران (۲۰۱۸)، گیلبرت و همکاران (۲۰۱۹)، شری و همکاران (۲۰۱۶) و مهدوی‌راد و همکاران (۱۴۰۲) همسو بود.

در تبیین این یافته می‌توان گفت که حساسیت بین‌فردی به‌عنوان یک عامل آسیب‌پذیری اجتماعی، موجب می‌شود فرد نسبت به نشانه‌های ارزیابی منفی، انتقاد، عدم پذیرش و طرد شدن از سوی دیگران حساسیت بیشتری نشان دهد (بویس و پارکر، ۱۹۸۹). این افراد معمولاً تعاملات اجتماعی را با نگرانی بیشتری پردازش کرده و ممکن است رفتارهای مبهم یا خنثی دیگران را به صورت نشانه‌ای از ناکافی بودن یا دوست‌داشتنی نبودن خود تفسیر کنند. چنین ادراک‌هایی می‌تولند زمینه فعال شدن فرآیند خودانتقادی را فراهم کند؛ به این معنا که فرد به جای ارزیابی واقع‌بینانه موقعیت، مشکلات بین‌فردی را به ویژگی‌های شخصی خود نسبت داده و خود را مسئول، ناتوان یا دارای نقص تلقی کند. در نتیجه، حساسیت نسبت به روابط اجتماعی از طریق افزایش ارزیابی‌های منفی درباره خود، زمینه افزایش نشانه‌های افسردگی را فراهم می‌کند (بک، ۱۹۷۶).

خودانتقادی در این مسیر به‌عنوان یک سازوکار شناختی عمل می‌کند که تجربه‌های منفی بین‌فردی را به هیجان‌های افسرده‌ساز تبدیل می‌کند. فرد دارای حساسیت بین‌فردی بالا، در مواجهه با ناکامی‌های اجتماعی یا احساس عدم پذیرش، ممکن است به جای تمرکز بر عوامل موقعیتی، خود را مورد سرزنش و ارزیابی منفی شدید قرار دهد (گیلبرت و آیرون، ۲۰۰۵). این الگوی ذهنی باعث تقویت احساس شکست، بی‌ارزشی و نارضایتی از خود می‌شود و به تدریج چرخه‌ای از افکار منفی درباره خود ایجاد می‌کند که از ویژگی‌های اصلی افسردگی محسوب می‌شود. بنابراین، نقش میانجی خودانتقادی نشان می‌دهد که حساسیت بین‌فردی زمانی اثر بیشتری بر افسردگی دارد که از مسیر پردازش‌های درونی مانند سرزنش خود و ارزیابی منفی خویشتن عبور کند (شری و همکاران، ۲۰۱۶).

همچنین می‌توان این یافته را بر اساس دیدگاه‌های هیجانی تبیین کرد؛ زیرا حساسیت بین‌فردی معمولاً با ترس از قضاوت شدن و نیاز شدید به تأیید دیگران همراه است (گیلبرت و همکاران، ۲۰۱۹). زمانی که فرد احساس کند در روابط اجتماعی مورد پذیرش قرار نگرفته است، ممکن است این تجربه را تهدیدی برای ارزش شخصی خود تلقی کرده و به سمت خودانتقادی گرایش پیدا کند. تداوم این فرایند باعث افزایش هیجان‌های منفی مانند شرم، ناامیدی و احساس ناکارآمدی می‌شود که در نهایت شدت افسردگی را افزایش می‌دهند. در واقع، خودانتقادی

می‌تواند حلقه اتصال میان تجربه‌های اجتماعی منفی و تجربه افسردگی باشد؛ زیرا باعث می‌شود فرد پیامدهای منفی روابط را به جای شرایط بیرونی، ناشی از نقص درونی خود بداند (تنگنی و همکاران، ۲۰۱۴).

از سوی دیگر، نقش میانجی خودانتقادی در رابطه حساسیت بین‌فردی و افسردگی می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت فرآیندهای شناختی در تبیین مشکلات هیجانی باشد (پورتر و همکاران، ۲۰۱۸). حساسیت بین‌فردی به خودی خود تنها یک ویژگی شخصیتی یا سبک پردازش اجتماعی است، اما زمانی که با خودارزیابی‌های منفی همراه شود، می‌تواند پیامدهای روان‌شناختی شدیدتری ایجاد کند. در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی، که معمولاً با سطوح بالاتری از مشکلات هیجانی و تعارضات درونی مواجه هستند، خودانتقادی ممکن است موجب تثبیت نگرش‌های منفی نسبت به خود شده و مسیر انتقال آسیب‌پذیری‌های بین‌فردی به افسردگی را تقویت کند (کاندی و همکاران، ۲۰۲۲). بنابراین، یافته مربوط به اثر غیرمستقیم حساسیت بین‌فردی بر افسردگی از طریق خودانتقادی نشان می‌دهد که تجربه حساسیت شدید نسبت به روابط اجتماعی، زمانی می‌تواند به افزایش شدت افسردگی منجر شود که فرد این تجربه‌ها را در قالب ارزیابی منفی از خود پردازش کند. به بیان دیگر، خودانتقادی نقش یک مسیر شناختی را ایفا می‌کند که از طریق آن نگرانی‌های بین‌فردی و برداشت‌های منفی از تعاملات اجتماعی به تجربه افسردگی تبدیل می‌شوند.

۵-۱-۷- فرضیه فرعی ششم

حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

یافته‌های پژوهش حاضر در مورد این فرضیه نشان داد که حساسیت بین‌فردی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم، مثبت و معناداری دارد؛ به‌طوری‌که ضریب مسیر غیرمستقیم حساسیت بین‌فردی و افسردگی از طریق شرمساری برابر با ۰/۲۶۲ و در سطح ۰/۰۰۱ معنادار بود. این یافته نشان داد که شرمساری به‌عنوان یک متغیر میانجی، نقش مهمی در انتقال اثر حساسیت بین‌فردی به شدت افسردگی دارد. این یافته با پژوهش مهدوی‌راد و همکاران (۱۴۰۲)، پورتر و همکاران (۲۰۱۸)، تنگنی و همکاران (۲۰۱۴) و کیم و همکاران (۲۰۲۱) همسو بود.

در تبیین این یافته می‌توان گفت که حساسیت بین‌فردی از طریق افزایش توجه فرد به ارزیابی‌های اجتماعی و احتمال طرد شدن، زمینه تجربه هیجان شرمساری را فراهم می‌کند (بویس و پارکر، ۱۹۸۹). افراد دارای حساسیت بین‌فردی بالا معمولاً نسبت به واکنش‌های دیگران، میزان پذیرش شدن و نشانه‌های احتمالی انتقاد یا رد شدن، نگرانی بیشتری دارند. این افراد ممکن است تعاملات اجتماعی مبهم را به صورت تهدیدآمیز تفسیر کرده و رفتار دیگران را نشانه‌ای از نقص یا ناکافی بودن خود بدانند. چنین فرایندی موجب می‌شود تجربه‌های بین‌فردی منفی نه فقط به عنوان یک رویداد بیرونی، بلکه به عنوان ارزیابی منفی از هویت شخصی تجربه شود و در نتیجه، احساس شرمساری افزایش یابد (گیلبرت و آیرون، ۲۰۰۵).

شرمساری در این مسیر به‌عنوان یک سازوکار هیجانی عمل می‌کند که تجربه حساسیت بین‌فردی را به نشانه‌های افسردگی تبدیل می‌نماید. برخلاف هیجان‌هایی که به یک رفتار خاص مربوط هستند، شرمساری کل خود فرد را مورد ارزیابی منفی قرار می‌دهد و باعث می‌شود فرد احساس کند دارای نقص، بی‌ارزش یا دوست‌نداشتنی است. تداوم چنین ارزیابی‌هایی می‌تواند موجب افزایش افکار منفی درباره خود، کاهش عزت‌نفس، احساس درماندگی و ناامیدی شود؛ عواملی که در شکل‌گیری و شدت یافتن افسردگی نقش اساسی دارند (تنگنی و همکاران، ۲۰۱۴؛ بک، ۱۹۷۶). همچنین می‌توان بیان کرد که حساسیت بین‌فردی بالا، فرد را در معرض تجربه مکرر موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که احتمال فعال شدن شرم در آن‌ها وجود دارد (گیلبرت، ۲۰۱۴). برای مثال، دریافت نکردن تأیید دیگران، تجربه تعارض رابطه‌ای یا احساس نادیده گرفته شدن می‌تواند در افراد حساس از نظر بین‌فردی، به صورت نشانه‌ای از بی‌ارزش بودن شخصی تفسیر شود. این برداشت، موجب درونی شدن تجربه‌های منفی و شکل‌گیری چرخه‌ای از شرم، کناره‌گیری اجتماعی و کاهش حمایت بین‌فردی می‌شود. کاهش ارتباطات حمایتی نیز می‌تواند زمینه تداوم خلق افسرده و افزایش شدت نشانه‌های افسردگی را فراهم کند (کیم و همکاران، ۲۰۲۱).

از منظر شناختی نیز می‌توان این رابطه میانجی را توضیح داد؛ زیرا حساسیت بین‌فردی باعث فعال شدن باورهای منفی درباره خود در موقعیت‌های اجتماعی می‌شود و شرمساری نتیجه هیجانی این باورهاست. فردی که به طور مداوم نگران قضاوت دیگران است، ممکن است شکست‌ها یا مشکلات رابطه‌ای را به ویژگی‌های ثابت و منفی خود نسبت دهد (گیلبرت و همکاران، ۲۰۱۹). این نسبت دادن درونی، احساس شرم را افزایش داده و فرد را به سمت نگرش‌های افسرده‌ساز سوق می‌دهد. بنابراین، شرمساری می‌تواند حلقه واسط میان آسیب‌پذیری‌های بین‌فردی و افسردگی باشد؛ به این معنا که حساسیت بین‌فردی زمانی بیشترین اثر را بر افسردگی دارد که از مسیر تجربه شرمساری عبور کند (پورتر و همکاران، ۲۰۱۸). در مجموع، یافته پژوهش حاضر نشان می‌دهد که حساسیت بین‌فردی تنها از طریق مواجهه با مشکلات مستقیم روابط اجتماعی بر افسردگی اثر نمی‌گذارد، بلکه از طریق ایجاد تجربه‌های هیجانی منفی مانند شرمساری، زمینه افزایش شدت افسردگی را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، ادراک تهدید در روابط اجتماعی هنگامی به افسردگی منجر می‌شود که فرد آن را به صورت نقص شخصی و کاهش ارزش خود تجربه کند؛ فرآیندی که نقش میانجی شرمساری را در رابطه میان حساسیت بین‌فردی و شدت افسردگی تبیین می‌کند.

۵-۱-۸- فرضیه فرعی هفتم

طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

یافته‌های پژوهش حاضر در مورد این فرضیه نشان داد که طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری خودانتقادی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری ندارد؛ به‌طوری‌که ضریب مسیر غیرمستقیم بین طرحواره رهاشدگی و افسردگی از طریق خودانتقادی برابر با ۰/۰۰۹ و مقدار معناداری ۰/۸۰۰ بود که نشان‌دهنده عدم تأیید نقش میانجی خودانتقادی در این رابطه است. بنابراین، اگرچه طرحواره رهاشدگی می‌تواند به صورت مستقیم با شدت افسردگی ارتباط داشته باشد، اما در مدل حاضر خودانتقادی

نتوانست مسیر انتقال اثر طرحواره رهاشدگی به افسردگی را پیش‌بینی کند. این یافته با پژوهش‌هایی که نشان داده‌اند نقش خودانتقادی در ارتباط میان عوامل آسیب‌پذیری روان‌شناختی و افسردگی وابسته به حضور متغیرهای شناختی و هیجانی دیگر است، همسو بود؛ از جمله پژوهش شری و همکاران (۲۰۱۶) درباره نقش فرآیندهای خودانتقادی در آسیب‌پذیری روان‌شناختی و پژوهش گیلبرت و همکاران (۲۰۱۹) درباره نقش چندبعدی خودانتقادی در مشکلات هیجانی. همچنین این یافته در برخی ابعاد با پژوهش پورتر و همکاران (۲۰۱۸) که نشان داد اثر خودانتقادی بر افسردگی در تعامل با سایر عوامل روان‌شناختی آشکار می‌شود، همخوانی داشت.

در تبیین این یافته می‌توان گفت که اگرچه طرحواره رهاشدگی به عنوان یکی از طرحواره‌های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد می‌تواند زمینه‌ساز تجربه ناامنی، ترس از دست دادن روابط و احساس بی‌ثباتی هیجانی شود، اما انتقال اثر این طرحواره به افسردگی الزاماً از مسیر خودانتقادی انجام نمی‌شود. طرحواره رهاشدگی بیشتر با تجربه‌های هیجانی مرتبط با فقدان امنیت، اضطراب جدایی، نگرانی از ترک شدن و نیاز شدید به اطمینان‌جویی همراه است و ممکن است اثر خود را از مسیرهایی مانند شرمساری، احساس تنهایی، ناامیدی یا اختلال در روابط بین‌فردی بر افسردگی اعمال کند. بر اساس نظریه طرحواره‌درمانی یانگ، طرحواره‌های ناسازگار اولیه ساختارهای عمیق شناختی–هیجانی هستند که بر ادراک فرد از خود و روابط اثر می‌گذارند، اما نوع پاسخ هیجانی و شناختی فرد به فعال شدن این طرحواره‌ها می‌تواند متفاوت باشد (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳؛ یانگ و همکاران، ۲۰۱۹).

همچنین می‌توان بیان کرد که خودانتقادی بیشتر زمانی فعال می‌شود که فرد تجربه‌های منفی را به صورت مستقیم به نقص شخصی، شکست فردی یا ناکارآمدی خود نسبت دهد (میکولینسر و شاور، ۲۰۱۶). در حالی که طرحواره رهاشدگی الزاماً همیشه با چنین الگوی شناختی همراه نیست و ممکن است بیشتر به نگرانی درباره از دست دادن دیگران و ناامنی رابطه‌ای منجر شود. به عبارت دیگر، فرد دارای طرحواره رهاشدگی ممکن است به جای سرزنش خود، بیشتر احساس ترس، اضطراب، نیاز به حمایت یا وابستگی هیجانی را تجربه کند. بنابراین، ممکن است مسیر میانجی خودانتقادی در نمونه پژوهش حاضر فعال نشده باشد و اثر طرحواره رهاشدگی بر افسردگی بیشتر از طریق سایر فرآیندهای هیجانی و بین‌فردی منتقل شده باشد (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳).

از سوی دیگر، عدم معناداری نقش میانجی خودانتقادی می‌تولند به ماهیت متفاوت این دو سازه مرتبط باشد. طرحواره رهاشدگی ریشه در تجربه فقدان امنیت و انتظار ناپایداری روابط دارد، در حالی که خودانتقادی بیشتر به نحوه ارزیابی فرد از عملکرد و ارزش شخصی خود مربوط است. اگرچه این دو متغیر می‌توانند در برخی افراد با یکدیگر همراه شوند، اما رابطه میان آن‌ها قطعی و مستقیم نیست. ممکن است فردی به دلیل طرحواره رهاشدگی احساس ناامنی و ترس از دست دادن رابطه داشته باشد، بدون آنکه الزاماً خود را مورد انتقاد شدید قرار دهد. در چنین شرایطی، افسردگی می‌تواند از مسیر هیجان‌هایی مانند غم، تنهایی و احساس طردشدگی شکل گیرد، نه از طریق خودانتقادی (گیلبرت و آیرون، ۲۰۰۵؛ تنگنی و همکاران، ۲۰۱۴). همچنین با توجه به اینکه در پژوهش حاضر شرمساری به عنوان یک مسیر میانجی معنادار بین متغیرهای آسیب‌پذیری و افسردگی مطرح شده است، می‌توان احتمال داد که تجربه هیجان‌های خودآگاه مانند شرم در مقایسه با خودانتقادی، نقش برجسته‌تری در تبدیل طرحواره رهاشدگی به نشانه‌های افسردگی داشته باشد. فردی که انتظار ترک شدن یا از دست دادن روابط مهم را دارد، ممکن

است بیشتر احساس دوست‌داشتنی نبودن، نقص یا بی‌ارزشی را تجربه کند و این تجربه هیجانی مستقیماً با افسردگی ارتباط پیدا کند. بنابراین، یافته حاضر نشان می‌دهد که خودانتقادی در رابطه بین طرحواره رهاشدگی و افسردگی، در این نمونه نقش واسطه‌ای مستقلی نداشته است و اثر طرحواره رهاشدگی احتمالاً از مسیرهای شناختی-هیجانی دیگری قابل تبیین است.

۵-۱-۹- فرضیه فرعی هشتم

طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری دارد.

یافته‌های پژوهش حاضر در مورد این فرضیه نشان داد که طرحواره رهاشدگی با شدت افسردگی با میانجی‌گری شرمساری در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد رابطه غیرمستقیم معناداری ندارد؛ به‌طوری‌که ضریب مسیر غیرمستقیم بین طرحواره رهاشدگی و افسردگی از طریق شرمساری برابر با ۰/۰۱۸ و مقدار معناداری ۰/۴۸۱ بود که نشان‌دهنده عدم تأیید نقش میانجی شرمساری در این رابطه است. بنابراین، اگرچه طرحواره رهاشدگی می‌تواند به صورت مستقیم با شدت افسردگی ارتباط داشته باشد، اما در مدل حاضر شرمساری نتوانست مسیر انتقال اثر طرحواره رهاشدگی به افسردگی را پیش‌بینی کند. این یافته با پژوهش‌هایی که نشان داده‌اند رابطه میان طرحواره‌های ناسازگار اولیه و افسردگی همواره از مسیر یک هیجان خاص مانند شرمساری منتقل نمی‌شود و تحت تأثیر مجموعه‌ای از فرآیندهای شناختی، هیجانی و بین‌فردی قرار دارد، همسو بود؛ از جمله پژوهش یانگ و همکاران (۲۰۱۹) درباره نقش طرحواره‌های ناسازگار اولیه در آسیب‌پذیری روان‌شناختی و پژوهش کاندی و همکاران (۲۰۲۲) درباره نقش عوامل شناختی و هیجانی در ارتباط با افسردگی. همچنین این یافته با برخی نتایج پژوهش‌های مرتبط با شرمساری مانند گیلبرت و همکاران (۲۰۱۹) و تنگنی و همکاران (۲۰۱۴) همخوانی داشت که نشان می‌دهند اثر شرمساری بر افسردگی به شرایط شناختی و هیجانی فرد وابسته است.

در تبیین این یافته می‌توان گفت که طرحواره رهاشدگی و شرمساری، اگرچه هر دو با تجربه‌های منفی هیجانی و روابط بین‌فردی ارتباط دارند، اما الزاماً در یک مسیر علّی مستقیم قرار نمی‌گیرند. طرحواره رهاشدگی بیشتر به انتظار پایدار فرد از ناپایداری روابط، عدم دسترسی به حمایت هیجانی و ترس از ترک شدن مربوط است و معمولاً با احساس ناامنی، اضطراب جدایی و نگرانی درباره حفظ روابط همراه می‌شود. در مقابل، شرمساری بیشتر زمانی شکل می‌گیرد که فرد رویدادهای منفی را به ارزش کلی خود نسبت داده و خود را دارای نقص یا بی‌ارزش تلقی کند. بنابراین، ممکن است فرد دارای طرحواره رهاشدگی، لزوماً تجربه شرمساری شدیدی نداشته باشد و واکنش غالب او به جای احساس نقص شخصی، بیشتر به صورت ترس از دست دادن، وابستگی هیجانی یا نگرانی از آینده رابطه ظاهر شود (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳؛ یانگ و همکاران، ۲۰۱۹).

همچنین می‌توان بیان کرد که فعال شدن طرحواره رهاشدگی می‌تواند از مسیرهای دیگری به افسردگی منجر شود و نقش شرمساری در این میان وابسته به نحوه تفسیر فرد از تجربه‌های رهاشدگی است. برای مثال، برخی افراد ممکن است در مواجهه با احساس طرد یا احتمال از دست دادن رابطه، بیشتر دچار غم، تنهایی، ناامیدی یا

اضطراب شوند، بدون آنکه این تجربه‌ها را به ارزیابی منفی از هویت خود تبدیل کنند. در چنین شرایطی، طرحواره رهاشدگی می‌تواند مستقیماً از طریق کاهش احساس امنیت روانی و افزایش هیجان‌های منفی بر افسردگی اثر بگذارد، اما مسیر شرمساری فعال نشود. این موضوع با دیدگاه‌های طرحواره‌ای و دلبستگی که بر نقش متفاوت سبک‌های مقابله‌ای و واکنش‌های هیجانی افراد به تجربه‌های طرد تأکید دارند، هماهنگ است (یانگ و همکاران، ۲۰۰۳؛ میکولینسر و شاور، ۲۰۱۶).

از سوی دیگر، عدم معناداری نقش میانجی شرمساری در این فرضیه می‌تواند ناشی از تفاوت میان تجربه «ترک شدن» و تجربه «بی‌ارزش بودن» باشد. طرحواره رهاشدگی عمدتاً حول انتظار از دست دادن رابطه و عدم ثبات دیگران شکل می‌گیرد، در حالی که شرمساری نیازمند آن است که فرد این تجربه را به صورت نقص درونی و کاهش ارزش شخصی پردازش کند. بنابراین، وجود طرحواره رهاشدگی به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده افزایش شرمساری باشد. ممکن است فردی از ترک شدن بترسد، اما همچنان ارزشمندی خود را حفظ کند و تجربه طرد را ناشی از شرایط رابطه یا عوامل بیرونی بداند. در این حالت، شرمساری نقش واسطه‌ای قابل توجهی در انتقال اثر طرحواره رهاشدگی به افسردگی نخواهد داشت (گیلبرت و آیرون، ۲۰۰۵؛ تنگنی و همکاران، ۲۰۱۴). با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان تبیین کرد که در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد، احتمالاً مسیر تأثیرگذاری طرحواره رهاشدگی بر افسردگی بیشتر از طریق سازوکارهایی مانند احساس ناامنی هیجانی، مشکلات بین‌فردی، نگرانی از دست دادن حمایت دیگران یا الگوهای دلبستگی ناایمن صورت گرفته است و شرمساری نتوانسته نقش انتقال‌دهنده معناداری ایفا کند. به عبارت دیگر، تجربه رهاشدگی در این نمونه پژوهشی بیشتر ممکن است به صورت ترس، فقدان و ناامیدی تجربه شده باشد تا احساس شرم و نقص شخصی. بنابراین، عدم تأیید این فرضیه نشان می‌دهد که رابطه میان طرحواره رهاشدگی و افسردگی پیچیده بوده و بسته به نوع پردازش شناختی و هیجانی فرد، می‌تواند از مسیرهای متفاوتی شکل گیرد.

۵-۲ نتیجه گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شدت افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی، تحت تأثیر تعامل پیچیده‌ای از عوامل شناختی، هیجانی و بین‌فردی قرار دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به یک عامل منفرد نسبت داد. برازش مدل ساختاری پژوهش نشان داد که حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی، در کنار متغیرهای میانجی خودانتقادی و شرمساری، چارچوب مناسبی برای تبیین شدت افسردگی فراهم می‌کنند. یافته‌ها نشان دادند که حساسیت بین‌فردی و طرحواره رهاشدگی به صورت مستقیم با شدت افسردگی ارتباط دارند؛ به این معنا که زنانی که نسبت به ارزیابی دیگران، طرد اجتماعی و بی‌ثباتی روابط حساس‌تر هستند یا انتظار از دست دادن حمایت و ترک شدن را در قالب طرحواره‌های عمیق تجربه می‌کنند، آمادگی بیشتری برای تجربه علائم افسردگی دارند. این موضوع با دیدگاه‌های شناختی و طرحواره‌ای همخوان است که بر نقش باورهای بنیادین منفی، تجربه‌های اولیه

ناکام‌کننده و الگوهای پایدار تفسیر رویدادها در شکل‌گیری افسردگی تأکید دارند (بک، ۱۹۷۶؛ یانگ و همکاران، ۲۰۰۳).

یافته‌های پژوهش همچنین نشان داد که شرمساری نقش مهمی در تبیین افسردگی ایفا می‌کند و می‌تواند به عنوان یکی از مسیرهای هیجانی مرتبط با تجربه‌های منفی بین‌فردی در نظر گرفته شود. حساسیت بین‌فردی از طریق افزایش نگرانی درباره قضاوت دیگران و احتمال طرد شدن، زمینه تجربه شرمساری را فراهم می‌کند و شرمساری نیز با ایجاد احساس نقص، بی‌ارزشی و ارزیابی منفی از خود، شدت افسردگی را افزایش می‌دهد. در مقابل، خودانتقادی در مدل حاضر به صورت مستقیم قادر به پیش‌بینی افسردگی نبود و نقش میانجی آن در رابطه برخی متغیرها تأیید نشد؛ این یافته نشان می‌دهد که خودانتقادی به تنهایی عامل تعیین‌کننده افسردگی نیست، بلکه اثر آن وابسته به حضور سایر فرآیندهای شناختی و هیجانی مانند شرمساری، ارزیابی منفی خود و طرحواره‌های ناسازگار اولیه است (گیلبرت و همکاران، ۲۰۱۹؛ تنگنی و همکاران، ۲۰۱۴). در مجموع، الگوی نهایی پژوهش نشان می‌دهد که افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی، حاصل یک فرایند چندلایه است که در آن آسیب‌پذیری‌های بین‌فردی مانند حساسیت نسبت به روابط و طرحواره رهاشدگی، از طریق سازوکارهای شناختی و هیجانی خاص، به تجربه افسردگی منجر می‌شوند. یافته‌های پژوهش حاضر بر اهمیت درک همزمان عوامل رابطه‌ای، باورهای بنیادین و هیجان‌های خودآگاه در تبیین افسردگی تأکید دارد؛ زیرا تجربه طرد، ناامنی رابطه‌ای و ارزیابی منفی از خود، در تعامل با یکدیگر می‌توانند مسیر شکل‌گیری و تداوم نشانه‌های افسردگی را تقویت کنند.

۵-۳ محدودیت‌های پژوهش

- یکی از محدودیت‌های پژوهش حاضر، انتخاب نمونه از میان زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شناختی شهر مشهد بود. این گروه به دلیل برخورداری از مشکلات روان‌شناختی و مراجعه برای دریافت خدمات درمانی، ممکن است ویژگی‌های شناختی و هیجانی متفاوتی نسبت به زنان جامعه عمومی داشته باشند؛ بنابراین، تعمیم یافته‌ها به تمام زنان جامعه باید با احتیاط انجام شود.
- در پژوهش حاضر تنها زنان مورد بررسی قرار گرفتند و نقش متغیرهای پژوهش در مردان یا سایر گروه‌های جمعیتی بررسی نشد. با توجه به تفاوت‌های احتمالی جنسیتی در نحوه تجربه روابط بین‌فردی، شیوه پردازش هیجان‌های منفی، احساس شرمساری، خودارزیابی و راهبردهای مقابله‌ای، ممکن است الگوی به‌دست‌آمده در گروه‌های دیگر متفاوت باشد.
- محدودیت دیگر مربوط به بررسی نشدن برخی متغیرهای مؤثر و بالقوه تعدیل‌کننده در مدل پژوهش است. اگرچه مدل حاضر توانست نقش حساسیت بین‌فردی، طرحواره رهاشدگی، خودانتقادی و شرمساری را در تبیین افسردگی نشان دهد، اما عواملی مانند سبک دلبستگی، حمایت اجتماعی، تنظیم هیجان، شفقت به خود، تجارب آسیب‌زای دوران کودکی و سبک‌های مقابله‌ای می‌توانند بر شدت یا جهت این روابط اثرگذار باشند.

- با توجه به اینکه یافته پژوهش نشـان داد خودانتقادی برخلاف انتظار، رابطه مسـتقیم معناداری با افسـردگی نداشـت و برخی مسیرهای میانجی آن نیز تأیید نشـد، یکی از محدودیت‌های پژوهش حاضـر، عدم بررسـی ابعاد مختلف خودانتقادی بود. خودانتقادی سـازه‌ای چندبعدی اسـت و ممکن اسـت مؤلفه‌هایی مانند خودانتقادی مقایسـه‌ای، تنبیه‌کننده، کمال‌گرایانه یا وابسـته به شـکسـت، روابط متفاوتی با افسـردگی داشـته باشند.
- از دیگر محدودیت‌های پژوهش می‌توان به محدود بودن دامنه جغرافیایی نمونه‌گیری به شـهر مشـهد اشـاره کرد. ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصـادی و الگوهای روابط خانوادگی در مناطق مختلف می‌تولند بر شـکل‌گیری طرحواره‌های ناسـازگار اولیه، حساسـیت نسـبت به روابط اجتماعی و تجربه شـرمسـاری اثرگذار باشـد؛ بنابراین، نتایج پژوهش ممکن اسـت قابلیت تعمیم کامل به زنان سـایر شـهرها و فرهنگ‌ها را نداشـته باشد.

۵-۴ پیشنهادهای کاربردی

- ✓ پیشـنهاد می شـود روان‌شـناسـان و درمانگران در ارزیابی اولیه زنان مراجعه‌کننده به کلینیک‌های روان‌شـناختی، علاوه بر بررسـی نشـانه‌های افسـردگی، حساسـیت بین‌فردی و نگرانی‌های مرتبط با طرد و ارزیابی دیگران را نیز مورد توجه قرار دهند. با توجه به یافته پژوهش حاضـر مبنی بر رابطه مسـتقیم حسـاسـیت بین‌فردی با شـدت افسـردگی، شـناسـایی این ویژگی می‌تواند به پیش‌بینی آسـیب‌پذیری بیشـتر افراد و طراحی مداخلات هدفمند کمک کند.
- ✓ پیشـنهاد می شـود در برنامه‌های درمانی زنان دارای علائم افسـردگی، مداخلاتی برای اصـلاح برداشـت‌های تهدیدآمیز از روابط اجتماعی و کاهش تفسـیرهای منفی از رفتار دیگران گنجانده شـود. نتایج پژوهش نشـان داد حساسـیت بین‌فردی یکی از عوامل مهم مرتبط با افسـردگی اسـت؛ بنابراین آموزش بازسـازی شـناختی و افزایش توانایی ارزیابی واقع‌بینانه موقعیت‌های اجتماعی می‌تواند در کاهش چرخه افسرده‌ساز مؤثر باشد.
- ✓ پیشـنهاد می شـود درمانگران در کار با زنانی که دارای نشـانه‌های افسـردگی هسـتند، به بررسـی طرحواره رهاشدگی و تجربه‌های مرتبط با ناامنی عاطفی، فقدان حمایت و ترس از ترک شدن توجه ویژه داشته باشند. با توجه به رابطه مستقیم طرحواره رهاشـدگی با شـدت افسـردگی در پژوهش حاضـر، کار بر روی باورهای عمیق مرتبط با بی‌ثباتی روابط و ایجاد احساس امنیت هیجانی می‌تواند بخشی از فرایند درمان باشد.
- ✓ پیشنهاد می شود در مداخلات روان‌شناختی، کاهش شرمساری و اصلاح ارزیابی منفی از خود به عنوان یکی از اهداف اصلی درمان در نظر گرفته شود. یافته‌های پژوهش نشان داد شرمساری رابطه مستقیم با افسردگی دارد و همچنین در انتقال اثر حساسیت بین‌فردی به افسردگی نقش معناداری ایفا می‌کند؛ بنابراین، درمان‌های مبتنی بر شفقت به خود، پذیرش خود و کاهش احساس نقص شخصی می‌توانند برای این گروه از مراجعان مفید باشند.
- ✓ پیشنهاد می شود درمانگران به جای تمرکز صرف بر کاهش افکار خودانتقادگر، زمینه‌های شناختی و هیجانی همراه با آن مانند شرمساری، احساس بی‌ارزشی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه را نیز بررسی کنند. با توجه

به اینکه خودانتقادی در پژوهش حاضر به صورت مستقیم شدت افسردگی را پیش‌بینی نکرد، مداخلات باید بر شبکه گسترده‌تری از فرآیندهای روان‌شناختی تمرکز داشته باشند.

- ✓ پیشنهاد می شود در کلینیک‌های روان‌شناختی، آموزش مهارت‌های ارتباطی، تنظیم هیجان و افزایش کیفیت روابط حمایتی برای زنان دارای افسردگی ارائه شود. زیرا یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مشکلات مرتبط با روابط بین‌فردی، ادراک طرد شدن و کاهش احساس امنیت اجتماعی می‌توانند مسیرهای مهمی در تشدید افسردگی ایجاد کنند.
- ✓ پیشنهاد می شود در ارزیابی و درمان زنان افسرده، سابقه تجربه‌های اولیه مرتبط با بی‌ثباتی روابط، عدم دریافت حمایت هیجانی و تجارب طردشدگی مورد بررسی قرار گیرد. شناسایی این عوامل می‌تواند به درمانگران کمک کند تا به جای تمرکز صرف بر علائم فعلی، ریشه‌های شناختی و هیجانی مشکلات مراجعان را هدف قرار دهند.
- ✓ پیشنهاد می شود مراکز خدمات روان‌شناختی از برنامه‌های پیشگیرانه برای آموزش مهارت‌های خودپذیری، افزایش شفقت به خود، مدیریت هیجان‌های خودآگاه و اصلاح الگوهای ارتباطی استفاده کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، تقویت این مهارت‌ها می‌تواند از تبدیل آسیب‌پذیری‌های بین‌فردی مانند حساسیت اجتماعی و ترس از رهاشدگی به نشانه‌های شدید افسردگی جلوگیری کند.

۵-۵ پیشنهادهای پژوهشی

- پیشنهاد می شود پژوهش‌های آینده این مدل ساختاری را در نمونه‌های غیر بالینی و همچنین در گروه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی کنند. مقایسه زنان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی با زنان جامعه عمومی می‌تواند مشخص کند که آیا روابط مشاهده‌شده ناشی از ویژگی‌های بالینی نمونه بوده است یا الگویی عمومی در آسیب‌پذیری نسبت به افسردگی محسوب می‌شود.
- پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، نقش جنسیت در ارتباط میان حساسیت بین‌فردی، طرحواره رهاشدگی، شرمساری، خودانتقادی و افسردگی بررسی شود. مقایسه مدل حاضر میان زنان و مردان می‌تواند به شناسایی تفاوت‌های احتمالی در مسیرهای شناختی و هیجانی منتهی به افسردگی کمک کند.
- پیشنهاد می شود در مطالعات آینده متغیرهای دیگری مانند سبک‌های دلبستگی، شفقت به خود، حمایت اجتماعی، تنظیم هیجان، احساس تنهایی، تجربه‌های آسیب‌زای دوران کودکی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی به مدل پژوهش افزوده شوند. بررسی این متغیرها می‌تولند مسیرهای پیچیده‌تری را که از طریق آن‌ها آسیب‌پذیری‌های بین‌فردی به افسردگی تبدیل می‌شوند، روشن‌تر سازد.
- پیشنهاد می شود در پژوهش‌های آینده ابعاد مختلف خودانتقادی به صورت جداگانه بررسی شود تا مشخص شود کدام نوع خودانتقادی بیشترین ارتباط را با افسردگی دارد. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر خودانتقادی اثر مستقیم معناداری بر افسردگی نداشت، بررسی تفاوت میان خودانتقادی سازنده، خودانتقادی تنبیهی و خودارزیابی منفی می‌تواند به تبیین دقیق‌تر این سازه کمک کند.

- پیشنهاد می شود پژوهش‌های آینده نقش میانجی یا تعدیل‌کننده شرمساری را در رابطه میان انواع مختلف طرحواره‌های ناسازگار اولیه و افسردگی بررسی کنند. یافته حاضر نشان داد شرمساری در مسیر حساسیت بین‌فردی نقش مهمی دارد، اما در رابطه طرحواره رهاشدگی با افسردگی میانجی معناداری نبود؛ بنابراین بررسی شرایط فعال شدن شرمساری می‌تواند خلأ موجود را کاهش دهد.
- پیشنهاد می شود مطالعات آینده اثربخشی مداخلات درمانی مبتنی بر طرحواره‌درمانی، درمان متمرکز بر شفقت، درمان شناختی-رفتاری و رویکردهای بین‌فردی را در کاهش حساسیت بین‌فردی، طرحواره رهاشدگی، شرمساری و افسردگی بررسی کنند. این پژوهش‌ها می‌توانند مشخص کنند کدام مسیر درمانی برای کاهش عوامل زیربنایی افسردگی در زنان مراجعه‌کننده به مراکز روان‌شناختی مؤثرتر است.

منابع

منابع فارسی

ابراهیم‌نژادشهربابکی، مریم. (۱۳۹۷). *طرحواره‌ها و نقش آن در زندگی شغلی پرستاران*. تهران: مؤسسه انتشاراتی بنیتا خورشید دانش.

احمدآبادی، م.، ذبیحی، م.، خدارحمی، ع.، و برخورداری احمدآبادی، ع. (۱۴۰۳). نقش میانجی خود انتقادی در رابطه بین ترس از ارزیابی منفی و اضطراب اجتماعی دانشجویان علوم پزشکی. طلوع بهداشت، ۲۳(۴)، ۴۴-۵۶.

ارشدی، ل. (۱۴۰۱). پیش‌بینی حساسیت بین‌فردی براساس مؤلفه‌های ذهن‌آگاهی و میانجی‌گری پذیرش و عمل. نشریه حوزه روان‌شناسی، ۳(۲)، ۴۷-۵۳.

اصغری، آ؛ میان آبادی، ه. (۱۳۹۷). نقش پیش‌بینی‌کنندگی طرحواره‌های هیجانی و دشواری در نظم‌جویی هیجان در رفتارهای پرخطر دانشجویان دختر. *دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی*، ۱۹(۳)، ۱۴۰-۱۴۹.

امیری مصور پریسا, شمسائی فرشید, صادقیان عفت, تاپاک لیلی, & مرادویسی لطیف. (۱۴۰۲). ارتباط افکار خودکشی با خودانتقادی و افسردگی در دانشجویان کارشناسی پرستاری. نشریه روان پرستاری. ۵ (۳)، ۳۲-۲۳.

امینی، ف.، و فرهادی، ع. (۱۳۸۰). بررسی میزان شیوع اضطراب و افسردگی و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. *ماهنامه همایش دانشجویان و بهداشت روانی*، ۸، ۲۱- ۲۷.

آزادی, اسما , صالح زاده, مریم , نادری نوبندگانی, زهرا و دستجردی, قاسم . (۱۴۰۴). بررسی رابطه تجارب بدرفتاری در دوران کودکی با شرم و گناه در اختلال افسردگی اساسی و اختلال شخصیت مرزی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی, ۱۹(۴).

برکت ارسلان، م.، و مقدم نیا، م.م. (۱۴۰۲). همبستگی طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با مهارت‌های بین فردی و اجتماعی در دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، ۱۳(۱)، ۷۷-۹۰ .

پیرساقی، ف؛ نظری، ع م؛ نعیمی، ق؛ شفائی، م. (۱۳۹۴). تعارض های زناشویی؛ نقش سبک های دفاعی و طرحواره‌های هیجانی. *روان پرستاری*، ۳(۱)، ۵۹-۶۹.

حسین آبادی، م. (۱۳۹۰). *اثربخشی گروه درمانی وجودی انسان‌گرایانه بر میزان سلامت روان زندانیان و بررسی سهم عزت نفس و احساس شرم در بهبود سلامت روان*. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.

حیاتی، م.، شهنی‌ییلاق، م.، و کیخسروانی، م. (۱۴۰۲). تأثیر طرحواره‌درمانی بافتاری بر حساسیت بین‌فردی و خودکارآمدی مقابله‌ای دختران نوجوان دارای اضطراب اجتماعی. پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، ۱۴(۱)، ۶۳-۸۰ .

خداپناهی، م. (۱۳۹۶). *انگیزش و هیجان*. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

خلعتبری، جواد؛ قربانیشیرودی، شهره؛ عطاری، مانا؛ کاشانی نژاد، خیام. (۱۴۰۰). *طرحواره درمانی در عمل*. چاپ اول تهران: مؤسسه انتشاراتی نشر ثالث.

رحمانی، نرگس. (۱۴۰۰). *طرحواره درمانی برای کودکان و نوجوانان*. چاپ اول رده‌بندی دیویی: ۶۱۸.۹۲۸۹۱۴۲ تهران: مؤسسه انتشاراتی اسباران.

رضایی، ع م. (۱۳۹۴). پیش‌بینی افسردگی بر اساس مؤلفه‌های کمال‌گرایی: نقش میانجی خود انتقادی. *مطالعات روان شناسی بالینی*، ۵ (۱۹)، ۱-۱۸.

ریو، ج.م. (۱۳۹۵). *انگیزش و هیجان*. (ویراست ششم). ترجمه: ی، سیدمحمدی. تهران: ویرایش.

رئیسی، راحله؛ مقیمیان، مریم. (۱۴۰۴). پیش بینی بی‌تلفن همراه هراسی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه با توجه به افسردگی، اضطراب و استرس در جوانان. طلوع بهداشت یزد, ۲۳(۶), ۶۴-۷۷.

سلمان نژاد، فاطمه، نصرالهی، بیتا، قربان جهرمی، رضا، و نامور، هومن. (۱۴۰۱). مدلی ساختاری برای مشکلات روانشناختی بر اساس حوزه طرد و بریدگی و افکارخودآیند منفی با نقش واسطه ای احساس تنهایی. علوم اعصاب شفای خاتم، ۱۰(۴)، ۳۲-۴۳

شریعت، مهسا. (۱۴۰۰). *طرحواره‌ها و نقش آن در زندگی جوانان*. رده‌بندی دیویی: ۱۵۸ چاپ اول تهران: مؤسسه انتشاراتی شاپرک سرخ.

طالبلو، الهام؛ محمدی، فرهاد. (۱۴۰۰). *طرحواره‌های ناسازگار اولیه در اختلالات*. رده‌بندی دیویی: ۱۵۲.۴ چاپ اول تهران: مؤسسه انتشاراتی پادینا.

فارسی جانی، نیلوفر؛ ابراهیم نژاد مقدم، سمانه؛ ملحی، الناز(۱۴۰۰)،« مروری بر خودانتقادی و خودشفقت ورزی در سلامت روان»، رویش روان شناسی، سال دهم ، شماره۱۱ .

فاریابی, مریم و اکرمی, ناهید . (۱۴۰۴). نقش میانجی حساسیت به طرد بین‌فردی در رابطه‌ی میان طرحواره‌های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و اختلال افسردگی با ویژگی‌های آتیپیک. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی, ۲۰(۷۸), ۷۵-۸۷.

فتحی آشتیانی، علی؛ داستانی، محبوبه. (۱۳۹۲). *آزمون‌های روان‌شناختی*. تهران: انتشارات بعثت.

فیست، جس. فیست، گریگوری. (۱۳۸۶). *نظریه‌های شخصیت*. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران. نشر روان.

قادری، هاشم؛ گل، علیرضا؛ ذوالفقاری، حمید. (۱۳۹۹). *طرحواره درمانی و ذهن‌آگاهی کاربرد عملی*. تهران: مؤسسه انتشاراتی اثار معاصر.

قاضی مرادی، ح. (۱۳۸۳). *در ستایش شرم، جامعه شناسی حس شرم در ایران*. تهران: نشر اختران.

کاویانی، ح.، احمدی ابهری، ع.، نظری، ه.، هرمزی، ک. (۱۳۸۱). شیوع اختلال های افسردگی در شهر تهران در سال ۱۳۷۹ . *مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران*، ۶۰ (۵)، ۳۹۳- ۳۹۹.

کریمیان، ن؛ کریمی، ی؛ بهمنی، ب. (۱۳۹۰). بررسی رابطه ابعاد سلامت روان و احساس گناه با تعهد زناشویی افراد متأهل. *مشاوره و روان درمانی خانواده*؛ ۱ (۲)، ۲۴۳-۲۵۶.

کورکی، م.، هاشمی، س.ا.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، و پیمان‌نیا، ب. (۱۴۰۲). اثربخشی تلفیق سایکودراما با درمان شناختی رفتاری گروهی بر ابعاد حساسیت بین‌فردی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر. نشریه روان‌شناسی بالینی، ۱۵(۱)، ۲۵-۴۴.

مالک پور، نغمه؛ بهروزیان، فروزان؛ نجفی، نریمان؛ موسوی اصل، اسماعیل. (۱۴۰۳). بررسی نقش واسطه‌ای شرم و خودانتقادگری در رابطه بین تجربیات اولیه زندگی و اندیشه‌پردازی پارانوئید در دانشجویان. *مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران*. ۳۰ (۱).

متین,شایان و جهان,فائزه . (۱۳۹۸). مدل پیش‌بینی تنهایی اجتماعی بر اساس حساسیت بین فردی و هوش اجتماعی با میانجی‌گری خود انتقادی. پژوهش های روانشناسی اجتماعی, ۹(۳۵), ۶۷-۸۸.

محمدنژاد، مهرانگیز. (۱۳۹۶). *طرحواره درمانی و تعدیل طرحواره‌ها*. چاپ اول رده‌بندی دیویی: ۶۱۶.۸۵۸

محمدی آشنانی، فاطمه. (۱۳۹۸). *طرحواره درمانی با رویکرد مبتگرا*. چاپ اول ویراستار: مرضیه جعفریان تهران: مؤسسه انتشاراتی هدف خوارزمی.

مغانلو, مهناز؛ دادفر, حمید. (۱۴۰۳). رابطه خودانتقادگری و احساس تنهایی با افسردگی در سالمندان: نقش میانجی نشخوار فکری .*روان‌شناسی پیری. ۱۰(۱)، ۱۱۰-۸۹.*

منتظری، ع.، موسوی، ج.، امیدواری، س.، طاووسی، م.، هاشمی، ا.، و رستمی، ط. (۱۳۹۲). افسردگی در ایران: مرور نظام‌مند متون پژوهشی. *فصلنامه پایش*، ۱۲ (۶)، ۵۹۴- ۵۶۷.

موسویان الهام.(۱۳۹۹). مروری نظری بر نقش شرم نهادینه در سبب شناسی اختلال افسردگی اتکایی و درون فکنی شده رویش روان شناسی. ۹ (۶) :۲۲۲-۲۱۳

مهدوی راد، حسین، زاهدی تجریشی، کمیل، رمضانی فرانی، عباس، و اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (۱۴۰۱). نقش واسطه ای شرم و خودانتقادگری در رابطه میان سبک های دلبستگی با شدت علائم افسردگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، ۲۸(۴)، ۴۸۰-۴۹۵

میره‌ای, نرگس, بزازیان, سعیده, & قدرتی, سیما. (۱۴۰۳). رابطه طرحواره‌های ناسازگار با افسردگی و اضطراب اجتماعی در سالمندان. روان‌شناسی پیری, ۱۰(۳), ۳۴۳-۳۲۵.

نیک آمال، میترا و یارمحمدی، پروانه و شادمان‌فر، نسرین و زنگنه، لیلا (۱۳۹۲). اثربخشی آموزش مقابله با اضطراب، افسردگی و حساسیت بین فردی بر سلامت روانی زنان میانسال. *مجله تحقیقات روان‌شناختی*؛ (۵) ۲۰، ۹۱-۷۸.

نیک بخت,لیلا و شفیعی تبار,مهدیه . (۱۴۰۳). نقش خودشفقتی، حساسیت به طرد و باورهای غیر منطقی در پیش بینی افسردگی و اضطراب زنان مطلقه. روانشناسی مثبت : پژوهش ها و کاربردها, ۱(۱), ۱-۱۶.

یعقوبی، سهیلا، بیرشک، بهروز، عاقبتی، اسما، و عاشوری، احمد. (۱۴۰۰). نقش میانجی شرم بیرونی و شفقت به خود در رابطه بین قربانی شدن توسط هم سالان و نشانه های افسردگی در نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، ۲۷(۱)، ۱۶-۳۱.

یگانه، راحله؛ باقری فرد، راحله؛ زمانی سامانی، فاطمه؛ رجایی زاده، منصوره سادات. (۱۴۰۳). ارتباط ساختاری دلبستگی ناایمن و احساس شرم با افکار خودکشی در افراد دارای علائم افسردگی: نقش میانجی بدتنظیمی هیجانی. *روان پرستاری*. ۱۲ (۵) :۳۸-۲۵.

منابع لاتین

Abramson, L. Y., Metalsky, G. I., & Alloy, L. B. (1989). Hopelessness depression: A theory-based subtype of depression. *Psychological Review*, 96(2), 358.

Athari, N., Abazari, A., & Rashki, M. (2024). Prediction of Escapism Based on Interpersonal Sensitivity, Self-Criticism, and the Need for Social Approval. *Iranian Journal of Neurodevelopmental Disorders*, *3*(3), 10-16.

Azeez, A. A. (2023). *Mindfulness-Based Stress Reduction And Diversional Therapies In The Management Of Psychological Distress Among Cervical Cancer Patients In Lagos And Ibadan, Nigeria* (Doctoral dissertation).

Bai, Y. (2023). *The impact of self-criticism and dependency on adolescent depression, treatment outcome, and therapeutic process in brief psychotherapies for depression* (Doctoral dissertation, UCL (University College London)).

Bär, A., Bär, H. E., Rijkeboer, M. M., & Lobbestael, J. (2023). Early Maladaptive Schemas and Schema Modes in clinical disorders: A systematic review. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, *96*(3), 716-747.

Barlow, D.H., Durand, V.M. (2002). *Abnormal psychology, An integrative Approach* (3nd Ed). Canada: Wadworth Group.

Barnett, B., Wise, I., Williams, P., &, Parsons, M. (2018). "You Ought To!": A Psychoanalytic *Study of the Superego and Conscience*. Routledge.

Barr, P. (2022). Dimensions of the burnout measure: Relationships with shame-and guilt-proneness in neonatal intensive care unit nurses. Australian Critical Care, 35(2), 174-180

Başer, N., &, Erden, S. Ç. (2023). Understanding Early Maladaptive Schemas Formation with Traumatic Experiences in Childhood: A Qualitative Study. Journal of Aggression, Maltreatment &, Trauma, 32(4), 55-73.

Beck, A. T., Epstein, N., & Harrison, R. (1983). Cognitions, attitudes and personality dimessions in depression. *British Journal of Cognitive Psychotherapy*, 1 (1), 1-16.

Beck, A., Rush, A. ,Shaw, B., & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press . Bernieri, F. J. (2001). Toward a taxonomy of interpersonal sensitivity. *Interpersonal sensitivity: Theory and measure*ment, 3-20.

Bernieri, F. J. (2001). Toward a taxonomy of interpersonal sensitivity. Interpersonal sensitivity: *Theory and measurement*, 3-20.

Biermann, M. (2023). *Shame, self-criticism and fears of compassion in Borderline Personality Disorder* (Doctoral dissertation).

Bishop, A., Younan, R., Low, J., & Pilkington, P. D. (2022). Early maladaptive schemas and depression in adulthood: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, *29*(1), 111-130.

Blatt, S. J., & Zuroff, D. C. (1992). Interpersonal relatedness and self-definition: Two prototypes for depression. *Clinical Psychology Review*, *12*(5), 527–562. https://doi.org/10.1016/0272-7358(92)90070-O

Bokhan, N. A., Belokrylova, M. F., Gutkevich, E. V., Kornetova, E. G., Kupriyanova, I. E., Lebedeva, V. F., ... & Vasilieva, S. N. (2024). Mental Health of Women in Midlife and Beyond. In *Essentials in Health and Mental Health: Unlocking the Keys to Wellness* (pp. 141-175). Cham: Springer International Publishing.

Boyce, P., & Parker, G. (1989). Development of a scale to measure interpersonal sensitivity. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 23(3), 341-351.

Boyce, P., & Parker, G. (1989). Development of the Interpersonal Sensitivity Measure. *Psychological Medicine, 19*(1), 107–114. https://doi.org/10.1017/S0033291700011128

Buchman-Wildbaum, T., Unoka, Z., Dudas, R., Vizin, G., Demetrovics, Z., Richman, M.J. (2021). Shame in borderline personality disorder: MetaAnalysis. *Journal of Pers Disord*, 35, 149-161.

Buchner, L., Amesberger, G., Finkenzeller, T., Moore, S. R., & Würth, S. (2022). The modified German subjective vitality scale (SVS-GM): Psychometric properties and application in daily life. Frontiers in Psychology, 13, 948906.

Campos, R. C., Besser, A., &, Blatt, S. J. (2013). Recollections of parental rejection, self-criticism and depression in suicidality. *Archives of Suicide Research*, 17(1), 58-74.

Cândea, D. M., & Szentagotai-Tătar, A. (2018). Shame and self-criticism in relation to depression and anxiety: The mediating role of self-compassion. *Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 18*(1), 31–45.

Carvalho, C. B., Sousa, M., da Motta, C., & Cabral, J. M. (2019). The role of shame, self-criticism and early emotional memories in adolescents' paranoid ideation. *Journal of Child and Family Studies*, *28*(5), 1337-1345.

Cavalera, C., &, Pepe, A. (2014). Social emotions and cognition: shame, guilt and working memory. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 112, 457-464.

Compton, W. M., & Baler, R. (2016). The epidemiology of DSM-5 cannabis use disorders among US adults: science to inform clinicians working in a shifting social landscape. *American Journal of Psychiatry*, *173*(6), 551-553.

Cudo, A., Dobosz, M., Griffiths, M. D., &, Kuss, D. J. (2022). The Relationship Between Early Maladaptive Schemas, Depression, Anxiety and Problematic Video Gaming Among Female and Male Gamers. International journal of mental health and addiction, 1-28.

Davidson, J. R. Zisook, S. Giller, E. & Helms, M. (1989). Symptoms of interpersonal sensitivity in depression. *Comprehensive Psychiatry*, 30, 357-368.

Davis, H. A., Kells, M., Todorov, S., Kosmas, J., & Wildes, J. E. (2023). Comorbid eating, depressive, and anxiety psychopathology is associated with elevated shame in women with food insecurity. *International Journal of Eating Disorders*, *56*(6), 1087-1097.

Davoodi, E., Wen, A., Dobson, K. S., Noorbala, A. A., Mohammadi, A., & Farahmand, Z. (2018). Early maladaptive schemas in depression and somatization disorder. *Journal of affective disorders*, *235*, 82-89.

Dinger, U., Barrett, M. S., Zimmermann, J., Schauenburg, H., Wright, A. G., Renner, F., ... & Barber, J. P. (2015). Interpersonal problems, dependency, and self-criticism in major depressive disorder. *Journal of clinical psychology*, *71*(1), 93-104.

Dobrek, L., & Głowacka, K. (2023). Depression and its phytopharmacotherapy—a narrative review. *International Journal of Molecular Sciences*, *24*(5), 4772.

Dorahy, M.J., McKendry, H., Scott, A., Yogeeswaran, K., Martens, A., &, Hanna, D. (2017). Reactive dissociative experiences in response to acute increases in shame feelings. *Behaviour Research and Therapy*, 89, 75 -85.

Dozois, D. J., & Beck, A. T. (2023). Negative thinking: Cognitive products and schema structures.

Dunkley, D. M., Sanislow, C. A., Grilo, C. M., & McGlashan, T. H. (2012). Self-criticism versus neuroticism in predicting depression and psychosocial impairment for 4 years in a clinical sample. *Comprehensive Psychiatry, 53*(7), 788–799. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2011.10.004

Etemadi Shamsababdi, P., & Dehshiri, G. R. (2024). Self-compassion, anxiety and depression symptoms; the mediation of shame and guilt. *Psychological reports*, 00332941241227525.

Fassbinder, E., &, Arntz, A. (2021). Schema therapy. In A. Wenzel (Ed.), Handbook of cognitive behavioral therapy: Overview and approaches (pp. 493-537). American Psychological Association. 50.

Freud, S. (1914). *On narcissism: an introduction*. London: Hogarth.

Freud, S. (1923). *The Ego and the Id.* London: Hogarth.

Gao, Y., Liu, X., Liu, J., & Wang, H. (2023). The effects of self-criticism and self-compassion on adolescents' depressive symptoms and nonsuicidal self-injury. *Psychology research and behavior management*, 3219-3230.

Gausel, N., &, Leach, C. W. (2011). Concern for self- image and social image in the management of moral failure: Rethinking shame. *European Journal of Social Psychology*, 41(4), 468-478.

Gausel, N., Vignoles, V.L., &, Leach, C.W. (2016). Resolving the paradox of shame: Differentiating among specific appraisal-feeling combinations explains pro-social and self-defensive motivation. *Motivation and Emotion*, 40, 118 - 139.

Gerhardt, B. C., Serra, J. G., Zimmer, C., & Arteche, A. X. (2024). Role of self-criticism in postpartum mental health: a network analysis. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, *37*, 38.

Ghorbani, N., Watson, P. J., & Chen, Z. (2012). Social science in Iran: Cultural perspectives. *Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 6*(2), 1–12.

Gilbert, P. (2002). *Body shame: Conceptualisation, research and treatment*. Routledge.

Gilbert, P., & Irons, C. (2005). Focused therapies and compassionate mind training for shame and self-attacking. In P. Gilbert (Ed.), *Compassion: Conceptualisations, research and use in psychotherapy* (pp. 263–325). Routledge.

Giovazolias, T. (2023). The relationship of rejection sensitivity to depressive symptoms in adolescence: the indirect effect of perceived social acceptance by peers. *Behavioral Sciences*, *14*(1), 10.

Gittins, C. B., & Hunt, C. (2020). Self-criticism and self-esteem in early adolescence: Do they predict depression?. *PloS one*, *15*(12), e0244182.

Godfrin, K. A., & Van Heeringen, C. (2010). The effects of mindfulness-based cognitive therapy on recurrence of depressive episodes, mental health and quality of life: A randomized controlled study. *Behaviour research and therapy*, *48*(8), 738-746.

Halamová, J., Kanovský, M., Gilbert, P., Troop, N. A., Zuroff, D. C., Petrocchi, N., ... & Kupeli, N. (2019). Multiple group IRT measurement invariance analysis of the forms of self-criticising/attacking and self-reassuring scale in thirteen international samples. *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*, *37*(4), 411-444.

Hall, J. A., & Bernieri, F. J. (Eds.). (2001). *Interpersonal sensitivity: Theory and measurement*. Psychology Press.

Hamann, D, M., Wonderlich-Tierney, A, N.,Vander Wal, J, S. (2009). Interpersonal sensitivity predicts bulimic symptomatology cross-sectionally and longitudinally. *Eating Behaviors*, 125-127.

Harb, G. C., Heimberg, R. G., Fresco, D. M., Schneier, F. R., & Liebowitz, M. R. (2019). The psychometric properties of the Interpersonal Sensitivity Measure in social anxiety disorder. *Journal of Anxiety Disorders, 65,* 20–27. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2019.01.006

Hasin, D. S., Goodwin, R. D., Stinson, F. S., & Grant, B. F. (2005). Epidemiology of major depressive disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcoholism and Related Conditions. *Archives of general psychiatry*, *62*(10), 1097-1106.

Hiçdurmaz, D,. Öz, F. (2015). Interpersonal sensitivity, copingways and automatic thoughts of nursing students before and after a cognitive-behavioral group counseling program. *Nurse Education* Today,

Howell, A. J., Turowski, J. B., &, Buro, K. (2012). ",Guilt, Empathy, and Apology,", in: *Personality and Individual Differences*, 53: 917-922.

Hudson, C. C., Hall, L., & Harkness, K. L. (2019). Prevalence of depressive disorders in individuals with autism spectrum disorder: A meta-analysis. *Journal of abnormal child psychology*, *47*(1), 165-175.

Iancua, L., Bodnerb, E., Ben-Zionc, I.Z. (2015). Self esteem, dependency, self-efficacy and selfcriticism in social anxiety disorder. Comprehensive Psychiatry, 58, 165-171.

Inbar, Y., Pizarro, D. A., Gilovich, T., &, Ariely, D. (2013). Moral masochism: On the connection between guilt and self-punishment. *Emotion*, 13(1), 14-18.

Ingram, R. E., Hamilton, N. A., & Johnson, S. L. (2015). The cognitive vulnerability to depression: Conceptual and empirical status. *Handbook of Depression*, 3rd ed. Guilford Press.

Ingram, R. E., Miranda, J., & Segal, Z. (2006). *Cognitive vulnerability to depression. Cognitive vulnerability to emotional disorders* (pp. 73-102). London: Routledge.

Kim, S., Thibodeau, R., & Jorgensen, R. S. (2011). Shame, guilt, and depressive symptoms: A meta-analytic review. *Psychological Bulletin, 137*(1), 68–96. https://doi.org/10.1037/a0021466

Kirmani, M. N. (2026). *A Comprehensive Guide to Clinical Psychology*. The Readers Paradise.

Klein, C., Corman, F., Homan, J., Jones, B., Schroeder, A., Duley, H., & Li, C. (2022). Development and validation of in-situ specimen orientation method for quantitative SEM/EDS analysis. *Microscopy and Microanalysis*, *28*(S1), 968-969.

Kuehner, C. (2017). Why is depression more common among women than among men? *The Lancet Psychiatry, 4*(2), 146–158. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30263-2

Leahy RL. (2001). Emotional schemas in cognitive therapy. *annualmeeting of the Association for Advancement of Behavior Therapy*, Philadelphia.

Leahy RL. (2012). *Emotion regulation in CBT: An emotional schema therapy approach*. Http://www psychotherapy com au/index php.

Leahy, R. L. (2015). *Emotional schema therapy*. Guilford Publications.

Leahy, R. L. (2019). Introduction: emotional schemas and emotional schema therapy. *International Journal of Cognitive Therapy*, 12(1), 1-4.

Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Allen, A. B., &, Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly. Journal of *Personality and Social Psychology*, 92, 887- 904.

Liu, X., Wang, Z., Zhang, C., Xu, J., Shen, Z., Peng, L., ... & Xu, H. (2024). Psychological capital and its factors as mediators between interpersonal sensitivity and depressive symptoms among Chinese undergraduates. *Psychology research and behavior management*, 429-441.

Liu, Y., Zhou, P., Chen, J., Peng, C., Li, Y., & He, Q. (2024). Chain mediating effect of negative core schemas and interpersonal sensitivity on the relationship between adult attachment and depressive symptoms among college students. *Current Psychology*, *43*(8), 7526-7534.

Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. *Perspectives on Psychological Sscience*, 3(5), 400-424.

Mahdavi Rad, H., Zahedi Tajrishi, K., Ramezanifarani, A., & Asgharnejad Farid, A. (2023). The mediating role of shame and self-criticism in the relationship between attachment styles and severity of depressive symptoms. *Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology*, *28*(4), 492-507.

Matos, M., &, Pinto-Gouveia, J. (2010). Shame as a traumatic memory. *Clinical psychology &, psychotherapy*, 17(4), 299-312.

McGinn, L. K. (2000). Cognitive behavioral therapy of depression: Theory, treatment, and empirical status. *American Journal of Psychotherapy*, 54(2), 257.

Meyer, B., and Carver, C, S. (2000). Negative Childhood Accounts, Sensitivity, And Pessimism: A Study Of Avoidant Personality Disorder Features In College Students. *Personality Disorders*, 233-248.

Miceli, M. (1992). How to make someone feel guilty: Strategies of guilt inducement and their goals. *Journal for the Theory of Social Behavior*, 22, 81-104.

Mikulincer, M., &, Orbach, I. (1995). Attachment styles and repressive defensiveness: the accessibility and architecture of affective memories. *Journal of personality and social psychology*, 68(5), 917.

Mongrain, M., &, Leather, F. (2006). Immature dependence and self-criticism predict the recurrence of major depression. *Journal of Clinical Psychology*, 62, 705-713.

Morrow, J., & Nolen-Hoeksema, S. (1990). Effects of responses to depression on the remediation of depressive affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(3), 519-523.

Nair, A. R., Shivanna, Y. K. G., Illimoottil, J. P., Rachana, A., Mahasampath, G. S., Abraham, S., & Kurian, S. (2022). Common mental disorders among women and its social correlates in an urban marginalized populace in South India. *International Journal of Social Psychiatry*, *68*(7), 1394-1402.

Nemeroff, C. B. (2007). The burden of severe depression: a review of diagnostic challenges and treatment alternatives. *Journal of psychiatric research*, *41*(3-4), 189-206.

Nolen-Hoeksema, S. (1987). Sex differences in unipolar depression: evidence and theory. *Psychological Bulletin*, 101(2), 259-260.

Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes. *Journal of Abnormal Ppsychology*, 100(4), 569.

Nolen-Hoeksema, S. (2004). *The response styles theory. Depressive rumination: Nature, theory and treatment* (pp. 105-123) .Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Nolen-Hoeksema, S., Parker, L. E., & Larson, J. (1994). Ruminative coping with depressed mood following loss. *Journal of Personality and Social Psychology*, 67(1), 92-93.

Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. *Perspectives on Psychological Sscience*, 3(5), 400-424.

Orgeta, V., Leung, P., del-Pino-Casado, R., Qazi, A., Orrell, M., Spector, A. E., & Methley, A. M. (2022). Psychological treatments for depression and anxiety in dementia and mild cognitive impairment. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4).

Otani, K., Suzuki, A., Ishii, G., Matsumoto, Y., Kamata, M. (2008). Relationship of interpersonal sensitivity with dimensions of the Temperament and Character Inventory in healthy subjects. *Comprehensive Psychiatry*, 184-187.

Otani, K., Suzuki, A., Matsumoto, Y., & Shirata, T. (2018). Close relation of interpersonal sensitivity with negative core beliefs about the self, the central construct of cognitive vulnerability to depression. *Psychiatry Research*, *263*, 162-165.

Otani, K., Suzuki, A., Matsumoto, Y., Shibuya, N., Sadahiro, R., Enokido, M. (2014). Correlations of interpersonal sensitivity with negative working models of the self and other: evidence for link with attachment insecurity. *Jurnal Of Ann Gen Psychiatry*, 1-4.

Persons, J. B. (2012). *The case formulation approach to cognitive-behavior therapy*. New York, NY: Guilford Press.

Peters, E. M., Yilmaz, O., Li, C., & Balbuena, L. (2024). Interpersonal sensitivity and response to selective serotonin reuptake inhibitors in patients with acute major depressive disorder. *Journal of Affective Disorders*, *355*, 422-425.

Polskaya, N. A., Basova, A. Y., Razvaliaeva, A. Y., & Severina, Y. V. (2025). Russian version of the Inventory of Motivations for Suicide Attempts: validation in a clinical sample of adolescents. *Consortium Psychiatricum*, *6*(2), 35-50.

Porter, A. C., Zelkowitz, R. L., & Cole, D. A. (2018). The unique associations of self-criticism and shame-proneness to symptoms of disordered eating and depression. *Eating behaviors*, *29*, 64-67.

Rachman, S. (1997). A cognitive theory of obsessions. *Behaviour Research and Therapy*, 35(9), 793-802.

Raghu, A. (2025). *Impact of Self Stigma in the Psycho-Social Well-Being of Women With Unipolar Depression: A Comparative Study* (Master's thesis, Central Institute of Psychiatry (India)).

Reddy, N. Y. (2023). The self-blame scale: Development, psychometric properties and its relationship with self-criticism and self-reassurance. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, *49*(1), 73-80.

Renner, F., Lobbestael, J., Peeters, F., Arntz, A., & Huibers, M. J. (2012). Early maladaptive schemas in depressed patients: Stability and relation to depressive symptoms over the course of treatment. *Journal of Affective Disorders, 136*(3), 581–590. https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.10.027

Richards, D. (2011). Prevalence and clinical course of depression: a review. *Clinical Psychology Review*, 31(7), 1117-1125.

Rose, A. V., & Rimes, K. A. (2018). Self-criticism self-report measures: Systematic review. *Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice*, *91*(4), 450-489.

Ryan, J. D., Kacollja, A., D'Angelo, M. C., Newsome, R. N., Gardner, S., & Rosenbaum, R. S. (2020). Existing semantic knowledge provides a schematic scaffold for inference in early cognitive decline, but not in amnestic MCI. *Cognitive neuropsychology*, *37*(1-2), 75-96.

Sadock, B.j. Sadock, A.V. (2003). *Synopsis of psychiatry. Behavior and science clinical psychiatry* (9 Ed). New York: Lippincott Williams and Wilkins.

Sadock, B.j. Sadock, A.V. (2005). *Comprehensive textbook of psychiatry*, Vol 1. New York: Lippincott Williams& Wilkins.

Schoenleber M, Beltran E, Peters JR, Anestis MD. (2021). Association between shame aversion and ruminative retribution: Evidence for moderation by externalization of blame and control. *Motivation and Emotion*, 45, 798 -808.

Schore, A.N. (2019). *The development of the unconscious mind*. New York: W.W. Norton &, Company.

Shahar, B., Carlin, E. R., Engle, D. E., Hegde, J., Szepsenwol, O., &, Arkowitz, H. (2011). A pilot investigation of emotionfocused two-chair dialogue intervention for self-criticism. *Clinical Psychology &, Psychotherapy*, 19, 496-507.

Shahar, G. (2015). *Erosion: The Psychopathology of Self-Criticism*. New York, NY, USA: Oxford University Press.

Shorey, S., Ng, E. D., & Wong, C. H. (2022). Global prevalence of depression and elevated depressive symptoms among adolescents: A systematic review and meta-analysis. *British journal of clinical psychology*, *61*(2), 287-305.

Sinha, M. (2017). *Shame and Psychotherapy: Theory, Method and Practice. In Vanderheiden E, Mayer CH* (Eds.), the Value of Shame: Exploring a Health Resource in Cultural Contexts. 251 -275.

Staebler, K.,Helbing, E., Rosenbach, C., and Renneberg,B. (2011). Rejection Sensitivity and Borderline Personality Disorder. *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 275-283.

Stefan, S., Stroian, P., Silviu, M., Fodor, L., & Nechita, D. (2025). Self-criticism, experiential avoidance, social anxiety and depression in an experience sampling paradigm. *Current Psychology*, 1-13.

Stroian, P. I. (2021). Emotional needs and schematic functioning in depression: A narrative review. *Journal of Evidence-Based Psychotherapies*, *21*(1).

Sullins, J., Turner, J., Kim, J., & Barber, S. (2024). Investigating the impacts of shame-proneness on students' state shame, self-regulation, and learning. Education Sciences, 14(2), 138.

Tangney, J. P., &, Dearing, R. L. (2002). *Gender differences in morality*.

Tangney, J. P., &, Dearing, R. L. (2002). *Shame and guilt*. Guilford Press

Tangney, J. P., Stuewig, J., & Mashek, D. J. (2014). Moral emotions and moral behavior. *Annual Review of Psychology, 65,* 95–119. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143412

Teroni, F., &, Deonna, J. A. (2008). Differentiating shame from guilt. *Consciousness and cognition*, 17(3), 725-740.

Thapar, A., Eyre, O., Patel, V., & Brent, D. (2022). Depression in young people. *The Lancet*, *400*(10352), 617-631.

Thimm, J. C., & Chang, M. (2022). Early maladaptive schemas and mental disorders in adulthood: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Cognitive Therapy*, *15*(4), 371-413.

Thompson, R., & Zuroff, D. C. (2004). The Levels of Self-Criticism Scale: Comparative self-criticism and internalized self-criticism. *Personality and Individual Differences, 36*(2), 419–430. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00106-5

Tibubos, A. N., Werner, A. M., Brähler, E., Shahar, G., Ernst, M., Reiner, I., & Beutel, M. E. (2023). Self-criticism in the general population: Development and psychometric properties of the depressive experiences questionnaire self-criticism 4 (DEQ-SC4). *Journal of personality assessment*, *105*(1), 74-86.

Tignor, S. M., &, Colvin, C. R. (2019). The meaning of guilt: Reconciling the past to inform the future. *Journal of Personality and Social Psychology*, 116(6), 989-1010.

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. *Cognitive Therapy and Research*, 27(3), 247-259.

Ümmet, D., Satici, B., Okur, S., Deniz, M. E., & Satici, S. A. (2023). Psychological maltreatment, psychological adjustment, family communication, and mental wellbeing: A longitudinal serial mediation study. Applied Research in Quality of Life, 18(3), 1321-1335.

Unoka, Z., Vizin, G. (2017). To see in a mirror dimly. The looking glass self is self-shaming in borderline personality disorder. *Psychiatry Research*, 258, 322-329.

Vieira, C., Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2023). Early maladaptive schemas and behavioural addictions: A systematic literature review. *Clinical psychology review*, *105*, 102340.

Vigo, D., Thornicroft, G., & Atun, R. (2016). Estimating the true global burden of mental illness. *The Lancet Psychiatry*, *3*(2), 171-178.

Wakelin, K. E., Perman, G., & Simonds, L. M. (2022). Effectiveness of self-compassion-related interventions for reducing self-criticism: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, *29*(1), 1-25.

Wang, Y., Gao, Y., Liu, J., Bai, R., & Liu, X. (2023). Reciprocal associations between early maladaptive schemas and depression in adolescence: long-term effects of childhood abuse and neglect. *Child and adolescent psychiatry and mental health*, *17*(1), 134.

Watkins, E., Scott, J., Wingrove, J., Rimes, K., Bathurst, N., Steiner, H.,et al. (2007). Rumination-focused cognitive behaviour therapy for residual depression: A case series. *Behaviour research and therapy*, 45(9), 2144-2154.

Weinberger, A., Gbedemah, M., Martinez, A., Nash, D., Galea, S., & Goodwin, R. (2018). Trends in depression prevalence in the USA from 2005 to 2015: widening disparities in vulnerable groups. *Psychological Medicine*, 48(8), 1308-1315.

Wilhelm, K. (2004). The relationship between interpersonal sensitivity, anxiety disorders and major depression. *J Affect Disorders*, 79 , 33 -41.

Williams, C., &, Bybee, J. (1994). What do children feel guilty about? Developmental and gender differences. *Developmental Psychology*, 30(5), 617-623.

Xu, H., Pei, Y., Yong, Z., Liu, X., & Wang, W. (2023). Pathway from interpersonal sensitivity to depression among Chinese college students during the COVID-19 campus lockdown. *Environmental health and preventive medicine*, *28*, 34-34.

Xu, H., Peng, L., Wang, Z., Zeng, P., & Liu, X. (2022). Interpersonal sensitivity on college freshmen's depression: a moderated moderation model of psychological capital and family support. *Frontiers in psychiatry*, *13*, 921045.

You, J., Jiang, Y., Zhang, M., Du, C., Lin, M. P., &, Leung, F. (2017). Perceived parental control, self-criticism, and nonsuicidal self-injury among adolescents: Testing the reciprocal relationships by a three-wave cross-lag model. *Archives of suicide research*, 21(3), 379-391.

Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema therapy: A practitioner's guide*. Guilford Press.

Zelkowitz, R. L., &, Cole, D. A. (2019). Self-criticism as a transdiagnostic process in nonsuicidal self-injury and disordered eating: Systematic review and meta-analysis. *Suicide and Life-Threatening Behavior*, 49(1), 310-327.

Zhang, H., Watson-Singleton, N. N., Pollard, S. E., Pittman, D. M., Lamis, D. A., Fischer, N. L., ... & Kaslow, N. J. (2019). Self-criticism and depressive symptoms: Mediating role of self-compassion. *OMEGA-Journal of Death and Dying*, *80*(2), 202-223.

Zhang, Y., & Sun, Q. (2023). How interpersonal sensitivity affects depression under the COVID-19 lockdown among college students in South China: a moderated mediation model. *Psychology research and behavior management*, 1271-1282.

پیوست ها

پرسشنامه پژوهش

با سلام؛

پاسخگوی گرامی

این پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعاتی در رابطه با بررسی پژوهش دانشگاهی تهیه شده است. خواهشمند است هر سؤال را به دقت مطالعه و گزینه ای را که به بهترین وجه نظر شما را نشان می دهد، علامت گذاری نماید. خواهشمند است، هیچ سؤالی را بدون پاسخ نگذارید.

لطفاً پیش از پاسخ دادن به پرسشنامه موارد زیر را تکمیل نمایید.

مشخصات فردی:

سن:

وضعیت تاهل: مجرد ☐ متاهل ☐ مطلقه/سایر ☐

وضعیت اشتغال: خانه دار ☐ کارمند ☐ مشاغل آزاد ☐ سایر ☐

سطح تحصیلات: زیر دیپلم ☐ دیپلم ☐ فوق دیپلم ☐ لیسانس ☐ فوق لیسانس ☐ دکتری☐

پرسشنامه اول	
۱)غمگینی	**۲)بدبینی**
۰ من احساس غمگینی نمی کنم	۰ من نسبت به آینده دلسرد نیستم.
۱ من خیلی اوقات احساس غمگینی میکنم.	۱ من بیشتر از قبل نسبت به آینده دلسرد هستم.
۲ من همیشه غمگین هستم.	۲ من انتظار ندارم اوضاع بر وفق مرادم باشد.
۳ من به قدری غمگین هستم که نمی توانم تحمل کنم.	۳ من احساس میکنم برای من امیدی به آینده نیست و اوضاع فقط بدتر می شود.
۳)شکست گذشته	**۴)لذت نبردن**
۰ من احساس نمی کنم که فردی شکست خورده هستم.	۰ من به اندازه گذشته از زندگی لذت می برم.
۱ من بیش از آنچه که باید شکست خورده ام.	۱ من به اندازه گذشته از زندگی لذت نمی برم.
۲ وقتی به گذشته می نگرم شکست های زیادی را می بینم.	۲ من از آنچه که قبلا از آنها لذت می بردم خیلی کم لذت می برم.
۳ من احساس می کنم به عنوان یک انسان، کاملا شکست خورده ام.	۳ من اصلا نمی توانم از چیزهایی که قبلا از آنها لذت می‌بردم، هیچ لذتی ببرم.
۵)احساس گناه	**۶)احساس تنبیه**
۰ ۰ من به طور خاصی احساس گناه نمی کنم.	۰ من احساس نمی کنم که دارم تنبیه می شوم.

۱ من در مورد خیلی چیزهایی که انجام داده ام و یا باید انجام می داده ام احساس گناه می کنم. ۲ من اغلب اوقات کاملا احساس گناه میکنم. ۳ من همواره احساس گناه می کنم.	۱ من احساس می کنم که شاید تنبیه شده ام. ۲ من انتظار تنبیه شدن را دارم. ۳ من احساس می کنم که دارم تنبیه می شوم.
۷)دوست نداشتن خویش ۰ من همان احساسی را درباره خود دارم که همیشه داشته ام. ۱ من اعتماد به نفسم را از دست داده ام. ۲ من از خودم مأیوس نشده ام. ۳ من از خودم بدم می آید.	**۸)خود انتقادی** ۰ من بیشتر از حد معمول از خودم انتقاد نمی کنم و یا خودم را مقصر نمی دانم. ۱ من بیشتر از گذشته از خودم انتقاد می کنم. ۲ من به خاطر تمامی اشتباهاتم از خودم انتقاد می کنم. ۳ من خودم را برای هر چیز بدی که اتفاق بیفتد مقصر می دانم.
۹)افکار خودکشی یا تمایل به خودکشی ۰ من هیچ نوع فکری در مورد کشتن خود ندارم. ۱ من به کشتن خود فکر کرده ام ولی این کار را نمی کنم. ۲ من دلم میخواهد خودم را بکشم. ۳ اگر این امکان را داشتم خودم را می کشتم.	**۱۰)گریه کردن** ۰ من بیشتر از گذشته گریه نمی کنم. ۱ من بیشتر از گذشته گریه می کنم. ۲ من به خاطر هر چیز کوچکی گریه می کنم. ۳ من دلم می خواهد گریه کنم ولی نمی توانم.
۱۱)بی قراری ۰ من بیشتر از حد معمول بی قرار و تحرک پذیر نیستم. ۱ من بیش از حد معمول احساس بی قراری میکنم ئ تحریک پذیر شده ام. ۲ من به قدری بی قرار و ناآرام هستم که نمی توانم آرام باقی بمانم. ۳ من به قدری بی قرار و ناآرام هستم که باید دایما حرکت کنم یا مشغول به کاری باشم.	**۱۲)از دست دادن علاقه** ۰ من علاقه ام را نسبت به سایر آدمها و فعالیتها از دست نداده‌ام. ۱ من در مقایسه با قبل ، کمتر به سایر آدمها و چیزها علاقه مندم. ۲ من بیشترِ علاقه ام را نسبت به آدم ها یا چیزها از دست داده ام. ۳ علاقه مند شدن به هر چیزی برایم دشوار است.
۱۳)بی تصمیمی من تقریبا به خوبی گذشته تصمیمی می گیرم. ۱ به نظرم می رسد که تصمیم گیری برایم مشکل تر از حد معمول است. ۲ من در تصمیم گیری بیشتر از گذشته مشکل دارم. ۳ من در گرفتن هر نوع تصمیمی مشکل دارم.	**۱۴)بی ارزشی** ۰ من احساس نمی کنم که بی ارزش هستم. ۱ من خودم را به اندازه گذشته ارزشمند و مفید نمی بینم. ۲ من احساس می کنم در مقایسه با سایر آدم ها کم ارزش تر هستم. ۳ من بی نهایت احساس بی ارزشی می کنم.
۱۵) از دست دادن انرژی	**۱۶)تغییر در الگوی خواب**

۰ من به اندازه گذشته انرژی دارم. ۱ من کمتر از گذشته انرژی دارم. ۲ من به آنقدر انرژی ندارم که خیلی کار کنم. ۳ آن قدر بی انرژی هستم که نمی توانم هیچ کاری انجام بدهم .	۰ من هیچ تغییری در سبک خوابیدنم تجربه نکرده ام. --- ۱-الف من تا حدودی بیشتر از حد معمول می خوابم. ۱-ب من تا حدودی کمتر از حد معمول میخوابم. --- ۲-الف من خیلی بیشتر از حد معمول میخوابم. ۲-ب من خیلی کمتر از حد معمول می خوابم. --- ۳-الف من بیشتر اوقات روز را می خوابم. ۳-ب من یک الی دو ساعت زودتر بیدار می شوم و نمی توانم بخوابم.
۱۷) تحرک پذیری ۰ من بیشتر از حد معمول تحریک پذیر نیستم. ۱ من بیشتر از حد معمول تحریک پذیر هستم. ۲ من به مراتب بیشتر از حد معمول تحریک پذیر هستم. ۳ من تمام مدت تحریک پذیر هستم.	**۱۸)تغییر در اشتها** من هیچ تغییری در اشتهایم تجربه نکرده ام. --- ۱-الف اشتهای من تا حدودی کمتر از حد معمول است. ۱-ب اشتهای من تا حدودی بیشتر از حد معمول است. --- ۲-الف اشتهای من به مراتب کمتر از گذشته است. ۲-ب اشتهای من به مراتب بیشتر از گذشته است. --- ۳-الف من اصلا اشتها ندارم. ۳-ب من همیشه اشتها به غذا دارم.
۱۹) اشکال در تمرکز ۰ من می توانم بخوبی گذشته تمرکز داشته باشم. ۱ من نمی توانم به خوبی همیشه تمرکز داشته باشم. ۲ خیلی سخت است که فکرم را روی هر چیزی به مدت طولانی متمرکز کنم. ۳ من متوجه شده ام که نمی توانم روی هیچ چیزی تمرکز کنم.	**۲۰)خستگی یا کسالت** ۰ من بیشتر از حد معمول خسته یا کسل نیستم. ۱ زودتر یا بیشتر از حد معمول خسته یا کسل می شوم. ۲ من به قدری خسته یا کسل می شوم که نمی توانم بسیاری از کارهایی را که قبلا می کردم، انجام دهم. ۳ من به قدری خسته یا کسل می شوم که نمی توانم اغلب کارهایی را که قبلا می کردم انجام دهم .
۲۱)از دست دادن علاقه جنسی ۰ من متوجه تغییر تازه ای در علاقه جنسی ام نشده ام. ۱ من کمتر از گذشته به امور جنسی علاقه دارم.	

۲ من در حال حاضر به مراتب کمتر به امور جنسی علاقه دارم. ۳ من علاقه جنسی ام را کاملا از دست داده ام.	

پرسشنامه دوم

تا چه میزان با هر یک از عبارت های زیر موافق هستید	کاملاً موافقم	موافقم	نظری ندارم	مخالفم	کاملاً مخالفم
من از عادات شخصی که دارم، شرمنده هستم.					
من نگران فکر مردم در مورد عادات شخصی خود هستم.					
من عادات شخصی خود را پنهان می کنم.					
من سعی میکنم چیزهایی که برای انجام آنها احساس شرمندگی دارم، پنهان کنم.					
من بخاطر سبک و روشم از مردم دوری می کنم.					
من نگران فکر مردم درباره توانایی انجام چیزها هستم.					
من نگران در مورد آنچه مردم در خصوص چیزی اشتباه می پندارند، هستم.					

پرسشنامه سوم

ردیف	عبارت	کاملا موافقم	تا حدی موافقم	تا حدی مخالفم	مخالفم
۱	هنگام خداحافظی کردن با دیگران، احساس ناامنی میکنم.				
۲	درباره تاثیری که بر دیگران دارم احساس نگرانی میکنم.				
۳	به خاطر ترس از طرد شدن از بازگو کردن افکارم اجتناب میکنم.				
۴	هنگام ملاقات با افراد جدید احساس عدم آرامش میکنم.				
۵	اگر دیگران شخصیت واقعی مرا بشناسند، مرا دوست نخواهند داشت.				
۶	هنگامی که در یک رابطه صمیمی هستم، احساس امنیت دارم.				
۷	ار ترس اینکه احتمالاً باعث رنجش خاطر کسی شوم ، به آنها عصبانی نمیشوم.				
۸	بعد از بحث و جدل با یک دوست، تازمانیکه با وی آشتی نکنم احساس آرامش ندارم.				
۹	همیشه از اینکه دیگران چه احساسی دارند آگاه هستم.				
۱۰	میترسم به خاطر حرفهایی که میزنم یا کارهایی که میکنم مورد انتقاد قرار گیرم.				
۱۱	اگر فردی علاقه ای به من نداشته باشد ،همیشه آن را تشخیص میدهم.				

۱۲	همیشه از اینکه یکی از نزدیکانم را از دست دهم احساس نگرانی دارم.				
۱۳	احساس میکنم اطرافیانم عموماً مرا دوست دارند.				
۱۴	برای اینکه کسی را نرنجانم و اذیت نکنم، کاری را انجام میدهم که در اصل نمیخواستم آن را انجام دهم.				
۱۵	زمانی معتقدم که کاری را به خوبی انجام دادهام که دیگران نیز آن را تائید کنند.				
۱۶	من تلاشی افراطی میکنم تا کسی که با او صمیمی هستم را خوشحال یا راضی کنم.				
۱۷	هنگامی که با کسی خداحافظی میکنم احساس اضطراب دارم.				
۱۸	وقتی کسی از من تعریف میکند احساس خوشحال بودن دارم.				
۱۹	میترسم که احساساتم دیگران را معذب کند.				
۲۰	میتوانم دیگران را خوشحال کنم.				
۲۱	عصبانی شدن به دیگران برایم سخت و دشوار است.				
۲۲	از انتقادات دیگران احساس نگرانی میکنم.				
۲۳	وقتی فردی از عملکرد من انتقاد میکند، احساس بدی دارم.				
۲۴	اگر دیگران خود واقعی من را بشناسند ،دیدگاهشان نسبت به من بد میشود.				
۲۵	من همیشه منتظر انتقاد یا بازخورد از طرف اطرافیانم هستم.				
۲۶	مطمئن نیستم وقتی کسی کنار من هست از حضورم خوشحال و راضی است یا نه.				
۲۷	دوست ندارم دیگران مرا به طور کامل بشناسند.				
۲۸	اگر کسی مرا ناراحت کند ،نمیتوانم به سادگی آن را فراموش کنم.				
۲۹	احساس میکنم دیگران مرا درک نمیکنند.				
۳۰	از آنچه که دیگران درباره من فکر میکنند نگران هستم.				
۳۱	زمانی احساس خوشحالی و شادی دارم که افرادی که میشناسم مرا تحسین کنند.				
۳۲	هرگز به فردی بیاحترامی نکردهام.				
۳۳	من در مورد اینکه احساسات دیگران را خدشه دار کنم نگران هستم.				
۳۴	هنگامی که دیگران با من با عصبانیت رفتار میکنند احساس رنجیده شدن دارم.				
۳۵	میزان ارزش من به عنوان یک فرد بسته به این است که دیگران چه دیدگاهی دربارهام دارند.				
۳۶	این که دیگران چه حسی درباره من دارند برایم مهم است.				

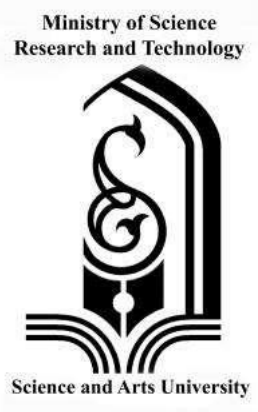
پرسشنامه چهارم						
نظر خود را در مورد میزان درستی هر یک از عبارت های زیر تا یکی از گزینه های روبرو انتخاب کنید.	کاملاً درست	تقریبا درست	اندکی درست	بیشتر درست تا غلط	تقریبا غلط	کاملاً غلط
۱. من به افراد نزدیک خودم خیلی می‌چسبم؛ چون میترسم مرا ترک کنند.						
۲. آنقدر به دیگران نیازمند هستم که نگران از دستدادن آنها هستم.						
۳. نگرانم از اینکه افرادی که به من نزدیکند، مرا ترک و رها کنند.						
۴. وقتی احساس کنم کسی که برایم مهم است از من دوری میکند، احساس یأس میکنم.						
۵. برخی اوقات آنقدر نگران آن هستم که مردم مرا ترک کنند که آنها را از خودم می رانم.						

		۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
		بسیار خوب توصیف کنندهٔ من است						اصلاً توصیف کنندهٔ من نیست
۱	هنگامی که شکست می خورم، بسیار تندخو می شوم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۲	دائما یک احساس حقارت آزار دهنده دارم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۳	هنگامی که به معیارهایی که برای خودم تعیین کردم نمی رسم، خیلی از دست خودم ناراحت می شوم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۴	معمولا در موقعیت های اجتماعی ای که نمی دانم اوضاع از چه قرار است، راحت نیستم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۵	اغلب وقتی که شکست می خورم، از دست خودم خیلی عصبانی می شوم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۶	وقت زیادی را صرف نگرانی در مورد اینکه دیگران در مورد من چه فکر خواهند کرد، نمی کنم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۷	وقتی شکست می خورم، خیلی دل خور می شوم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۸	اگر در مورد ضعف هایتان با دیگران روراست باشید،آنها به احتمال زیاد احترام شما را حفظ خواهند کرد.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۹	شکست برای من تجربهٔ بسیار دردناکی است.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۰	اغلب نگرانم که دیگران بفهمند من واقعا چه جور آدمی هستم و از دستم دلخور شوند.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۱	اغلب در خصوص احتمال شکست نگرانی ندارم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۲	مطمئنم اکثر افرادی که با آن ها صمیمی هستم ، من را همان طور که هستم، قبول خواهند داشت.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۳	وقتی که موفق نمی شوم، در مورد ارزشمندی خودم شک می کنم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۴	اگر به آدم ها اعتماد کنید، آن ها احتمالا از شما سوء استفاده خواهندکرد.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۵	وقتی به آن خوبی که دوست دارم، عمل نمی کنم، احساس می کنم آدم شکست خورده ای هستم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۶	معمولا با افرادی که از من دربارهٔ خودم سؤال می کنند، راحتم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۷	شکست در یک زمینه از زندگی ام باعث می شود از خودم به عنوان یک شخص، ارزیابی منفی ای داشته باشم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۸	می ترسم اگر دیگران من را خیلی خوب بشناسند، به من احترام نگذارند.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۱۹	اغلب خودم را با اهداف و ایده آل هایم مقایسه می کنم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۲۰	به ندرت از خودم خجالت می کشم.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۲۱	روراست و صادق بودن بهترین راه به دست آوردن احترام دیگران است.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶
۲۲	برخی اوقات قدری عدم صداقت برای به دست آوردن آنچه که می خواهید، لازم است.	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶

Abstract

The present study was conducted with the aim of investigating the mediating role of self-criticism and shame in the relationship between interpersonal sensitivity and abandonment schema with depression severity in women referred to psychological clinics in Mashhad. The research method was descriptive-correlational and based on structural equation modeling. The statistical population included women referring to psychological clinics in Mashhad, from whom 220 were selected by convenience sampling. Data were collected using the Levels of Self-Criticism Scale (LOSC; Thompson & Zuroff, 2004), the Experience of Shame Scale (ESS; Andrews et al., 2002), the Beck Depression Inventory-II (BDI-II), the Interpersonal Sensitivity Measure (IPSM; Boyce & Parker, 1989), and the Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ-S3; Smith et al., 1995), and were analyzed using path analysis and structural equation modeling. Findings showed that the structural model of the study had a favorable fit with the data (GFI=0.98, AGFI=0.96, CFI=0.99, RMSEA=0.046). The results indicated that interpersonal sensitivity and abandonment schema directly and positively predict depression severity. Also, shame played a significant mediating role in the relationship between interpersonal sensitivity and depression severity, but the mediating role of self-criticism in this relationship was not confirmed. Furthermore, the indirect paths from abandonment schema to depression through self-criticism and shame were not significant. Based on the findings, depression in women referring to psychological clinics is the result of the interaction of cognitive, emotional, and interpersonal factors, and sensitivity to social relationships and the expectation of losing others' support can be associated with greater depression severity through increased negative emotional experiences, especially shame. This study emphasizes the importance of simultaneously examining interpersonal, schema-based, and emotional factors in explaining depression.

Keywords: Self-criticism, Shame, Interpersonal sensitivity, Abandonment schema, Depression, Women



The Thesis of M.A in Faculty of Humanities

Department of Clinical Psychology

Title:

The Mediating Role of Self-Criticism and Shame in the Relationship Between Interpersonal Sensitivity and Abandonment Schema with Depression Severity in Women Referring to Psychological Clinics

Supervisor :

Dr. Farangis Demehri

Research by:

Mahdieh Qahhar

February 2026